



Katalog: 2201007

Statistik Demografi Indonesia

(Hasil Sensus Penduduk 2020)



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 2201007

Statistik Demografi Indonesia

(Hasil Sensus Penduduk 2020)



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Demografi Indonesia

(Hasil Sensus Penduduk 2020)

Katalog: 2201007

Nomor Publikasi: 04100.25001

Ukuran Buku: 17,6 cm X 25 cm

Jumlah Halaman: xviii+168 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Tim Penyusun

Statistik Demografi Indonesia
(Hasil Sensus Penduduk 2020)

Pengarah

Ateng Hartono

Penanggung Jawab

Ali Said

Penyunting

Uray Naviandi

Sri Wahyuni

Diah Ikawati

Dwi Trisnani

Penulis Naskah

Uray Naviandi

Apriliani Nurida Dwi Aswarawati

Nur Amalia Ramadhani

Putricia Synthesa

Ikhsan Fahmi

Arief Pratama

Anita Rahmawatiningsih

Penata Letak

Putricia Synthesa





Kata Pengantar

Dinamika kependudukan menjadi topik menarik dalam pembangunan, karena indikator demografi memegang peran penting dalam pembangunan manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan perspektif yang luas dan komprehensif dalam memahami keterkaitan antara pembangunan dan kependudukan. Sebagai subjek pembangunan, penduduk harus menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, sehingga integrasi antara penduduk dan pembangunan dapat tercapai secara harmonis.

Publikasi “Statistik Demografi Indonesia” disajikan secara menarik dan komprehensif. Publikasi ini membahas tren indikator kependudukan yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, distribusi, struktur umur, serta indikator fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sumber data berasal dari hasil Sensus Penduduk 1961 hingga Long Form Sensus Penduduk 2020, juga hasil SUPAS 1995 hingga SUPAS 2015. Selain itu, potret kependudukan di Daerah Otonomi Baru (DOB) turut disajikan untuk memberikan gambaran kondisi kependudukan di 6 (enam) provinsi baru di wilayah DOB, dengan harapan dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui upaya kita dalam berkontribusi membangun bangsa melalui penyediaan informasi dan analisis data berkualitas.

Jakarta, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



Ringkasan Eksekutif

Publikasi statistik demografi merupakan upaya untuk mengulas secara komprehensif dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia. Dengan mengandalkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk (SP) maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), publikasi ini menyoroti beragam aspek penting terkait penduduk Indonesia, mulai dari tren kependudukan yang meliputi pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan migrasi internal, hingga struktur kependudukan yang mencakup distribusi usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Selain itu, indikator demografi kunci seperti fertilitas, mortalitas, dan mobilitas juga menjadi fokus utama dalam pembahasan, yang didukung oleh analisis mendalam dan interpretasi yang memperkuat pemahaman tentang perubahan demografi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai upaya mengakomodir kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di wilayah pemekaran yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disebut sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), publikasi ini menyajikan jumlah penduduk pada setiap provinsi, serta indikator demografi yang terdiri dari fertilitas, mortalitas dan migrasi hasil Long Form SP2020.

Kondisi terkini kependudukan di Indonesia beserta dengan tren yang digambarkan dan disajikan secara menarik pada publikasi ini dapat membantu banyak pihak dalam memahami keadaan kependudukan yang dapat digunakan pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung berbagai kebijakan.



Daftar Isi

Statistik Demografi Indonesia

(Hasil Sensus Penduduk 2020)

halaman

Tim Penyusun.....	III
Kata Pengantar	V
Ringkasan Eksekutif	VII
Daftar Isi	IX
Daftar Gambar	XVII
Daftar Lampiran.....	XXI

Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Data Kependudukan dan Pembangunan	3
1.2 Peran Parameter Demografi dalam Pembangunan	4

Bab 2 Penduduk Indonesia.....	9
2.1 Tren Penduduk Indonesia	11
2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	14
2.3 Distribusi Penduduk	17
2.4 Kepadatan Penduduk	19
2.5 Struktur dan Karakteristik Penduduk	25

Bab 3 Fertilitas Indonesia.....	33
3.1 <i>Crude Birth Rate (CBR)</i>	35
3.2 <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	37
3.3 <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR)</i>	41



Bab 4 Mortalitas Indonesia 45

4.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	48
4.2	Umur Harapan Hidup (UHH)	51
4.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	55
4.4	Angka Kematian Anak	58
4.4	Angka Kematian Balita (AKBA)	58

Bab 5 Mobiltas Penduduk 57

5.1	Migrasi Risen.....	59
5.2	Migrasi Seumur Hidup.....	71

Bab 6 Indikator Daerah Otonomi Baru di Papua 93

6.1	Penduduk.....	95
6.2	Rasio Ketergantungan.....	102
6.3	Angka Kematian Balita (AKBA)	115
6.4	Angka Kematian Bayi (AKB).....	117
6.5	Angka Kelahiran Total (TFR)	119
6.6	Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup	121
6.7	Jumlah Migran Keluar Seumur Hidup	122
6.8	Jumlah Migran Neto Seumur Hidup	124
6.9	Jumlah Migran Masuk Risen.....	126
6.10	Jumlah Migran Keluar Risen	128
6.11	Jumlah Migran Neto Risen	129
6.12	<i>Maternal Mortality Ratio</i> (MMR)	131
6.13	Umur Harapan hidup (UHH)	133

Bab 7 Penutup 143



Daftar Pustaka	132
Lampiran	136

<https://www.bps.go.id>



Daftar Gambar

halaman

Gambar 2.1	Penduduk Indonesia, Tahun 1961–1971, 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2010, dan 2010–2020	11
Gambar 2.2	Lima Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, 2020	12
Gambar 2.3	Penduduk di Negara Anggota ASEAN (juta jiwa)	13
Gambar 2.4	Tren Jumlah Penduduk di Negara Anggota ASEAN (juta jiwa)	13
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Tahun 1961–1971, 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2010, dan 2010–2020	15
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia menurut Provinsi, 2010–2020...	16
Gambar 2.7	Tiga Provinsi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Terendah, 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2010, dan 2010–2020	16
Gambar 2.8	Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Tertinggi dan Terendah, 2020	17
Gambar 2.9	Tren Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Tertinggi (juta jiwa), 1971–2020	18
Gambar 2.10	Penduduk Indonesia Menurut Pulau, 2020	19
Gambar 2.11	Kepadatan Penduduk Indonesia, 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020	20
Gambar 2.12	Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, 2020	21
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Hasil SP2020.....	22
Gambar 2.14	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia, 1971–2020.....	23
Gambar 2.15	Kepadatan Penduduk Indonesia, 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020	23
Gambar 2.16	Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Generasi, 2020.....	24
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Indonesia, tahun 1971–2020.....	26
Gambar 2.18	Rasio Ketergantungan di Indonesia, hasil SP1971–SP2020	28
Gambar 2.19	Rasio Ketergantungan Umur Muda (0-14 Tahun), hasil SP1971–SP2020..	29
Gambar 2.20	Rasio Ketergantungan Umur Tua (65 Tahun ke Atas) Indonesia, Hasil SP1971–SP2020.....	29



	halaman
Gambar 2.21 Persentase Penduduk Usia Lanjut (60 Tahun ke Atas) Indonesia, Hasil SP1971-SP2020	30
Gambar 2.22 Piramida Penduduk Indonesia, tahun 1971-2020	31
Gambar 3.1 Angka Kelahiran Total (TFR) Hasil <i>Long Form</i> SP2020	36
Gambar 3.2 Tren Angka Kelahiran Total (TFR)	38
Gambar 3.3 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) Hasil <i>Long Form</i> SP2020	39
Gambar 3.4 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (15-19 tahun) Menurut Provinsi Hasil <i>Long Form</i> SP2020	42
Gambar 3.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (15-19 tahun) Menurut Provinsi Hasil <i>Long Form</i> SP2020	43
Gambar 4.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Indonesia, 1971-2020	49
Gambar 4.2 Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia, SP1971-LF SP2020	51
Gambar 4.3 Perkembangan Umur Harapan Hidup di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan SP1971-LF SP2020	52
Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Hasil <i>Long Form</i> SP2020	52
Gambar 4.5 Tren Angka Kematian Ibu tahun 2010-2020	56
Gambar 4.6 Angka Kematian Ibu Menurut Provinsi Hasil <i>Long Form</i> SP2020	57
Gambar 4.7 Angka Kematian Anak Menurut Provinsi Hasil <i>Long Form</i> SP2020	60
Gambar 4.8 Angka Kematian Balita Menurut Provinsi Hasil <i>Long Form</i> SP2020	59
Gambar 5.1 Angka Migrasi Masuk Risen (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	67
Gambar 5.2 Angka Migrasi Keluar Risen (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	69
Gambar 5.3 Angka Migrasi Risen Neto Positif (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	71
Gambar 5.4 Grafik Sankey Migrasi Risen di Indonesia 2022	73
Gambar 5.5 Angka Migrasi Masuk Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	80
Gambar 5.6 Angka Migrasi Keluar Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	82
Gambar 5.7 Angka Migrasi Netto Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia, 2022	84



	halaman
Gambar 5.8 Grafik Sankey Migrasi Seumur Hidup Indonesia, 2022	86
Gambar 6.1 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020–2023	95
Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023	97
Gambar 6.3 Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 2020–2023	98
Gambar 6.4 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Selatan, 2020–2023	99
Gambar 6.5 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Tengah, 2020–2023	100
Gambar 6.6 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Pegunungan, 2020–2023	101
Gambar 6.7 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Barat, 2020–2023	104
Gambar 6.8 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023	105
Gambar 6.9 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua, 2020–2023	107
Gambar 6.10 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Selatan, 2020–2023	108
Gambar 6.11 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tengah, 2020–2023	110
Gambar 6.12 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Pegunungan, 2020–2023	113
Gambar 6.13 Angka Kematian Balita Daerah Otonomi Baru	116
Gambar 6.14 Angka Kematian Bayi (IMR) Daerah Otonomi Baru.....	118
Gambar 6.15 Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah Otonomi Baru Hasil <i>Long Form</i> SP2020.....	120
Gambar 6.16 Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023	122
Gambar 6.17 Jumlah Migran Keluar Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023	124
Gambar 6.18 Jumlah Migran Neto Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023.....	125
Gambar 6.19 Jumlah Migran Masuk Risen DOB Papua, 2020–2023	127
Gambar 6.20 Jumlah Migran Keluar Risen DOB Papua, 2020–2023	129
Gambar 6.21 Jumlah Migran Neto Risen DOB Papua, 2020–2023	131
Gambar 6.22 Angka Kematian Ibu (MMR) DOB Papua, 2020–2023.....	132
Gambar 6.23 UHH Provinsi Papua Barat, 2020–2023	134
Gambar 6.24 UHH Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023.....	136
Gambar 6.25 UHH Provinsi Papua, 2020–2023	137
Gambar 6.26 UHH Provinsi Papua Selatan, 2020–2023.....	138
Gambar 6.27 UHH Provinsi Papua Tengah, 2020–2023	140
Gambar 6.28 UHH Provinsi Papua Pegunungan, 2020–2023	141



<https://www.bps.go.id>





Daftar Lampiran

halaman

Lampiran 1	Penduduk Indonesia (juta jiwa), 1961–2020	153
Lampiran 2	Jumlah Penduduk Negara ASEAN (juta jiwa), 1961–2020	154
Lampiran 3	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk, 1961–2020	155
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2020, dan 2010–2020	156
Lampiran 5	Angka Kelahiran Kasar (CBR) Hasil LF SP2020	157
Lampiran 6	Tren Angka Kelahiran Total (TFR) dari SP1971–LF SP2020	158
Lampiran 7	Penduduk Indonesia Menurut Provinsi (ribu jiwa), 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2020, dan 2010–2020	159
Lampiran 8	Penduduk Indonesia Menurut Pulau, 2020	160
Lampiran 9	Tren Angka Kelahiran Menurut Umur Tertentu (ASFR) dari SP 1971–LF SP2020	161
Lampiran 10	Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Laki-Laki)	166
Lampiran 11	Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Perempuan)	167
Lampiran 12	Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Total)	168

1

Pendahuluan





Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi saat ini memberikan ruang bagi studi demografi menjadi semakin relevan dalam pemahaman struktur dan karakteristik penduduk suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang beragam secara etnis, budaya, dan agama, menawarkan konteks demografi yang unik terdiri dari 17.001 pulau (BPS, 2024) dan menurut hasil *Long Form* SP2020 terdapat lebih dari 1200 suku yang berbeda. Indonesia menyajikan tantangan dan peluang bagi berkembangnya analisis demografi. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang pesat, perubahan pola migrasi, serta perbedaan dalam tingkat fertilitas dan umur harapan hidup menjadi beberapa aspek penting yang dapat memengaruhi dinamika demografi Indonesia.

1.1 Data Kependudukan dan Pembangunan

Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi, yaitu periode di mana proporsi anak-anak di bawah 15 tahun terus menurun, sedangkan untuk proporsi penduduk usia 15–64 tahun meningkat cukup cepat dan kenaikan proporsi penduduk lansia masih lamban (Adioetomo, 2018). Bonus demografi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan pada sisi ekonomi dan sosial. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan data kependudukan yang akurat dan terkini. Data ini dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan dalam mengelola bonus demografi memerlukan investasi yang tepat dalam pendidikan, pelatihan tenaga kerja, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Berdasarkan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional) tahun 2020–2024 salah satu target pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat tata kelola kependudukan dan kesehatan dimana tidak terlepas dari pembahasan parameter demografi yang dapat menggambarkan dinamika kependudukan saat ini di Indonesia. Indonesia yang telah masuk kedalam fase transisi demografi dan terjadinya bonus demografi yang diharapkan dapat membuat Indonesia dapat mencapai target-target dalam RPJMN.

Hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat ke-4 penduduk terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan momentum bonus demografi diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah sebaik mungkin dengan penerapan kebijakan yang tepat dalam merespon kondisi demografi tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penting keanggotaan Indonesia dalam G20, selain karena pertumbuhan ekonomi yang pesat juga dikarenakan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Selain itu posisi Indonesia semakin kuat sebagai pemimpin ASEAN. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN di G20, Indonesia membawa suara dan kepentingan negara-negara berkembang di kawasan. Memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keahlian angkatan kerja. Memastikan pemerataan pembangunan agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang kuat menjadi salah satu keunggulan Indonesia di kancah internasional, termasuk dalam keanggotaannya di G20. Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan ekonomi global.



Peran serta penduduk pada suatu negara sangat mempengaruhi proses pembangunan, kualitas penduduk yang baik dapat mempercepat tercapainya pembangunan karena semakin banyak penduduk maka akan menambah tenaga kerja dan penduduk yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan (Burhanuddin, dkk, 2020). Kualitas penduduk dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena semakin baik kualitas penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa yang mendukung pembangunan negara (Wahyuningrum & Soesilowati, 2021)

Ilmu kependudukan adalah sebuah hasil penggabungan dari berbagai disiplin ilmu sosial yang memfokuskan kajiannya pada isu-isu kependudukan. Kesadaran akan perlunya pengembangan ilmu kependudukan karena dibutuhkan solusi untuk penyelesaian persoalan-persoalan mengenai kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk yang cepat, tingginya angka kematian dan tidak meratanya penduduk secara geografis. Karena isu kependudukan yang terjadi dapat berpengaruh kepada kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat (Rahadian dan Handayani, 2020)

Data kependudukan yang akurat dan terkini menyediakan informasi penting tentang struktur dan dinamika penduduk, seperti jumlah, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan distribusi geografis memegang peranan krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, visi ambisius bangsa untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing pada tahun 2045. Merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok penduduk, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu data kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penduduk di berbagai wilayah. Data kependudukan dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

1.2 Peran Data Demografi dalam Pembangunan

Memahami dinamika kependudukan menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan bangsa. Indonesia, dengan populasi besar dan beragam, memiliki potensi luar biasa untuk mencapai kejayaan. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan dengan strategi yang tepat dan terukur. Variabel penduduk memegang peranan dalam analisis pembangunan karena pengambil kebijakan yang memperhatikan masalah kependudukan di wilayahnya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam suatu perencanaan pembangunan ekonomi (Heryanah, 2015).

Arah kebijakan dalam mewujudkan target pembangunan kependudukan tertuang dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang memiliki tujuan utama yaitu tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Terdapat 5 pilar dalam GDPK dimana keseluruhan pilar mengarah pada peningkatan pada bidang kependudukan yang sangat berkaitan erat pada parameter demografi.



Salah satu tujuan utama Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Data kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antara wilayah dan kelompok penduduk. Pada umumnya beberapa masalah dalam pembangunan berkelanjutan berasal dari masalah kependudukan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat kelahiran, penurunan tingkat kematian, peningkatan kualitas penduduk dan persebaran penduduk seperti mobilitas penduduk yang dimana nantinya akan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan berkualitas. (Bidarti, 2020). Pencapaian Indonesia Emas 2045 juga berkaitan erat dengan terjadinya bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan generasi Indonesia emas yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara global, pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membawa Indonesia dalam kancah internasional (Puspa,dkk, 2023).

Penurunan fertilitas yang diiringi dengan menurunnya kematian mengindikasikan terjadinya transisi demografi yang menyebabkan perubahan struktur demografi pada suatu populasi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi serta pertumbuhan populasi yang lambat ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah serta pertumbuhan populasi yang cepat. Transisi demografi pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya bonus demografi yang dapat memberikan keuntungan bagi negara yang mendapatkannya bila dapat memanfaatkan dengan tepat kesempatan tersebut.

Parameter demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan mobilitas memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Ketiga hal tersebut memberikan informasi penting yang membantu dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Adanya integrasi data fertilitas, mortalitas, dan mobilitas memungkinkan pemerintah untuk membuat perencanaan yang lebih akurat dan terinformasi. Hal tersebut membantu dalam mengidentifikasi tren demografi yang memerlukan perhatian khusus dan merespons dengan kebijakan yang tepat. Data terkait parameter demografi tersebut memungkinkan pemerintah dalam merancang kebijakan sosial yang lebih efektif misalkan pada program kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ataupun program lainnya yang mendukung kebijakan pembangunan. Selain itu, data parameter demografi juga digunakan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan yaitu dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sumber daya di masa depan, sehingga pemerintah dapat merencanakan penggunaan sumber daya yang tepat.

Data fertilitas yang mencakup beberapa indikator seperti angka kelahiran kasar, angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu, angka kelahiran total memiliki implikasi signifikan untuk berbagai sektor pembangunan. Data fertilitas memungkinkan pemerintah untuk memperkirakan jumlah anak yang akan memasuki usia sekolah di masa mendatang. Dengan informasi terkait dengan jumlah anak yang lahir setiap tahun, pemerintah dapat merencanakan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk jumlah ruang kelas, sekolah baru, dan kebutuhan tenaga pengajar. Data fertilitas juga dapat digunakan dalam program kesehatan ibu dan anak untuk memastikan kehamilan, kelahiran yang aman dan anak-anak yang sehat. Pemerintah dapat menggunakan data fertilitas untuk mengidentifikasi daerah dengan angka kelahiran yang tinggi dan bagaimana menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan, seperti klinik prenatal dan postnatal, serta program imunisasi untuk bayi dan anak-anak.



Pembangunan ekonomi juga didukung oleh data fertilitas khususnya terkait dengan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat fertilitas yang stabil atau meningkat dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif, yang berdampak positif pula pada produktivitas ekonomi. Namun, hal tersebut juga berarti bahwa pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang cukup dan memastikan bahwa angkatan kerja yang baru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pengendalian penduduk menjadi salah satu program pembangunan yang tidak kalah penting juga memerlukan informasi terkait data fertilitas. Dengan adanya informasi terkait data fertilitas, pemerintah dapat membantu keluarga dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan dan mengatur jarak kelahirannya, yang tentunya bertujuan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya yang ada.

Selain fertilitas, data terkait mortalitas yang mencakup angka kematian anak, kematian ibu, ataupun umur harapan hidup memiliki informasi yang sangat penting dalam aspek perencanaan pembangunan. Data mortalitas membantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam merancang program kesehatan dan intervensi yang tepat untuk mengurangi angka kematian. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka kematian pada bayi, anak, ataupun ibu akibat penyakit tertentu, pemerintah dapat memfokuskan upaya pada pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang baik dan layanan kesehatan yang efektif. Data tersebut memengaruhi kebijakan terkait pensiun, perawatan lansia, dan program kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat merencanakan sistem pensiun yang berkelanjutan dan program kesehatan lansia yang memadai berdasarkan harapan hidup penduduk tersebut.

Informasi tentang data mortalitas dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur kesehatan. Dengan mengetahui daerah-daerah dengan tingkat kematian bayi, anak, ataupun ibu yang tinggi, pemerintah dapat memastikan bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan tersedia dan sudah diakses oleh penduduk. Data mortalitas juga digunakan untuk menilai efektivitas program kesehatan yang ada. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan, menentukan apakah program tersebut berhasil mengurangi angka kematian bayi, anak, ataupun ibu, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Data mobilitas seperti migrasi risen maupun seumur hidup memiliki banyak aspek dalam perencanaan pembangunan. Data mobilitas tersebut memberikan wawasan penting tentang pergerakan penduduk dan dampaknya terhadap berbagai sektor. Migrasi risen ataupun seumur hidup memengaruhi pertumbuhan kota dan penyediaan layanan dasar seperti perumahan, air bersih, dan sanitasi. Dengan memahami pola migrasi risen ataupun seumur hidup, pemerintah dapat merencanakan pengembangan infrastruktur perkotaan yang memadai, memastikan bahwa kota-kota mampu menampung pertumbuhan penduduk yang pesat.



Data mobilitas juga memengaruhi pasokan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Data mobilitas membantu dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan keterampilan migran dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal tersebut menjadi penting bahwa migran dapat berkontribusi secara produktif dalam ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Data tersebut juga digunakan untuk memastikan keseimbangan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk mengurangi tekanan sumber daya di kota besar dan mendorong pembangunan di daerah perdesaan. Hal tersebut membantu mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

<https://www.bps.go.id>

2

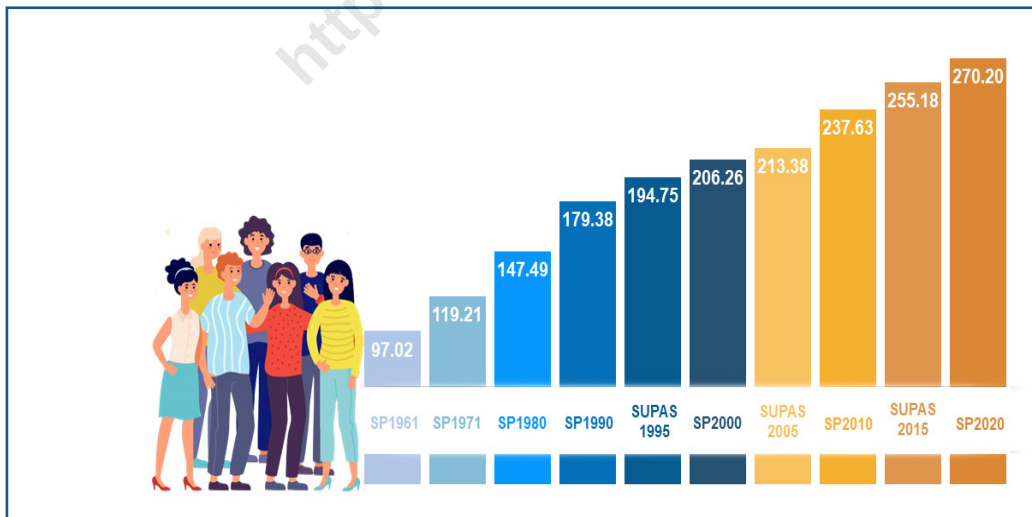
Penduduk Indonesia





2.1 Penduduk Indonesia

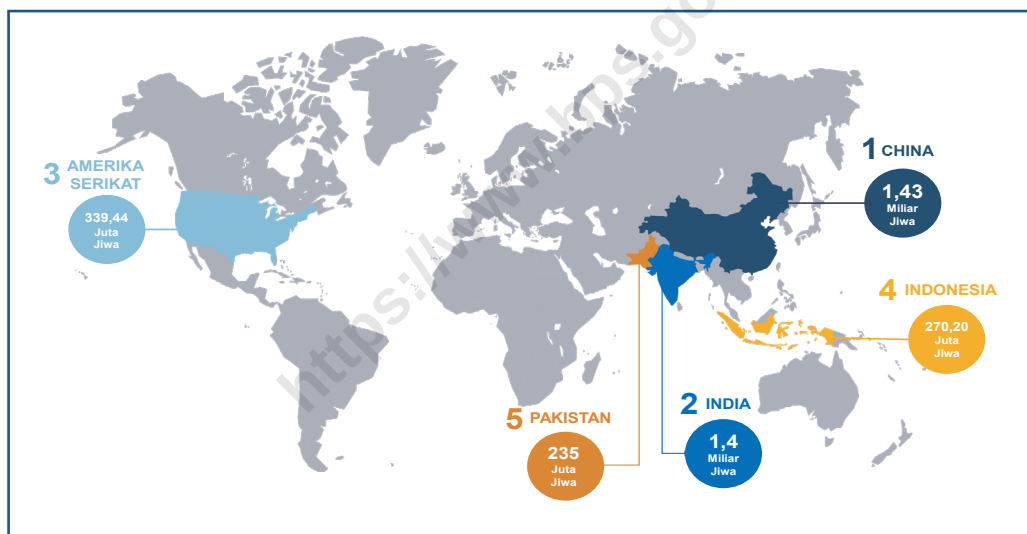
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah 270.203.917 jiwa. Definisi penduduk Indonesia dalam SP2020 adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya, referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Dibandingkan dengan sensus dan survei periode sebelumnya, jumlah penduduk Indonesia telah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa dekade mendatang, karena peningkatan rata-rata angka harapan hidup, dan tingkat fertilitas yang masih tinggi di beberapa daerah. Selama periode 1961-2020, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 97,02 juta jiwa pada 1961 menjadi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020. Dengan demikian, dalam kurun waktu sekitar setengah abad, penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak hampir tiga kali lipat. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 32,56 juta jiwa, yaitu dari 237,63 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020 (Gambar 2.1). Populasi penduduk dapat menjadi potensi maupun beban bagi suatu negara. Populasi penduduk menjadi potensi jika jumlahnya seimbang dengan sumber daya yang tersedia dan memiliki kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, penduduk menjadi beban jika jumlahnya melebihi kapasitas wilayah negara tersebut. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dan terus-menerus tanpa diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan sebagainya merupakan masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya.



Gambar 2.1 Penduduk Indonesia, Tahun 1961-1971, 1971-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010, dan 2010-2020



Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk di dunia juga ikut mengalami pertumbuhan. Dilansir dari World Population Prospects 2024, jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 mencapai 7,89 milyar jiwa. Jumlah tersebut tersebar di negara-negara di dunia, dan terus bertambah setiap detik. Dari seluruh negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak, yaitu dengan angka 270,02 juta jiwa. Posisi pertama negara dengan penduduk terbanyak di dunia masih ditempati oleh China dengan jumlah populasi sebanyak 1,43 milyar jiwa, diikuti oleh India (1,4 milyar jiwa), Amerika Serikat (339,44 juta jiwa), dan Pakistan (235 juta jiwa), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. Ledakan penduduk telah menyebabkan berbagai permasalahan di seluruh dunia. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui badan yang menangani masalah kependudukan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Namun demikian, kebijakan mana yang paling baik dan efektif untuk dilakukan, sampai saat ini masih terus dicari dan diperdebatkan dalam berbagai konferensi.



Catatan: Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP2020

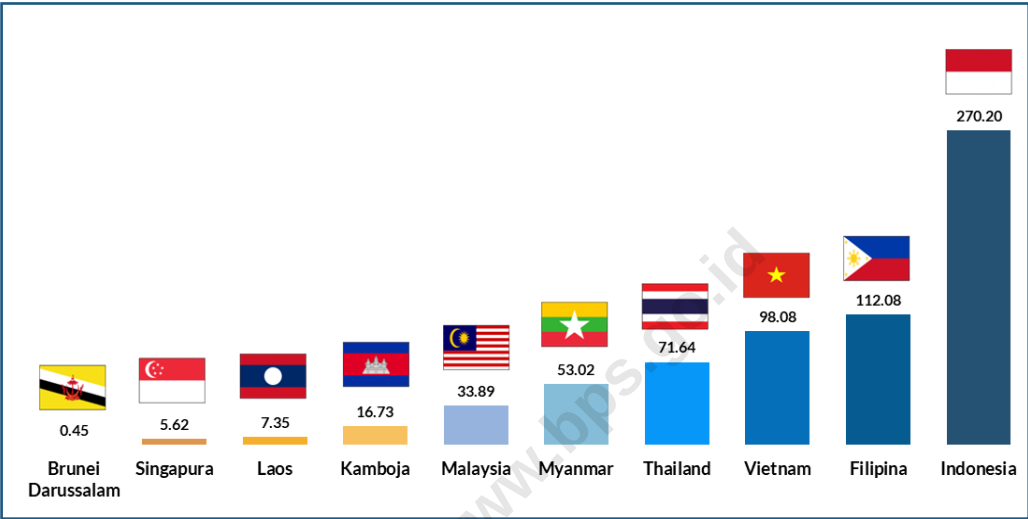
Sumber: UN, World Population Prospects 2024

Gambar 2.2 Lima Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, 2020

Pada tahun 2020, jika dibandingkan antara negara anggota ASEAN (gambar 2.3), Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 270,20 juta jiwa. Angka ini sangat jauh bila dibandingkan dengan Filipina yang menduduki posisi kedua dengan populasi penduduk paling banyak. Thailand dan Myanmar secara berurutan memiliki jumlah penduduk 71,64 juta jiwa dan 53,02 juta jiwa. Sementara itu, negara dengan penduduk paling sedikit di ASEAN adalah Brunei Darussalam, yaitu sebanyak 447 ribu jiwa. Apabila dilihat perkembangannya selama tahun 1961-2020, Indonesia masih menduduki peringkat pertama sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya (Gambar 2.4).



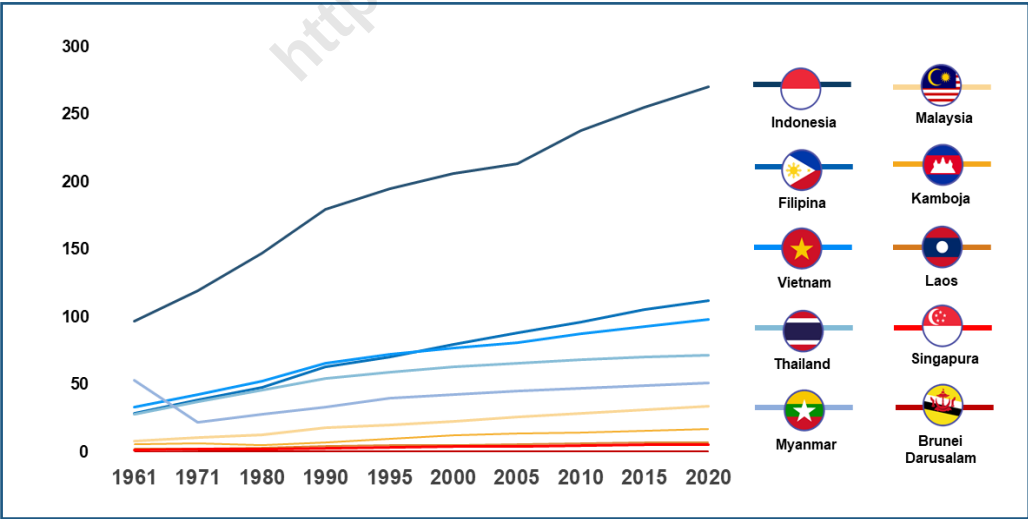
Jika dipadankan dengan Filipina pun, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk kedua terbanyak di antara negara ASEAN, Indonesia masih memiliki jumlah penduduk lebih dua kali lipatnya. Bahkan, jika disandingkan dengan Brunei Darussalam, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 600 kali lipat jumlah penduduk dari negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di ASEAN tersebut.



Catatan: Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP2020

Sumber: UN, World Population Prospects 2024

Gambar 2.3 Penduduk di Negara Anggota ASEAN (juta jiwa)



Catatan: Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, 2005, 2015

Sumber: UN, World Population Prospects 2024

Gambar 2.4 Tren Jumlah Penduduk di Negara Anggota ASEAN (juta jiwa)



2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.

Rumus LPP adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

Keterangan:

r : Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

P_t : Jumlah penduduk tahun t

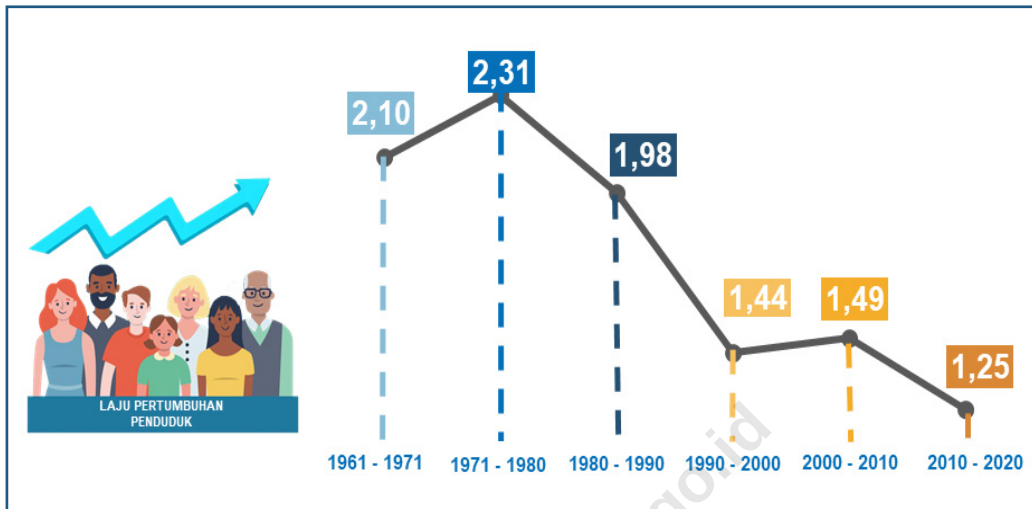
P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Laju pertumbuhan penduduk digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Interpretasi LPP adalah sebagai berikut:

- LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP $= 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP < 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

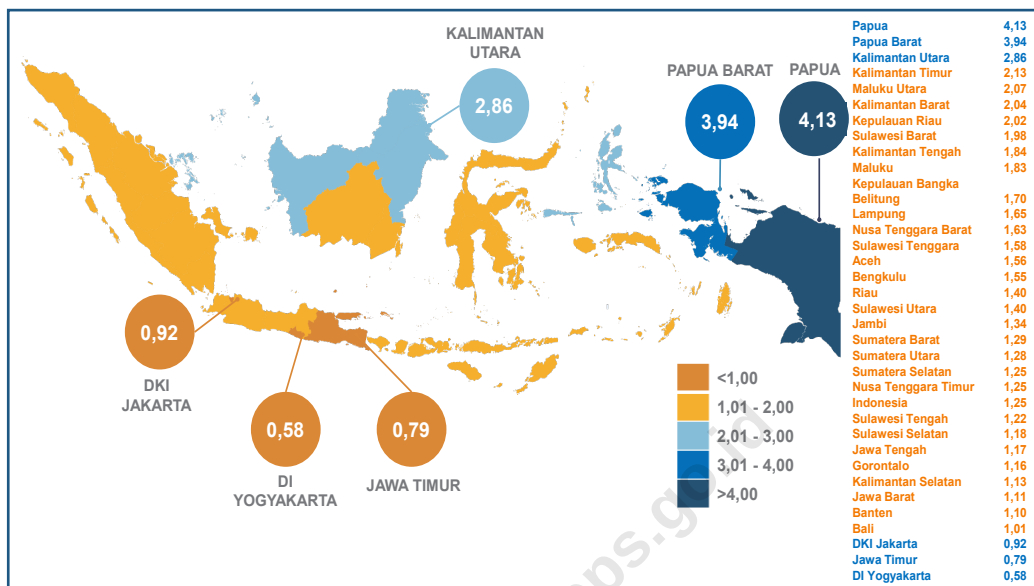
Gambar 2.5 menyajikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1961 hingga tahun 2020. Selama periode ini, pertumbuhan penduduk pertama-tama meningkat dan kemudian perlahan-lahan mengalami perlambatan. Pada periode 1961-1971, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu sebesar 2,10 persen per tahun. Angka ini mengalami fluktuasi dan melambat dalam beberapa dekade terakhir hingga pada periode 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi sebesar 1,25 persen. Dibandingkan dengan periode 2000-2010, terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen poin, yaitu dari 1,49 persen pada periode 2000-2010, menjadi sebesar 1,25 persen pada periode 2010-2020, dan diperkirakan akan terus melambat. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah jumlah penduduk dan kekuatan yang mengurangnya. Penduduk secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, dan secara bersamaan akan dikurangi oleh jumlah kematian. Faktor migrasi juga memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan penduduk. Kontribusi dari ketiga variabel ini menentukan pertumbuhan penduduk pada saat ini, termasuk karakteristik dan distribusinya akan menentukan tren di masa depan.



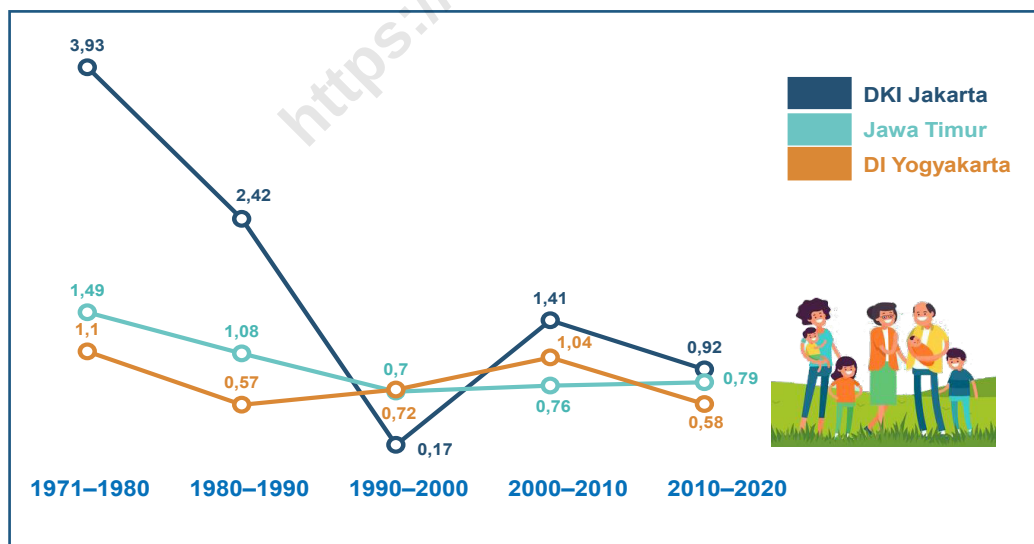
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Tahun 1961-1971, 1971-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010, dan 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk bervariasi antar provinsi di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah tantangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial dan ekonomi, terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas. Meskipun hal ini merupakan salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi pembangunan, namun pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus berlanjut akan memperbesar tantangan yang ada, seperti penghapusan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang layak dan bergizi. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat juga menjadi tantangan dalam mengakhiri penyakit dan kondisi yang dapat dicegah dan diobati, memastikan pendidikan yang inklusif dan adil, serta mempromosikan pekerjaan yang produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua (UN DESA, 2021).

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan salah satu gejala dari pembangunan yang lambat. Berdasarkan gambar 2.6, provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tercepat pada 2010-2020 antara lain Provinsi Papua (4,13 persen), Provinsi Papua Barat (3,94 persen), dan Provinsi Kalimantan Utara (2,86 persen). Provinsi-provinsi tersebut memerlukan anggaran yang besar dalam memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi, serta memastikan kemudahan akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pertumbuhan penduduk yang cepat menambah urgensi untuk memperbesar skala investasi dan menambah upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita.



Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, 2010–2020



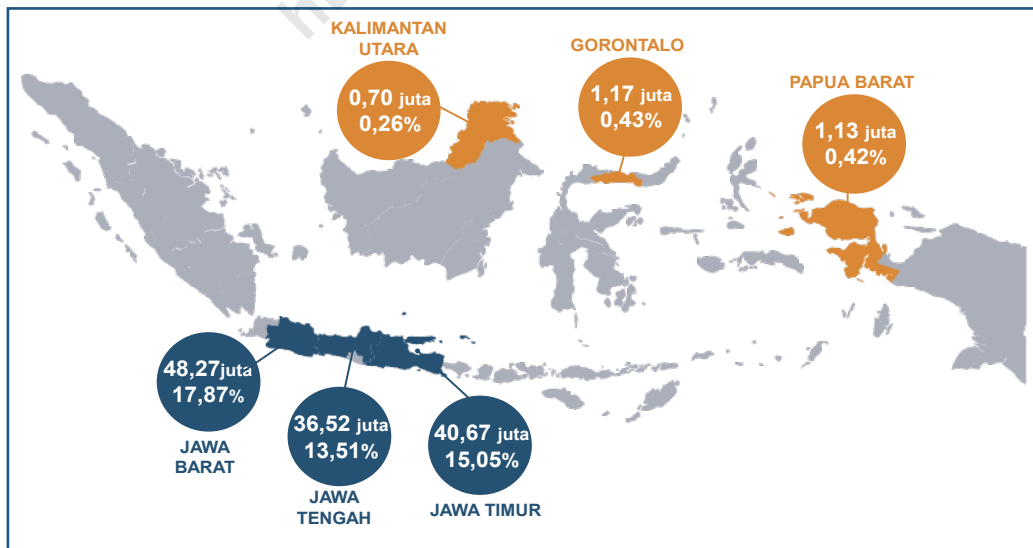
Gambar 2.7 Tren Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tiga Provinsi Terendah, Tahun 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2020, dan 2010–2020



2.3 Distribusi Penduduk

2.3.1 Penduduk Menurut Provinsi

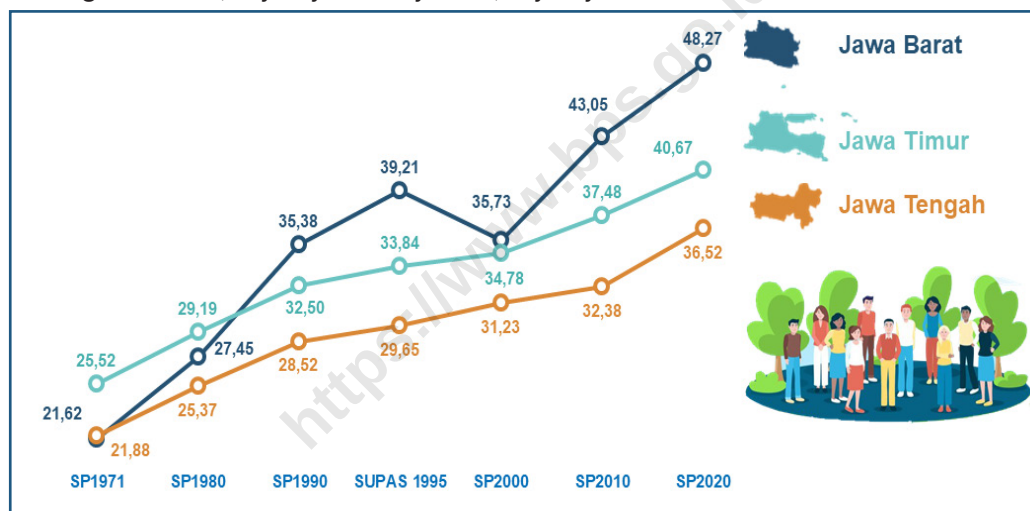
Berbagai perubahan kependudukan yang terjadi dalam jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, akan memengaruhi berbagai aspek dalam pembangunan. Selanjutnya, perubahan pada aspek pembangunan akan memengaruhi perubahan dalam tiga aspek elemen pokok kependudukan, yaitu perubahan dalam angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Perubahan pada ketiga elemen tersebut juga akan memengaruhi perubahan dalam jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk (Prihastuti, 2000). Tujuan pembangunan adalah untuk tercapainya kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Namun demikian yang terjadi selama ini, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung menitikberatkan pada pembangunan yang terpusat di Jawa. Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduk berada di wilayah pulau Jawa. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8, bahwa tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan hasil SP2020 adalah Provinsi Jawa Barat yaitu 48,27 juta jiwa atau 17,87 persen dari total penduduk Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur yaitu 40,67 juta jiwa (15,05 persen), dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 36,52 juta jiwa (13,51 persen). Di sisi lain, provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara yaitu 0,70 juta jiwa (0,26 persen), Provinsi Papua Barat yaitu 1,13 juta jiwa (0,42 persen), dan Provinsi Gorontalo yaitu 1,17 juta jiwa (0,43 persen dari total penduduk Indonesia). Jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia timur cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk provinsi-provinsi di wilayah Indonesia barat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan seluruh penduduk tanpa terkecuali.



Gambar 2.8 Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Tertinggi dan Terendah, 2020



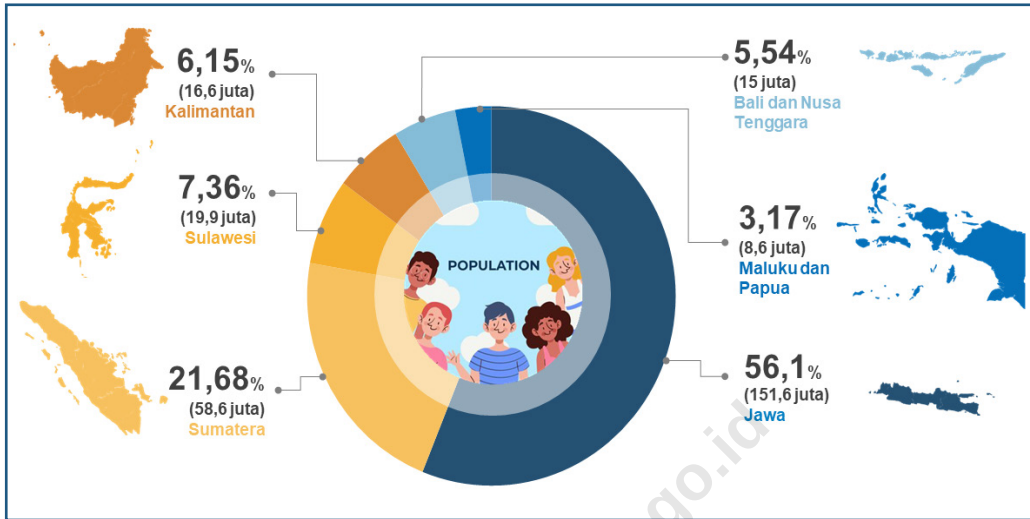
Terdapat kecenderungan bahwa aktivitas ekonomi akan terpusat pada daerah yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan antara konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan semakin membesarnya jumlah penduduk yang terkonsentrasi di area tersebut. Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan wilayah yang luas, namun aktivitas ekonomi saat ini masih cenderung terpusat di wilayah Jawa. Di samping itu, arus migrasi penduduk juga cenderung terpusat ke daerah yang relatif padat penduduknya, seperti Pulau Jawa. Hal ini tercermin dari Gambar 2.9 yang menunjukkan tren dari tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, dan jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada periode 1971-2020, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat terus meningkat dari 21,62 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 48,27 juta jiwa pada tahun 2020. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur meningkat dari 25,52 juta jiwa menjadi 40,67 juta jiwa. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk meningkat dari 21,88 juta jiwa menjadi 36,52 juta jiwa.



Gambar 2.9 Tren Tiga Provinsi dengan Jumlah Penduduk Tertinggi (juta jiwa), 1971–2020

2.3.2 Penduduk Menurut Pulau

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penduduk Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun luasnya secara geografis hanya mencakup sekitar tujuh persen dari total luas wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta orang atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia. Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan distribusi penduduk terbesar kedua dengan jumlah 58,56 juta orang, setara dengan 21,68 persen. Pulau Sulawesi memiliki distribusi sebesar 7,36 persen, sementara Pulau Kalimantan sebesar 6,15 persen. Wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing memiliki distribusi penduduk sebesar 5,54 persen dan 3,17 persen (Gambar 2.10). Persebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.



Gambar 2.10 Penduduk Indonesia Menurut Pulau, 2020

2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis:

- Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi luas wilayah.
- Kepadatan Fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan jumlah penduduk per kilometer persegi lahan yang ditanami (*cultivable land*).
- Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan jumlah penduduk petani per kilometer persegi *cultivable land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah.

Rumus kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

$$KP = \frac{P}{A}$$

Keterangan:

KP : Kepadatan penduduk

P : Jumlah penduduk

A : Luas wilayah (km²)

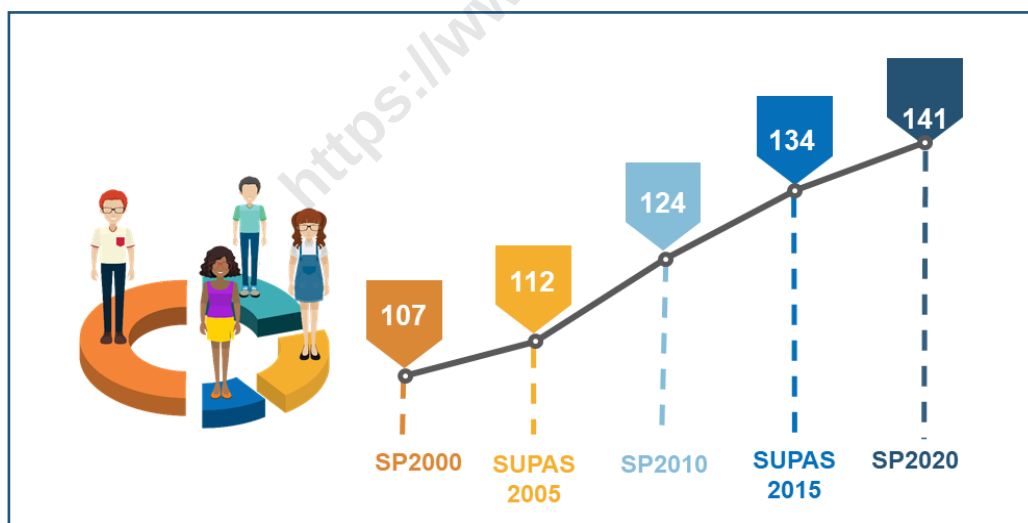


Kepadatan penduduk digunakan untuk:

- Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah.
- Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi).

Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

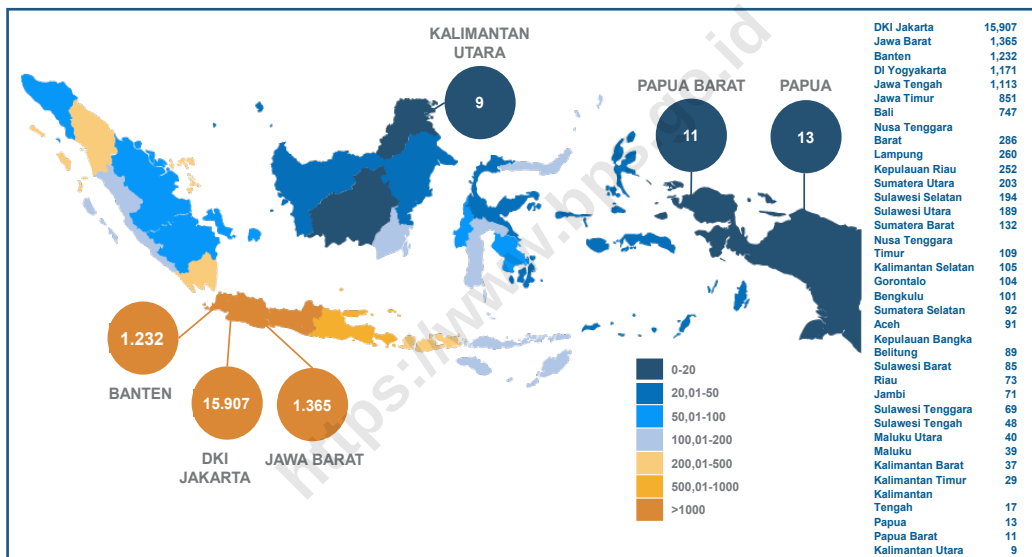
Kepadatan penduduk Indonesia pada periode 2000-2020 disajikan oleh Gambar 2.11. Hasil SP2000 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia sebesar 107 jiwa per kilometer persegi. Artinya, ada sebanyak 107 orang yang tinggal di setiap satu kilometer persegi wilayah Indonesia. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 141 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020, meningkat dari 134 orang per kilometer persegi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, semakin padat jumlah penduduk yang mendiami wilayah Indonesia. Jika kondisi ini terus menerus berlanjut, luas wilayah Indonesia tidak akan dapat lagi mencukupi kebutuhan akan lahan pemukiman. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial ekonomi, seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, kurangnya fasilitas sosial dan kesehatan, serta tidak memadainya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja (Christiani, Tedjo, & Martono, 2014).



Gambar 2.11 Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020



Kepadatan penduduk di suatu daerah mencerminkan penyebaran lokasi dimana penduduk bermukim. Urbanisasi yang pesat dari desa ke kota menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di suatu daerah, sehingga kepadatan penduduk di suatu negara tidak merata. Fakta menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Indonesia relatif kurang merata, masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi di Indonesia bagian barat, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.12. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta sudah sangat tinggi, yaitu mencapai 15.907 jiwa per kilometer persegi, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (1.365 jiwa per meter persegi), dan Provinsi Banten (1.232 jiwa per kilometer persegi). Sementara itu, provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kalimantan Utara, yaitu hanya 9 jiwa per kilometer persegi. Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah berikutnya adalah Provinsi Papua Barat (11 jiwa per kilometer persegi), dan Provinsi Papua (13 jiwa per kilometer persegi).



Gambar 2.12 Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, 2020

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat memengaruhi kualitas hidup dari masyarakatnya. Pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan lebih sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang harus diatasi, seperti masalah sosial dan ekonomi, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, ketersediaan lahan, kebutuhan pangan dan air bersih, serta kerusakan lingkungan (Christiani, Tedjo, & Martono, 2014). Tingginya kepadatan penduduk di provinsi-provinsi Pulau Jawa, khususnya Jakarta, telah menambah beban yang semakin berat. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai masalah lain, seperti kemacetan lalu lintas yang sudah sangat parah, serta meningkatnya polusi udara dan air. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah disparitas kepadatan penduduk adalah pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dengan Pemindahan ibu kota ini, pemerintah memproyeksikan jumlah penduduk di IKN terus meningkat hingga 2045, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan IKN melalui Surat Edaran Nomor: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022.

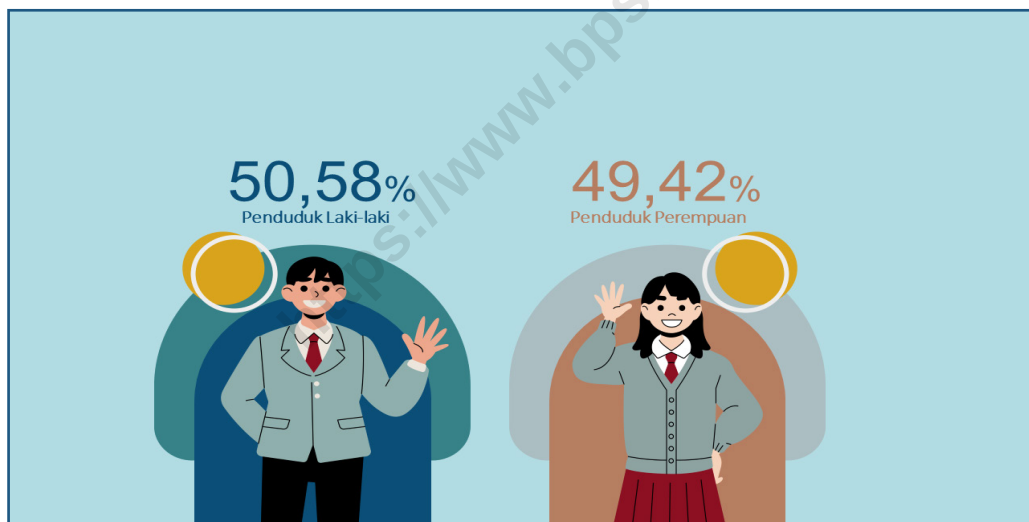


Jumlah penduduk IKN diproyeksikan mencapai 1,91 juta jiwa pada 2040-2045 (Pratiwi, 2023). Namun demikian, pemerintah tetap harus mencari solusi lainnya untuk mengatasi kondisi populasi penduduk di Pulau Jawa, karena pemindahan ibu kota saja tidak cukup dalam mengurangi masalah tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa (Cakti, 2019).

2.5 Struktur dan Karakteristik Penduduk

2.5.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin

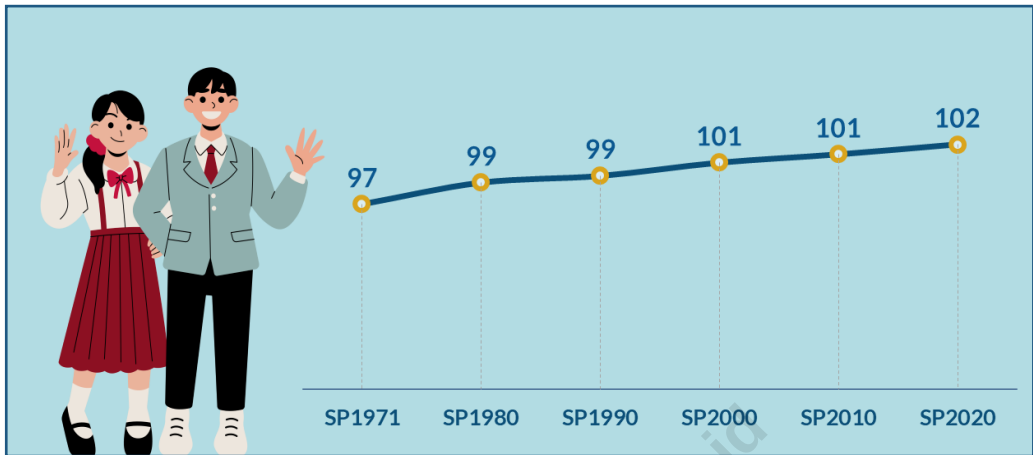
Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk laki-laki di Indonesia mencapai 136,66 juta orang, atau 50,58 persen dari total populasi. Sementara itu, penduduk perempuan tercatat sebanyak 133,54 juta orang, yang setara dengan 49,42 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Indonesia adalah sekitar 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan pada tahun 2020 (Gambar 2.13).



Gambar 2.13 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Indonesia, Hasil SP2020

Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu (Gambar 2.14). Berdasarkan data Sensus Penduduk, rasio jenis kelamin pada tahun 1971 tercatat sebesar 97, yang berarti terdapat 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sepuluh tahun kemudian, hasil Sensus Penduduk 1980 menunjukkan rasio jenis kelamin meningkat menjadi 99. Rasio ini tetap stabil pada angka 99 hingga Sensus Penduduk 1990.

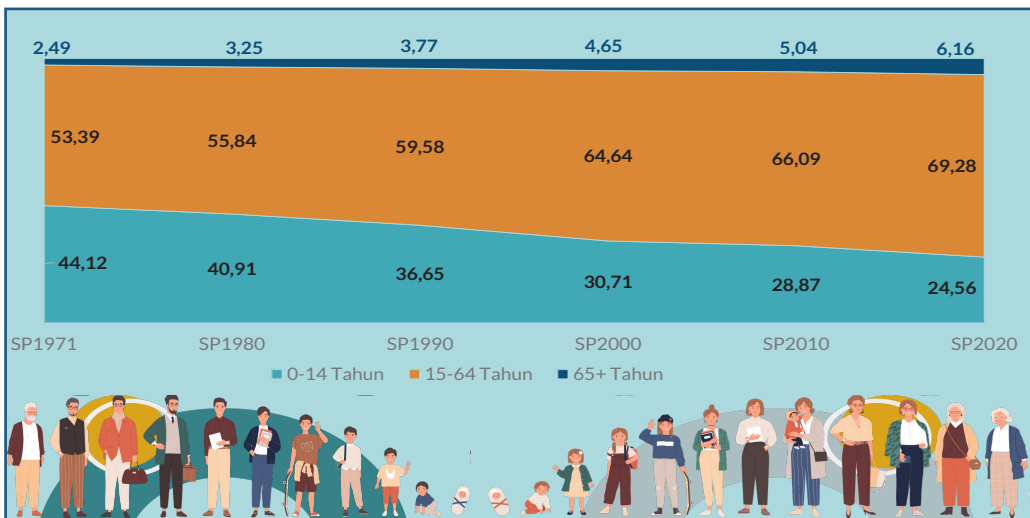
Namun, mulai tahun 2000, terjadi peningkatan lebih lanjut dalam rasio jenis kelamin, dengan hasil Sensus Penduduk mencatat rasio sebesar 101. Angka ini tetap konsisten pada Sensus Penduduk 2010. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin Indonesia kembali meningkat menjadi 102, menunjukkan adanya 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.



Gambar 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia, 1971–2020

2.5.2 Penduduk Menurut Umur

Terdapat tiga kelompok umur besar yang mencerminkan struktur umur penduduk (Gambar 2.15), yaitu kelompok umur 0-14 tahun, kelompok umur 15-64 tahun, dan kelompok umur di atas 65 tahun. Persentase kelompok umur 0-14 tahun lebih dari 40 persen mencerminkan struktur umur muda. Persentase kelompok umur di atas 65 tahun lebih dari 10 persen mencerminkan struktur umur tua. Sementara itu, jika persentase kelompok umur 0-14 tahun kurang dari 40 persen dan kelompok umur di atas 65 tahun kurang dari 10 persen, mencerminkan struktur umur penduduk antara muda dan tua (Samosir & Prihastuti, 2016), Hasil SP1971 dan SP1980 mencatat bahwa Indonesia masih termasuk struktur umur penduduk muda. Sementara sejak SP1990, struktur umur penduduk Indonesia termasuk antara muda dan tua.



Gambar 2.15 Komposisi Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur, 1971–2020

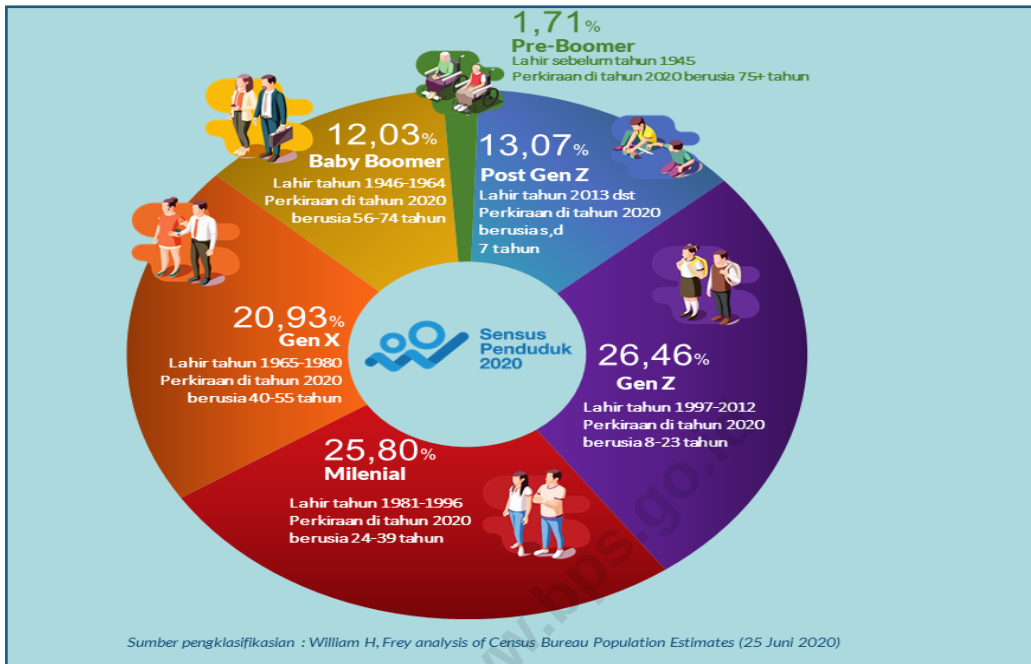


Kelompok umur 0-14 tahun mengalami penurunan persentase dari 44,12 persen pada tahun 1971 menjadi 24,56 persen pada tahun 2020. Penurunan ini mencerminkan angka kelahiran yang menurun, sebagaimana terlihat dari penurunan Total Fertility Rate (TFR) Indonesia dari 5,61 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Selain itu, penurunan persentase kelompok usia 0-14 tahun juga mencerminkan perbaikan dalam bidang kesehatan (Samosir & Prihastuti, 2016), serta bidang pendidikan yang berkontribusi dalam menunda usia pernikahan dan kelahiran anak. World Marriage Data (2019) mencatat bahwa terdapat kenaikan usia rata-rata penduduk Indonesia saat menikah pertama kali. Pada tahun 1971, usia rata-rata perempuan saat menikah pertama kali adalah 19,3 tahun, meningkat menjadi 22,4 tahun pada tahun 2010. Sementara itu, usia rata-rata laki-laki saat menikah pertama kali adalah 23,1 tahun pada tahun 1971, meningkat menjadi 27,1 tahun pada tahun 2017.

Indonesia, seperti kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya, mulai menua secara bertahap (Yeung, 2022). Kelompok usia 65 tahun ke atas di Indonesia meningkat dari 2,49 persen pada tahun 1971 menjadi 6,16 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, kelompok usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan persentase dari 53,39 persen pada tahun 1971 menjadi 69,28 persen pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa bonus demografi, yaitu proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, hal ini akan memberikan potensi keuntungan ekonomi yang besar jika diiringi dengan kebijakan yang tepat.

Pada tahun 2020, lebih dari setengah penduduk Indonesia terdiri dari Generasi Z dan Generasi Milenial (Gambar 2.16). Generasi Z mencakup 26,46 persen dari total populasi, sedangkan Generasi Milenial mencakup 25,80 persen. Pada tahun 2020, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial termasuk dalam kelompok usia produktif (15-65 tahun). Sementara itu, Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif (di bawah 15 tahun) dan usia produktif. Diperkirakan pada sekitar tahun 2027, seluruh Generasi Z akan berada dalam kelompok usia produktif. Mereka berada dalam usia produktif dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perubahan sosial. Kebijakan yang fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan teknologi akan sangat penting untuk memaksimalkan kontribusi mereka. Investasi dalam generasi ini dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Sementara itu, Baby Boomers dan Pre-Boomers, yang bersama-sama mencakup sekitar 13,74 persen dari populasi, menunjukkan adanya populasi lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial.



Catatan:

- Sumber pengklasifikasian : William H. Frey Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 Juni 2020)
- Hasil Perapihan Umur dari Data Administrasi Kependudukan dan Sensus Penduduk 2020 (September)

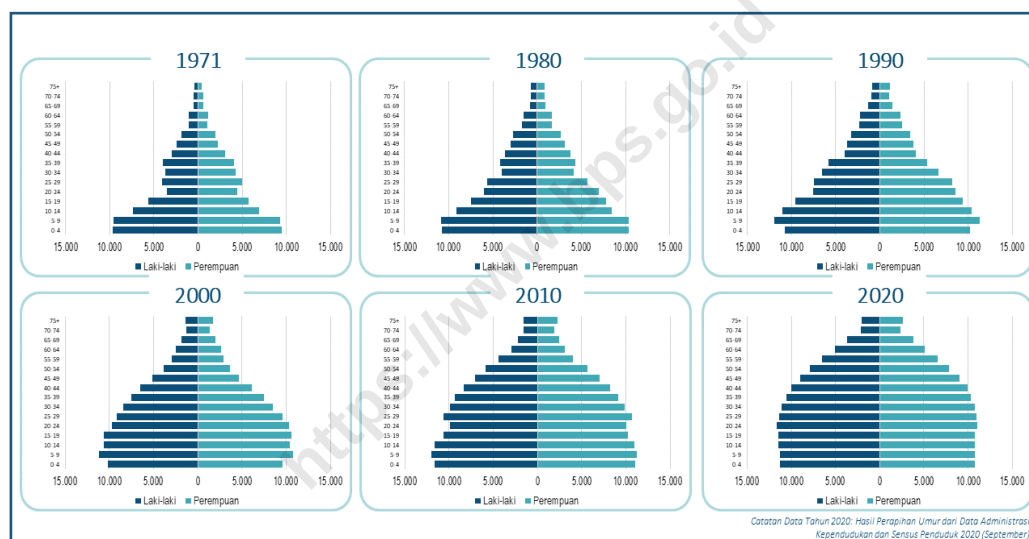
Gambar 2.16 Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Generasi, 2020

2.5.3 Piramida Penduduk

Karakteristik penduduk suatu wilayah dibagi menjadi tiga kelompok menurut umur dan jenis kelamin, yaitu berdasarkan bentuk piramida penduduk (Lembaga Demografi UI, 1981). Tipe pertama adalah Tipe Ekspansif, yaitu jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ekspansif umumnya terdapat pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan kematian tinggi. Tipe kedua adalah Tipe Konstruktif, yaitu jika penduduk yang berada dalam kelompok muda jumlahnya sedikit. Tipe konstruktif terdapat pada negara-negara dimana tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan tingkat kematiannya rendah. Tipe ketiga adalah Tipe Stasioner, yaitu jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe stasioner terdapat pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah.



Enam dekade terakhir di Indonesia ditandai dengan perubahan signifikan pada struktur piramida penduduk (Gambar 2.17). Dimulai dari periode 1970-an hingga 1980-an, piramida penduduk Indonesia berbentuk ekspansif, dengan proporsi generasi muda yang mendominasi. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan angka kematian yang masih tergolong tinggi (Lembaga Demografi UI, 1981). Jika dilihat pada setiap periode Sensus Penduduk, piramida penduduk tahun 1971 berbentuk sangat ekspansif dengan alas yang lebar dan puncak yang sempit, menunjukkan dominasi generasi muda dan tingginya angka fertilitas. Piramida penduduk tahun 1980 memiliki puncak yang sedikit lebih lebar yang mengindikasikan pergeseran proporsi penduduk ke arah usia dewasa. BKKBN mencatat di tahun 1980-an berbagai program terobosan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan (BKKBN, 2020). Program tersebut diantaranya Program Gugur Gunung, Safari KB dan pencitraan kontrasepsi melalui Program Lingkaran Biru dan Lingkaran Emas. Berbagai program tersebut berkontribusi pada perubahan piramida penduduk dekade berikutnya.



Gambar 2.17 Piramida Penduduk Indonesia, tahun 1971-2020

Pada tahun 1990, piramida penduduk semakin ramping dengan alas yang semakin sempit dan puncak yang semakin lebar. Piramida penduduk tahun 1990 ini menunjukkan penurunan angka fertilitas yang lebih signifikan dan peningkatan proporsi penduduk usia dewasa. Pada tahun 2000, piramida penduduk mulai melebar di bagian tengah, menunjukkan bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Pada tahun 2010 dan 2020, piramida semakin melebar di bagian tengah dan menyempit di bagian bawah, menunjukkan penurunan angka fertilitas yang terus berlanjut dan peningkatan proporsi penduduk usia dewasa dan lansia.



2.5.4 Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika proporsi anak-anak di bawah usia 15 tahun menurun, sedangkan proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun) meningkat dengan cepat, sementara proporsi penduduk lansia naik secara perlahan (Adioetomo & Pardede, 2018). Mason (2003) menyebut bonus demografi (atau secara internasional dikenal sebagai *demographic dividend* sebagai keuntungan unik dari transisi demografi yang hanya terjadi sekali, yaitu ketika angka kelahiran menurun dan penduduk usia kerja bertambah lebih cepat dibandingkan anak-anak. Hasilnya, lebih banyak orang berada dalam usia kerja yang produktif. Penurunan fertilitas mengurangi beban tanggungan pada penduduk usia kerja, dan perempuan dapat mengalokasikan lebih sedikit waktu untuk mengasuh anak dan lebih banyak untuk kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, sumber daya dapat diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Sehingga, penurunan fertilitas dapat meningkatkan produktivitas populasi dengan dua cara tersebut.

Bonus demografi diukur dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi (Asmanedi, 2016). Pertama, kualitas sumber daya manusia yang baik, ditandai dengan pendidikan dan kesehatan penduduk usia kerja yang baik. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan melalui sektor industri yang terus berkembang. Ketiga, tingginya pendapatan pekerja. Keempat, kemampuan penduduk untuk mengelola pendapatan secara produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut rumus rasio ketergantungan:

$$\frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

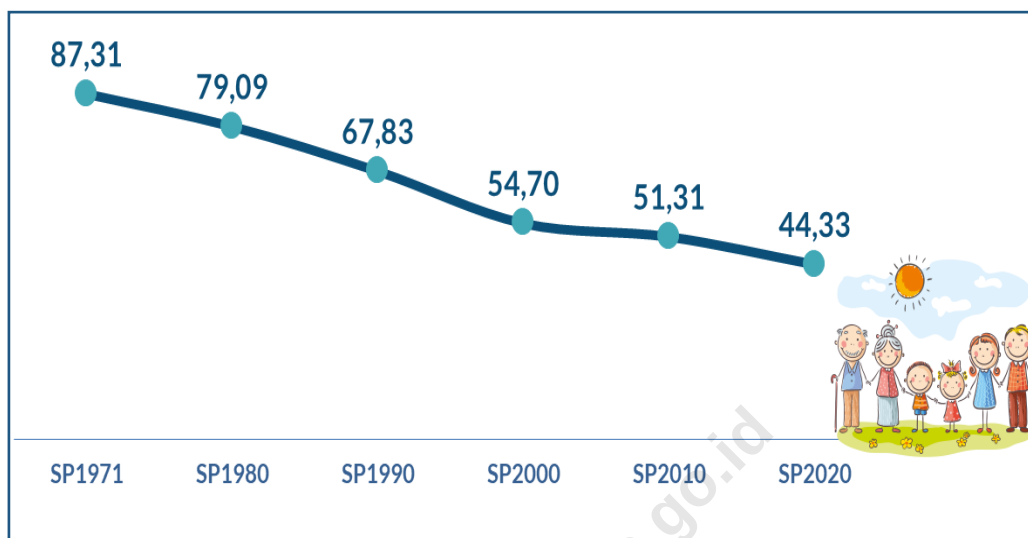
Dengan P_{0-14} merupakan jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun; P_{65+} merupakan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas; dan P_{15-64} merupakan jumlah penduduk usia antara 15 dan 64 tahun. Jika dibedakan antara umur penduduk non-produktif yang muda dan tua, rasio ketergantungan usia muda dapat dihitung sebagai:

$$\frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$$

sedangkan rasio ketergantungan usia tua dapat dihitung sebagai:

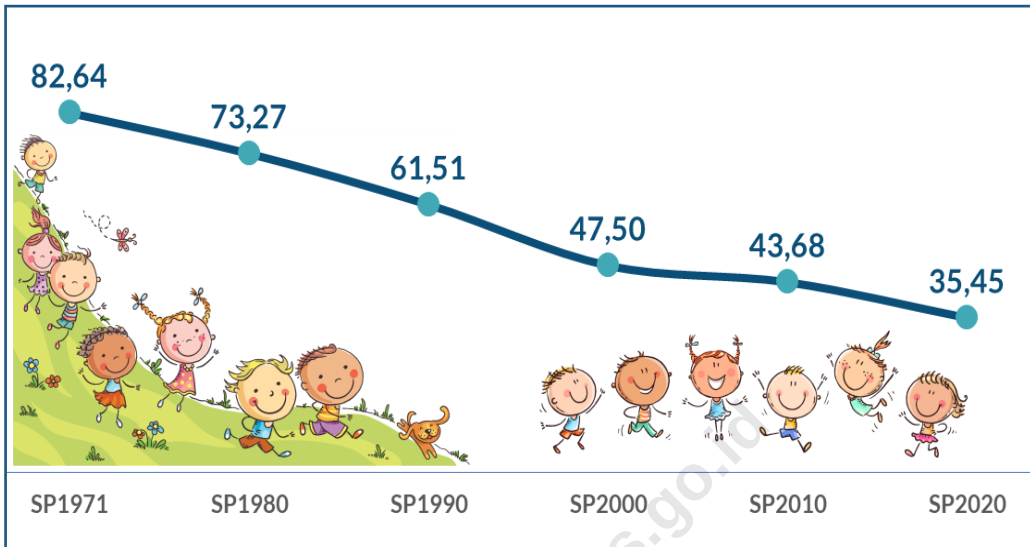
$$\frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

Rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus menunjukkan penurunan tajam dalam 50 tahun terakhir (Gambar 2.18). Pada tahun 1971, rasio ketergantungan sebesar 87,31. Artinya, setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 87 orang usia non-produktif. Jumlah ini berangsur turun, dengan rasio ketergantungan menyusut menjadi 67,83 pada tahun 1990, dan lebih rendah lagi di tahun 2000, yaitu 54,70. Pada tahun 2010, rasio ketergantungan sudah berada di angka 51,31. Rasio ketergantungan di tahun 2020 menyentuh titik terendah sebesar 44,33, yang menandakan bahwa Indonesia tengah menikmati bonus demografi, dengan lebih banyak orang yang berada di usia produktif dibandingkan non-produktif.

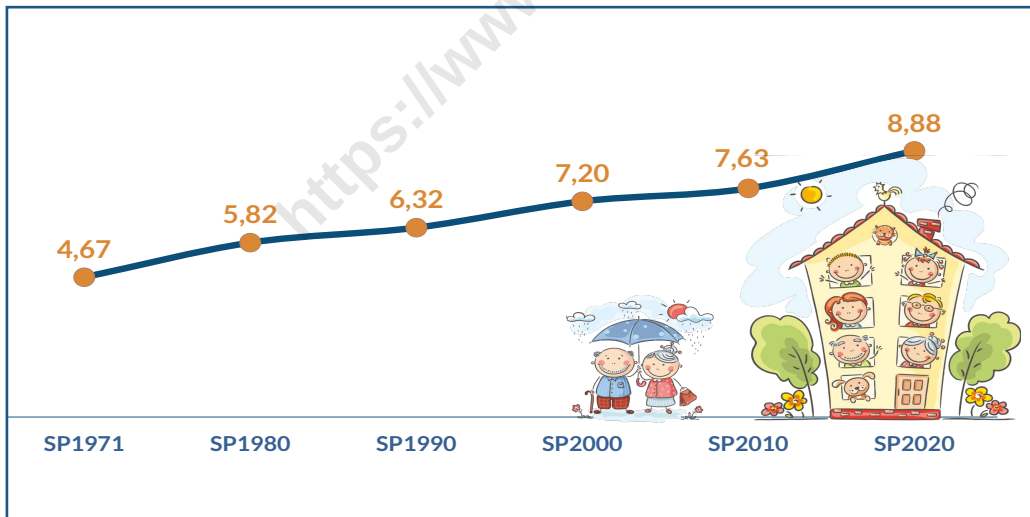


Gambar 2.18 Rasio Ketergantungan di Indonesia, hasil SP1971- SP2020

Pada Gambar 2.19 dan 2.20 digambarkan series rasio ketergantungan umur muda dan umur tua di Indonesia hasil SP1971 hingga SP2020. Gambar tersebut menunjukkan perubahan pola angka ketergantungan selama transisi demografi. Pada periode awal, karena tingginya kelahiran angka ketergantungan penduduk muda sangat besar hingga di angka 82,64. Artinya, dari 100 penduduk usia kerja di Indonesia saat itu akan menanggung sekitar 83 orang usia muda. Selanjutnya, penurunan fertilitas telah mengurangi proporsi penduduk di bawah 15 tahun, sehingga angka ketergantungan usia muda menurun. Pada tahun 2020, angka ketergantungan usia muda sudah menurun hingga dua setengah kali lipat dari tahun 1971 menjadi hanya sekitar 35,45. Artinya, pada tahun 2020, 100 penduduk usia kerja di Indonesia hanya akan menanggung sekitar 35 orang penduduk muda. Di sisi lain, perbaikan kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia menyebabkan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat. Akibatnya, terdapat kenaikan angka ketergantungan usia tua meningkat dari 4,67 di tahun 1971 menjadi 8,88 di tahun 2020 (Gambar 2.20).



Gambar 2.19 Rasio Ketergantungan Umur Muda (0-14 Tahun), hasil SP1971-SP2020



Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan Umur Tua (65 Tahun ke Atas) Indonesia, Hasil SP1971-SP2020

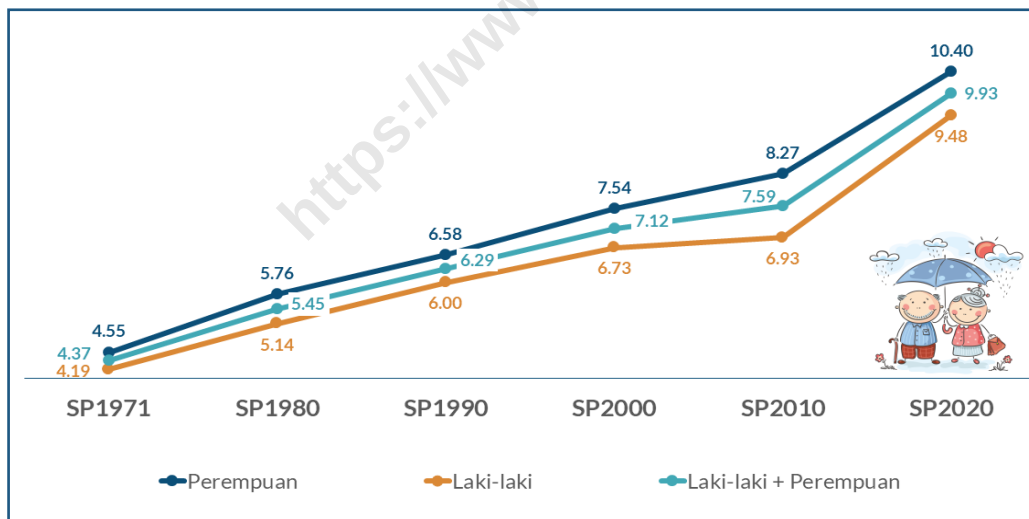


2.5.5 Penduduk Usia Lanjut (60 Tahun ke Atas)

Gambar 2.21 menunjukkan adanya penuaan populasi (*aging population*) di Indonesia. Proporsi penduduk usia lanjut terus meningkat selama 50 tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan peningkatan harapan hidup dan perubahan struktur usia. Menurut WHO (2015), terdapat dua faktor utama yang mendorong penuaan populasi adalah meningkatnya harapan hidup akibat perkembangan sosial ekonomi yang pesat secara global serta menurunnya angka kelahiran.

Pada 1971, persentase penduduk usia lanjut tercatat sekitar 4,37 persen, dengan persentase perempuan (4,55 persen) sedikit lebih banyak dibanding laki-laki (4,19 persen). Persentase penduduk usia lanjut ini terus meningkat setiap dekade, mencapai 5,45 persen pada 1980 dan 6,29 persen pada 1990.

Pada tahun 2000, persentase penduduk usia lanjut bertambah menjadi 7,12 persen, dengan gap gender yang semakin terlihat: perempuan mencapai 7,54 persen sedangkan laki-laki sebesar 6,73 persen. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2010, ketika proporsi penduduk usia lanjut mencapai 7,59 persen, dengan perempuan masih mendominasi pada angka 8,27 persen. Penduduk usia lanjut menunjukkan tren penuaan populasi. Persentase penduduk usia lanjut hingga tahun 2020 mencapai 9,93 persen, dengan perempuan mencapai 10,40 persen dan laki-laki sebesar 9,48 persen.



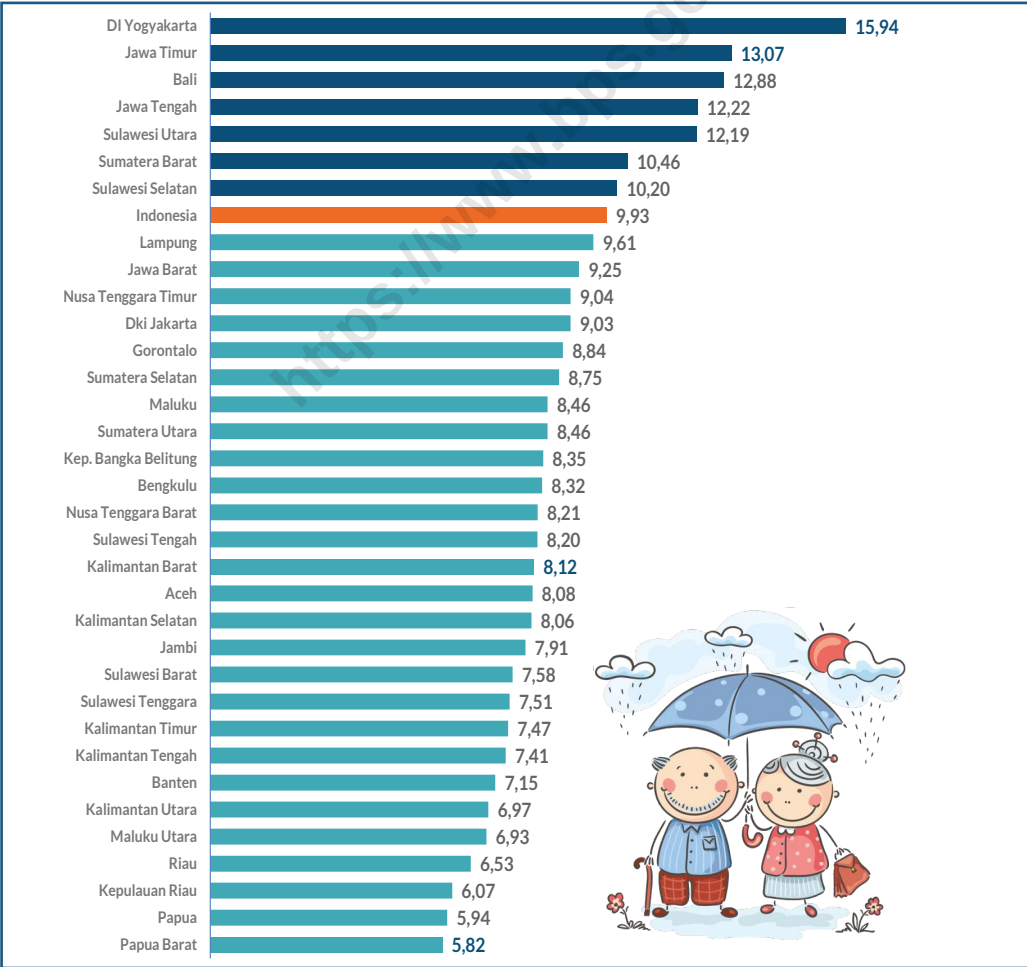
Gambar 2.21 Persentase Penduduk Usia Lanjut (60 Tahun ke Atas) Indonesia, Hasil SP1971– SP2020

Terdapat variasi tingkat penuaan populasi antara wilayah-wilayah di Indonesia (Gambar 2.22). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat persentase penduduk usia lanjut tertinggi, mencapai 15,94 persen. Sementara Provinsi Papua memiliki persentase penduduk lanjut usia terendah, sebesar 5,82 persen.



Secara nasional, persentase penduduk usia lanjut berada di angka 9,93%, terdapat pada 7 (tujuh) provinsi. Ketujuh provinsi dengan persentase penduduk usia lanjut di atas nasional yaitu: Provinsi Jawa Timur (13,07 persen), Bali (12,88 persen), Jawa Tengah (12,22 persen), Sulawesi Utara (12,19 persen), Sumatera Barat (10,46 persen), dan Sulawesi Selatan (10,20 persen). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa wilayah mengalami penuaan populasi yang lebih cepat dibandingkan yang lain.

DKI Jakarta, sebagai salah satu wilayah metropolitan, memiliki persentase penduduk usia lanjut sebesar 9,03 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, beberapa provinsi memiliki persentase penduduk lanjut usia yang lebih rendah, seperti Papua Barat (5,82 persen), Papua (5,94 persen), dan Kepulauan Riau (6,07 persen). Provinsi di Kalimantan dan Maluku juga mencatat angka yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Merujuk pada temuan WHO (2015), variasi persentase penduduk usia lanjut di antara provinsi-provinsi di Indonesia menggambarkan bahwa tingkat penuaan tidak merata dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing provinsi.



Gambar 2.22 Persentase Penduduk Usia Lanjut (60 tahun ke atas) Menurut Provinsi, 2020

3

Fertilitas Indonesia





Pertumbuhan penduduk suatu negara sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah tingkat fertilitas, yang merupakan salah satu komponen dalam demografi. Tingkat fertilitas sering digunakan sebagai dasar dan arah kebijakan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk bersama dengan komponen demografi lainnya seperti mortalitas dan mobilitas. Menurut Gunawan et al (2020), terdapat hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait stabilitas ekonomi dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesempatan kerja dan distribusi persebaran kepadatan penduduk yang lebih merata. Hal itu untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di suatu wilayah, tingkat fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling terkait. Perbedaan tingkat fertilitas dapat diamati antar wilayah, sehingga diperlukan pengukuran tambahan untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Jumlah kelahiran hidup setiap tahunnya dipengaruhi oleh faktor – faktor demografi seperti distribusi umur dan jenis kelamin, status perkawinan antar kelompok umur, dan jumlah anak yang dilahirkan. Selain itu, faktor sosial ekonomi lainnya juga menentukan jumlah kelahiran dalam jangka waktu tertentu, termasuk kondisi perumahan, tingkat pendidikan, pendapatan, agama, dan sikap terhadap nilai – nilai mengenai anak.

Fertilitas menjadi topik menarik untuk dibahas karena menjadi dasar oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan masa depan. Sebagai salah satu indikator yang penting dalam demografi, fertilitas memainkan peran kunci dalam perubahan jumlah penduduk. Perkembangan yang pesat di bidang kedokteran dan obat-obatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kematian, namun di sisi lain, masih tingginya tingkat fertilitas menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi cepat. Masalah pertumbuhan penduduk inilah yang menjadikan studi dan kajian mengenai fertilitas menjadi penting.

3.1 Crude Birth Rate (CBR)

Angka Kelahiran Kasar (CBR) dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Kelebihan dari CBR adalah penghitungannya yang sederhana karena hanya memerlukan keterangan tentang jumlah anak yang dilahirkan dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan, kelemahan dalam penghitungan CBR adalah tidak memisahkan penduduk laki-laki dan perempuan. Selain itu, juga tidak memisahkan penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah atau pun 50 tahun ke atas. Jadi, angka yang dihasilkan sangat kasar. Karena penduduk yang terpapar yang digunakan sebagai penyebut adalah penduduk dari semua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan) dan semua kelompok umur yang tidak memiliki potensi untuk melahirkan.

Rumus CBR adalah sebagai berikut:

$$CBR = \frac{B}{P} \times 1000$$



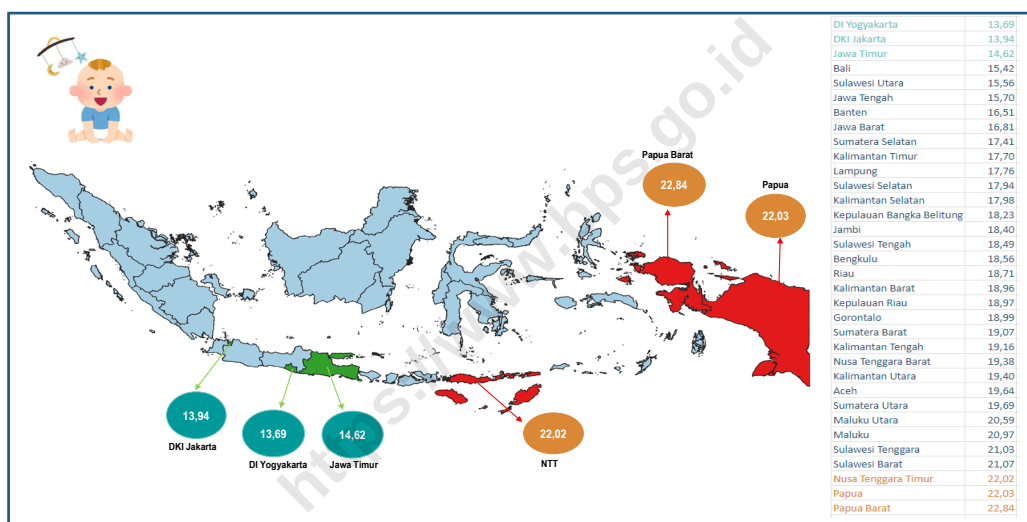
Keterangan:

CBR : Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate

B : Jumlah kelahiran

P : Jumlah penduduk

Jumlah kelahiran hasil *Long Form* SP2020 diperoleh dari jumlah kelahiran menurut kelompok umur wanita. Kelahiran menurut umur wanita dapat diperoleh dari perkalian ASFR dari jumlah wanita pada kelompok umur yang sama. Dari jumlah kelahiran dan jumlah penduduk dari hasil *Long Form* SP2020 diperoleh estimasi angka kelahiran kasar. Hasil *Long Form* SP2020 mencatat terdapat 17,07 kelahiran hidup di antara 1.000 penduduk Indonesia.



Gambar 3.1 Angka Kelahiran Kasar (CBR) Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil *Long Form* SP2020

Angka kelahiran kasar (CBR) merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengukur tingkat kelahiran suatu wilayah. Berdasarkan gambar 3.1, terlihat bahwa tingkat CBR bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun provinsi dengan tingkat CBR terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, dengan angka CBR sebesar 13,69 yang berarti terdapat 14 kelahiran hidup di antara 1.000 penduduk di Provinsi DI Yogyakarta. Beberapa provinsi yang memiliki angka CBR terendah lainnya adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 13,94; Provinsi Jawa Timur sebesar 14,64; dan Provinsi Bali sebesar 15,42.

Provinsi Papua Barat menduduki tingkat CBR tertinggi yaitu sebesar 22,84 yang berarti terdapat 23 kelahiran hidup di antara 1.000 penduduk di Provinsi Papua Barat. Provinsi yang memiliki angka CBR tertinggi lainnya adalah Provinsi Papua sebesar 22,03 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22,02. Secara umum, provinsi – provinsi di Indonesia timur cenderung memiliki tingkat CBR yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Barat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam merancang kebijakan terkait program keluarga berencana dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.



Perbedaan angka kelahiran kasar salah satunya disebabkan oleh perbedaan persentase penggunaan kontrasepsi yang sedang digunakan. Menurut Listiyaningsih dan Satiti (2021), penggunaan alat/cara KB memiliki pengaruh langsung terhadap angka kelahiran di suatu wilayah. Penggunaan alat/cara KB dapat membantu individu untuk merencanakan keluarga dengan lebih baik. Program KB menjadi kunci dalam menaikkan atau menurunkan tingkat fertilitas di suatu wilayah. Oleh karena itu, kesertaan penduduk dalam program KB menjadi faktor penting dalam mengatur tingkat kelahiran.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia Timur memiliki persentase penggunaan kontrasepsi yang relatif rendah. Provinsi Papua mencatat penggunaan kontrasepsi terendah di antara provinsi-provinsi lainnya, yaitu sebesar 21,08 persen. Selain itu, Provinsi Papua Barat (28,38 persen), Provinsi Maluku (33,26 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (38,2 persen) juga memiliki persentase yang rendah. Rendahnya penggunaan kontrasepsi ini sejalan dengan tingginya angka kelahiran kasar di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selain penggunaan kontrasepsi, perbedaan angka kelahiran kasar juga dapat dilihat dari perbedaan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Menurut Febryanna (2022), terdapat hubungan positif antara angka kelahiran kasar dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dapat memengaruhi angka kelahiran kasar melalui berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Kemiskinan yang tinggi dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sehingga dapat berpotensi meningkatkan angka kelahiran kasar.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 26,56 persen, diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan 21,33 persen. Tingginya angka kemiskinan di kedua provinsi tersebut sejalan dengan angka kelahiran kasar yang juga tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong keluarga untuk memiliki lebih banyak anak sebagai bentuk jaminan dukungan ekonomi di masa depan. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta dan Bali mencatat tingkat kemiskinan yang rendah, masing-masing sebesar 4,69 persen dan 4,57 persen. Rendahnya tingkat kemiskinan sejalan dengan angka kelahiran kasar yang rendah di kedua provinsi tersebut.

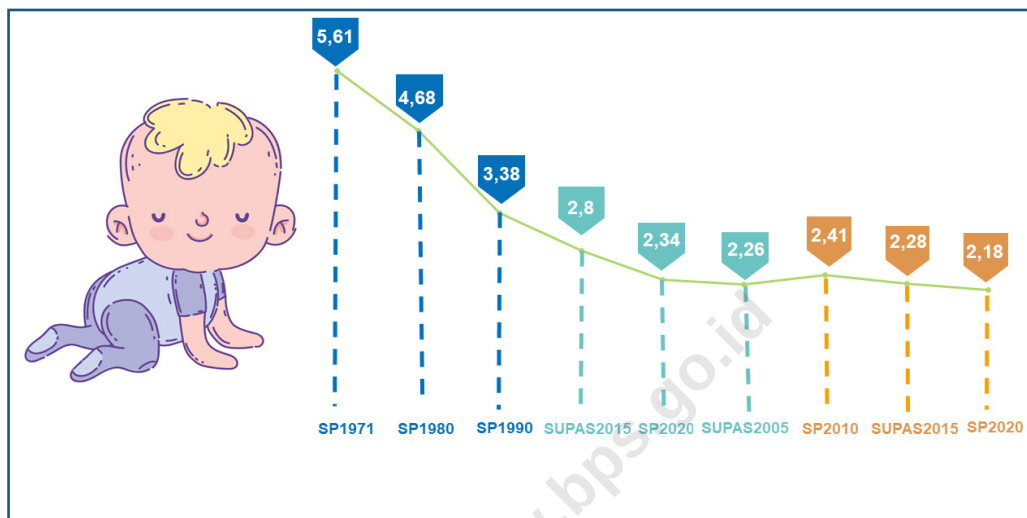
3.2 Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Total (TFR) merupakan angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Ukuran TFR menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan hipotesis selama masa reproduksinya. Dalam penghitungannya, TFR dihitung dengan menjumlahkan tingkat fertilitas perempuan menurut kelompok umur 5 tahunan, dengan asumsi bahwa tingkat fertilitas menurut umur tunggal sama dengan rata-rata tingkat fertilitas kelompok umur lima tahunan. Rumus TFR sebagai berikut:

$$TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$



ASFRi menyatakan banyaknya kelahiran menurut kelompok umur wanita ke i. Kelebihan dari penghitungan TFR adalah TFR merupakan ukuran dari seluruh wanita 15 – 49 tahun, yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur.



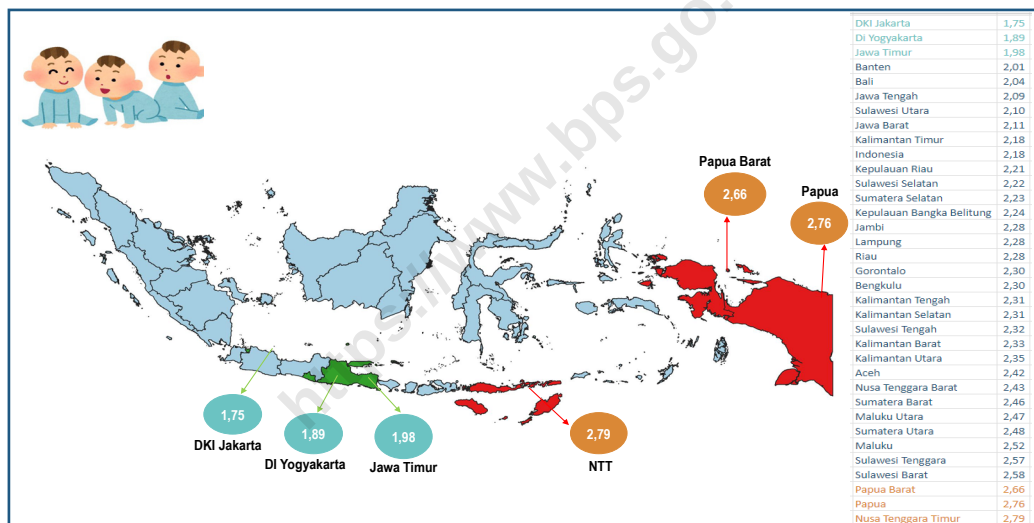
Gambar 3.2 Tren Angka Kelahiran Total (TFR) Indonesia, Tahun 1971–2020

Data Angka Kelahiran Total (TFR) di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Hasil SP1971 menunjukkan TFR mencapai 5,61, yang berarti rata-rata seorang perempuan melahirkan 5 – 6 anak sepanjang masa reproduksinya. Hasil SP1980, TFR turun mencapai 4,68 dan pada hasil SP1990 turun kembali menjadi 3,33. Tren penurunan ini berlanjut, dengan TFR mencapai 2,8 dari hasil SUPAS 1995, dan turun menjadi 2,34 dari hasil SP2000. Hasil SUPAS 2005 menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan TFR sebesar 2,26. Meskipun sempat terjadi kenaikan sebesar 2,41 dari hasil SP2010, angka TFR kembali menurun menjadi 2,28 berdasarkan SUPAS 2015. Hasil Long Form SP2020 menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan TFR sebesar 2,18, yang berarti rata-rata perempuan melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya.

Penurunan tingkat TFR ini mencerminkan perubahan besar dalam pola berkeluarga, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta perkembangan sosial ekonomi di Indonesia. Meskipun ada sedikit fluktuasi dalam penurunan TFR, secara keseluruhan data menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan ini berdampak penting, termasuk pada perubahan pertumbuhan penduduk, struktur umur, dan kebijakan keluarga. Hal tersebut mencerminkan pergeseran menuju keluarga yang lebih kecil serta perubahan preferensi dan prioritas kesejahteraan keluarga di Indonesia.



Menurut Freedman (1975) dalam *The Sociology of Human Fertility*, faktor – faktor yang memengaruhi fertilitas terdiri dari faktor secara langsung atau pun tidak langsung. Adapun yang termasuk tidak langsung antara lain: (1) Demografi yaitu umur dan tempat tinggal; (2) Sosial ekonomi: tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan kuintil kekayaan; (3) Kematian: kematian anak; (4) Norma: Jumlah anak yang diinginkan, jenis kelamin yang diinginkan, keinginan suami terhadap jumlah anak, dan pendapat suami terhadap Keluarga Berencana; (5) Lingkungan: akses terhadap media dan jenis media, kontak terhadap petugas KB/kesehatan, dan keputusan untuk ber-KB. Sedangkan faktor langsung yang memengaruhi fertilitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Faktor yang memengaruhi kemungkinan hubungan kelamin seperti umur kawin pertama, umur hubungan seksual pertama, dan status perkawinan; (2) Faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadi konsepsi seperti alat kontrasepsi, ASI eksklusif, segera haid setelah melahirkan, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan dan infertilitas; (3) Faktor yang memengaruhi kehamilan dan kelahiran seperti umur pertama melahirkan.



Gambar 3.3 Angka Kelahiran Total (TFR) Menurut Provinsi di Indonesia, Hasil Long Form SP2020

Gambar 3.3 menunjukkan perbandingan angka kelahiran total (TFR) antar provinsi di Indonesia. Adapun provinsi yang memiliki angka TFR terendah adalah provinsi DKI Jakarta sebesar 1,75, menunjukkan tren kelahiran yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan provinsi yang memiliki angka kelahiran total (TFR) tertinggi, dengan masing-masing provinsi sebesar 2,79 dan 2,76, yang berarti seorang perempuan melahirkan 2 - 3 anak selama masa reproduksinya di kedua provinsi tersebut. Tren TFR dari tahun-tahun sebelumnya juga dapat dilihat pada lampiran 2.



Menurut Bongaarts (1978), terdapat delapan variabel antara yang memengaruhi tingkat fertilitas. Adapun kedelapan variabel tersebut antara lain proporsi penduduk yang menikah, penggunaan kontrasepsi, induced abortion (proses pengakhiran kehamilan secara sengaja sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yang dilakukan melalui tindakan medis), pemberian ASI, frekuensi hubungan seksual, tidak memiliki keturunan atau tidak subur, kondisi lahir mati, dan periode seorang wanita berpotensi hamil selama siklus menstruasi. Dari beberapa variabel tersebut, terdapat empat faktor seperti perkawinan, kontrasepsi, pemberian ASI, dan aborsi sebagai faktor penyebab adanya perbedaan fertilitas dalam suatu populasi.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan pada persentase perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Pada tahun 2018, persentase perkawinan anak di Indonesia mencapai puncaknya, yaitu 11,21 persen. Namun, antara tahun 2018 hingga 2022, angka ini turun sebesar 3,15 persen poin, menjadi 8,06 persen pada tahun 2022. Dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan angka 9,44 persen pada tahun 2022, capaian nasional menunjukkan hasil yang lebih rendah.

Jika dikaitkan dengan TFR, Provinsi DKI Jakarta mencatat TFR terendah, dan provinsi ini juga memiliki persentase perkawinan anak terendah di Indonesia. Rendahnya persentase perkawinan anak di suatu wilayah berdampak pada penurunan tingkat kelahiran di wilayah tersebut. Perkawinan yang terjadi pada usia muda cenderung menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi karena biasanya diikuti oleh kehamilan dan persalinan yang lebih cepat, dan sebaliknya. Penelitian oleh Samsaputra (2022) menunjukkan bahwa perkawinan umur dini berkontribusi pada peningkatan tingkat fertilitas penduduk, karena wanita yang menikah pada usia muda cenderung memiliki lebih banyak anak dibandingkan dengan wanita yang menikah di usia yang lebih tua. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat fertilitas di Indonesia. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama penentu tinggi rendahnya tingkat kelahiran di suatu wilayah. Menurut Freedman (1961/1962), fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, demografi, ekonomi, norma, dan lingkungan yang merupakan faktor tidak langsung yang memengaruhi fertilitas melalui faktor langsung.

Berkaitan dengan TFR, Provinsi Papua mencatat TFR tertinggi setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari segi pendidikan, Papua memiliki persentase tertinggi penduduk perempuan berusia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah bersekolah, yaitu sebesar 32,12 persen. Persentase penduduk yang tidak bersekolah ini berpotensi menjadi faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran di wilayah tersebut. Ketika tingkat pendidikan rendah, masyarakat cenderung kurang memiliki pengetahuan tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi yang baik. Selain itu, kurangnya pendidikan juga mengakibatkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya merencanakan jumlah anak, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan dan angka kelahiran yang tinggi. Sejalan dengan penelitian Jayakusuma dan Sudibia (2022), semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, semakin rendah tingkat kelahiran. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi mampu mempertimbangkan keuntungan finansial yang diperoleh dari memiliki anak dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkannya.



3.3 Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu pada kelompok umur 15 – 49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1.000 wanita pada kelompok umur tersebut.

Rumus ASFR adalah sebagai berikut:

$$ASFR_i = \frac{\sum B_i}{\sum P_{fi}} \times 1.000$$

$ASFR_i$: Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur tertentu

B_i : Jumlah kelahiran perempuan menurut kelompok umur tertentu

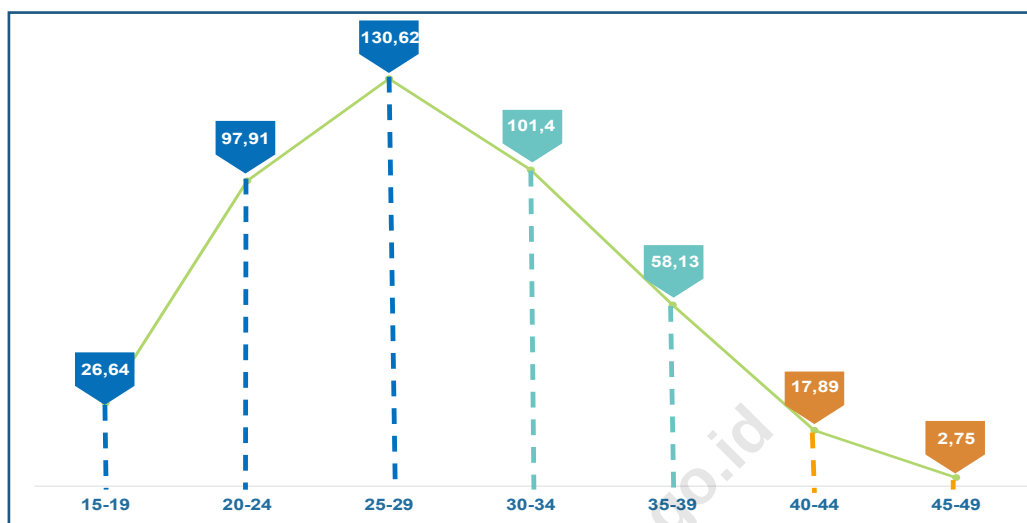
P_{fi} : Jumlah perempuan menurut kelompok umur tertentu

i : kelompok umur perempuan 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49

Kelebihan dari penghitungan ASFR adalah penghitungan ini lebih cermat dibandingkan dengan TFR karena sudah membagi penduduk yang exposed to risk ke dalam berbagai kelompok umur. Dengan ASFR dimungkinkan analisis perbedaan fertilitas menurut berbagai karakteristik wanita dan dilakukannya studi fertilitas menurut kohor.

Metode ASFR ini merupakan dasar untuk penghitungan ukuran fertilitas dan reproduksi selanjutnya (TFR, GRR, dan NRR). Adapun kelemahan dari penghitungan ASFR ini adalah membutuhkan data yang rinci yaitu banyaknya kelahiran untuk kelompok umur. Sedangkan data tersebut tentu di tiap negara/wilayah, khususnya di negara – negara berkembang, belum tentu tersedia. Jadi, pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan ukuran ASFR.

Angka kelahiran bervariasi di antara kelompok umur perempuan. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, angka kelahiran perempuan berumur 15 – 19 tahun tercatat sebesar 27 kelahiran hidup per 1.000 perempuan dalam kelompok umur tersebut. Puncak angka kelahiran terjadi pada perempuan berumur 25–29 tahun dengan 131 kelahiran per 1.000 perempuan. Sementara itu, perempuan berumur 20–24 tahun juga memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi, yaitu 98 kelahiran per 1.000 perempuan. Namun, seiring bertambahnya umur perempuan, angka kelahiran mulai menurun. Pada kelompok umur 30 – 34 tahun, tercatat 101 kelahiran hidup per 1.000 perempuan. Penurunan ini berlanjut di kelompok umur yang lebih tua, yaitu 18 kelahiran per 1.000 perempuan pada umur 40–44 tahun dan hanya 3 kelahiran per 1.000 perempuan pada umur 45–49 tahun.

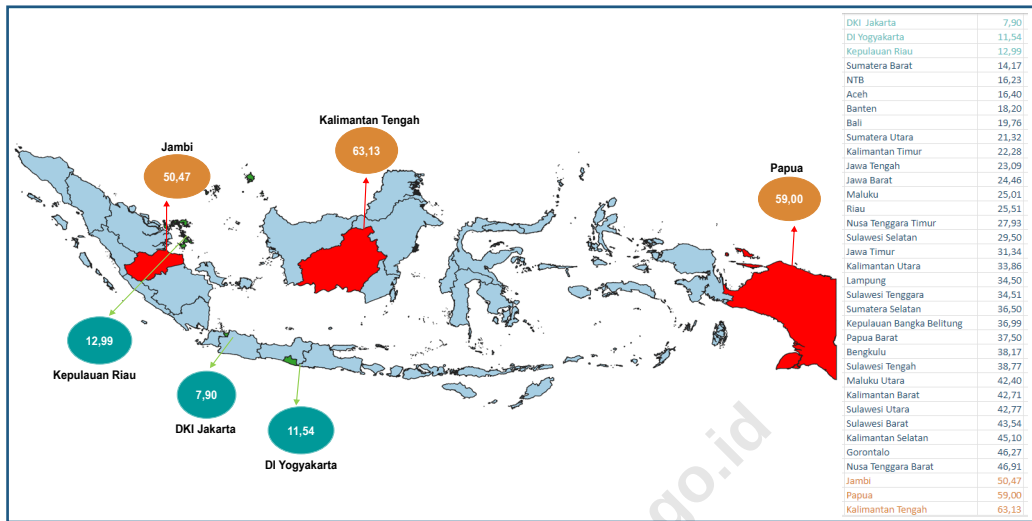


Gambar 3.4 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) Indonesia, Hasil Long Form SP2020

Pola angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu (ASFR) dapat dibandingkan antar provinsi berdasarkan hasil Long Form SP2020 (lampiran 3). Berdasarkan data tersebut, angka kelahiran tertinggi secara umum berada pada kelompok umur perempuan 25–29 tahun, kecuali di Provinsi Papua, di mana angka kelahiran tertinggi tercatat pada kelompok umur 20 – 24 tahun. Beberapa provinsi di Sumatera seperti Sumatera Barat sebanyak 163 kelahiran, Sumatera Utara sebanyak 159 kelahiran, dan Kepulauan Riau sebanyak 151 kelahiran, memiliki angka kelahiran tertinggi pada kelompok umur 25–29 tahun per 1.000 perempuan. Sementara itu, beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah (113 kelahiran), Sulawesi Utara (116 kelahiran), dan Jawa Timur (113 kelahiran) per 1.000 perempuan menunjukkan angka kelahiran yang lebih rendah pada kelompok umur yang sama. Tren ASFR dari tahun-tahun sebelumnya juga dapat dilihat pada lampiran 3.

Beberapa hal yang menjadi isu terkait fertilitas adalah fertilitas remaja. Fertilitas remaja yang biasanya menjadi topik adalah terkait kelahiran pada kelompok umur wanita 10 – 14 tahun dan 15 – 19 tahun. Data angka kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok umur 15 – 19 tahun menyoroti adanya perbedaan yang signifikan antara provinsi – provinsi di Indonesia. Hal tersebut mencerminkan perbedaan dalam praktik kesehatan reproduksi, akses terhadap pendidikan seksual, dan faktor-faktor sosial budaya lainnya.

Hasil LF SP2020 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka kelahiran remaja tertinggi mencapai 63,13 kelahiran per 1.000 wanita kelompok umur 15 – 19 tahun, kemudian diikuti oleh Provinsi Papua sebesar 59,00 per 1.000 wanita, dan Provinsi Jambi sebesar 50,47 per 1.000 wanita pada kelompok umur yang sama. Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan angka kelahiran remaja yang rendah seperti Provinsi DKI Jakarta dengan angka kelahiran 7,90 per 1.000 wanita, yang disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,54 dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,99 per 1.000 wanita pada kelompok umur yang sama.



Gambar 3.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR 15-19 tahun) Menurut Provinsi, Hasil Long Form SP2020

4

Mortalitas Indonesia





Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga elemen dalam proses demografi yang memengaruhi struktur populasi (Mantra, 2000). Dua elemen lainnya adalah kelahiran (fertilitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Menurut WHO, kematian merupakan peristiwa menghilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sementara itu, still birth dan keguguran tidak tercakup dalam pengertian kematian. Beberapa konsep terkait pengertian mortalitas adalah:

- a. Neo-natal death yaitu kejadian kematian pada bayi yang belum berumur satu bulan.
- b. Lahir mati (still birth) atau sering juga disebut dengan kematian janin (fetal death) merupakan kematian sebelum dikeluarkannya secara lengkap bayi dari ibunya pada saat dilahirkan (tanpa memperhatikan lamanya dalam kandungan).
- c. Post neo-natal merupakan kematian anak yang berumur antara satu bulan sampai dengan kurang dari satu tahun.
- d. Infant death (kematian bayi) merupakan kematian anak yang terjadi sebelum mencapai umur satu tahun.

Kematian dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk demografi, kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sudut pandang demografi, kematian tidak hanya berperan dalam mengurangi jumlah penduduk, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memperkirakan jumlah penduduk di masa depan. Di Indonesia, tingkat kematian telah mengalami penurunan secara konsisten selama beberapa dekade terakhir. Dengan tersedianya berbagai indikator kematian, maka dapat dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu wilayah dalam menurunkan tingkat mortalitas serta memungkinkan untuk dilakukan perbandingan antar wilayah. Bahkan, jika dikaitkan dengan capaian target Sustainable Development Goals (SDGs), beberapa indikator kematian memegang peranan penting. Selain itu, data tentang kematian memberikan wawasan tentang berbagai permasalahan masyarakat, seperti kondisi sosial ekonomi penduduk, penyebab kematian, serta kaitannya dengan dinamika kependudukan lainnya seperti kelahiran, migrasi, dan pertumbuhan populasi. Hal ini penting mengingat Indonesia sedang memasuki fase penduduk menua (ageing population) dimana rentan terhadap munculnya penyakit dan terjadinya kematian.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai upaya untuk mendukung hal ini, diperlukan upaya kesehatan anak yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Berbagai upaya tersebut diperlukan sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Hal ini penting, salah satunya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kualitas hidup anak dengan cara menurunkan angka kematian, meningkatkan status gizi, serta menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bagi bayi baru lahir, bayi, dan balita (Kemenkes, 2023).



Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk turut serta memberikan kontribusi yang positif dalam pencapaian tujuan global yang ditetapkan oleh komunitas internasional salah satunya adalah dalam pencapaian target-target SDGs. Mengikuti SDGs adalah bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk berkontribusi pada pembangunan global dan kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim. Fokus pada target pencapaian SDGs 3 khususnya 3.1 dan 3.2, akan membantu Indonesia pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan berupaya untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Indikator angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu, dan angka kematian balita berperan penting dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas berbagai program kesehatan pemerintah. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas layanan kesehatan yang diberikan, mengidentifikasi daerah yang masih membutuhkan intervensi. Terkait SDGs, pemantauan indikator ini membantu pemerintah mengetahui seberapa jauh mereka telah mencapai target penurunan kematian yang dapat dicegah dan apa yang masih perlu diperbaiki untuk memenuhi standar global. Melalui pemantauan yang terus menerus terhadap indikator ini, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Indikator kematian anak yang banyak digunakan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR), Angka Kematian Balita (AKBA) atau *Under Five Mortality Rate* (U5MR) dan Angka Kematian Anak (AKABA) atau *Child Mortality Rate* (CMR). Indikator kematian lainnya yang juga menjadi perhatian bersama adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dimana salah satu agenda prioritas pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah tercapainya percepatan penurunan kematian ibu.

4.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat penting dan mendesak di berbagai belahan di dunia. Ketersediaan data yang akurat menjadi sangat penting karena sebagian besar kematian bayi ini dapat dicegah jika pemangku kebijakan bisa melakukan intervensi yang tepat berbasis bukti yaitu berupa data-data terkait yang akurat dan berkualitas tinggi. AKB menjadi indikator penting yang mampu mencerminkan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan dimana tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua dari bayi. AKB mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan dan lain-lain. Selain itu, AKB juga mencerminkan tingkat kesehatan ibu.

Sistem pencatatan kependudukan belum memiliki cakupan cukup baik dalam pelaporan kejadian kematian, sehingga penghitungan AKB di Indonesia sebagian besar didasarkan pada data sensus dan survei kependudukan. Dalam publikasi ini, data yang dipergunakan untuk menghitung estimasi AKB adalah hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan LF SP2020. Informasi untuk menghitung AKB diambil dari pertanyaan khusus tentang kelahiran dan kematian bayi dalam rentang waktu tertentu.



Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Rumus AKB adalah sebagai berikut:

$$AKB = \frac{D_0}{B} \times K$$

Keterangan:

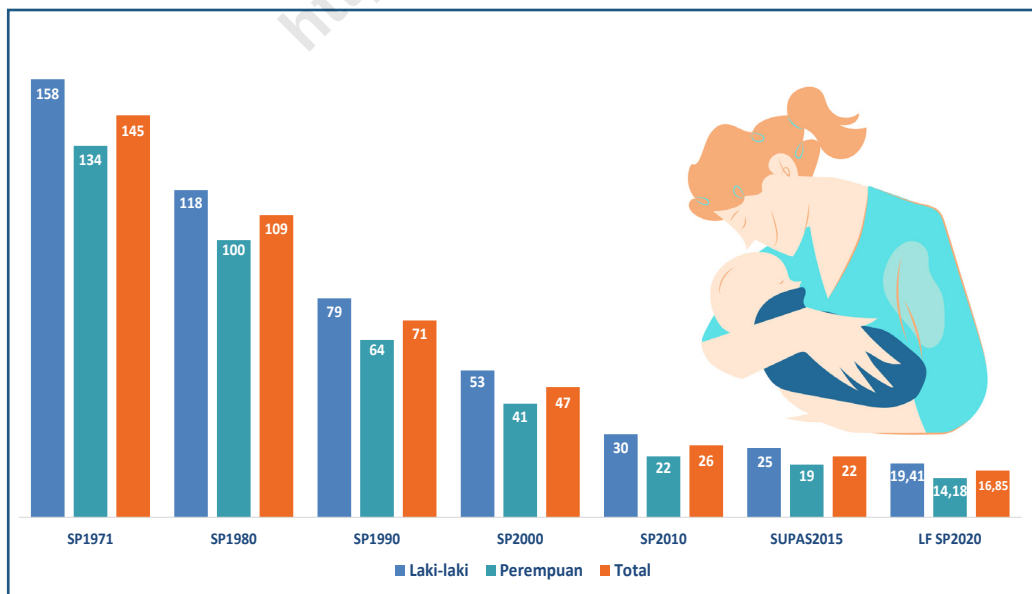
AKB : Angka Kematian Bayi

D_0 : Jumlah Kematian bayi (berumur kurang dari satu tahun pada tahun tertentu)

B : Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu

K : Bilangan konstan 1000

Penurunan AKB merupakan bukti keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, AKB juga mampu menunjukkan keberhasilan dalam pencegahan maupun upaya untuk mengatasi ancaman penyakit yang bisa diderita oleh bayi baru lahir. Sebagai indikator yang sangat sensitif, AKB mencerminkan efektivitas serta keberhasilan berbagai program pembangunan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dilaksanakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, penurunan angka kematian bayi ditetapkan menjadi salah satu program prioritas nasional pada bidang kesehatan. Pemerintah menargetkan, pada tahun 2024 angka kematian bayi bisa mencapai 16 kematian per 1000 kelahiran hidup.



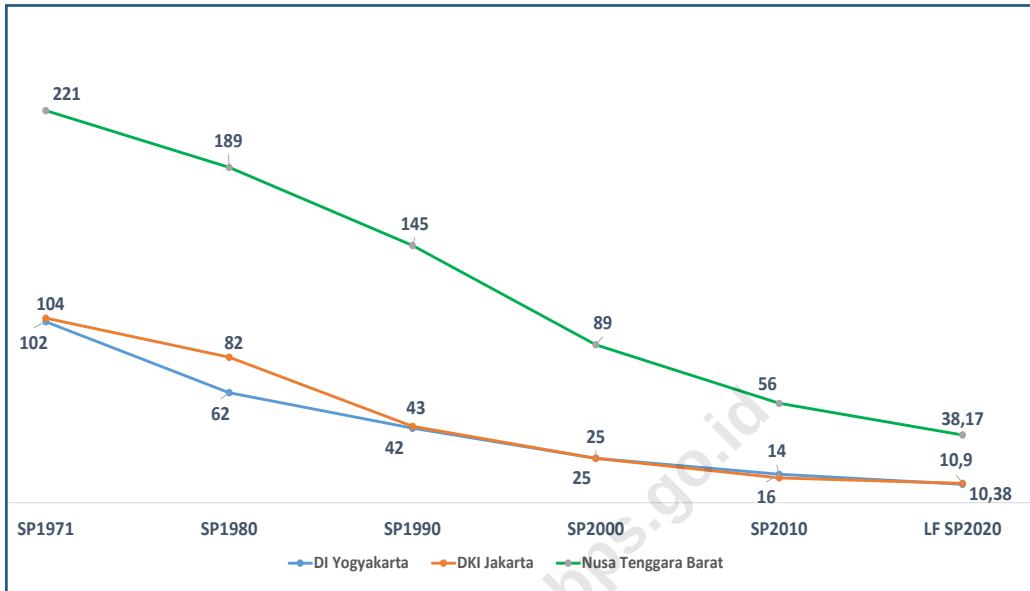
Gambar 4.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Indonesia, 1971–2020



Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan IMR di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yaitu SP1971 menurut jenis kelamin, SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010, SUPAS2015 dan Long Form (LF) SP2020. Pada 1971, angka kematian bayi adalah 145 per 1000 kelahiran hidup. Jika diamati secara total, angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 angka kematian bayi mencapai 16,85 yang berarti bahwa terdapat 16-17 kematian bayi usia kurang dari satu tahun hasil LF SP2020 per 1000 kelahiran hidup di Indonesia. Penurunan tajam terjadi pada periode antara SP1971 dan SP1980, dimana angka kematian bayi menurun dari 145 menjadi 109 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada periode SP1980 ke SP1990 kembali terjadi penurunan yang drastis yaitu sebanyak 38 poin (dari 109 menjadi 71). Setelah SP1990, terjadi perlambatan penurunan kecepatan angka kematian bayi. Angka kematian bayi hasil SP2000 turun 24 poin jika dibanding SP1990, yaitu dari 71 menjadi 47. Angkanya terus melambat dan turun dari 22 di SUPAS2015 menjadi 16,85 di LF SP2020 (turun 5,15).

Grafik tersebut juga menunjukkan adanya pola yang sama pada setiap sensus/survei terkait angka kematian bayi laki-laki dan perempuan dimana secara umum, angka kematian bayi laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, baik angka kematian bayi laki-laki maupun angka kematian bayi perempuan menunjukkan tren penurunan yang serupa. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan secara keseluruhan untuk kedua jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan penelitian Drevenstedt et al. (2008) dimana bayi laki-laki memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan. Perbedaan mortalitas antara bayi laki-laki dan perempuan tidak semata-mata karena faktor biologis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi medis dan lingkungan.

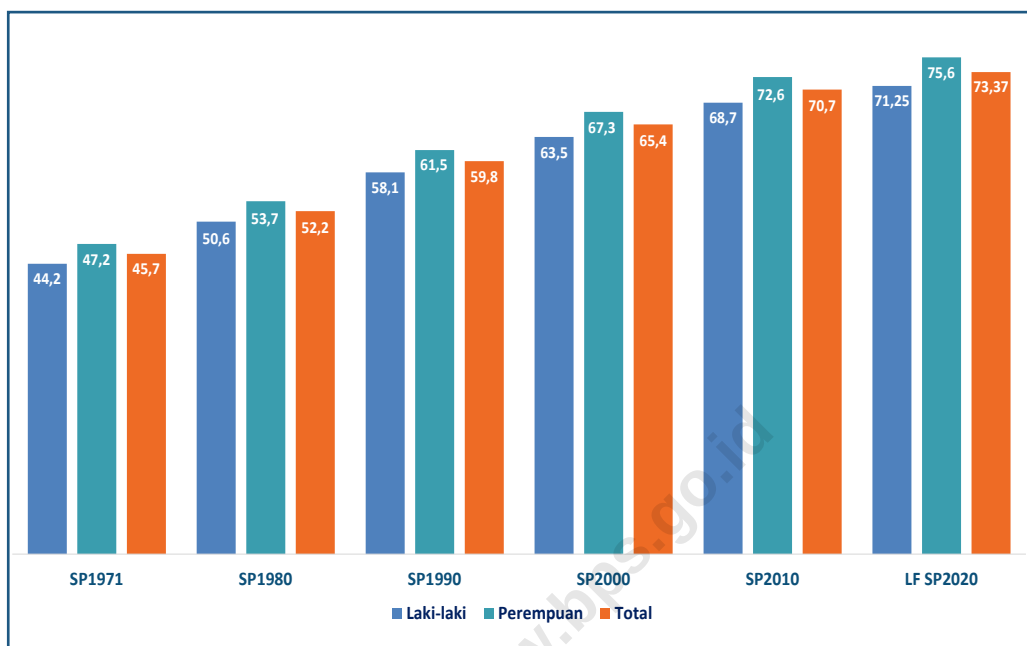
Jika mengamati tren IMR pada tingkat provinsi, maka semua provinsi menggambarkan pola yang sama dimana pada setiap provinsi menunjukkan adanya penurunan IMR dari hasil SP1971 sampai dengan LF SP2020. Dua provinsi yang paling sering menduduki peringkat pertama dan kedua untuk pencapaian IMR terendah adalah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Pada SP1971 sampai dengan SP2000, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan angka IMR paling rendah dibanding provinsi-provinsi lainnya. Kondisi berbalik ketika pada SP2010 dan LF SP2020, DKI Jakarta menjadi peringkat pertama dengan nilai IMR terendah dan DI Yogyakarta menempati peringkat kedua. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat secara konsisten menjadi provinsi dengan nilai IMR tertinggi sejak SP1971 sampai dengan SP2000. Baru pada SP2010, Nusa Tenggara Barat menempati posisi terendah kedua setelah Gorontalo. Berdasarkan SP1971, DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan IMR terendah yaitu 102 dan yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan IMR 221. Pada periode sensus selanjutnya yaitu SP1980, SP1990 dan SP2000 DI Yogyakarta masih menempati posisi pertama dengan masing-masing 62 (SP1980), 42 (SP1990) dan 25 (SP2000) dan posisi dengan IMR tertinggi masih di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 189 (SP1980), 145 (SP1990) dan 89 (SP2000). Berdasarkan hasil SP2010, DKI Jakarta bertukar posisi dengan DI Yogyakarta di posisi pertama dengan angka IMR mencapai 14. Demikian juga dengan Gorontalo yang menggantikan posisi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IMR tertinggi yaitu 56. Pada periode sensus terakhir yaitu LF SP2020, DKI Jakarta mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan IMR terendah yaitu mencapai 10,38 dan di posisi terakhir terdapat Provinsi Papua dengan IMR tertinggi yaitu 38,17.



Gambar 4.2 Perkembangan Angka Kematian Bayi Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia, SP1971–LF SP2020

4.2 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penghitungan umur harapan hidup dilakukan dengan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Data yang dimanfaatkan untuk penghitungan UHH adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Dalam proses penghitungan UHH, digunakan paket program Mortpak. Gambar 4.3 menampilkan umur harapan hidup berdasarkan hasil sensus penduduk yaitu SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010, dan LF SP2020. Dari grafik tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan usia harapan hidup dari setiap periode sensus. Berdasarkan hasil SP1971 UHH Indonesia adalah 45,7 tahun, angkanya mengalami kenaikan menjadi 52,2 tahun dari hasil SP1980 atau naik sebesar 14,22 persen. Lonjakan kenaikan UHH paling tinggi terjadi antara SP1980 dan SP1990 yaitu dari 52,2 tahun menjadi 59,8 tahun (naik 14,56 persen). Angka UHH terus mengalami kenaikan pada periode-periode sensus berikutnya dan akhirnya mencapai 73,37 tahun berdasarkan hasil LF SP2020.



Gambar 4.3 Perkembangan Umur Harapan Hidup di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan SP1971-LF SP2020

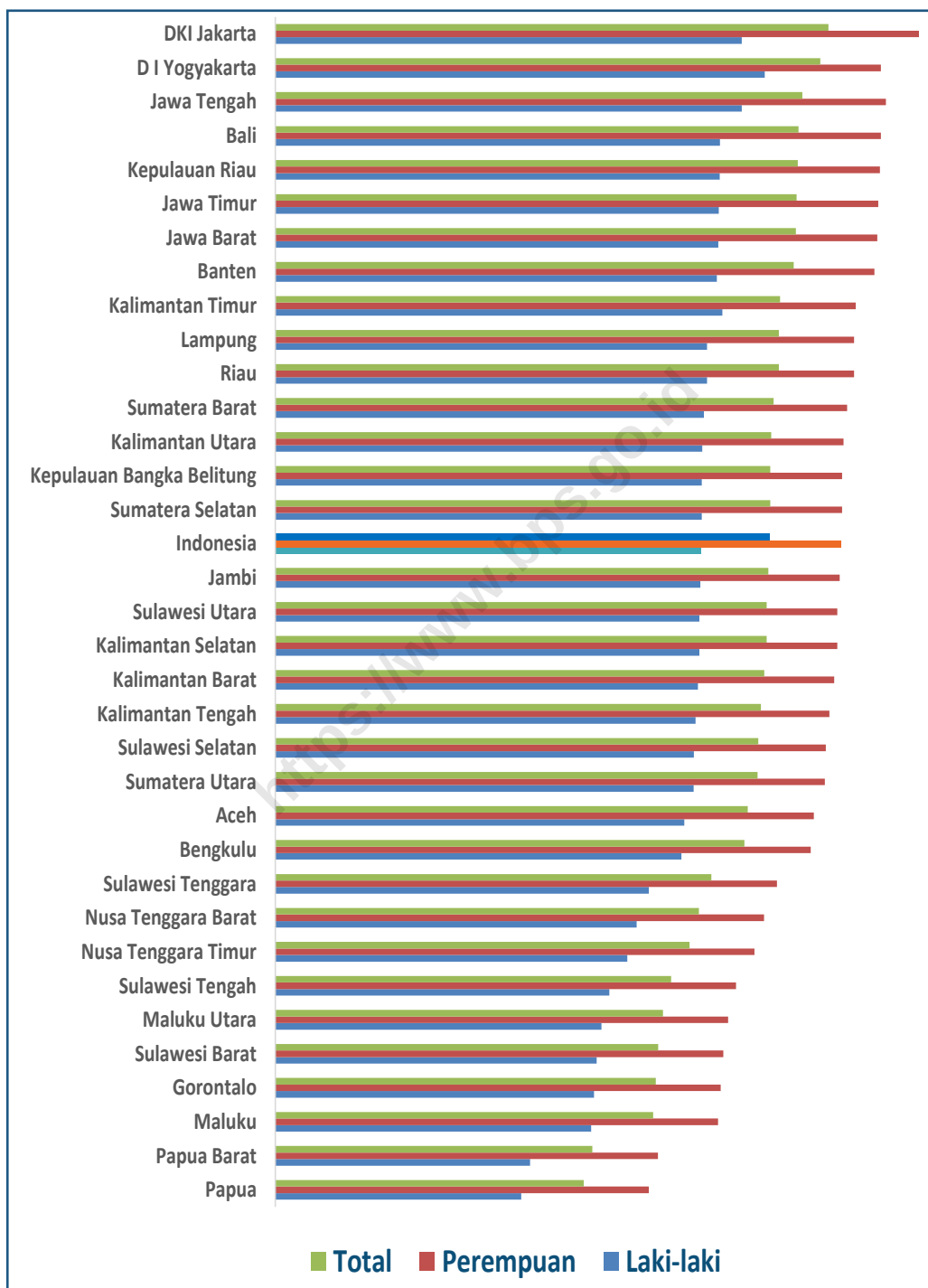
Jika diamati menurut jenis kelamin, baik UHH laki-laki maupun perempuan juga mengalami kenaikan dari setiap periode sensus dengan pola yang sama dimana UHH perempuan konsisten lebih tinggi daripada UHH laki-laki. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki usia harapan hidup lebih panjang daripada laki-laki (WHO, 2022). Perbedaan ini dikaitkan dengan berbagai faktor seperti faktor biologis, perilaku risiko, serta aspek sosial yaitu perbedaan akses terhadap perawatan kesehatan. Dari hasil SP1971, UHH laki-laki adalah 44,2 tahun sementara UHH perempuan 47,2 tahun. Hasil SP1980 mengalami kenaikan dimana UHH laki-laki menjadi 50,6 tahun dan UHH perempuan menjadi 53,7 tahun. Sebagaimana pada UHH total, lonjakan kenaikan UHH pada laki-laki maupun perempuan juga terjadi antara SP1980 dan SP1990 dengan kenaikan sebesar 14,53 persen untuk UHH laki-laki dan 14,56 persen UHH perempuan. UHH laki-laki dan perempuan terus naik hingga mencapai 71,25 tahun untuk UHH laki-laki dan 75,6 tahun untuk UHH perempuan.

Sama halnya dengan pola angka IMR di level provinsi, dengan kondisi yang terbalik, maka UHH semua provinsi cenderung menunjukkan adanya penurunan dari hasil SP1971 sampai dengan LF SP2020. Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta juga merupakan dua provinsi yang konsisten menempati posisi pertama dan kedua dengan nilai UHH tertinggi di Indonesia dan Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan nilai UHH terendah sejak SP1971 sampai dengan SP2000. Berdasarkan SP1971, dengan UHH 53,5 tahun, DI Yogyakarta menjadi provinsi menempati posisi tertinggi di Indonesia dan Nusa Tenggara Barat dengan UHH 35,0 tahun menempati posisi terendah. Demikian juga pada tahun-tahun sensus berikutnya. Selanjutnya, pada SP2010, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan UHH 74,7 tahun dan Gorontalo menjadi provinsi dengan UHH terendah yaitu 65,1 tahun.



Berdasarkan LF SP2020, Umur Harapan Hidup penduduk Indonesia adalah sebesar 73,37 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, seorang bayi yang lahir di Indonesia pada periode LF SP2020 diperkirakan akan hidup hingga usia 73 sampai 74 tahun. Apabila diamati menurut jenis kelamin, UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu masing-masing 75,6 untuk perempuan dan 71,25 untuk laki-laki. Sebagaimana terjadi secara global, dari hasil Long Form SP2020, umur harapan hidup perempuan di Indonesia lebih tinggi daripada umur harapan hidup laki-laki. Fakta ini mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan antara UHH dan AKB dimana pada ulasan sebelumnya, AKB laki-laki lebih tinggi daripada AKB perempuan.

Jika dilihat per provinsi, secara total, provinsi yang memiliki angka UHH paling tinggi adalah DKI Jakarta yaitu mencapai 75,2 tahun. Disusul DI Yogyakarta dengan UHH yang sedikit lebih rendah yaitu sebesar 74,95 tahun. Berbeda dari periode-periode sensus sebelumnya, berdasarkan LF SP2020, Jawa Tengah akhirnya mampu menduduki peringkat tertinggi ketiga dalam pencapaian angka UHH yaitu sebesar 74,39 tahun. Sementara itu, secara total, provinsi-provinsi di Indonesia wilayah timur mendominasi angka UHH dengan nilai terendah yang diawali dengan Papua sebagai provinsi dengan UHH terendah pertama dengan nilai UHH 67,59 tahun. Selanjutnya disusul oleh Papua Barat dengan UHH yang sedikit lebih tinggi dari Papua yaitu 67,86 tahun. Berikutnya, pada peringkat terendah ketiga ditempati oleh Maluku dengan UHH sebesar 69,75. Dengan angka UHH nasional sebesar 73,37, maka masih terdapat 19 provinsi atau lebih dari setengah dari seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki angka UHH di bawah angka nasional dan baru 15 provinsi yang mampu mencapai UHH di atas angka nasional (Gambar 4.4).



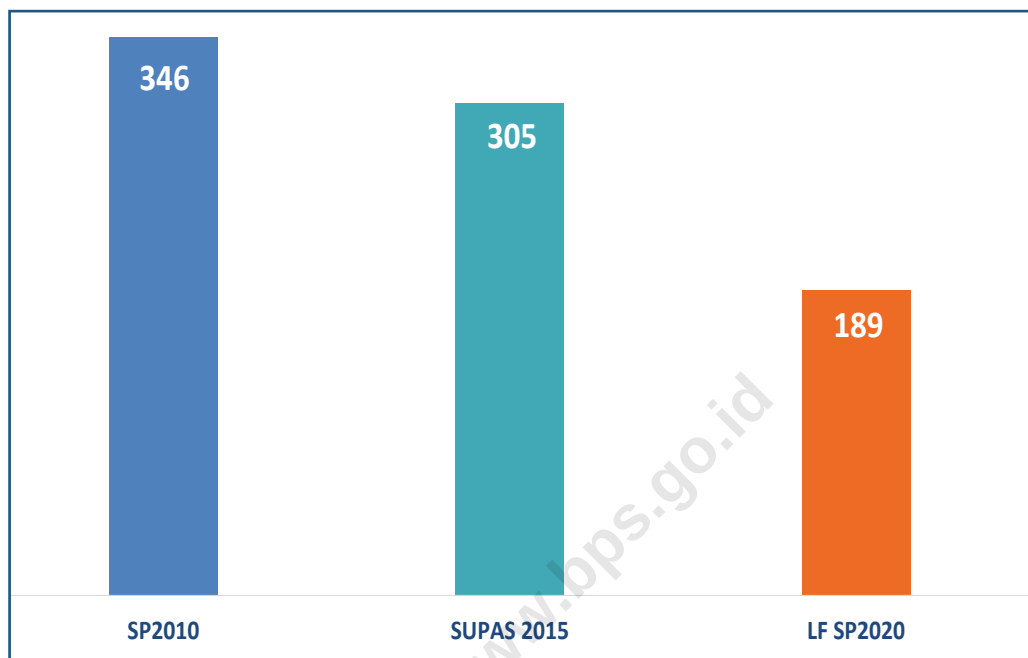
Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Hasil Long Form SP2020



4.3 Angka Kematian Ibu

SDG menetapkan target berupa penurunan angka kematian ibu secara global dimana pada tahun 2030 nilainya menjadi kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun telah tercapai kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu selama era MDG's, sempat terjadi stagnasi pada era SDG's ini (2016 s.d 2020). Diperkirakan sebanyak 287.000 perempuan meninggal dunia terkait dengan kehamilan dan persalinan atau sekitar 800 perempuan meninggal per hari karena kehamilan atau persalinan (WHO, 2023). Angka ini setara dengan 223 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tersebut. Pada beberapa wilayah, negara dan kelompok sosial masih terjadi ketimpangan angka kematian ibu yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya yang berkelanjutan dan menysar secara lebih merata untuk mencegah kematian ibu.

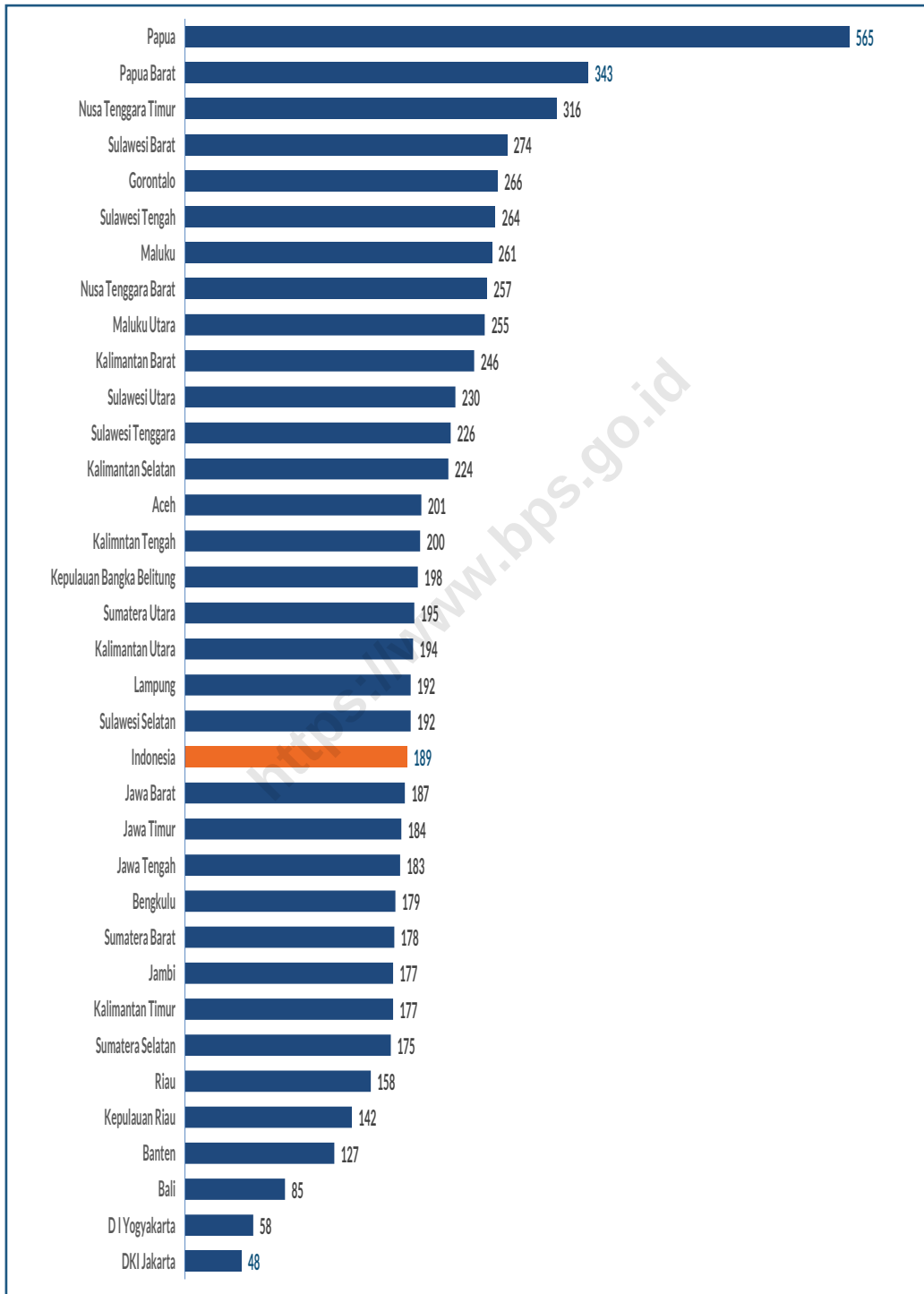
Definisi kematian ibu (*maternal death*) yang dirumuskan WHO dalam *the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem tenth revision*, 1992 (ICD 10) adalah kematian seorang perempuan dalam masa kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa mempertimbangkan lama dan letak kehamilan, dari semua penyebab yang berhubungan dengan dan/atau dipicu oleh kehamilan atau penatalaksanaannya tetapi bukan oleh sebab kecelakaan dan insiden. Definisi ini mencakup penyebab obstetri langsung maupun tidak langsung dimana terdapat beberapa aspek terkait bahwa perempuan yang mengalami kejadian kematian dalam keadaan baru/ sedang hamil, sedang melahirkan (lahir hidup/ lahir mati maupun abortus) atau pada masa nifas dalam waktu 42 hari setelah terminasi kehamilan, lama dan letak bayi dan bukan karena kecelakaan dan insiden (WHO, 2010).



Gambar 4.5 Tren Angka Kematian Ibu Indonesia, 2010–2020

Gambar 4.5 menunjukkan adanya penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia dimana berdasarkan SP2010 AKI di Indonesia masih cukup tinggi yaitu di angka 346 atau terdapat sebanyak 346 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SUPAS 2015 dan terakhir, berdasarkan hasil Long Form SP2020 turun drastis menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 4.6 menunjukkan Angka Kematian Ibu menurut provinsi berdasarkan hasil Long Form SP2020. Berdasarkan grafik ini, bisa diamati bahwa adanya penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia dari setiap periode sensus atau survei ini masih menyisakan pekerjaan besar lainnya yaitu adanya disparitas tingkat kematian ibu di berbagai wilayah di Indonesia terutama jika membandingkan kondisi antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Berdasarkan hasil LF SP2020 masih terdapat 20 provinsi di Indonesia dengan Angka Kematian Ibu di atas rata-rata angka nasional. Sebagian besar diantaranya merupakan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Sisanya, yaitu 14 provinsi dengan AKI di bawah angka nasional didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, Papua menempati posisi pertama dengan Angka Kematian Ibu tertinggi yaitu sebesar 565 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, disusul oleh Papua Barat dengan angka 343 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 4.6 Angka Kematian Ibu Menurut Provinsi Hasil Long Form SP2020



Selanjutnya, pada posisi ketiga tertinggi, terdapat provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai AKI sebesar 316 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Hampir serupa dengan indikator kematian lainnya, tiga provinsi dengan indikator kematian terbaik yaitu yang memiliki AKI terendah di Indonesia ditempati oleh provinsi-provinsi di Jawa dan Bali. Peringkat pertama dengan AKI terendah yaitu DKI Jakarta yang mampu menembus angka 48 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, sedikit lebih tinggi dari DKI Jakarta, D I Yogyakarta memiliki pencapaian dengan AKI sebesar 58 per 100.000 kelahiran hidup dan di posisi ketiga ditempati oleh Bali dengan AKI sebesar 85 per 100.000 kelahiran hidup.

Jika dibandingkan dengan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk AKI pada tahun 2024 dimana pemerintah menetapkan nilainya sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup, maka baru 12 provinsi di Indonesia yang mampu mencapai target tersebut.

4.4 Angka Kematian Anak

Angka Kematian Anak (AKABA) atau *Child Mortality Rate* (CMR) adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian anak ini tidak mencakup kematian bayi. Angka Kematian Anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung memengaruhi tingkat kesehatan anak karena kondisi kesehatan lingkungan dapat langsung memengaruhi tingkat kesehatan anak. Pada kondisi lingkungan yang tidak bersih, gizi buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah akan menyebabkan tingginya angka kematian anak. Jika dikaitkan dengan pencapaian SDGs, ketersediaan data terkait AKABA sangat penting dalam upaya pencapaian target khususnya terkait mortalitas, yaitu *no child being left behind*, karena data menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program berbasis bukti.

Rumus AKABA sebagai berikut:

$$AKABA = \frac{D_{1-4\text{tahun}}}{B} \times K$$

Keterangan:

AKABA : Angka Kematian Anak

$D_{(1-4\text{tahun})}$: Jumlah kematian anak berusia satu sampai empat tahun pada tahun tertentu di daerah tertentu

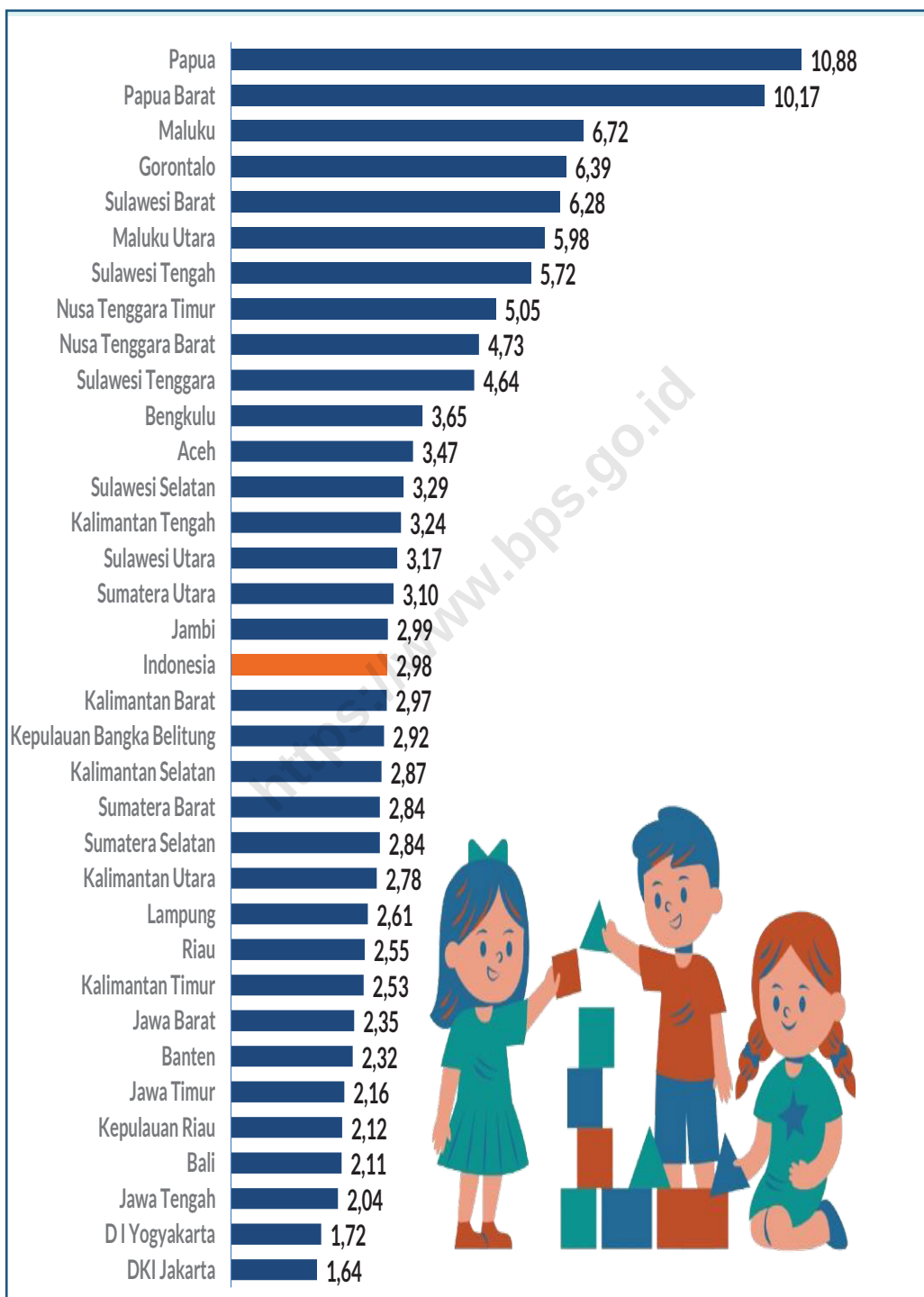
B : Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

K : Bilangan konstan 1000



Gambar 4.7 menunjukkan AKABA menurut provinsi berdasarkan hasil LF SP2020. Berdasarkan hasil LF SP2020, secara nasional, AKABA di Indonesia adalah 2,98 per 1000 kelahiran hidup yang artinya bahwa diantara 1000 kelahiran hidup, sekitar 3 orang diantara anak yang berumur antara 1 sampai 4 tahun tidak dapat mencapai usia 5 tahun. Jika dibandingkan dengan angka nasional, dari 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebanyak 17 provinsi atau setengah diantaranya memiliki nilai AKABA di atas angka nasional. Sebagian besar provinsi-provinsi tersebut yaitu sebanyak 12 provinsi diantaranya terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencakup provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Tin Afifah, dkk (2008) bahwa indikator mortalitas termasuk AKABA di KTI nilainya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera maupun Jawa-Bali.

Provinsi Papua menempati peringkat pertama dengan AKABA paling tinggi yaitu sebesar 10,88, disusul Papua Barat yang juga memiliki nilai AKABA dua digit yaitu sebesar 10,17. Pada posisi ketiga masih ditempati oleh provinsi di wilayah Indonesia bagian timur yaitu Provinsi Maluku dengan AKABA mencapai 6,72. Sementara itu, tiga provinsi dengan AKABA terendah merupakan provinsi-provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (1,64), disusul D I Yogyakarta (1,72) dan di peringkat ketiga ditempati Jawa Tengah (2,04). Jika dibandingkan dengan AKABA DKI Jakarta, maka AKABA provinsi Papua lebih dari 6 kali lipatnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi dalam pencapaian indikator mortalitas khususnya AKABA. Dalam penelitian lain ditemukan masih terdapat ketimpangan dalam pencapaian AKB dan AKABA di daerah. Beberapa daerah khususnya di timur Indonesia masih memiliki nilai AKABA yang jauh di atas angka nasional seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Masih adanya ketimpangan antar daerah bisa menjadi cerminan kurang optimalnya upaya daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak (Saputra, 2013). Beberapa daerah yang mampu menurunkan AKB dan AKABA seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi-provinsi yang memiliki inovasi dan kebijakan pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Tentunya bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memiliki arah dan strategi khusus dalam upaya penurunan AKB dan AKABA menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.



Gambar 4.7 Angka Kematian Anak Menurut Provinsi Hasil Long Form SP2020



4.5 Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita/AKBA atau *Under Five Mortality Rate* (U5MR) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup (termasuk kematian bayi). Pada tahun 2022, jumlah kematian anak di bawah lima tahun menurun menjadi 4,9 juta. Sejak tahun 2000, angka kematian balita global (U5MR) telah turun lebih dari setengahnya. Pencapaian yang signifikan ini didorong oleh komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah, organisasi, komunitas lokal, tenaga kesehatan, dan keluarga (UNICEF, 2024).

Rumus AKBA adalah sebagai berikut:

$$AKBA = \frac{D_{0-4\text{tahun}}}{B} \times K$$

Keterangan:

AKBA : Angka Kematian Balita

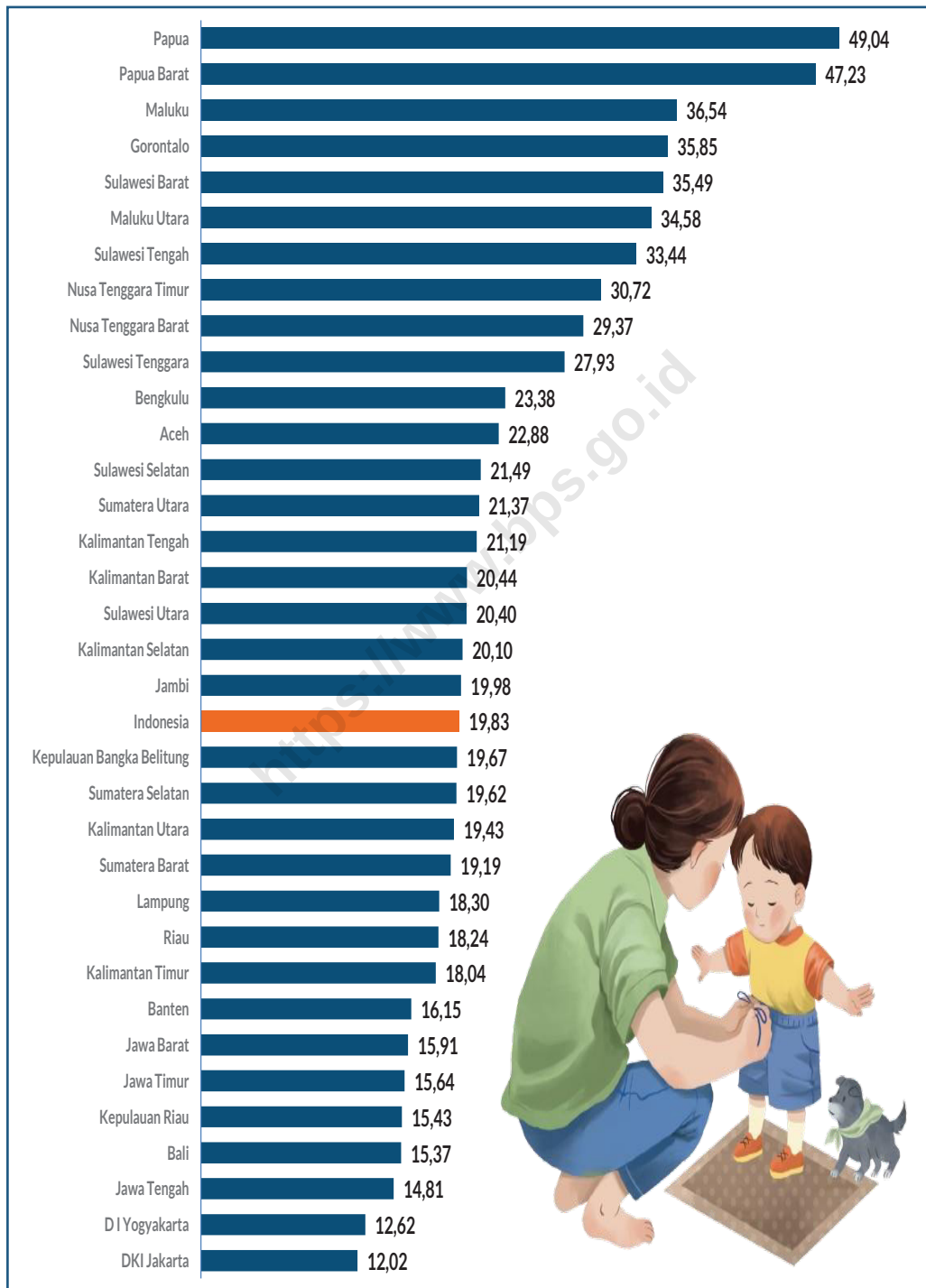
$D_{(0-4\text{tahun})}$: Jumlah kematian anak berusia nol sampai empat tahun pada tahun tertentu

B : Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

K : Bilangan konstan 1000

Berdasarkan hasil LF SP2020, angka kematian balita di Indonesia mencapai 19,83 per 1000 kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 1000 bayi yang lahir di Indonesia, sekitar 20 orang tidak dapat mencapai usia 5 tahun.

Gambar 4.8 menunjukkan Angka Kematian Balita menurut Provinsi Hasil Long Form SP2020. Jika diamati pada tingkat provinsi, masih nampak adanya kesenjangan antar provinsi terutama provinsi dengan AKBA terendah dan tertinggi. Sejalan dengan pola indikator mortalitas lainnya, berdasarkan hasil LF SP2020, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan AKBA terendah di Indonesia yaitu mencapai 12,02. Jauh berbeda dengan Papua yang merupakan provinsi dengan AKBA tertinggi dimana nilainya sebesar 49,04 atau hampir empat kali lipat dari AKBA DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan angka nasional, masih terdapat 19 provinsi yang memiliki AKBA lebih tinggi dari angka nasional. Sebagaimana terjadi pada indikator AKABA, sebagian besar provinsi dengan AKBA di atas angka nasional adalah provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu sebanyak 12 provinsi. Setelah DKI Jakarta, provinsi yang menempati posisi kedua dan ketiga dengan nilai AKBA terendah adalah DI Yogyakarta yaitu 12,62 dan disusul Jawa Tengah dengan nilai AKBA 14,81. Sementara itu, menyusul Papua, dua provinsi dengan AKBA tertinggi di Indonesia adalah Papua Barat yaitu sebesar 47,23 dan Maluku yang mencapai 36,54.



Gambar 4.8 Angka Kematian Balita Menurut Provinsi Hasil Long Form SP2020

5

Mobilitas Penduduk





5.1 Migrasi Risen

Migrasi Risen berkonsep penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu. Migrasi risen adalah perpindahan penduduk ke wilayah administrasi yang berbeda dalam lima tahun terakhir. Hal ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpindah tempat tinggal selama periode tersebut.

Migrasi Risen dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Migrasi Masuk Risen, Migrasi Keluar Risen, dan Migrasi Netto Risen. Migrasi Masuk Risen merujuk pada penduduk yang saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) yang berbeda dibandingkan dengan tempat tinggalnya lima tahun sebelumnya. Jumlah migran masuk risen ke suatu provinsi dihitung berdasarkan banyaknya penduduk yang lima tahun lalu tinggal di luar provinsi tersebut. Migrasi Masuk Risen menggambarkan jumlah penduduk usia lima tahun ke atas di suatu wilayah yang sebelumnya tinggal di wilayah administrasi lain, dinyatakan per 100 penduduk. Semakin tinggi persentase migran masuk risen, semakin banyak penduduk yang lima tahun sebelumnya tinggal di wilayah lain. Penyajian data berdasarkan wilayah memungkinkan perbandingan proporsi migran risen antarwilayah.

Perbandingan jumlah migran masuk risen dengan jumlah populasi dengan satuan persentase. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$m_i = \frac{M_i}{p_{i,t+n}} \times 100\%$$

Keterangan:

m_i : Persentase Migrasi Masuk

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode t dan $t+n$.

$p_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpotensi migrasi) di wilayah i pada tahun $t+n$.

Migrasi Keluar Risen mengacu pada penduduk yang saat pendataan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda (provinsi atau kabupaten/kota) dibandingkan tempat tinggal mereka lima tahun sebelumnya. Jumlah migran keluar risen dari suatu provinsi adalah total penduduk yang tinggal di provinsi lain saat pendataan, namun lima tahun lalu berdomisili di provinsi tersebut. Angka Migrasi Keluar Risen menunjukkan rasio penduduk yang berpindah tempat dalam lima tahun terakhir terhadap jumlah penduduk yang berpotensi bermigrasi di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase migrasi keluar risen, semakin banyak penduduk yang pindah dari wilayah itu dalam lima tahun terakhir sebelum pendataan.



Perbandingan jumlah migran keluar risen dengan jumlah population at risk.
Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$m_{.i} = \frac{M_{.i}}{p_{i,t+n} - M_{.i} + M_{i.}} \times 100\%$$

Keterangan:

m_i : Persentase Migrasi Keluar

$M_{.i}$: Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode i selama periode t dan t+n

$M_{i.}$: Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang keluar di wilayah i selama periode i selama periode t dan t+n

$P_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpotensi melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun t+n.

Migrasi Netto Risen mengacu pada penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dari wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) tempat tinggalnya lima tahun sebelumnya. Migrasi Netto Risen menghitung perbedaan jumlah migran risen yang masuk dan keluar, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berpotensi bermigrasi di suatu wilayah. Persentase migran netto risen menggambarkan apakah suatu wilayah menjadi pengirim atau penerima migran risen. Persentase positif menunjukkan lebih banyak migran risen yang masuk (wilayah penerima), sedangkan persentase negatif menunjukkan lebih banyak migran risen yang keluar (wilayah pengirim).

Menggunakan mekanisme penghitungan perbandingan net migrasi risen dengan jumlah penduduk yang berpotensi melakukan migrasi tengah periode. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

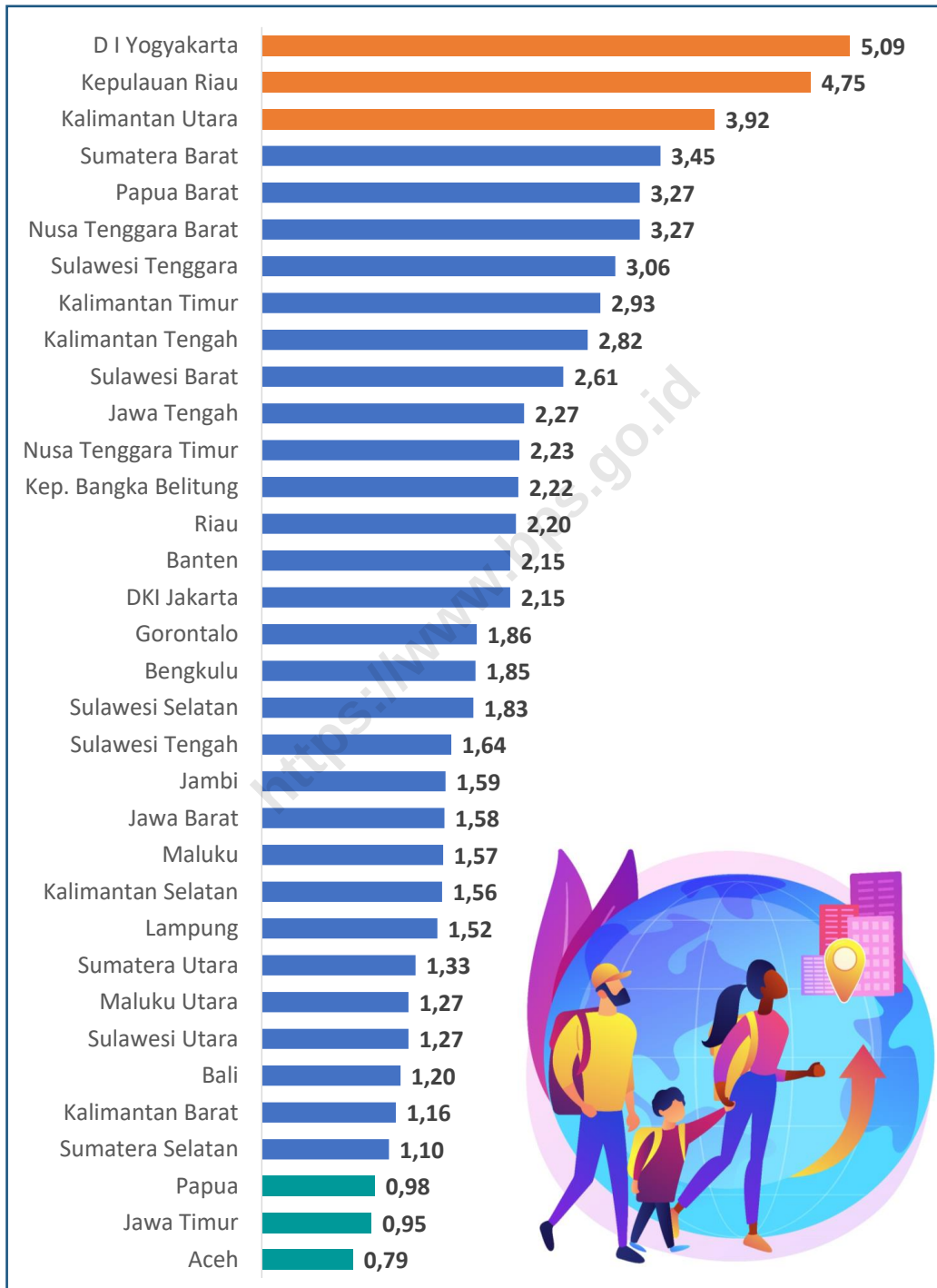
$$m_{(.i-.i)} = \frac{M_{.i} - M_{i.}}{p_{i,t+n} - 0,5(M_{.i} + M_{i.})} \times 100\%$$

m_i : Persentase Migrasi Netto

$M_{.i}$: Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode i selama periode t dan t+n

$M_{i.}$: Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang keluar di wilayah i selama periode i selama periode t dan t+

$P_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpotensi melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun t+n.



Gambar 5.1 Angka Migrasi Masuk Risen (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020

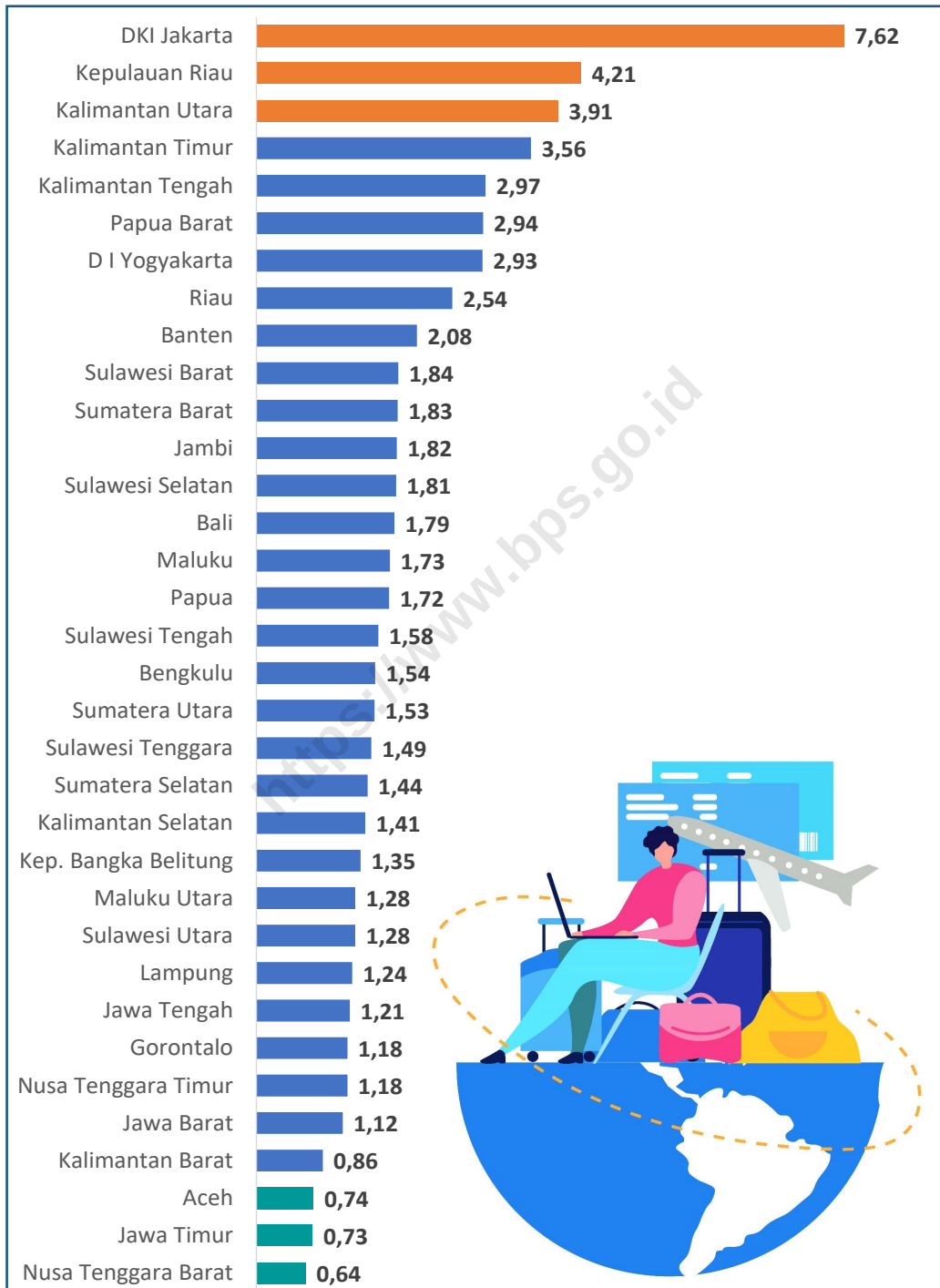


Gambar 5.1 tersebut menunjukkan tingkat migrasi masuk risen di Indonesia untuk tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi dengan Migrasi Masuk Tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta yang menempati posisi pertama dengan tingkat migrasi masuk sebesar 5,09, lalu disusul dengan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,75, dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,92. Provinsi DIY Yogyakarta, meskipun merupakan salah satu provinsi terkecil, memiliki daya tarik migrasi yang kuat. Mengingat Yogyakarta merupakan pusat pendidikan nasional, yang menjelaskan tingginya migrasi masuk dari kalangan pelajar dan mahasiswa, hal tersebut mungkin disebabkan oleh statusnya sebagai pusat pendidikan, dengan banyak universitas ternama. Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama di sektor industri dan perdagangan internasional, yang menarik banyak migran. Wilayah-wilayah dengan perkembangan ekonomi yang signifikan, seperti Kalimantan Utara (industri tambang) dan Kepulauan Riau (pelabuhan internasional dan industri), cenderung memiliki tingkat migrasi masuk yang tinggi.

Kemudian, Provinsi dengan Migrasi Masuk terendah adalah Provinsi Aceh yang memiliki tingkat migrasi masuk terendah yaitu sebesar 0,79, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 0,95, lalu disusul oleh Provinsi Papua sebesar 0,98. Rendahnya tingkat migrasi masuk di Aceh bisa disebabkan oleh faktor ekonomi atau infrastruktur yang masih berkembang, atau mungkin juga karena geografi yang kurang menguntungkan. Jawa Timur yang sebenarnya merupakan provinsi besar dengan populasi tinggi justru memiliki tingkat migrasi yang rendah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa penduduk Jawa Timur lebih banyak melakukan migrasi keluar daripada masuk.

Jika dilihat dari pengelompokkan wilayahnya, Jawa Tengah dan DIY menunjukkan tingkat migrasi masuk yang cukup tinggi, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur relatif rendah. Ini mencerminkan pergeseran migrasi dalam pulau, di mana pusat pendidikan dan pekerjaan menarik lebih banyak migran dibandingkan dengan daerah lainnya. Lalu, untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera, beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatera, seperti Kalimantan Utara dan Sumatera Barat, memiliki migrasi masuk yang cukup tinggi. Hal ini terkait dengan pengembangan infrastruktur dan potensi ekonomi seperti tambang dan perkebunan. Hal berbeda terlihat dari Provinsi Papua dan Maluku, Wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku menunjukkan angka migrasi yang relatif rendah. Faktor geografis dan pembangunan yang belum merata mungkin menjadi penyebab utamanya.

Dapat disimpulkan bahwa DIY Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara menunjukkan daya tarik migrasi yang kuat, dipengaruhi oleh pendidikan, perdagangan, dan industri. Selain itu, migrasi masuk cenderung terpusat di wilayah-wilayah dengan ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju, sementara wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, masih menunjukkan angka migrasi yang rendah. Provinsi-provinsi dengan migrasi masuk yang rendah mungkin memiliki tantangan dalam hal daya tarik ekonomi dan infrastruktur, namun juga membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih mendorong pembangunan di daerah tersebut. Migrasi masuk ini bisa menjadi indikator penting untuk memahami pola demografi dan pembangunan di Indonesia, serta arah kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan antar-wilayah.



Gambar 5.2 Angka Migrasi Keluar Risen (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020



Gambar 5.2 tersebut menunjukkan data migrasi keluar risen di Indonesia pada tahun 2022, yaitu jumlah migran yang meninggalkan suatu provinsi. Berdasarkan grafik tersebut, provinsi dengan migrasi keluar tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat migrasi keluar tertinggi, yaitu sebesar 7,62. Disusul oleh provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4,21. Lalu, Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi ketiga, yaitu sebesar 3,91.

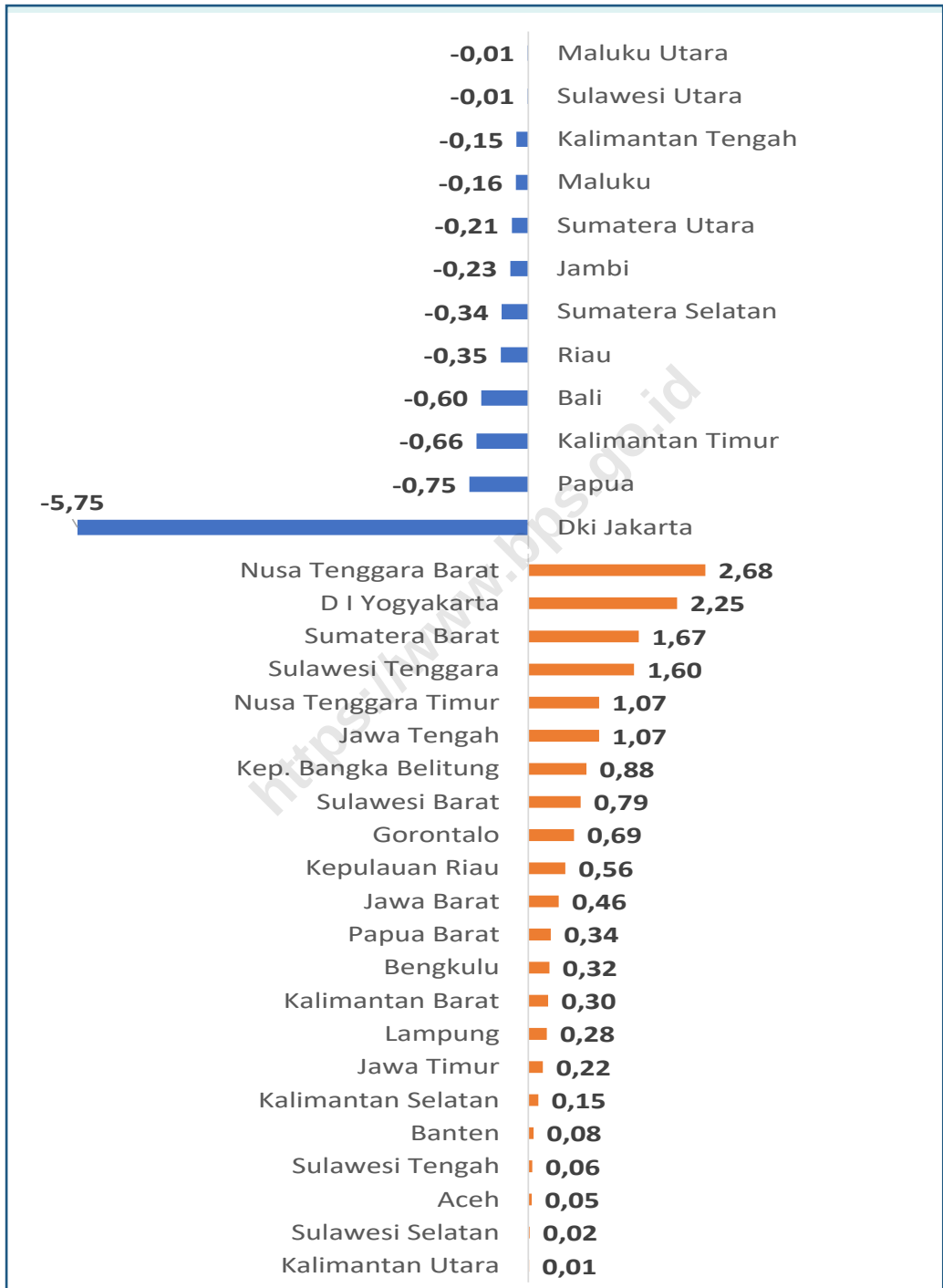
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki dinamika mobilitas yang tinggi. Tingginya tingkat migrasi keluar mungkin disebabkan oleh tingginya biaya hidup dan urbanisasi yang padat, sehingga banyak orang memilih pindah ke daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah atau untuk mencari kesempatan di wilayah lain. Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara juga menunjukkan migrasi keluar yang tinggi, kemungkinan karena keterbatasan lapangan pekerjaan lokal dan sifat wilayah ini yang merupakan pusat industri atau tambang. Banyak penduduk mungkin berpindah ke provinsi lain yang menawarkan lebih banyak kesempatan.

Provinsi dengan Migrasi Keluar Terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat migrasi keluar terendah, yaitu 0,64, diikuti oleh provinsi Jawa Timur, yaitu 0,73, dan Aceh dengan nilai 0,74. Rendahnya migrasi keluar di Nusa Tenggara Barat bisa mencerminkan keterikatan penduduk lokal terhadap wilayah tersebut, mungkin karena faktor budaya atau ketergantungan pada sumber daya lokal. Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia, memiliki angka migrasi keluar yang rendah, menunjukkan bahwa banyak penduduk mungkin lebih memilih untuk tinggal di sana karena stabilitas ekonomi atau hubungan keluarga.

Provinsi Banten dan Riau menunjukkan tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi, tetapi tidak termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat migrasi masuk yang tinggi. Ini mungkin menunjukkan bahwa provinsi ini berfungsi sebagai daerah penghubung atau transit, di mana penduduk lokal lebih cenderung pindah ke daerah lain, mungkin ke provinsi besar seperti DKI Jakarta atau wilayah sekitarnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Jika dilihat dari sisi geografisnya, DKI Jakarta memiliki migrasi keluar yang tinggi, namun provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki angka yang jauh lebih rendah. Ini mencerminkan bahwa Jawa, sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia, memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk dari provinsi lain, meskipun ada beberapa orang yang meninggalkan Jakarta, mungkin untuk menghindari kepadatan atau mencari lingkungan hidup yang lebih baik di luar ibukota. Selain itu, beberapa provinsi di Kalimantan dan Papua memiliki tingkat migrasi keluar yang relatif tinggi. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam, peluang kerja yang terkait dengan industri ini mungkin tidak cukup untuk mempertahankan penduduk lokal dalam jangka panjang.

Jika dilihat dari sisi faktor pendorongnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki biaya hidup yang sangat tinggi dan tingkat urbanisasi yang pesat, sehingga banyak penduduk, terutama kelas menengah dan bawah, mungkin memilih untuk pindah ke daerah pinggiran atau provinsi lain dengan biaya hidup yang lebih rendah. Kemudian, beberapa provinsi seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau, meskipun memiliki industri besar, mungkin masih terbatas dalam hal penyediaan pekerjaan bagi penduduk lokal, mendorong mereka untuk mencari peluang di tempat lain.



Gambar 5.3 Angka Migrasi Risen Neto Positif (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020



Maka, dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat migrasi keluar yang sangat tinggi, menandakan bahwa, meskipun merupakan pusat ekonomi Indonesia, banyak penduduk yang meninggalkan ibukota karena berbagai faktor, termasuk biaya hidup yang tinggi dan kesempatan di daerah lain. Lalu, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan provinsi di Kalimantan lainnya juga menunjukkan angka migrasi keluar yang signifikan, mencerminkan dinamika populasi yang mungkin disebabkan oleh fluktuasi dalam peluang ekonomi atau industri di daerah tersebut. Provinsi dengan migrasi keluar terendah, seperti Nusa Tenggara Barat dan Aceh, menunjukkan ketahanan populasi lokal terhadap migrasi keluar, mungkin karena keterikatan budaya atau kurangnya kesempatan di daerah lain. Data ini menggambarkan bagaimana dinamika migrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan geografis yang bervariasi antara satu provinsi dengan lainnya.

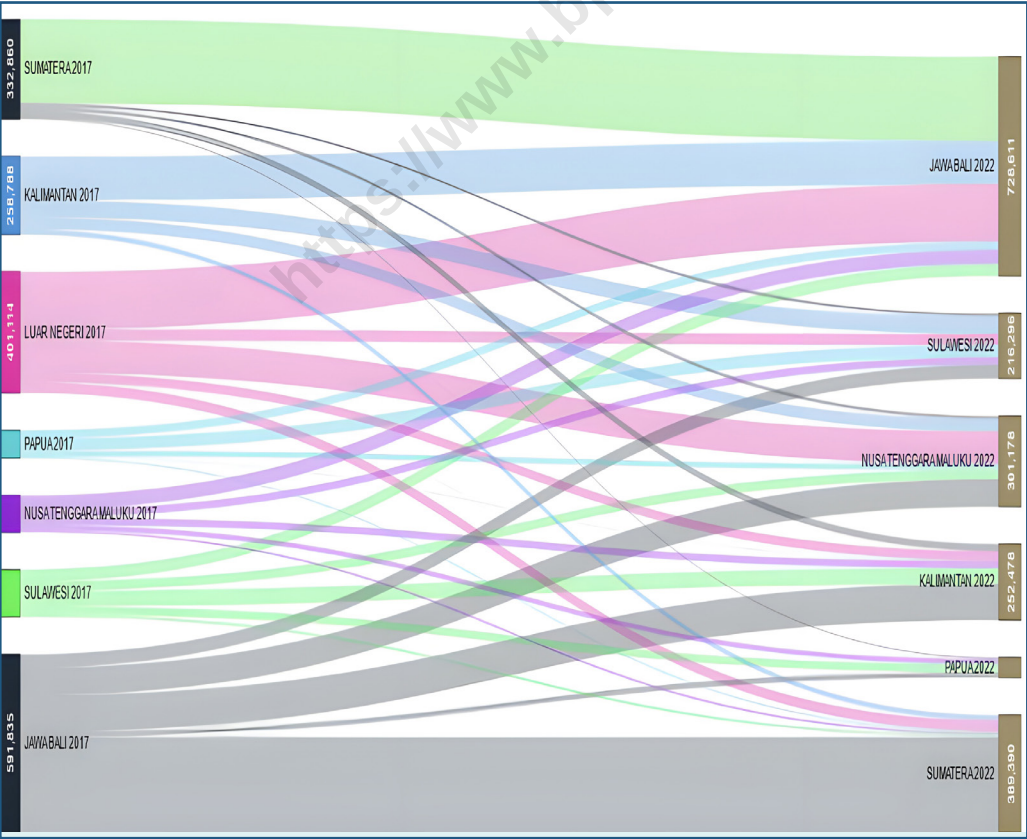
Gambar 5.3 menunjukkan migrasi neto atau selisih antara jumlah migrasi masuk dan keluar pada berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Nilai positif menandakan bahwa lebih banyak orang yang masuk ke provinsi tersebut dibandingkan yang keluar, sementara nilai negatif menandakan sebaliknya. Jika angkanya positif, lebih banyak orang pindah masuk ke provinsi tersebut, sedangkan nilai negatif menunjukkan lebih banyak orang yang meninggalkan provinsi tersebut. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi dengan Migrasi Neto Positif Tertinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (+2,68), disusul oleh DI Yogyakarta (+2,25), dan Sumatera Barat (+1,67). Hal tersebut kemungkinan dikarenakan Provinsi NTB menjadi destinasi migrasi terbesar, menunjukkan peningkatan masuknya penduduk. Kemungkinan besar ini terkait dengan pengembangan sektor pariwisata (seperti Mandalika), pembangunan infrastruktur, atau kembalinya pekerja migran ke daerah asal setelah pandemi. Selain itu, Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya. Peningkatan migrasi masuk bisa disebabkan oleh kedatangan mahasiswa, atau peningkatan jumlah pekerja di sektor pariwisata dan jasa. Urbanisasi dan kualitas hidup yang baik juga menarik migrasi masuk. Serta, Sumatera Barat menunjukkan migrasi neto positif, mungkin karena arus balik migran atau orang yang kembali ke kampung halaman pascapandemi, serta perkembangan ekonomi berbasis UMKM dan sektor pariwisata.

Kemudian, Provinsi dengan Migrasi Neto Negatif atau migrasi keluar lebih tinggi dari migrasi masuk, adalah provinsi DKI Jakarta (-5,75), Papua (-0,75), dan Bali (-0,60). Hal tersebut kemungkinan dikarenakan oleh urbanisasi balik ke kampung halaman atau provinsi asal, tingginya biaya hidup, dan kondisi pascapandemi yang membuat beberapa orang lebih memilih menetap di kota-kota satelit atau daerah asal mereka. Lain halnya di Papua, penurunan jumlah penduduk di Papua bisa disebabkan oleh perpindahan tenaga kerja ke daerah lain atau tantangan dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Namun, yang terjadi di Bali, meskipun dikenal sebagai destinasi pariwisata, menunjukkan migrasi neto negatif. Ini bisa disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi atau adanya pekerja sektor informal yang keluar menuju daerah asal mereka.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogyakarta, dan Sumatera Barat mencatat peningkatan migrasi masuk pada tahun 2022, yang menandakan adanya pemulihan ekonomi dan berkembangnya sektor pariwisata. NTB mengalami lonjakan migrasi masuk karena pembangunan infrastruktur seperti Sirkuit Mandalika dan pariwisata berbasis alam. Sementara itu, Yogyakarta tetap menjadi magnet bagi mahasiswa dan pekerja di sektor jasa dan pariwisata. Di Sumatera Barat, arus balik perantau pascapandemi serta penguatan ekonomi lokal melalui UMKM dan pariwisata turut mendorong peningkatan migrasi.

Sebaliknya, DKI Jakarta dan Papua mengalami migrasi keluar tertinggi, mencerminkan beberapa masalah struktural seperti tingginya biaya hidup, perpindahan tenaga kerja, dan tren urbanisasi balik. Jakarta, sebagai kota metropolitan, mengalami eksodus penduduk yang memilih menetap di daerah asal atau kota-kota satelit dengan biaya hidup lebih rendah. Di Papua, kondisi sosial-ekonomi dan terbatasnya peluang kerja menyebabkan banyak orang berpindah ke provinsi lain. Secara keseluruhan, pola migrasi pada 2022 mencerminkan dampak langsung dari pandemi COVID-19, di mana perubahan prioritas ekonomi, pemulihan sektor pariwisata, dan biaya hidup menjadi faktor utama yang memengaruhi perpindahan penduduk di berbagai wilayah Indonesia.



Gambar 5.4 Grafik Sankey Migrasi Risen di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020



Grafik Sankey yang ditampilkan di atas menggambarkan arus Migrasi Risen di Indonesia pada tahun 2022, mencakup berbagai wilayah di Indonesia dan mencerminkan perubahan arah migrasi dari tahun 2017 hingga 2022 yang bisa diamati dari sisi kiri ke sisi kanan pada grafik Sankey di atas. Grafik ini sekaligus menunjukkan pola perpindahan penduduk antarwilayah di Indonesia serta interaksi migrasi luar negeri yang khusus untuk menggambarkan Migrasi Risen.

a. Wilayah Sumatera

Berdasarkan data yang ditampilkan, arus Migrasi Risen dari Sumatera tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa wilayah Jawa-Bali menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 279.940 orang atau sekitar 84,10% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik wilayah tersebut, yang didorong oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan fasilitas yang lebih maju. Di sisi lain, Kalimantan menjadi tujuan migrasi terbesar kedua dengan jumlah 23.752 orang atau 7,14%, yang mungkin terkait dengan proyek pembangunan dan peluang kerja. Sulawesi mencatat jumlah migrasi sebesar 12.400 orang atau 3,73%, sementara Nusa Tenggara dan Maluku mencatat 13.056 orang atau 3,92%, keduanya menunjukkan kontribusi yang lebih kecil namun signifikan. Papua mencatat jumlah migrasi terendah sebesar 3.712 orang atau 1,12%, yang kemungkinan disebabkan oleh jarak geografis dan minimnya peluang ekonomi.

Sebaliknya, arus migrasi menuju Sumatera pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi daerah asal terbesar dengan kontribusi 316.502 orang atau 81,28% dari total migrasi, yang kemungkinan didorong oleh tingginya biaya hidup di Jawa-Bali. Kalimantan menyumbang 17.744 orang atau 4,56%, diikuti oleh Sulawesi dengan 8.768 orang atau 2,25%, serta Nusa Tenggara dan Maluku dengan 7.021 orang atau 1,80%. Papua mencatat migrasi terkecil sebesar 4.559 orang atau 1,17%, sedangkan migrasi dari luar negeri mencapai 34.796 orang atau 8,94%. Total migrasi ke Sumatera selama periode ini adalah 389.390 orang, dengan faktor pendorong utama berupa peluang ekonomi, biaya hidup yang lebih rendah, serta daya tarik Sumatera sebagai tujuan domestik maupun internasional.

b. Wilayah Jawa-Bali

Arus Migrasi Risen dari wilayah Jawa-Bali tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa Sumatera menjadi tujuan utama migrasi dengan jumlah migran mencapai 316.502 orang atau 53,48% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Sumatera, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh biaya hidup yang lebih rendah, peluang ekonomi, dan ketersediaan lahan yang luas. Kalimantan menjadi tujuan terbesar kedua dengan 120.900 orang atau 20,43%, didorong oleh proyek-proyek pembangunan besar seperti rencana ibu kota baru. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 91.307 orang atau 15,43%, mencerminkan minat terhadap potensi pariwisata atau pengembangan wilayah. Sulawesi menerima 44.987 orang atau 7,60%, didorong oleh sektor agrikultur dan infrastruktur. Papua mencatat jumlah migrasi terkecil, yakni 18.139 orang atau 3,06%, kemungkinan karena tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Total migrasi dari Jawa-Bali selama periode ini adalah 591.835 orang. Secara keseluruhan, migrasi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk di Jawa-Bali mendorong perpindahan ke wilayah dengan peluang yang lebih baik, terutama Sumatera.



Sebaliknya, pada tahun 2022, Jawa-Bali tetap menjadi pusat utama daya tarik migrasi di Indonesia. Sumatera menjadi daerah asal utama migrasi dengan jumlah 279.940 orang atau 38,42% dari total migrasi, diikuti oleh Kalimantan yang menyumbang 144.504 orang atau 19,83%. Migrasi dari luar negeri menjadi kontribusi signifikan dengan 190.922 orang atau 26,20%, menunjukkan bahwa Jawa-Bali juga menjadi pusat migrasi internasional. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat 46.685 orang atau 6,41%, sedangkan Sulawesi dan Papua masing-masing menyumbang 39.375 orang (5,40%) dan 27.185 orang (3,73%). Total migrasi menuju Jawa-Bali selama periode ini mencapai 728.611 orang. Faktor utama yang mendorong migrasi ke Jawa-Bali mencakup peluang ekonomi, akses pendidikan, dan fasilitas publik yang lebih baik, sementara kontribusi migrasi luar negeri menunjukkan peran penting Jawa-Bali sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi berskala internasional.

c. Wilayah Kalimantan

Arus Migrasi Risen dari wilayah Kalimantan tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 144.504 orang atau 55,84% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial. Sulawesi menjadi tujuan kedua dengan 56.502 orang atau 21,83%, yang mencerminkan hubungan ekonomi dan geografis yang erat antara kedua wilayah. Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 39.218 orang atau 15,15%, diikuti oleh Sumatera dengan 17.744 orang atau 6,86%. Papua mencatat jumlah migrasi terendah, yaitu 820 orang atau 0,32%, mencerminkan tantangan geografis dan infrastruktur. Total migrasi dari Kalimantan selama periode ini mencapai 258.788 orang. Kesimpulannya, arus migrasi ini cenderung terpusat ke wilayah ekonomi tinggi seperti Jawa-Bali, sementara Papua menerima migrasi yang sangat kecil karena tantangan geografis.

Sebaliknya, pada tahun 2022, Jawa-Bali menjadi daerah asal terbesar migrasi ke Kalimantan, dengan jumlah migran mencapai 120.900 orang atau 47,89%. Hal ini menunjukkan daya tarik Kalimantan sebagai wilayah dengan peluang kerja baru di sektor sumber daya alam dan infrastruktur. Sulawesi menjadi sumber migrasi terbesar kedua dengan 51.298 orang atau 20,32%, diikuti oleh luar negeri dengan 30.653 orang atau 12,14%. Sumatera menyumbang 23.752 orang atau 9,41%, sementara Nusa Tenggara dan Maluku mencatat 24.397 orang atau 9,66%. Papua mencatat jumlah migrasi terendah, yaitu 1.478 orang atau 0,59%. Total migrasi menuju Kalimantan selama periode ini mencapai 252.478 orang. Kalimantan menjadi daerah tujuan yang menarik, terutama bagi penduduk Jawa-Bali dan Sulawesi, serta mencatat kontribusi signifikan dari migrasi luar negeri, meskipun migrasi dari Papua tetap kecil karena kendala akses dan geografis.

d. Wilayah Sulawesi

Arus Migrasi Risen dari wilayah Sulawesi tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Kalimantan menjadi tujuan utama migrasi dengan jumlah mencapai 51.298 orang atau 32,75% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Kalimantan bagi penduduk Sulawesi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh peluang kerja di sektor sumber daya alam, agrikultur, atau proyek infrastruktur. Jawa-Bali menjadi tujuan kedua dengan jumlah migrasi sebesar 39.375 orang atau 25,14%, menunjukkan bahwa wilayah ini tetap menjadi magnet migrasi, terutama karena peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lebih baik. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 30.969



orang atau 19,77%, diikuti oleh Papua dengan 26.216 orang atau 16,74%. Kedua wilayah ini menunjukkan hubungan geografis dan budaya yang erat dengan Sulawesi. Sumatera mencatat jumlah migrasi terkecil, yakni 8.768 orang atau 5,60%, yang kemungkinan disebabkan oleh jarak geografis dan peluang ekonomi yang lebih rendah. Total migrasi dari Sulawesi selama periode ini adalah 156.626 orang, dengan Kalimantan dan Jawa-Bali menjadi tujuan utama.

Sebaliknya, pada tahun 2022, Kalimantan menjadi daerah asal terbesar migrasi ke Sulawesi, dengan jumlah mencapai 56.502 orang atau 26,12% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan hubungan geografis dan ekonomi yang signifikan antara kedua wilayah, terutama di sektor agrikultur dan perdagangan. Jawa-Bali menyumbang 44.987 orang atau 20,80%, menunjukkan potensi pengembangan wilayah Sulawesi sebagai daya tarik migrasi. Papua menyumbang 40.045 orang atau 18,51%, yang didorong oleh kedekatan geografis dan hubungan budaya. Migrasi dari luar negeri mencatat jumlah signifikan, yaitu 37.068 orang atau 17,14%, menunjukkan bahwa Sulawesi menjadi tujuan menarik bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat 25.294 orang atau 11,69%, sementara Sumatera menyumbang 12.400 orang atau 5,73%, mencerminkan minimnya hubungan ekonomi dan geografis antara Sumatera dan Sulawesi. Total migrasi menuju Sulawesi selama periode ini adalah 216.296 orang, dengan Kalimantan, Jawa-Bali, dan Papua sebagai kontributor utama.

e. Wilayah Nusa Tenggara-Maluku

Arus Migrasi Risen dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 46.685 orang atau 38,86% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lebih maju. Sulawesi menjadi tujuan kedua terbesar dengan jumlah migrasi sebesar 25.294 orang atau 21,05%, didorong oleh kedekatan geografis dan hubungan sosial-budaya. Kalimantan mencatat jumlah migrasi sebesar 24.397 orang atau 20,31%, yang menunjukkan potensi ekonomi baru sebagai daya tarik utama. Papua menerima 16.742 orang atau 13,94%, mencerminkan hubungan regional yang kuat, sementara Sumatera mencatat jumlah migrasi terkecil, yaitu 7.021 orang atau 5,84%, kemungkinan karena keterbatasan geografis dan hubungan ekonomi. Total migrasi dari Nusa Tenggara dan Maluku selama periode ini adalah 120.139 orang, dengan dominasi perpindahan ke Jawa-Bali dan wilayah dengan potensi ekonomi yang signifikan.

Sebaliknya, pada tahun 2022, wilayah Nusa Tenggara dan Maluku menjadi tujuan migrasi yang signifikan, terutama dari luar negeri yang menyumbang 107.235 orang atau 35,61% dari total migrasi. Hal ini menunjukkan daya tarik wilayah ini bagi WNI yang kembali dari luar negeri, terutama karena faktor hubungan keluarga dan budaya. Jawa-Bali menyumbang 91.307 orang atau 30,32%, mencerminkan hubungan migrasi yang erat. Kalimantan mencatat migrasi sebesar 39.218 orang atau 13,02%, diikuti oleh Sulawesi dengan 30.969 orang atau 10,28%, menunjukkan hubungan ekonomi dan geografis yang erat. Papua menyumbang 19.393 orang atau 6,44%, sementara Sumatera mencatat jumlah migrasi terkecil sebesar 13.056 orang atau 4,33%, mencerminkan koneksi yang terbatas. Total migrasi menuju Nusa Tenggara dan Maluku selama periode ini mencapai 301.178 orang, dengan kontribusi utama dari luar negeri dan Jawa-Bali, serta hubungan signifikan dengan Kalimantan dan Sulawesi.



f. Wilayah Papua

Arus Migrasi Risen dari wilayah Papua tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Sulawesi menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 40.045 orang atau 43,22% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan kedekatan geografis dan peluang ekonomi di Sulawesi, terutama di sektor agrikultur dan perikanan, sebagai daya tarik utama bagi penduduk Papua. Jawa-Bali berada di posisi kedua dengan 27.185 orang atau 29,34%, yang menunjukkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang maju. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 19.393 orang atau 20,93%, mencerminkan hubungan budaya dan geografis yang erat. Sumatera menerima 4.559 orang atau 4,92%, sedangkan Kalimantan mencatat migrasi terkecil, yaitu 1.478 orang atau 1,60%, menunjukkan keterbatasan hubungan geografis dan peluang ekonomi dengan Papua. Total migrasi dari Papua selama periode ini adalah 92.660 orang, dengan Sulawesi dan Jawa-Bali sebagai tujuan utama.

Sebaliknya, pada tahun 2022, Sulawesi menjadi sumber migrasi utama ke Papua dengan jumlah 26.216 orang atau 39,68%, menunjukkan hubungan geografis dan peluang ekonomi yang signifikan antara kedua wilayah. Jawa-Bali menyumbang 18.139 orang atau 27,45%, mencerminkan program pembangunan dan peluang kerja di Papua sebagai daya tarik. Nusa Tenggara dan Maluku mencatat 16.742 orang atau 25,34%, didorong oleh hubungan budaya dan geografis. Sumatera menyumbang 3.712 orang atau 5,62%, diikuti oleh Kalimantan dengan jumlah migrasi terkecil, yaitu 820 orang atau 1,24%. Migrasi dari luar negeri sangat kecil, hanya sebesar 440 orang atau 0,67%, menunjukkan bahwa Papua bukan tujuan utama bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Total migrasi ke Papua selama periode ini adalah 66.069 orang, dengan Sulawesi, Jawa-Bali, dan Nusa Tenggara-Maluku sebagai kontributor utama, mencerminkan pengaruh geografis, budaya, dan peluang ekonomi lokal.

g. Wilayah Luar Negeri

Arus Migrasi Risen dari wilayah luar negeri tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan utama, dengan jumlah migran mencapai 190.922 orang atau 47,60% dari total migrasi, mencerminkan daya tarik wilayah ini sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lengkap, sehingga menjadi pilihan utama bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku berada di posisi kedua dengan 107.235 orang atau 26,73%, menunjukkan hubungan kultural dan keluarga yang erat, diikuti oleh Sumatera yang menerima 34.796 orang atau 8,67%, yang mencerminkan peluang agrikultur atau ekonomi lokal. Sulawesi mencatat 37.068 orang atau 9,24%, disusul Kalimantan dengan 30.653 orang atau 7,64%, keduanya mencerminkan daya tarik dari peluang kerja dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Papua mencatat migrasi terkecil dengan 440 orang atau 0,11%, menegaskan bahwa wilayah ini bukanlah tujuan utama bagi WNI yang kembali dari luar negeri, kemungkinan karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Total migrasi risen dari luar negeri menuju Indonesia selama periode ini mencapai 401.114 orang, dengan Jawa-Bali mendominasi, diikuti oleh Nusa Tenggara dan Maluku, serta kontribusi dari Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, sedangkan Papua menerima bagian terkecil.



5.2 Migrasi Seumur Hidup

Seseorang dikatakan melakukan migrasi seumur hidup apabila kabupaten/kota tempat tinggal pada saat dilakukan sensus/survei berbeda dengan kabupaten/kota tempat lahirnya.

Migrasi Seumur Hidup dibagi menjadi tiga, yaitu Migrasi Masuk Seumur Hidup, Migrasi Keluar Seumur Hidup, dan Migrasi Netto Seumur Hidup. Migrasi Seumur Hidup Masuk berkonsep penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya. Banyaknya penduduk yang pada saat pendataan tinggal di suatu wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya per 100 penduduk. Migrasi Seumur Hidup menginterpretasikan semakin tinggi persentase migran masuk seumur hidup di suatu wilayah, artinya semakin banyak penduduk wilayah tersebut yang lahir di wilayah lain. Penyajian menurut wilayah dapat menunjukkan keterbandingan proporsi migran seumur hidup antarwilayah.

Perbandingan jumlah migran masuk seumur hidup dengan jumlah populasi. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$m_i = \frac{M_i}{P_{i,t+n}} \times 100\%$$

Keterangan:

m_i : Persentase Migrasi Keluar

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode i selama periode t dan $t+n$

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang keluar di wilayah i selama periode i selama periode t dan $t+n$

$P_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpeluang melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun $t+n$.

Migrasi Seumur Hidup Keluar berkonsep pada penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya. Perbandingan antara jumlah penduduk yang lahir di suatu wilayah administrasi dan tercatat telah bermigrasi pada saat pendataan, dengan jumlah penduduk yang berpeluang bermigrasi pada suatu wilayah. Migrasi Seumur Hidup Keluar menginterpretasikan semakin tinggi persentase migran keluar seumur hidup, artinya semakin banyak penduduk yang lahir di wilayah tersebut namun pada saat pendataan tinggal di wilayah lain. Penyajian menurut wilayah dapat menunjukkan keterbandingan proporsi migran keluar seumur hidup antarwilayah.

Perbandingan jumlah migran keluar seumur hidup dengan jumlah penduduk yang berpeluang melakukan migrasi. Rumus yang digunakan sebagai berikut:



$$m_i = \frac{M_i}{p_{i,t+n} - M_i + M_i} \times 100\%$$

m_i : Persentase Migrasi Keluar

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode t dan t+n

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang keluar di wilayah i selama periode t dan t+n

$P_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpotensi melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun t+n.

Migrasi Seumur Hidup Netto berkonsep pada penduduk yang pada saat pencacahan tinggal di wilayah administrasi yang berbeda dengan wilayah administrasi tempat lahirnya. Perbandingan selisih antara jumlah migran masuk seumur hidup dan migran keluar seumur hidup terhadap penduduk yang berpotensi bermigrasi pada suatu wilayah. Migrasi Seumur Hidup Netto menginterpretasikan persentase migran netto seumur hidup menunjukkan gambaran suatu wilayah merupakan pengirim atau penerima migran. Persentase positif artinya migran seumur hidup masuk lebih besar daripada migran seumur hidup keluar (penerima). Sedangkan persentase negatif artinya migran seumur hidup masuk lebih kecil daripada migran seumur hidup keluar (pengirim).

Perbandingan net migrasi seumur hidup dengan Jumlah penduduk yang berpotensi melakukan migrasi tengah periode. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

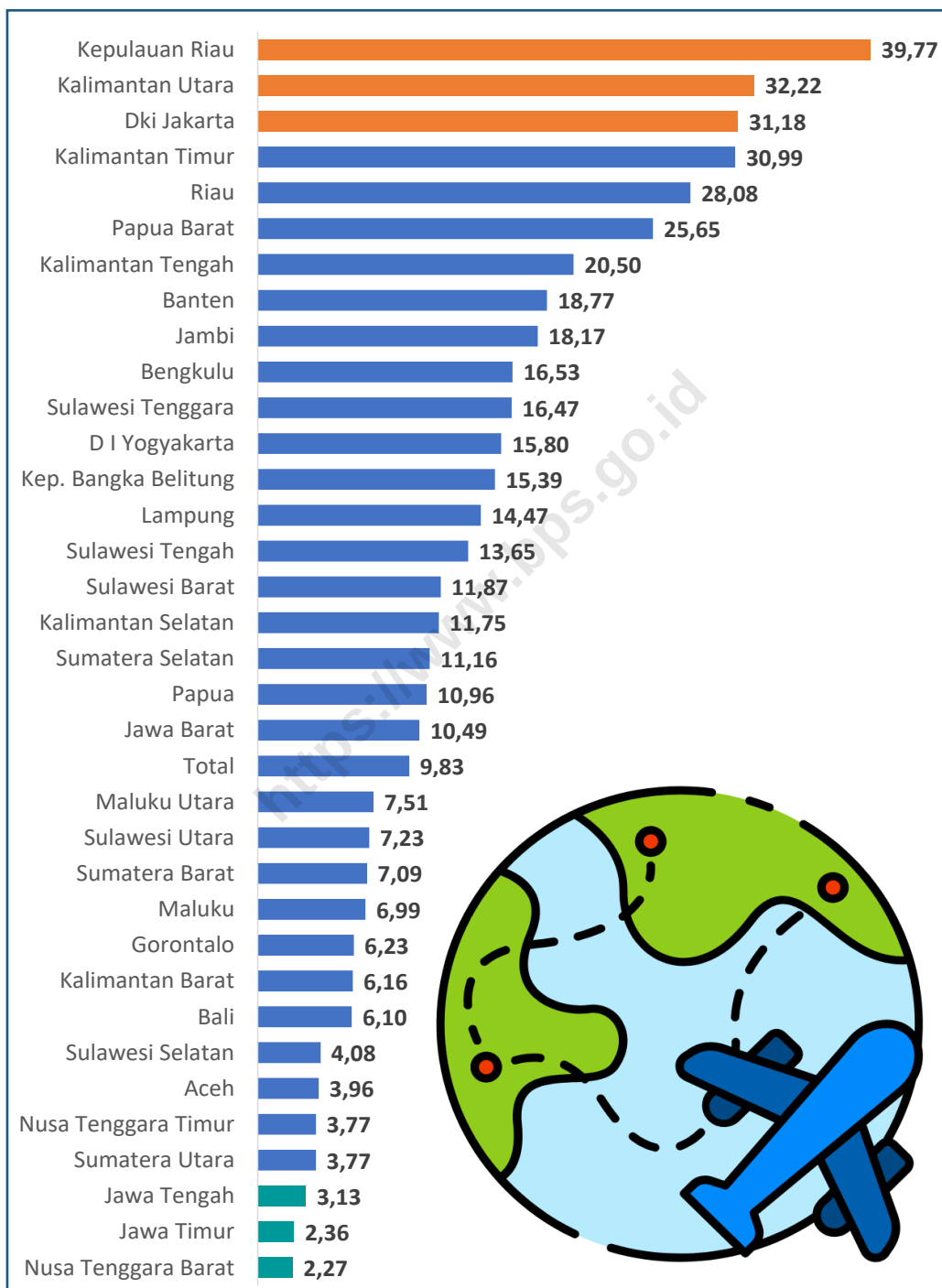
$$m_{(i-i)} = \frac{M_i - M_i}{p_{i,t+n} - 0,5(M_i + M_i)} \times 100\%$$

$m_{(i-i)}$: Persentase Migrasi Netto

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode t dan t+n

M_i : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang keluar di wilayah i selama periode t dan t+n

$P_{i,t+n}$: Jumlah populasi (penduduk yang berpotensi melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun t+n.



Gambar 5.5 Angka Migrasi Masuk Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020

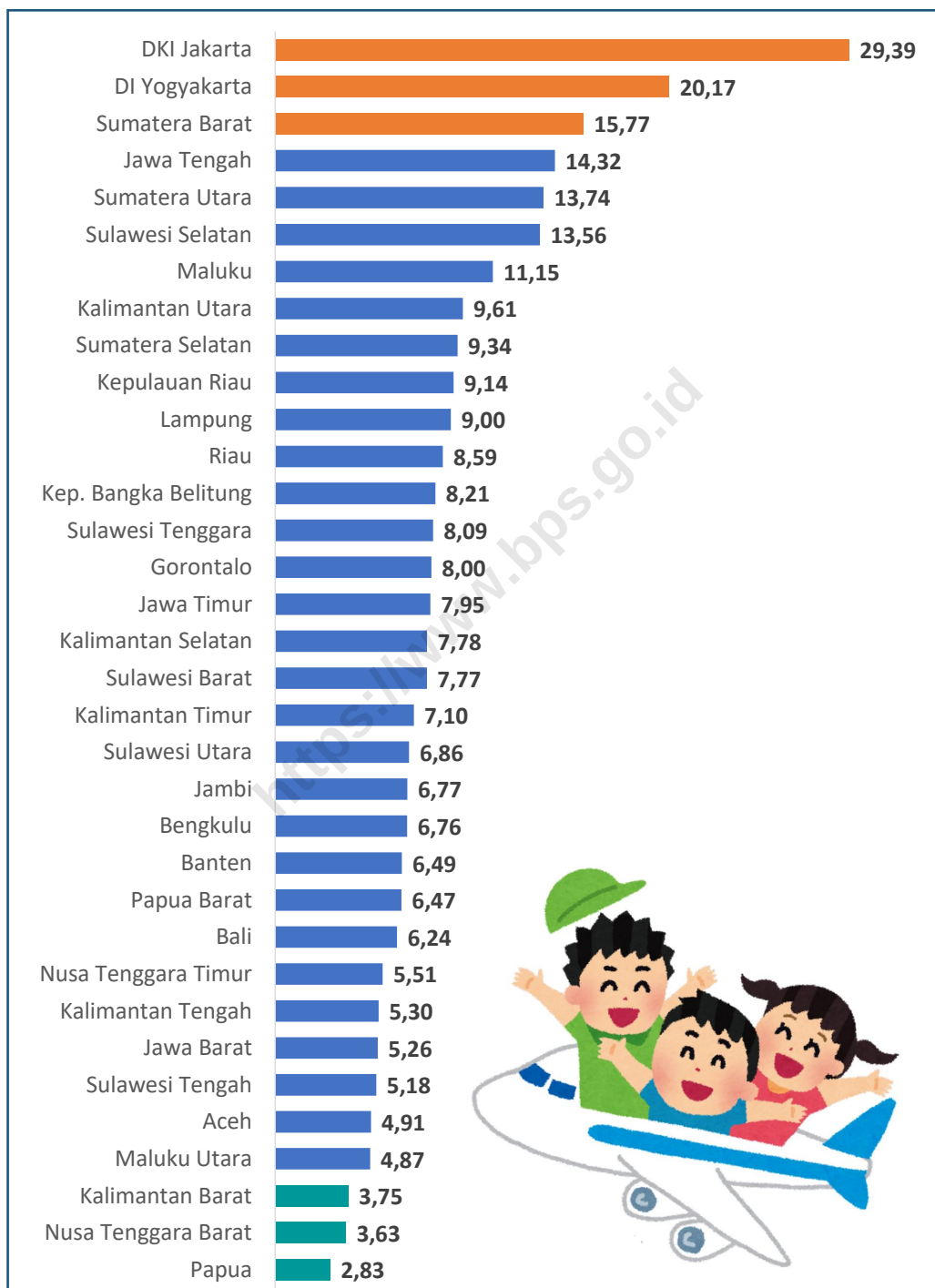


Grafik di atas menunjukkan persentase migran masuk seumur hidup di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Data ini mengukur proporsi penduduk yang pada suatu waktu dalam hidupnya pernah berpindah dari provinsi lain dan menetap di provinsi tersebut. Provinsi dengan persentase migran masuk tertinggi mencakup Kepulauan Riau (39,77 persen), Kalimantan Utara (32,2 persen), dan DKI Jakarta (31,18 persen). Kepulauan Riau menarik banyak migran karena berkembangnya industri manufaktur dan status kawasan perdagangan bebas Batam, yang didukung kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia. Kalimantan Utara, sebagai provinsi baru, juga mengalami peningkatan migrasi masuk berkat sektor perkebunan, energi, dan posisinya sebagai wilayah perbatasan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sementara itu, DKI Jakarta masih menjadi pusat migrasi karena perannya sebagai ibu kota dan pusat bisnis nasional, meskipun tren urbanisasi balik dan eksodus ke daerah lain mulai terlihat.

Di sisi lain, provinsi dengan persentase migran masuk terendah adalah NTB (2,27 persen), Jawa Timur (2,36 persen), dan Jawa Tengah (3,13 persen). Rendahnya angka migrasi masuk ini dapat disebabkan oleh tingginya arus migrasi keluar, di mana penduduk lebih memilih merantau ke pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta dan kota-kota besar lain untuk mencari peluang yang lebih baik. Meskipun daerah-daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal, masyarakat setempat cenderung melakukan urbanisasi keluar atau merantau dan hanya kembali dalam kesempatan tertentu seperti perayaan tradisional atau pensiun.

Migrasi masuk ke beberapa provinsi dipengaruhi oleh pusat ekonomi dan pembangunan. DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur menjadi magnet bagi migran karena adanya peluang kerja di sektor industri, jasa, dan proyek infrastruktur. Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, menawarkan lapangan kerja di berbagai bidang. Sementara itu, Kepulauan Riau memiliki kawasan perdagangan bebas seperti Batam, dan Kalimantan Timur semakin menarik dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, pemekaran wilayah juga berperan penting dalam peningkatan migrasi masuk. Provinsi baru seperti Kalimantan Utara dan Papua Barat mengalami peningkatan jumlah migran seiring dengan pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur dasar. Pemekaran menciptakan peluang kerja baru dan memerlukan tenaga kerja di sektor-sektor pemerintahan dan jasa. Selain itu, pembukaan daerah baru juga mendorong urbanisasi, di mana masyarakat berpindah dari daerah asal ke provinsi baru dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Sektor perkebunan dan industri energi menjadi daya tarik utama bagi migran di beberapa provinsi seperti Riau dan Jambi. Riau, dengan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak dan gas, memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal serupa terjadi di Jambi, di mana perkebunan berkontribusi signifikan dalam menarik migran dari berbagai wilayah. Faktor ekonomi ini memicu perpindahan tenaga kerja secara masif, terutama dari daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti NTB, Sumatera Barat, dan Aceh mencatat migrasi masuk rendah karena kultur dan identitas lokal yang kuat. Masyarakat di daerah ini cenderung memiliki pola migrasi keluar untuk mencari peluang di luar provinsi, seperti ke Jakarta atau kota besar lainnya, dengan tujuan merantau. Namun, mereka sering kembali ke kampung halaman pada waktu-waktu tertentu, seperti saat lebaran atau pensiun. Kultur yang kuat dalam menjaga ikatan dengan tanah kelahiran membuat sebagian besar penduduk lebih memilih kembali ke daerah asal setelah bekerja di perantauan, sehingga angka migrasi masuk tetap rendah.



Gambar 5.6 Angka Migrasi Keluar Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020



Jika dilihat dari 3 provinsi tertinggi, DKI Jakarta mencatat persentase migrasi keluar tertinggi sebesar 29,39 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun ibu kota adalah pusat ekonomi nasional, banyak penduduknya memilih untuk meninggalkan wilayah ini. Alasan utamanya adalah tingginya biaya hidup, kemacetan, dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Sebagian besar migran pindah ke daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), di mana biaya hidup lebih terjangkau tetapi tetap memberikan akses ke Jakarta sebagai pusat pekerjaan. Fenomena urban sprawl atau penyebaran populasi ke daerah-daerah sekitar ini menjadi pola umum migrasi dari Jakarta. Di Yogyakarta, meskipun dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, memiliki angka migrasi keluar sebesar 20,17 persen. Banyak penduduk Yogyakarta, khususnya lulusan universitas, pindah ke kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya untuk mencari peluang karier yang lebih baik, karena keterbatasan lapangan kerja di wilayah tersebut. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat angka migrasi keluar sebesar 15,77 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh tradisi merantau dalam masyarakat Minangkabau. Penduduk Sumatera Barat, terutama yang muda, sering merantau untuk mencari pekerjaan dan pengalaman di luar daerah asal, biasanya menuju pusat-pusat ekonomi seperti Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara.

Jika dilihat dari 3 provinsi terendah, Papua mencatat angka migrasi keluar terendah, sebesar 2,83 persen. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya angka ini adalah kondisi geografis Papua yang sulit diakses, dengan medan yang berat dan terbatasnya infrastruktur transportasi yang mempersulit mobilitas penduduk. Selain itu, faktor budaya dan keterikatan sosial yang kuat dengan tanah leluhur membuat penduduk Papua cenderung menetap di wilayah asalnya. Hal ini menjadikan Papua salah satu wilayah yang paling sedikit mengalami migrasi keluar di Indonesia, meskipun terdapat tantangan ekonomi yang cukup besar di wilayah ini. Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga memiliki persentase migrasi keluar yang rendah, yakni 3,63 persen. Meskipun provinsi ini menghadapi tantangan ekonomi seperti kemiskinan, banyak penduduk yang memilih untuk tetap tinggal karena faktor keterikatan budaya dan tradisi yang kuat. Keterbatasan aksesibilitas dan transportasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat migrasi keluar. Selain itu, peluang migrasi keluar mungkin kurang menarik bagi penduduk NTB, terutama karena tantangan dalam memperoleh pekerjaan di luar wilayah tersebut. Selain itu, Kalimantan Barat dengan angka migrasi keluar sebesar 3,75 persen juga menunjukkan stabilitas dalam migrasi. Rendahnya angka ini dapat dikaitkan dengan potensi ekonomi lokal yang cukup baik, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Namun, seperti di Papua dan NTB, keterbatasan infrastruktur transportasi di beberapa bagian wilayah ini juga turut membatasi mobilitas penduduk ke wilayah lain, sehingga jumlah penduduk yang bermigrasi keluar relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.



Gambar 5.7 Angka Migrasi Netto Seumur Hidup (per 100 penduduk) di Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020

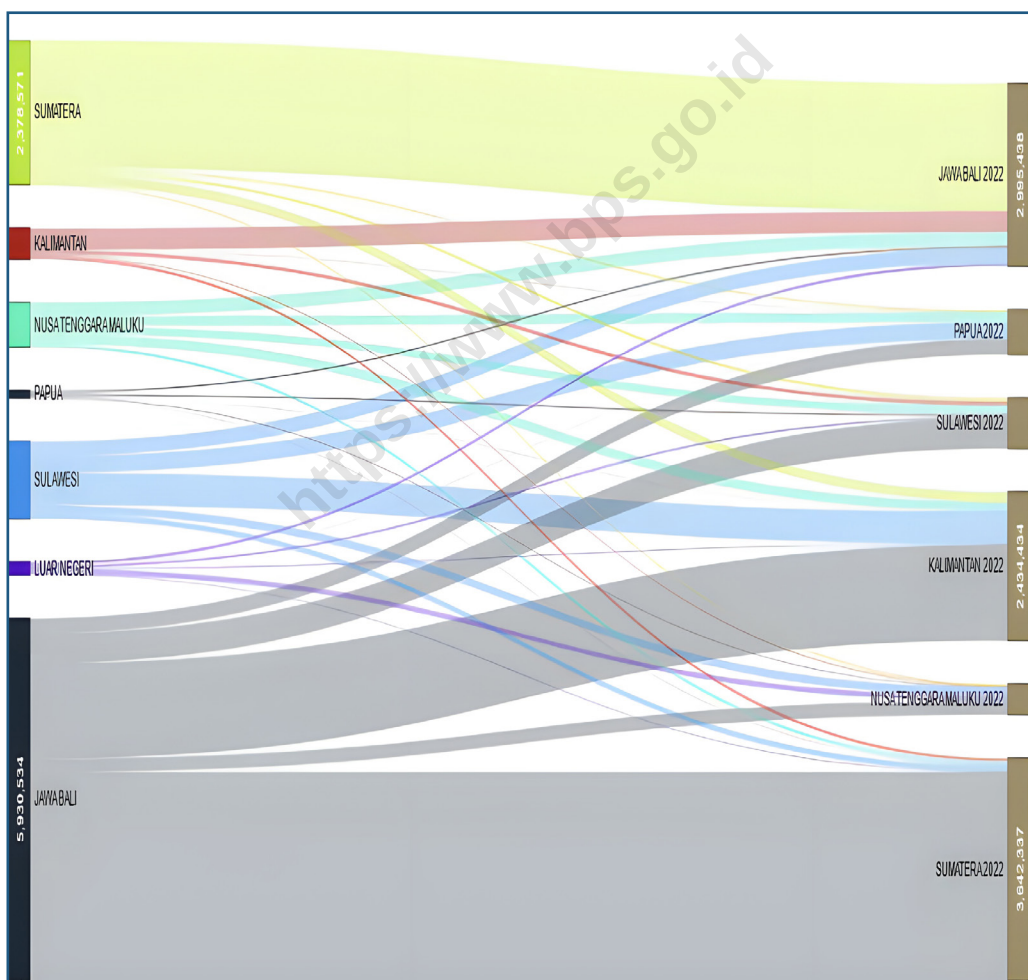


Berdasarkan Gambar 5.7 mengenai persentase migran neto seumur hidup tahun 2022, kita dapat melihat distribusi migrasi neto untuk berbagai wilayah di Indonesia. Persentase migran neto mencerminkan perbedaan antara migrasi masuk dan migrasi keluar; nilai positif menunjukkan wilayah dengan lebih banyak migran masuk daripada keluar, sedangkan nilai negatif mencerminkan wilayah dengan lebih banyak migran keluar daripada masuk. Beberapa wilayah memiliki migrasi neto positif yang cukup tinggi, artinya lebih banyak orang yang pindah masuk ke wilayah tersebut daripada yang keluar. Wilayah dengan persentase tertinggi adalah Kepulauan Riau (40,55 persen) yang memiliki persentase migrasi neto tertinggi di Indonesia, menunjukkan bahwa Kepulauan Riau menjadi tujuan migrasi yang sangat menarik. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut, terutama di pusat industri seperti Batam yang menarik banyak pekerja dari berbagai daerah. Letaknya yang strategis dekat dengan Singapura dan Malaysia juga membuat Kepulauan Riau menjadi pusat perdagangan dan industri, yang menjadi magnet bagi migran. Kemudian disusul oleh Kalimantan Timur sebesar (29,52 persen) yang menjadi wilayah dengan migrasi neto yang tinggi, didorong oleh rencana pemindahan ibu kota negara ke provinsi ini. Pembangunan infrastruktur besar-besaran dan peningkatan investasi di berbagai sektor membuat wilayah ini menarik bagi migran yang mencari peluang ekonomi dan pekerjaan baru. Lalu, Kalimantan Utara (28,60 persen) sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia, Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan migrasi neto yang positif. Wilayah ini terus berkembang sebagai pusat industri dan pertambangan, menarik banyak penduduk dari wilayah lain yang mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Infrastruktur yang terus dikembangkan di wilayah ini turut mendukung pertumbuhan migrasi masuk.

Sebaliknya, beberapa provinsi mencatat migrasi neto negatif yang menunjukkan lebih banyak penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut dibandingkan yang masuk. Provinsi dengan migrasi neto negatif tertinggi adalah Jawa Tengah (-12,26 persen) yang mencatat angka migrasi neto terendah, dengan lebih banyak penduduk yang pindah keluar dibandingkan yang masuk. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi di provinsi ini dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa seperti Jakarta atau Jawa Barat. Banyak penduduk Jawa Tengah yang bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja, terutama ke Jakarta dan kota-kota penyangga. Kemudian, Sumatera Utara (-10,93 persen) yang memiliki migrasi neto negatif yang signifikan. Ini dapat dijelaskan oleh kurangnya perkembangan ekonomi yang cepat di provinsi ini, yang membuat banyak penduduknya memilih merantau ke wilayah lain yang lebih dinamis secara ekonomi, seperti Riau atau DKI Jakarta. Keterbatasan kesempatan kerja lokal memaksa banyak orang untuk mencari peluang di luar Sumatera Utara. Lalu, disusul oleh Sulawesi Selatan (-10,39 persen) yang meskipun Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, merupakan pusat ekonomi utama di Indonesia timur, provinsi ini tetap mengalami migrasi keluar yang signifikan. Banyak penduduk Sulawesi Selatan, terutama generasi muda, bermigrasi ke daerah lain yang menawarkan lebih banyak peluang pendidikan dan pekerjaan, seperti Jakarta dan Surabaya.



Pola migrasi neto di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Peluang ekonomi menjadi daya tarik terbesar di wilayah dengan industri yang berkembang pesat, terutama yang berbasis sumber daya alam seperti di Kalimantan dan Papua, sementara provinsi dengan ekonomi yang stagnan seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara cenderung mengalami migrasi keluar yang lebih besar. Pembangunan infrastruktur, seperti rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, juga berperan besar dalam menarik migran ke wilayah-wilayah yang berkembang pesat. Selain itu, kualitas hidup dan biaya hidup mendorong banyak penduduk Jakarta dan Jawa Tengah untuk pindah ke wilayah lain yang lebih terjangkau dan menawarkan kualitas hidup yang lebih baik, seperti Jawa Barat dan Banten, karena tingginya tekanan urban di kota-kota besar.



Gambar 5.8 Grafik Sankey Migrasi Seumur Hidup Indonesia tahun 2022, Hasil Long Form SP2020



Migrasi Seumur Hidup atau yang biasa dikenal juga dengan Migrasi Seumur Hidup mencerminkan pola perpindahan penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2022, analisis ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai Migrasi Seumur Hidup di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku, Papua, serta migrasi dari luar negeri.

a. Wilayah Sumatera

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Sumatera tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan migrasi terbesar dengan jumlah mencapai 2.093.832 orang atau 88,03% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial di Indonesia. Kalimantan berada di posisi kedua dengan jumlah migrasi sebesar 162.077 orang atau 6,81%, mencerminkan minat terhadap pembangunan infrastruktur dan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Sulawesi menerima 56.136 orang atau 2,36%, menunjukkan adanya hubungan migrasi meskipun kontribusinya kecil. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 29.017 orang atau 1,22%, yang lebih kecil karena tantangan geografis dan infrastruktur. Papua mencatat migrasi sebesar 37.509 orang atau 1,58%, menunjukkan sebagian kecil penduduk Sumatera tertarik pindah ke Papua, kemungkinan karena peluang kerja atau program transmigrasi. Total Migrasi Seumur Hidup dari Sumatera selama periode ini mencapai 2.378.571 orang, dengan dominasi perpindahan ke Jawa-Bali, mencerminkan daya tarik sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial.

Arus Migrasi Seumur Hidup menuju Sumatera pada tahun 2022 didominasi oleh perpindahan dari Jawa-Bali, yang menyumbang 3.410.136 orang atau 93,62% dari total migrasi. Hal ini menunjukkan daya tarik Sumatera bagi penduduk Jawa-Bali, kemungkinan karena peluang ekonomi, biaya hidup yang lebih rendah, atau program transmigrasi. Sulawesi menyumbang 93.165 orang atau 2,56%, diikuti oleh Kalimantan dengan 60.368 orang atau 1,66%, dan Nusa Tenggara-Maluku dengan 58.074 orang atau 1,59%, mencerminkan koneksi migrasi yang signifikan meskipun lebih kecil dibandingkan Jawa-Bali. Papua mencatat migrasi terkecil di antara wilayah domestik lainnya, yaitu 6.649 orang atau 0,18%, mencerminkan tantangan geografis dan minimnya hubungan langsung dengan Sumatera. Migrasi dari luar negeri tercatat sebesar 13.945 orang atau 0,38%, menunjukkan bahwa Sumatera tetap menjadi tujuan bagi sebagian kecil WNI yang kembali dari luar negeri. Total Migrasi Seumur Hidup menuju Sumatera selama periode ini mencapai 3.642.337 orang, dengan dominasi perpindahan dari Jawa-Bali, mencerminkan daya tarik Sumatera bagi migran domestik dan internasional.

b. Wilayah Jawa-Bali

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Jawa-Bali tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan dominasi perpindahan ke Sumatera, dengan jumlah migran mencapai 3.410.136 orang atau 57,50% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Sumatera bagi penduduk Jawa-Bali karena biaya hidup yang lebih rendah, peluang agrikultur, serta program transmigrasi. Kalimantan menjadi tujuan kedua dengan 1.563.885 orang atau 26,37%, didukung oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran, potensi sumber daya alam, dan peluang kerja. Sulawesi menerima 488.109 orang atau 8,23%, mencerminkan hubungan migrasi yang signifikan melalui sektor agrikultur, perikanan, dan perdagangan. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 223.246 orang atau 3,76%, yang



menunjukkan hubungan budaya dan geografis yang erat. Papua mencatat 245.158 orang atau 4,13%, menggambarkan minat terhadap peluang di sektor sumber daya alam atau program pembangunan. Total Migrasi Seumur Hidup dari Jawa-Bali selama periode ini adalah 5.930.534 orang, dengan dominasi migrasi ke Sumatera dan Kalimantan, sementara wilayah lain memberikan kontribusi lebih kecil namun tetap signifikan.

Sebaliknya, pada tahun 2022, arus Migrasi Seumur Hidup menuju Jawa-Bali menunjukkan dominasi migrasi dari Sumatera dengan jumlah 2.093.832 orang atau 69,90% dari total migrasi, mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Kalimantan menyumbang 341.519 orang atau 11,40%, menunjukkan koneksi migrasi yang signifikan. Sulawesi mencatat 238.567 orang atau 7,96%, diikuti oleh Nusa Tenggara dan Maluku dengan 219.812 orang atau 7,34%, yang menggambarkan hubungan budaya dan peluang ekonomi di Jawa-Bali. Papua menyumbang 50.410 orang atau 1,68%, menunjukkan bahwa migrasi dari Papua relatif kecil karena tantangan geografis dan keterbatasan akses. Migrasi dari luar negeri mencatat 51.298 orang atau 1,71%, menunjukkan peran Jawa-Bali sebagai tujuan utama bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Total migrasi menuju Jawa-Bali selama periode ini mencapai 2.995.438 orang, dengan dominasi migrasi dari Sumatera, sementara wilayah lain memberikan kontribusi yang signifikan, menjadikan Jawa-Bali sebagai tujuan strategis baik domestik maupun internasional.

c. Wilayah Kalimantan

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Kalimantan tahun 2017 hingga 2022 didominasi oleh perpindahan ke Jawa-Bali, dengan jumlah migran mencapai 341.519 orang atau 68,24% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lebih maju dibandingkan wilayah lain. Sumatera menjadi tujuan kedua dengan 60.368 orang atau 12,06%, mencerminkan peluang agrikultur dan biaya hidup yang lebih rendah. Sulawesi mencatat migrasi sebesar 73.709 orang atau 14,73%, yang menunjukkan hubungan geografis dan ekonomi yang signifikan melalui sektor agrikultur dan perikanan. Nusa Tenggara dan Maluku menyumbang 18.201 orang atau 3,64%, sementara Papua mencatat jumlah migrasi terkecil, yaitu 6.661 orang atau 1,33%, mencerminkan tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi. Total Migrasi Seumur Hidup dari Kalimantan selama periode ini adalah 500.458 orang, dengan dominasi perpindahan ke Jawa-Bali dan kontribusi yang lebih kecil dari wilayah lain.

Sebaliknya, pada tahun 2022, arus Migrasi Seumur Hidup menuju Kalimantan menunjukkan dominasi migrasi dari Jawa-Bali, yang menyumbang 1.563.885 orang atau 64,24% dari total migrasi. Sulawesi menjadi sumber migrasi kedua dengan 524.416 orang atau 21,54%, menunjukkan hubungan geografis dan ekonomi yang erat. Sumatera mencatat 162.077 orang atau 6,66%, diikuti oleh Nusa Tenggara dan Maluku dengan 159.329 orang atau 6,54%, mencerminkan hubungan budaya dan geografis. Papua menyumbang jumlah migrasi terkecil, yaitu 4.677 orang atau 0,19%, sementara migrasi dari luar negeri mencapai 20.050 orang atau 0,82%, menunjukkan bahwa Kalimantan tetap memiliki daya tarik sebagai wilayah tujuan bagi sebagian kecil WNI yang kembali dari luar negeri. Total Migrasi Seumur Hidup menuju Kalimantan selama periode ini adalah 2.434.434 orang, dengan dominasi perpindahan dari Jawa-Bali, diikuti oleh Sulawesi, mencerminkan peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkembang di Kalimantan.



d. Wilayah Sulawesi

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Sulawesi tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Kalimantan menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 524.416 orang atau 41,52% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan hubungan geografis dan ekonomi yang erat antara kedua wilayah, didukung oleh peluang kerja di sektor agrikultur, perikanan, dan industri. Papua menjadi tujuan kedua dengan 275.794 orang atau 21,84%, menunjukkan daya tarik ekonomi dan kedekatan geografis. Jawa-Bali menerima 238.567 orang atau 18,89%, mencerminkan daya tariknya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Nusa Tenggara dan Maluku mencatat migrasi sebesar 131.011 orang atau 10,37%, menunjukkan hubungan budaya dan geografis yang signifikan. Sumatera mencatat migrasi terkecil, yaitu 93.165 orang atau 7,38%, menunjukkan bahwa jarak dan perbedaan peluang ekonomi memengaruhi preferensi migrasi. Total Migrasi Seumur Hidup dari Sulawesi selama periode ini adalah 1.262.953 orang, dengan Kalimantan sebagai tujuan utama, diikuti oleh Papua dan Jawa-Bali.

Sebaliknya, pada tahun 2022, arus Migrasi Seumur Hidup menuju Sulawesi didominasi oleh migrasi dari Jawa-Bali, yang menyumbang 488.109 orang atau 59,22% dari total migrasi. Hal ini menunjukkan daya tarik Sulawesi bagi penduduk Jawa-Bali, kemungkinan karena peluang ekonomi dan hubungan budaya yang erat. Nusa Tenggara dan Maluku menjadi sumber migrasi kedua dengan 131.506 orang atau 15,95%, diikuti oleh Kalimantan dengan 73.709 orang atau 8,94%. Sumatera menyumbang 56.136 orang atau 6,81%, sementara Papua mencatat migrasi sebesar 38.848 orang atau 4,71%. Migrasi dari luar negeri mencapai 35.924 orang atau 4,36%, mencerminkan peran Sulawesi sebagai tujuan bagi WNI yang kembali dari luar negeri. Total Migrasi Seumur Hidup menuju Sulawesi selama periode ini adalah 824.232 orang, dengan dominasi perpindahan dari Jawa-Bali, diikuti oleh kontribusi signifikan dari Nusa Tenggara-Maluku dan Kalimantan, menunjukkan pentingnya Sulawesi sebagai tujuan migrasi domestik dan internasional.

e. Wilayah Nusa Tenggara-Maluku

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 219.812 orang atau 30,09% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lengkap. Papua berada di posisi kedua dengan 161.737 orang atau 22,14%, didukung oleh peluang kerja dan kedekatan wilayah. Kalimantan menjadi tujuan migrasi ketiga dengan 159.329 orang atau 21,81%, menunjukkan hubungan migrasi yang signifikan, terutama melalui sektor agrikultur, perikanan, dan sumber daya alam. Sulawesi mencatat 131.506 orang atau 18,00%, mencerminkan hubungan budaya dan geografis yang erat, sementara Sumatera menerima 58.074 orang atau 7,95%, menunjukkan kontribusi migrasi yang lebih kecil. Total Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku selama periode ini adalah 730.458 orang, dengan dominasi perpindahan ke Jawa-Bali, diikuti oleh Papua dan Kalimantan.

Sebaliknya, pada tahun 2022, arus Migrasi Seumur Hidup menuju wilayah Nusa Tenggara dan Maluku didominasi oleh perpindahan dari Jawa-Bali, yang menyumbang 223.246 orang atau 44,49% dari total migrasi. Sulawesi menjadi sumber migrasi kedua dengan 131.011 orang atau 26,11%, mencerminkan kedekatan wilayah dan hubungan sosial-budaya yang kuat. Migrasi dari luar negeri mencatat 82.878 orang atau 16,52%, menunjukkan bahwa



wilayah ini juga menjadi tujuan penting bagi WNI yang kembali ke Indonesia. Sumatera menyumbang 29.017 orang atau 5,78%, diikuti oleh Kalimantan dengan 18.201 orang atau 3,63%, dan Papua dengan 17.388 orang atau 3,47%, mencerminkan kontribusi yang relatif kecil. Total Migrasi Seumur Hidup menuju wilayah Nusa Tenggara dan Maluku selama periode ini mencapai 501.741 orang, dengan dominasi perpindahan dari Jawa-Bali, serta kontribusi signifikan dari Sulawesi dan luar negeri, mencerminkan peran budaya, ekonomi, dan hubungan sosial sebagai faktor pendorong utama.

f. Wilayah Papua

Arus Migrasi Seumur Hidup dari wilayah Papua tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Jawa-Bali menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 50.410 orang atau 42,73% dari total migrasi. Hal ini mencerminkan daya tarik Jawa-Bali sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan fasilitas sosial yang lengkap. Sulawesi menjadi tujuan kedua dengan 38.848 orang atau 32,93%, didukung oleh kedekatan geografis dan hubungan budaya yang erat. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku menyumbang 17.388 orang atau 14,74%, mencerminkan koneksi migrasi yang signifikan. Sumatera menerima 6.649 orang atau 5,64%, sedangkan Kalimantan mencatat migrasi terkecil dengan 4.677 orang atau 3,96%, menunjukkan keterbatasan hubungan migrasi ke kedua wilayah tersebut. Total Migrasi Seumur Hidup dari Papua selama periode ini adalah 117.972 orang, dengan dominasi perpindahan ke Jawa-Bali dan Sulawesi, sementara wilayah lainnya memberikan kontribusi yang lebih kecil.

Sebaliknya, pada tahun 2022, arus Migrasi Seumur Hidup menuju Papua didominasi oleh migrasi dari Sulawesi, yang menyumbang 275.794 orang atau 37,76% dari total migrasi, mencerminkan kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang signifikan. Jawa-Bali menjadi sumber migrasi kedua dengan 245.158 orang atau 33,57%, menunjukkan daya tarik Papua untuk peluang kerja di sektor infrastruktur dan sumber daya alam. Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku menyumbang 161.737 orang atau 22,15%, diikuti oleh Sumatera dengan 37.509 orang atau 5,14%. Kalimantan memiliki jumlah migrasi terkecil, yaitu 6.661 orang atau 0,91%, sedangkan migrasi dari luar negeri hanya 3.468 orang atau 0,47%, mencerminkan keterbatasan hubungan internasional ke Papua. Total Migrasi Seumur Hidup menuju Papua selama periode ini adalah 730.327 orang, dengan dominasi migrasi dari Sulawesi dan Jawa-Bali, serta kontribusi signifikan dari Nusa Tenggara-Maluku, mencerminkan pengaruh geografis dan peluang ekonomi sebagai faktor utama migrasi.

g. Wilayah Luar Negeri

Arus Migrasi Seumur Hidup dari luar negeri tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa Nusa Tenggara dan Maluku menjadi tujuan utama dengan jumlah migran mencapai 82.878 orang atau 39,93% dari total migrasi, mencerminkan daya tarik wilayah ini yang didorong oleh hubungan budaya, sosial, dan kehadiran komunitas lokal yang besar. Jawa-Bali berada di posisi kedua dengan 51.298 orang atau 24,71%, menunjukkan bahwa wilayah ini tetap menjadi tujuan populer bagi WNI yang kembali dari luar negeri, terutama karena infrastruktur dan peluang ekonomi yang lebih baik. Sulawesi mencatat 35.924 orang atau 17,31%, mencerminkan hubungan geografis dan budaya yang kuat, diikuti oleh Kalimantan dengan 20.050 orang atau 9,66%, yang menunjukkan daya tarik di sektor sumber daya alam dan infrastruktur. Sumatera mencatat migrasi sebesar 13.945 orang atau 6,72%, meskipun kontribusinya kecil, sementara Papua menerima 3.468 orang atau 1,67%,



menunjukkan bahwa wilayah ini bukan tujuan utama, kemungkinan karena keterbatasan infrastruktur dan jarak geografis. Total Migrasi Seumur Hidup dari luar negeri ke Indonesia selama periode ini adalah 207.563 orang, dengan dominasi perpindahan ke Nusa Tenggara-Maluku dan Jawa-Bali, sementara Sulawesi dan Kalimantan memberikan kontribusi signifikan, serta Sumatera dan Papua yang memiliki kontribusi lebih kecil, mencerminkan perbedaan daya tarik ekonomi dan infrastruktur di berbagai wilayah.

<https://www.bps.go.id>

6

Indikator Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua



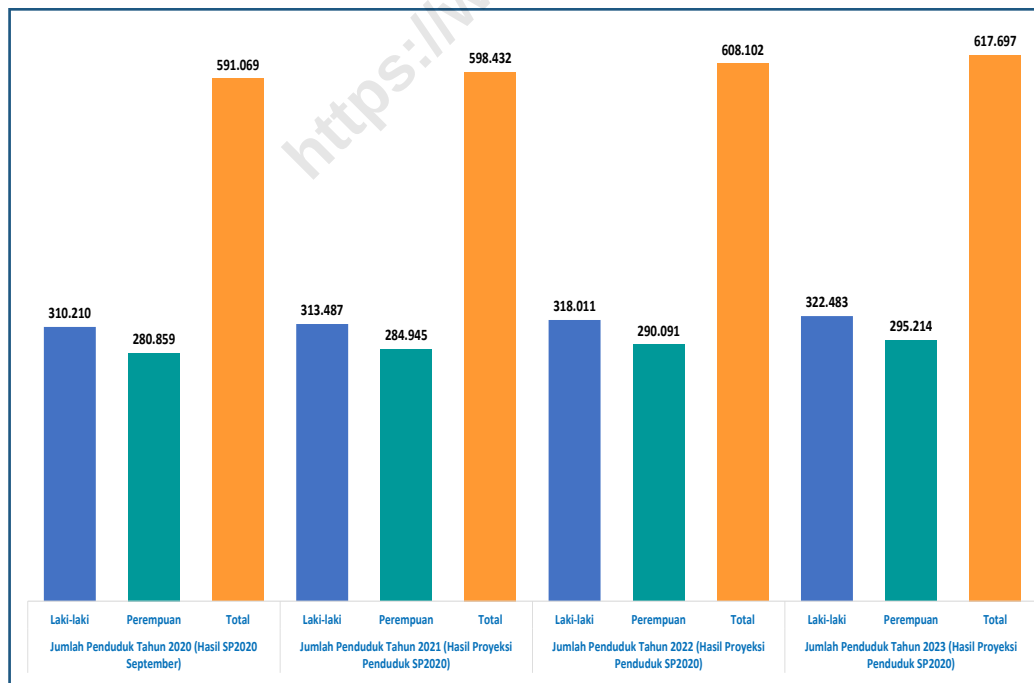


Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan pembentukan provinsi baru di Papua Barat diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Pemerintah berpandangan bahwa pembentukan provinsi baru di Papua dan Papua Barat sangat urgen dilakukan sebagai upaya dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan lebih terfokus dengan rentang kendali yang lebih dekat, memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial, serta optimalisasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung tujuan pembentukan provinsi baru di wilayah Papua dan Papua Barat, perlu dukungan data yang terpisah pula dari data yang sudah tersedia untuk provinsi induknya. *Long Form* SP2020 menghasilkan beberapa data terkait kependudukan yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan di provinsi-provinsi baru tersebut. Data yang tersedia antara lain data jumlah penduduk, angka kelahiran total, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, angka harapan hidup, serta data-data migrasi.

6.1 Penduduk



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.1 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020–2023

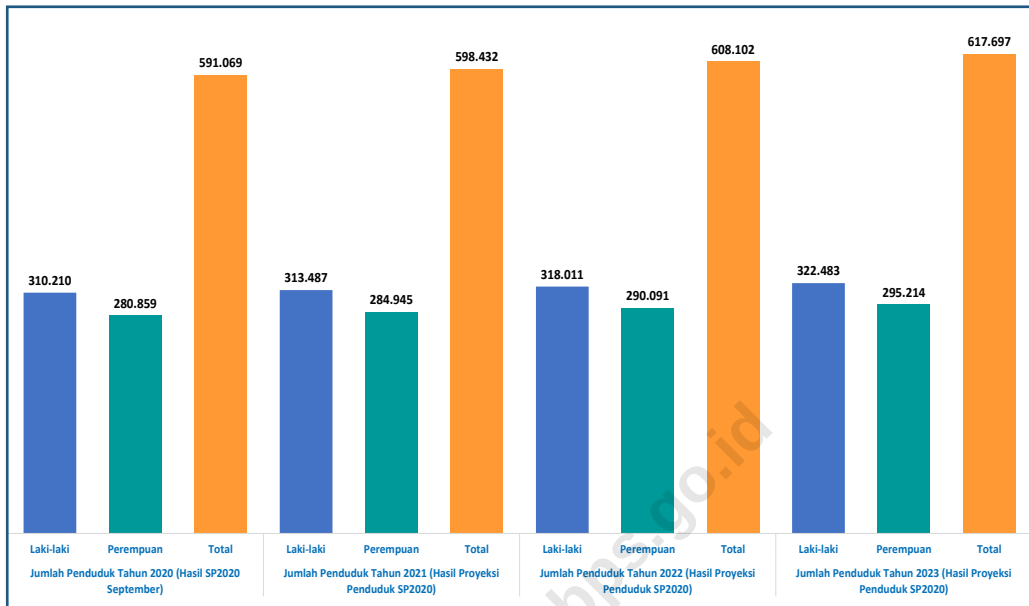


Gambar 6.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, selama periode 2020 hingga 2023. Data ini diambil dari hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) dan proyeksi berdasarkan hasil sensus tersebut untuk tahun-tahun berikutnya. Setiap tahun terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk, dengan dominasi jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bila dilihat, pada tahun 2020, jumlah penduduk di Papua Barat tercatat sebesar 542.999 orang berdasarkan hasil SP2020. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 286.918 orang, sedangkan perempuan berjumlah 256.081 orang. Selisih antara laki-laki dan perempuan mencapai 30.837 orang, menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun tersebut. Lalu, berdasarkan proyeksi untuk tahun 2021, jumlah penduduk di Papua Barat diperkirakan meningkat menjadi 550.941 orang. Rinciannya, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan mencapai 290.749 orang, sementara perempuan mencapai 260.192 orang. Selisih antara laki-laki dan perempuan sedikit mengecil menjadi 30.557 orang, namun laki-laki tetap mendominasi jumlah penduduk dibandingkan perempuan. Kemudian, pada tahun 2022, proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Papua Barat akan terus meningkat, mencapai 560.320 orang. Jumlah laki-laki diperkirakan bertambah menjadi 295.280 orang, dan perempuan menjadi 265.040 orang. Selisih antara laki-laki dan perempuan kembali sedikit menurun menjadi 30.240 orang, meskipun laki-laki masih menjadi kelompok mayoritas di provinsi ini. Pada tahun 2023, proyeksi penduduk untuk Papua Barat menunjukkan peningkatan populasi total menjadi 569.570 orang, dengan laki-laki mencapai 299.745 orang dan perempuan 269.825 orang. Selisih antara laki-laki dan perempuan diperkirakan berkurang lagi menjadi 29.920 orang.

Secara keseluruhan, gambar 6.1 mencerminkan tren peningkatan populasi yang stabil setiap tahunnya di Provinsi Papua Barat, dengan jumlah penduduk laki-laki yang selalu lebih banyak dibandingkan perempuan. Data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Gambar 6.2 menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2020 hingga 2023, yang disajikan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta total keseluruhan penduduk. Jumlah penduduk provinsi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2020 dengan total penduduk 591.069 jiwa, kemudian meningkat menjadi 598.432 jiwa di tahun 2021, naik lagi menjadi 608.102 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai 617.697 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang konsisten ini menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Jika dilihat dari jenis kelamin, setiap tahun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Pada tahun 2020, terdapat 310.210 laki-laki dan 280.859 perempuan. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana penduduk laki-laki mencapai 322.483 jiwa, sementara perempuan berjumlah 295.214 jiwa. Selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, dengan jumlah laki-laki yang selalu mendominasi populasi.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

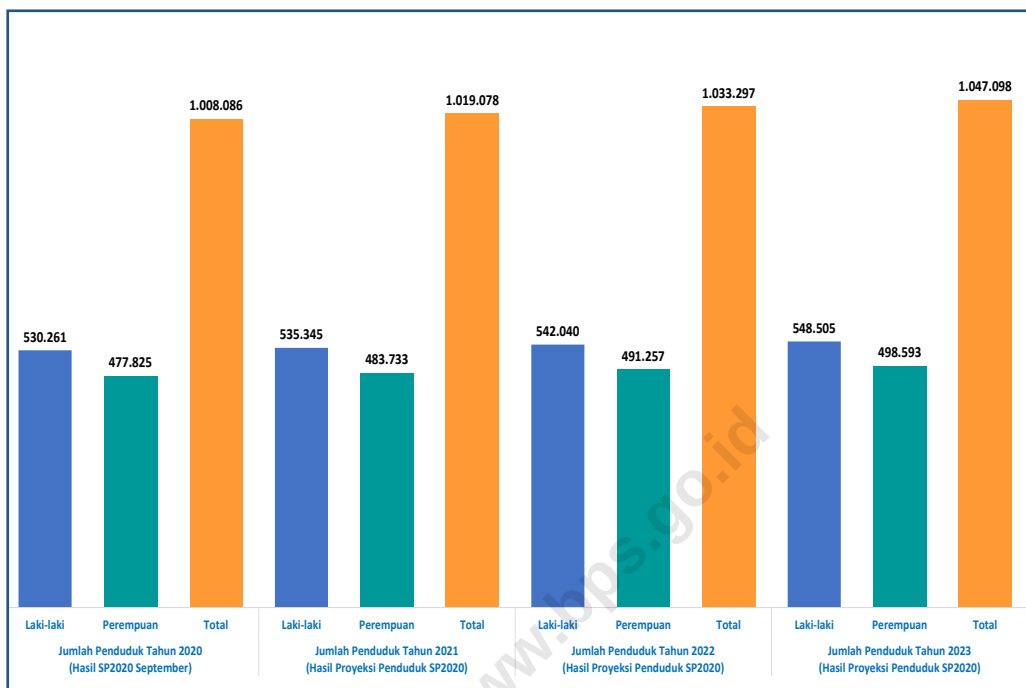
Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023

Pertumbuhan jumlah penduduk di Papua Barat Daya ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil setiap tahunnya, baik untuk total populasi maupun kategori jenis kelamin. Peningkatan tahunan ini konsisten di setiap kelompok, yang menandakan perkembangan populasi positif. Dalam konteks pembangunan daerah, tren pertumbuhan penduduk yang stabil ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan fasilitas dan layanan publik.

Terkait kesenjangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa perbedaan jumlah antara kedua kelompok ini relatif konstan setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2020 selisihnya sekitar 29.351 jiwa, sementara di tahun 2023 selisih ini turun menjadi 27.269 jiwa. Meskipun jumlah laki-laki lebih banyak, distribusi populasi secara umum tetap seimbang. Hal ini memberikan indikasi bahwa perbedaan gender tidak terlalu mencolok, meski laki-laki sedikit lebih mendominasi.

Data proyeksi dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang digunakan untuk tahun 2021 hingga 2023 terlihat cukup akurat dalam menggambarkan pertumbuhan penduduk Papua Barat Daya. Proyeksi ini membantu memberikan gambaran mengenai arah perkembangan populasi di masa depan, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini sebagai acuan untuk menyusun program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan adanya tren positif dalam jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya, dengan distribusi yang sedikit didominasi oleh laki-laki.

Gambar 6.3 menggambarkan jumlah penduduk di Provinsi Papua dari tahun 2020 hingga 2023. Data yang disajikan merupakan hasil Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Hasil SP2020, yang mengelompokkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta total populasi setiap tahunnya. Grafik ini memberikan pandangan umum mengenai tren pertumbuhan penduduk di Papua yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.3 Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 2020–2023

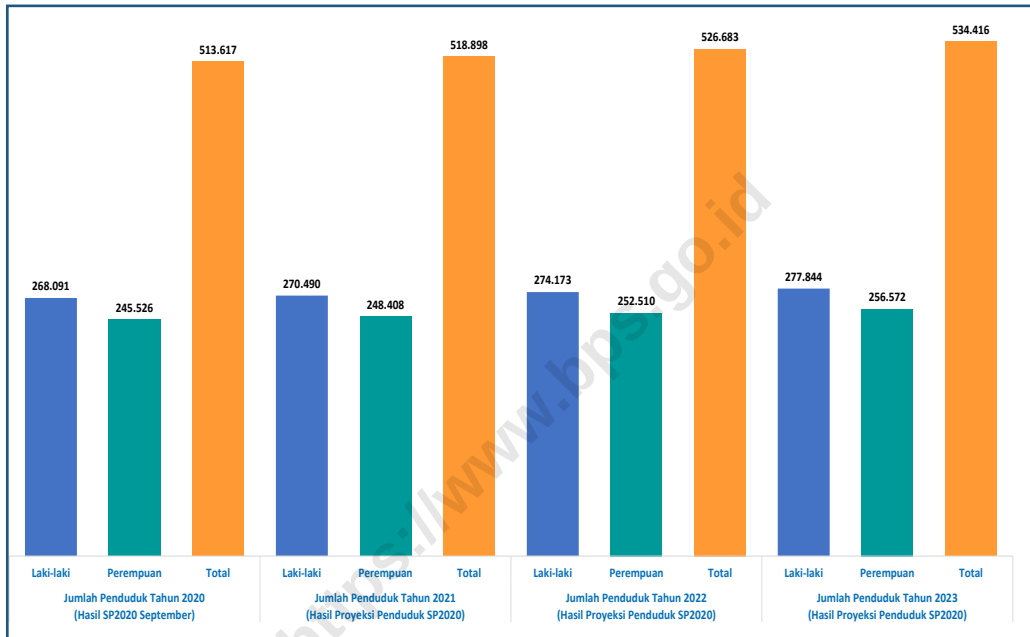
Setiap tahunnya, total penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, total penduduk mencapai 1.008.086 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 1.047.098 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan tren positif yang konsisten selama empat tahun terakhir, menandakan bahwa Papua mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi indikasi penting bagi pemerintah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan di setiap tahun. Pada tahun 2020, penduduk laki-laki berjumlah 530.261 jiwa, sementara perempuan berjumlah 477.825 jiwa. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana laki-laki mencapai 548.505 jiwa dan perempuan 498.593 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang stabil ini menunjukkan bahwa dominasi jumlah laki-laki atas perempuan di Papua masih berlanjut dari tahun ke tahun.

Kesenjangan jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan tetap cukup konsisten selama periode ini. Pada tahun 2020, selisih antara laki-laki dan perempuan sekitar 52.436 jiwa, dan selisih ini sedikit berkurang menjadi 49.912 jiwa pada tahun 2023. Meskipun jumlah laki-laki lebih banyak, distribusi penduduk tetap seimbang dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, yang menandakan adanya stabilitas dalam komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.



Proyeksi dari SP2020 yang digunakan dalam grafik ini menunjukkan akurasi dalam menggambarkan tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua. Data ini penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan adanya tren pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil di Provinsi Papua, dengan jumlah laki-laki yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.4 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Selatan, 2020–2023

Gambar 6.4 menggambarkan data jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2023. Data yang disajikan merupakan hasil Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Hasil SP2020. Data ini mencakup jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta total keseluruhan penduduk setiap tahunnya. Melalui grafik ini, terlihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk secara konsisten, yang memberikan gambaran perkembangan populasi di Papua Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Setiap tahun, total jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 513.617 jiwa, kemudian meningkat menjadi 518.898 jiwa pada tahun 2021. Tren ini berlanjut dengan peningkatan hingga 526.683 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai 534.416 jiwa di tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang konsisten ini mencerminkan adanya pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di Papua Selatan, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

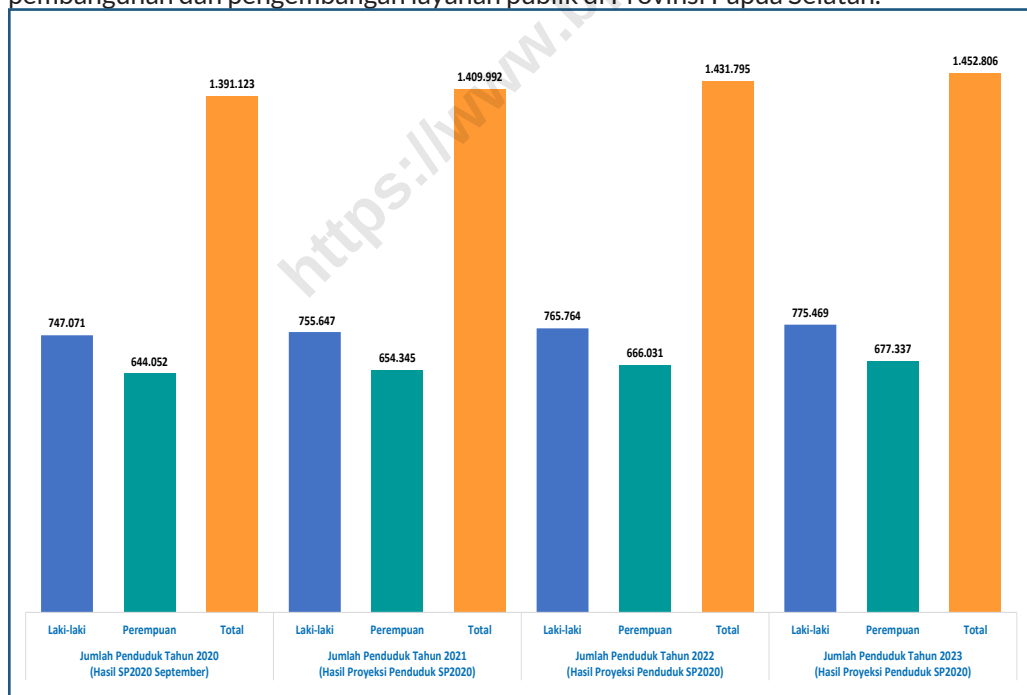
Dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki selalu sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 268.091 laki-laki dan 245.526



perempuan. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun, di mana pada tahun 2023 penduduk laki-laki mencapai 277.844 jiwa dan perempuan 256.572 jiwa. Perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang stabil ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan dalam komposisi penduduk Papua Selatan cukup konsisten dari tahun ke tahun.

Kesenjangan jumlah antara laki-laki dan perempuan di Papua Selatan juga menunjukkan pola yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah sekitar 22.565 jiwa, sementara pada tahun 2023 selisih ini hanya sedikit berubah menjadi 21.272 jiwa. Meskipun laki-laki cenderung lebih dominan dalam jumlah, distribusi penduduk secara umum masih seimbang. Selisih yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa populasi di Papua Selatan cukup merata antara laki-laki dan perempuan.

Data proyeksi dari Sensus Penduduk 2020 yang digunakan dalam grafik ini memberikan pandangan yang akurat mengenai pertumbuhan penduduk di Papua Selatan. Proyeksi ini penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang stabil, dengan laki-laki yang sedikit mendominasi, yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan layanan publik di Provinsi Papua Selatan.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

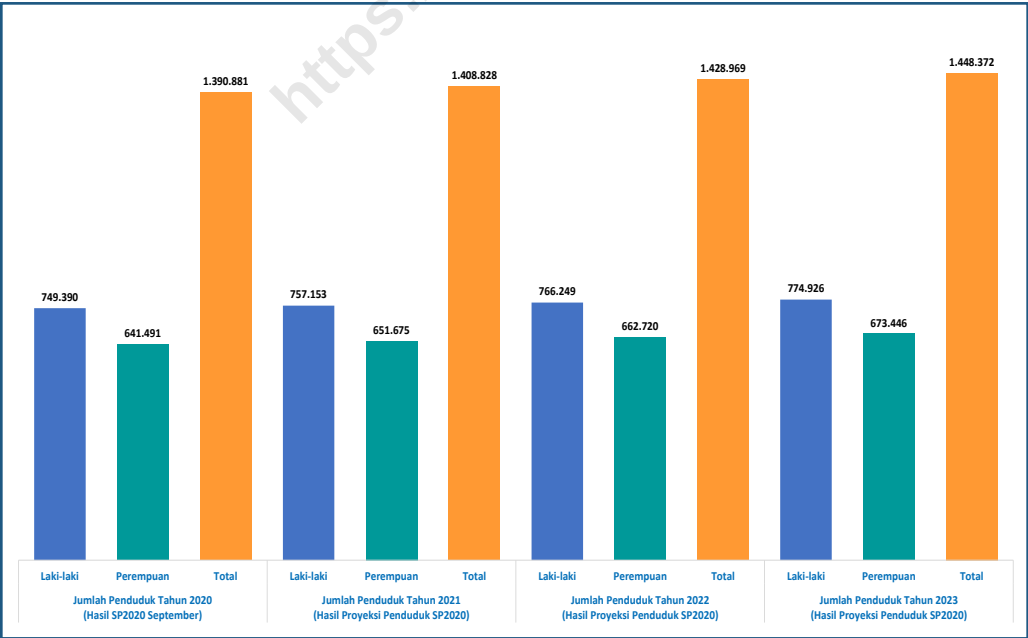
Gambar 6.5 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Tengah, 2020–2023



Gambar 6.5 menggambarkan jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2023, Data yang disajikan merupakan hasil Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Hasil SP2020. Data ini mengelompokkan penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta total keseluruhan penduduk untuk setiap tahunnya. Informasi dalam grafik menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang konsisten, yang penting untuk dipahami dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Setiap tahunnya, Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang stabil. Pada tahun 2020, total penduduk tercatat sebesar 1.391.123 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.409.992 jiwa pada tahun 2021. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah 1.431.795 jiwa, dan mencapai 1.452.806 jiwa di tahun 2023. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan adanya peningkatan populasi secara berkelanjutan di provinsi ini.

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah laki-laki tercatat sebanyak 747.071 jiwa, sementara perempuan berjumlah 644.052 jiwa. Pola ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah laki-laki mencapai 775.469 jiwa dan perempuan mencapai 677.337 jiwa. Dominasi jumlah laki-laki ini merupakan karakteristik yang konsisten dalam struktur populasi Papua Tengah. Selisih jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan di Papua Tengah juga menunjukkan pola yang relatif stabil. Pada tahun 2020, selisih jumlah laki-laki dan perempuan sekitar 103.019 jiwa, dan sedikit berkurang menjadi 98.132 jiwa pada tahun 2023. Meskipun jumlah laki-laki tetap lebih banyak, kesenjangan ini tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa distribusi penduduk cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan di provinsi tersebut.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.6 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Pegunungan, 2020–202



Data proyeksi dari Sensus Penduduk 2020 yang digunakan dalam gambar 6.5 ini memberikan pandangan akurat mengenai tren pertumbuhan populasi di Papua Tengah. Proyeksi ini sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam merencanakan layanan publik dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dengan dominasi jumlah laki-laki, yang memberikan dasar kuat untuk perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik di wilayah ini.

Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP2020) pada bulan September 2020, terlihat di Gambar 6.6 jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan mencapai 1.390.881 jiwa, terdiri atas 749.390 jiwa laki-laki dan 641.491 jiwa perempuan, dengan selisih 107.899 jiwa yang menunjukkan dominasi jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2021, proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2020 memperlihatkan peningkatan populasi menjadi 1.408.828 jiwa, yang terdiri dari 757.153 laki-laki dan 651.675 perempuan, menandakan pertumbuhan sebesar 17.947 jiwa dari tahun sebelumnya dengan penambahan 7.763 laki-laki dan 10.184 perempuan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk terus meningkat hingga mencapai 1.428.969 jiwa, yang terdiri dari 766.249 laki-laki dan 662.720 perempuan, menunjukkan kenaikan populasi sebesar 20.141 jiwa dibandingkan tahun 2021, dengan pertambahan laki-laki sebanyak 9.096 jiwa dan perempuan sebanyak 11.045 jiwa. Tahun 2023 melanjutkan tren peningkatan penduduk, dengan total populasi mencapai 1.448.372 jiwa, terdiri dari 774.926 laki-laki dan 673.446 perempuan, mengalami kenaikan sebanyak 19.403 jiwa dari tahun 2022, dengan tambahan 8.677 laki-laki dan 10.726 perempuan.

Dari tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Papua Pegunungan mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 18.000 hingga 20.000 jiwa per tahun. Pertumbuhan ini konsisten pada kelompok laki-laki dan perempuan, meskipun jumlah laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini mencerminkan tren demografis yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan pelayanan publik di provinsi tersebut. Pertumbuhan jumlah penduduk juga menunjukkan potensi peningkatan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur dasar di wilayah Papua Pegunungan.

6.2 Rasio Ketergantungan

Gambar 6.7 memperlihatkan rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat dari tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan perkembangan dalam beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio yang lebih tinggi menunjukkan beban ekonomi yang lebih besar bagi penduduk usia produktif dalam menopang penduduk non-produktif. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan total tercatat sebesar 43,01. Rasio ketergantungan perempuan lebih tinggi (44,49) dibandingkan laki-laki (41,71), menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki beban ketergantungan yang lebih besar. Tren ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, meskipun rasio ketergantungan total mengalami penurunan kecil dari 42,90 pada 2021 menjadi 42,80 pada 2022, dan sedikit lagi menjadi 42,76 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya

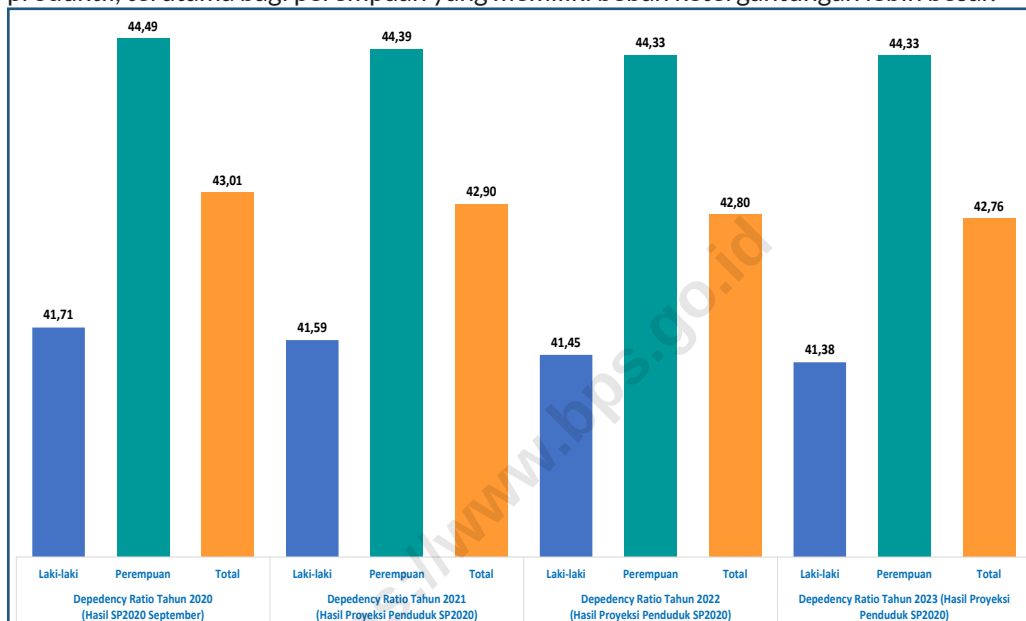


sedikit peningkatan dalam efisiensi ekonomi, namun beban perempuan tetap lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Lalu, pada tahun 2021, penurunan kecil pada rasio ketergantungan terjadi baik pada laki-laki (41,59) maupun perempuan (44,39), dengan rasio total mencapai 42,90. Begitu pula pada tahun 2022, rasio ketergantungan laki-laki menurun menjadi 41,45 dan perempuan menjadi 44,33, menjadikan rasio total 42,80. Meski terdapat penurunan, perempuan tetap memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi, menunjukkan tantangan ekonomi yang lebih besar bagi kelompok perempuan dalam menopang penduduk non-produktif. Kemudian, pada tahun 2023, rasio ketergantungan laki-laki menurun lagi menjadi 41,38, sementara rasio perempuan tetap stabil di 44,33, menghasilkan rasio total 42,76. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan bertahap pada rasio ketergantungan total, beban ekonomi perempuan dalam menopang usia non-produktif tetap konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki sepanjang periode tersebut.

Berdasarkan Gambar 6.7 rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat beberapa aspek penting terkait tren perubahan rasio, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta stabilitas pada masing-masing gender. Secara umum, tren rasio ketergantungan di Papua Barat menunjukkan penurunan yang bertahap dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan total tercatat sebesar 43,01 dan menurun sedikit pada tahun 2021 menjadi 42,90. Tren penurunan ini berlanjut ke tahun 2022 dengan total rasio ketergantungan sebesar 42,80, hingga akhirnya mencapai angka 42,76 pada tahun 2023. Meskipun perubahan ini tampak kecil setiap tahunnya, tren penurunan yang berkesinambungan menunjukkan adanya pengurangan dalam beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk menopang penduduk non-produktif di Papua Barat. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor demografis atau peningkatan produktivitas ekonomi pada kelompok usia produktif yang memungkinkan penurunan rasio ketergantungan secara bertahap. Jika dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, setiap tahun, terdapat perbedaan konsisten antara rasio ketergantungan laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan laki-laki berada di angka 41,71, sementara perempuan mencapai 44,49. Perbedaan ini terus terlihat pada tahun-tahun berikutnya, di mana perempuan selalu memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan laki-laki turun menjadi 41,38, sementara perempuan tetap tinggi di angka 44,33. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa perempuan di Papua Barat cenderung menghadapi beban ekonomi yang lebih besar dalam menopang penduduk usia non-produktif dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh struktur demografi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, atau peran sosial-ekonomi yang membuat perempuan memiliki tanggungan lebih tinggi dalam keluarga atau komunitas. Dalam hal stabilitas gender, rasio ketergantungan pada kelompok perempuan menunjukkan konsistensi yang relatif tinggi di atas angka 44, dengan hanya sedikit fluktuasi sepanjang empat tahun tersebut. Angka ini dimulai di 44,49 pada tahun 2020 dan tetap berada di sekitar angka 44 hingga tahun 2023, yaitu pada 44,33. Di sisi lain, rasio ketergantungan laki-laki menunjukkan sedikit variasi namun tetap relatif stabil di sekitar angka 41, dengan sedikit penurunan setiap tahunnya. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan pada total rasio ketergantungan, beban ketergantungan pada perempuan tetap tinggi dan konsisten. Tingginya stabilitas pada kelompok perempuan mencerminkan bahwa mereka tetap menghadapi tantangan ekonomi yang konstan dalam mendukung penduduk usia non-produktif. Secara keseluruhan, Gambar 6.7 menunjukkan bahwa



meskipun rasio ketergantungan total di Papua Barat mengalami penurunan bertahap, perempuan tetap memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan stabilitas yang tinggi pada kelompok perempuan. Tren ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan beban ketergantungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta mendukung kesejahteraan penduduk usia produktif, terutama bagi perempuan yang memiliki beban ketergantungan lebih besar.



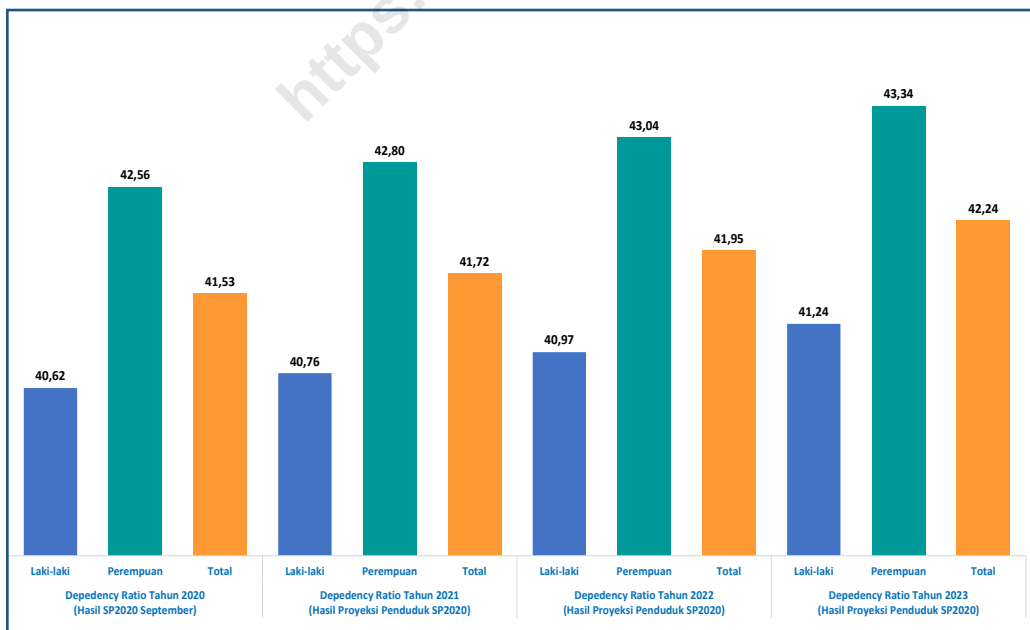
Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.7 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Barat, 2020-2023

Gambar 6.8 menampilkan rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2020 hingga 2023, berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta total rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk menopang kelompok usia non-produktif. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Provinsi Papua Barat Daya dimulai dengan angka 41,53 secara total. Rasio ketergantungan laki-laki berada pada angka 40,62, sementara perempuan lebih tinggi, yaitu 42,56. Hal ini menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk usia non-produktif sedikit lebih besar di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Dengan rasio yang lebih tinggi pada perempuan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun tersebut, perempuan cenderung memiliki tanggungan ketergantungan yang lebih tinggi, yang mungkin disebabkan oleh distribusi usia atau faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi penduduk non-produktif di kalangan perempuan. Memasuki tahun 2021, rasio ketergantungan total sedikit meningkat menjadi 41,72. Rasio ketergantungan laki-laki juga mengalami peningkatan kecil menjadi 40,76, sementara rasio ketergantungan perempuan naik lebih signifikan menjadi 42,80. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terjadi kenaikan dalam total rasio ketergantungan, perbedaan beban antara laki-laki



dan perempuan tetap terlihat jelas. Rasio ketergantungan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki mengindikasikan bahwa kelompok perempuan tetap mengalami beban ketergantungan yang lebih besar dibandingkan laki-laki, yang kemungkinan dipengaruhi oleh struktur demografi dan faktor sosial-ekonomi yang spesifik pada tahun tersebut. Lalu, pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam rasio ketergantungan, dengan total rasio mencapai 41,95. Rasio ketergantungan laki-laki naik menjadi 40,97, sedangkan rasio perempuan mengalami peningkatan yang lebih drastis lagi menjadi 43,04. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan beban ekonomi bagi penduduk usia produktif dalam menopang kelompok usia non-produktif, terutama di kalangan perempuan. Angka yang lebih tinggi pada perempuan menunjukkan bahwa kelompok ini terus menanggung beban ketergantungan yang lebih berat dibandingkan laki-laki, mengindikasikan bahwa tahun 2022 menjadi tahun dengan peningkatan tekanan ekonomi yang lebih signifikan, khususnya untuk menopang penduduk non-produktif dalam kelompok perempuan. Kemudian, pada tahun 2023, rasio ketergantungan laki-laki menunjukkan sedikit penurunan menjadi 41,24, namun rasio ketergantungan perempuan tetap tinggi pada angka 43,34, menghasilkan total rasio ketergantungan sebesar 42,24. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada rasio ketergantungan laki-laki, beban ketergantungan perempuan tetap berada di level yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan dalam beban ekonomi untuk laki-laki, kelompok perempuan masih menanggung beban yang lebih tinggi dalam menopang penduduk usia non-produktif. Tren ini mengindikasikan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan tetap signifikan, yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dari segi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ketergantungan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan.

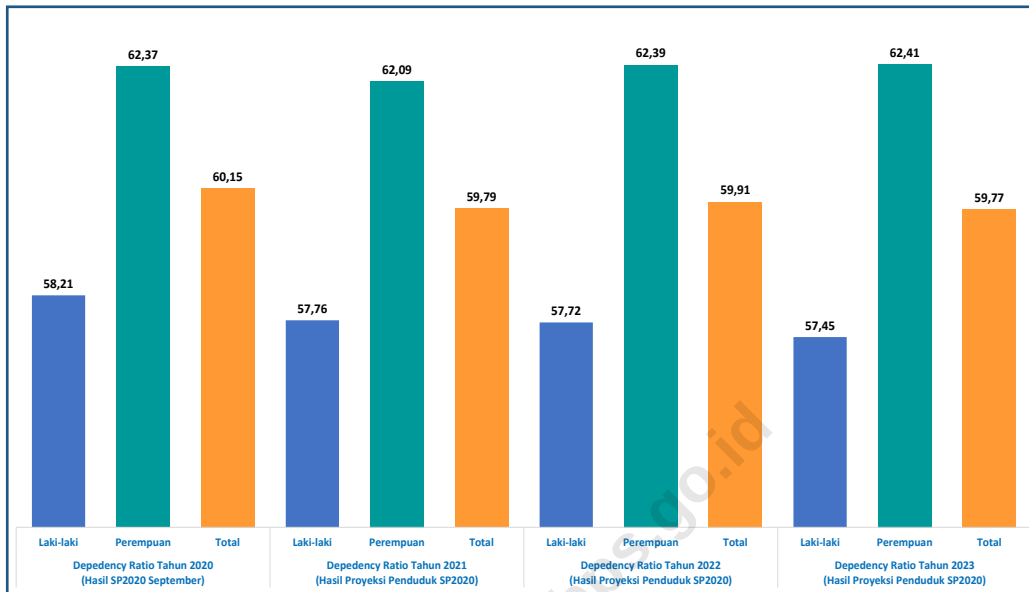


Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.8 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023



Berdasarkan data yang disajikan mengenai rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat beberapa pola dan tren penting yang dapat diamati. Rasio ketergantungan, yang mencerminkan perbandingan jumlah penduduk tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) terhadap penduduk produktif, menunjukkan perubahan kecil namun signifikan pada periode ini. Secara keseluruhan, terjadi sedikit peningkatan dalam rasio ketergantungan dari tahun ke tahun, yang dapat mengindikasikan pertambahan jumlah penduduk di kelompok usia tidak produktif atau pengurangan relatif pada penduduk usia produktif. Pada tahun 2020, data menunjukkan rasio ketergantungan total sebesar 41,53, yang kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 42,24 pada tahun 2023. Walaupun perubahan ini relatif kecil, adanya kenaikan menunjukkan potensi pergeseran dalam struktur demografi, yang mungkin berdampak pada beban sosial dan ekonomi di provinsi ini. Tren yang terlihat ini mungkin merupakan indikasi bahwa Papua Barat Daya mengalami sedikit peningkatan populasi yang membutuhkan dukungan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Lonjakan kecil ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur sosial di masa mendatang. Jika dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam setiap tahun yang dianalisis, terdapat perbedaan yang konsisten antara rasio ketergantungan laki-laki dan perempuan. Rasio ketergantungan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki sepanjang periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, misalnya, rasio ketergantungan untuk laki-laki tercatat sebesar 40,62, sementara untuk perempuan mencapai 42,56. Selisih ini tetap bertahan di setiap tahun berikutnya, dengan rasio ketergantungan perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2023, perbedaan ini terlihat cukup nyata dengan rasio ketergantungan laki-laki sebesar 41,95 dibandingkan perempuan yang mencapai 43,34. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan dalam harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan biasanya memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga kelompok usia lanjut yang tidak produktif pada perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga bisa berperan dalam struktur populasi ini, di mana peran dan tanggung jawab gender yang berbeda bisa memengaruhi angka partisipasi dalam usia produktif. Kemudian, analisis stabilitas gender memperlihatkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal rasio ketergantungan cukup stabil dari tahun ke tahun. Rasio ketergantungan untuk laki-laki dan perempuan meningkat secara proporsional dan tanpa perubahan signifikan dalam perbedaan antara kedua kelompok gender tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur demografi Provinsi Papua Barat Daya memiliki stabilitas dalam komposisi gender, di mana perubahan yang terjadi relatif konsisten bagi kedua kelompok. Stabilitas ini memberikan indikasi bahwa perubahan dalam rasio ketergantungan lebih dipengaruhi oleh faktor populasi secara keseluruhan daripada perubahan spesifik yang hanya berdampak pada salah satu gender. Secara keseluruhan, stabilitas rasio ketergantungan antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan kelompok usia tidak produktif di antara kedua gender. Namun, perbedaan kecil yang terlihat tetap mengindikasikan bahwa perempuan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi. Ini dapat berimplikasi pada kebutuhan layanan sosial dan kesejahteraan yang mungkin perlu lebih diperhatikan untuk kelompok perempuan, terutama bagi mereka yang masuk dalam kelompok usia lanjut.



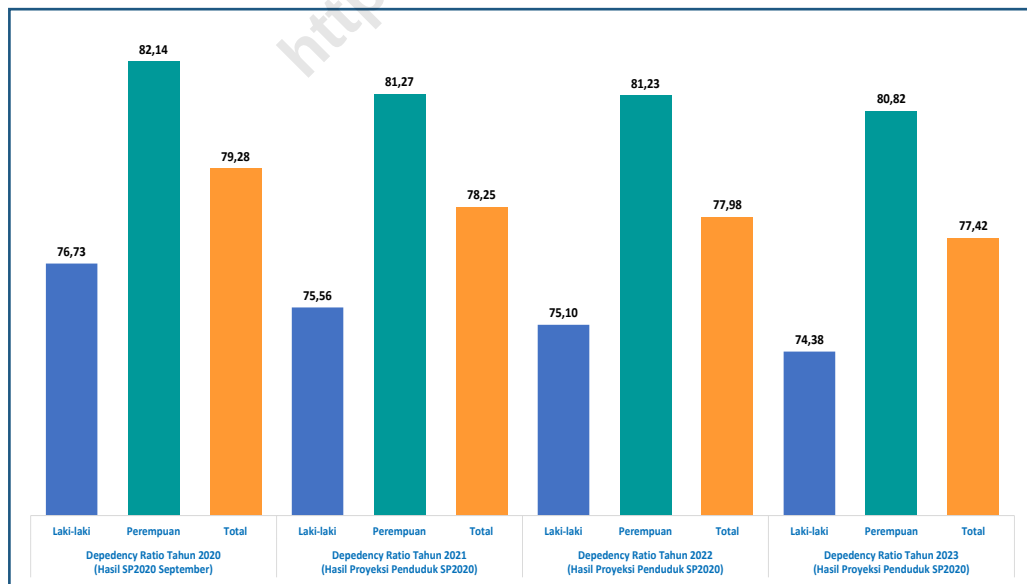
Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.9 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua, 2020–2023

Berdasarkan Gambar 6.9 yang disajikan, analisis deskriptif terhadap *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan) di Provinsi Papua dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola perubahan yang dapat dicermati berdasarkan jenis kelamin dan total keseluruhan. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan untuk laki-laki berada di angka 58,21, sementara perempuan lebih tinggi yaitu 62,37. Secara keseluruhan, rasio ketergantungan di Papua pada tahun tersebut adalah 60,15. Angka yang lebih tinggi pada perempuan menunjukkan beban ketergantungan yang lebih besar pada kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. Pada 2021, *Dependency Ratio* mengalami sedikit penurunan. Rasio untuk laki-laki turun menjadi 57,76, sedangkan perempuan menjadi 62,09. Hal ini juga mempengaruhi total rasio ketergantungan yang mengalami penurunan sedikit menjadi 59,79. Penurunan ini menunjukkan adanya sedikit pengurangan beban ketergantungan di Provinsi Papua. Lalu, pada tahun 2022, trend rasio ketergantungan yang lebih rendah terus berlanjut. Rasio untuk laki-laki berada pada angka 57,72 dan untuk perempuan sedikit menurun ke 62,39. Total rasio ketergantungan juga mengalami sedikit kenaikan ke 59,91, namun angkanya masih relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan dalam *Dependency Ratio* bagi kedua jenis kelamin. Untuk laki-laki, rasio ini berada di angka 57,45, sedangkan untuk perempuan mencapai 62,41, yang merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu empat tahun. Total rasio ketergantungan pada tahun ini adalah 59,77, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kenaikan pada perempuan ini mencerminkan peningkatan proporsi penduduk yang tidak bekerja dalam kelompok ini. Secara keseluruhan, rasio ketergantungan di Provinsi Papua cenderung fluktuatif namun relatif stabil, dengan sedikit perubahan antar tahun. Selain itu, rasio ketergantungan di Provinsi Papua dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan beberapa pola yang menarik dalam hal tren tahunan, perbedaan antar gender, serta stabilitas gender. Secara keseluruhan, rasio ketergantungan di Papua menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020-2023, dengan sedikit variasi setiap tahunnya.



Rasio ketergantungan total mengalami penurunan dari 60,15 pada tahun 2020 menjadi 59,77 pada tahun 2023. Mengindikasikan adanya pengurangan beban penduduk usia non-produktif terhadap populasi usia produktif, meskipun fluktuasi antar tahun tetap ada. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan pada total rasio ketergantungan dibandingkan tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2023, menunjukkan pola naik-turun yang tidak terlalu signifikan. Jika dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan, rasio ketergantungan perempuan secara konsisten lebih tinggi daripada laki-laki sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan perempuan mencapai 62,37, sementara laki-laki berada pada 58,21. Pola ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana rasio ketergantungan perempuan adalah 62,41 dan laki-laki 57,45. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa populasi perempuan di Papua cenderung memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan demografis, seperti perbedaan angka harapan hidup dan peran gender dalam masyarakat yang memengaruhi komposisi usia non-produktif. Jika dilihat dari stabilitas gender, rasio ketergantungan laki-laki menunjukkan penurunan yang lebih konsisten dari 58,21 pada tahun 2020 menjadi 57,45 pada tahun 2023. Sebaliknya, rasio ketergantungan perempuan cenderung stabil pada kisaran angka 62, dengan sedikit kenaikan dan penurunan antar tahun. Ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki stabilitas yang lebih tinggi dalam hal beban ketergantungan, meskipun angkanya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan stabilitas antara laki-laki dan perempuan ini mungkin mencerminkan distribusi usia yang berbeda dan peran gender dalam struktur sosial dan ekonomi di Papua. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan rasio ketergantungan antar gender, pola tren tahunan menunjukkan sedikit penurunan beban ketergantungan secara keseluruhan di Provinsi Papua, dengan perempuan yang cenderung lebih stabil namun lebih tinggi bebannya dibanding laki-laki.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.10 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Selatan, 2020–202

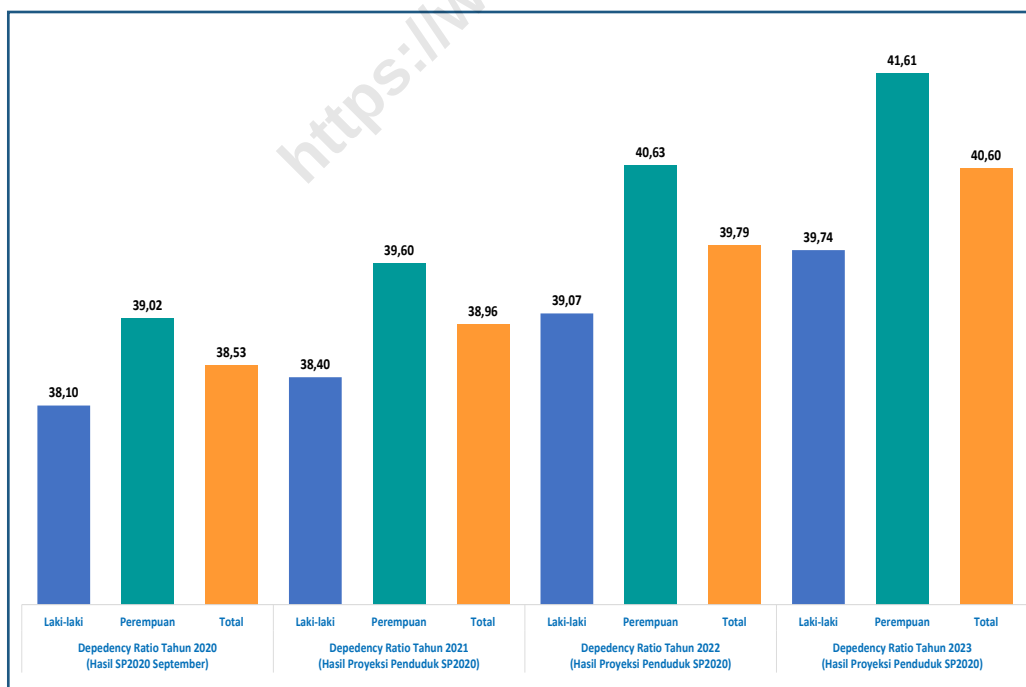


Berdasarkan Gambar 6.10 rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat pola yang konsisten dalam perbedaan beban ketergantungan antara laki-laki dan perempuan, serta fluktuasi kecil dalam rasio ketergantungan total setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan laki-laki di Provinsi Papua Selatan adalah 76,73, sementara untuk perempuan mencapai angka 82,14, yang menghasilkan rasio ketergantungan total sebesar 79,28. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mungkin menunjukkan komposisi penduduk usia non-produktif yang lebih besar di kalangan perempuan atau peran sosial yang berbeda dalam struktur keluarga. Beban ketergantungan total yang mendekati angka 80 mengindikasikan tingkat ketergantungan yang tinggi secara keseluruhan di provinsi ini. Kemudian, pada tahun 2021, rasio ketergantungan laki-laki mengalami penurunan menjadi 75,56, dan rasio untuk perempuan juga menurun ke 81,27. Penurunan ini juga berdampak pada rasio ketergantungan total yang berkurang menjadi 78,25. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, beban ketergantungan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penurunan ini mungkin menunjukkan peningkatan populasi usia produktif atau penurunan jumlah penduduk usia non-produktif, yang sedikit mengurangi beban ketergantungan. Lalu, pada tahun 2022, rasio ketergantungan laki-laki sedikit meningkat kembali ke angka 75,10, sedangkan rasio ketergantungan perempuan naik ke 81,23. Rasio ketergantungan total pada tahun ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 77,98. Peningkatan kecil ini menunjukkan fluktuasi beban ketergantungan yang mungkin disebabkan oleh perubahan dalam komposisi usia penduduk. Meskipun terjadi kenaikan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap terlihat, di mana perempuan cenderung memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi. Namun, pada tahun 2023, tren menunjukkan adanya penurunan signifikan pada rasio ketergantungan laki-laki menjadi 74,38, sementara rasio ketergantungan perempuan turun menjadi 80,82. Total rasio ketergantungan pada tahun ini berada di angka 77,42, yang merupakan penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi pada tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam komposisi penduduk usia produktif yang mampu mengurangi beban ketergantungan, terutama dalam kelompok laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode empat tahun tersebut, rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan menunjukkan fluktuasi namun relatif stabil, dengan perempuan secara konsisten memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Meskipun total rasio ketergantungan mengalami sedikit penurunan di akhir periode, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap menjadi ciri khas utama dari struktur ketergantungan di wilayah ini.

Selain itu, berdasarkan grafik rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2023, berikut adalah analisis deskriptif berdasarkan tren yang terlihat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta stabilitas gender. Secara umum, tren rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan mengalami sedikit fluktuasi namun menunjukkan kecenderungan penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan total berada di angka 79,28, kemudian menurun menjadi 78,25 pada tahun 2021, meningkat sedikit menjadi 77,98 pada tahun 2022, dan kembali menurun ke 77,42 pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan di Papua Selatan secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan selama periode empat tahun, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dan kembali stabil pada tahun 2023. Perbedaan rasio ketergantungan antara laki-laki dan perempuan di Papua Selatan tampak jelas dan konsisten sepanjang periode ini. Rasio ketergantungan perempuan lebih



tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, perempuan memiliki rasio ketergantungan sebesar 82,14, sedangkan laki-laki berada di angka 76,73. Pola ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana rasio ketergantungan perempuan mencapai 80,82 sementara laki-laki turun ke 74,38. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan pada perempuan lebih besar, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan harapan hidup atau peran sosial perempuan dalam keluarga yang sering kali menanggung tanggung jawab untuk anggota keluarga yang lebih muda atau lebih tua. Dari segi stabilitas gender, laki-laki menunjukkan tren yang lebih konsisten dan cenderung mengalami penurunan yang stabil dari tahun ke tahun, dengan fluktuasi yang relatif kecil. Rasio ketergantungan laki-laki menurun dari 76,73 pada tahun 2020 ke 74,38 pada tahun 2023. Sebaliknya, rasio ketergantungan perempuan cenderung lebih bervariasi, meskipun tetap lebih tinggi dari laki-laki. Setelah mencapai puncaknya di angka 82,14 pada tahun 2020, rasio ketergantungan perempuan mengalami penurunan yang fluktuatif, hingga akhirnya mencapai angka 80,82 pada tahun 2023. Stabilitas pada laki-laki yang lebih terjaga ini mengindikasikan bahwa beban ketergantungan pada laki-laki lebih stabil, sementara pada perempuan sedikit lebih dinamis dengan adanya variasi tiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun rasio ketergantungan di Papua Selatan menunjukkan tren penurunan dalam periode empat tahun, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap konstan, dengan perempuan menanggung beban ketergantungan yang lebih tinggi. Stabilitas rasio ketergantungan pada laki-laki cenderung lebih kuat dibandingkan perempuan, menunjukkan bahwa kelompok laki-laki memiliki perubahan yang lebih teratur dan konsisten.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.11 Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tengah, 2020–2023



Berdasarkan Gambar 6.11 rasio ketergantungan di Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat pola yang menunjukkan peningkatan bertahap dalam rasio ketergantungan setiap tahunnya baik untuk laki-laki, perempuan, maupun total keseluruhan. Berikut adalah analisis deskriptif yang menggambarkan kondisi rasio ketergantungan di Papua Tengah berdasarkan tahun. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan untuk laki-laki berada di angka 38,10, sementara perempuan sedikit lebih tinggi dengan angka 39,02, menghasilkan rasio ketergantungan total sebesar 38,53. Angka-angka ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan di Papua Tengah pada tahun ini relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga kecil, dengan perempuan hanya memiliki sedikit beban ketergantungan yang lebih tinggi. Hal ini bisa diakibatkan oleh struktur demografi penduduk yang cukup seimbang antara populasi usia produktif dan non-produktif. Lalu, pada tahun 2021, rasio ketergantungan menunjukkan sedikit peningkatan untuk kedua jenis kelamin. Rasio ketergantungan laki-laki naik menjadi 38,40 dan perempuan meningkat ke angka 39,60. Total rasio ketergantungan di tahun ini juga meningkat menjadi 38,96. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan beban ketergantungan di Papua Tengah, meskipun kenaikannya relatif kecil. Hal ini mungkin mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk non-produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia produktif, meskipun perbedaannya masih kecil sehingga beban ketergantungan tetap terkendali. Kemudian, pada tahun 2022, rasio ketergantungan kembali meningkat.

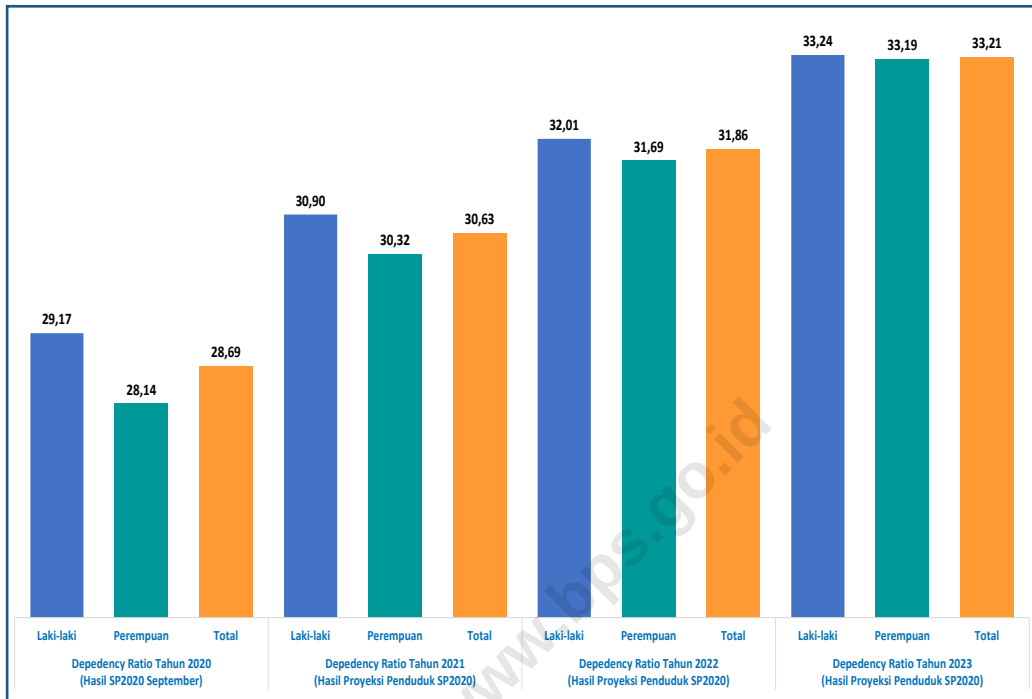
Rasio untuk laki-laki mencapai 39,07, sementara perempuan naik signifikan ke angka 40,63. Total rasio ketergantungan di tahun ini menjadi 39,79. Peningkatan yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki mungkin mengindikasikan adanya perubahan dalam struktur populasi, di mana terdapat lebih banyak perempuan usia non-produktif atau peningkatan harapan hidup pada perempuan yang mempengaruhi komposisi usia di kelompok ini. Total beban ketergantungan yang meningkat menandakan adanya penambahan penduduk non-produktif, yang sedikit meningkatkan tekanan terhadap populasi usia produktif di Papua Tengah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023, tren peningkatan rasio ketergantungan berlanjut. Rasio ketergantungan laki-laki naik lagi ke angka 39,74, sedangkan perempuan mencapai 41,61. Total rasio ketergantungan di tahun ini berada di angka 40,60, yang merupakan angka tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Kenaikan yang konsisten setiap tahun menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penduduk usia non-produktif di Papua Tengah, dengan beban ketergantungan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki secara konsisten. Hal ini mungkin menunjukkan dinamika demografis yang mendorong peningkatan rasio ketergantungan, seperti peningkatan angka harapan hidup atau perubahan pola reproduksi yang memengaruhi jumlah penduduk usia produktif. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat tren peningkatan yang konsisten dalam rasio ketergantungan di Papua Tengah. Perbedaan rasio antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki beban ketergantungan yang lebih tinggi setiap tahunnya. Meskipun peningkatan beban ketergantungan terlihat cukup moderat, hal ini tetap menunjukkan bahwa populasi usia produktif di Papua Tengah menanggung beban yang semakin besar dari tahun ke tahun, terutama karena populasi non-produktif yang terus bertambah.



Selain itu, rasio ketergantungan di Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2023 dapat dianalisis berdasarkan tren yang terlihat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta stabilitas gender. Secara umum, tren rasio ketergantungan di Provinsi Papua Tengah menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2020 hingga 2023. Rasio ketergantungan total mengalami kenaikan dari 38,53 pada tahun 2020 menjadi 40,60 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya beban ketergantungan di provinsi ini, yang berarti semakin banyak penduduk usia non-produktif yang perlu ditanggung oleh penduduk usia produktif. Kenaikan bertahap ini mengindikasikan adanya dinamika demografis yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di luar usia produktif atau penurunan proporsi usia produktif.

Terdapat perbedaan rasio ketergantungan antara laki-laki dan perempuan setiap tahunnya, di mana perempuan secara konsisten memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan untuk perempuan adalah 39,02, sedangkan untuk laki-laki adalah 38,10. Perbedaan ini terus terlihat hingga tahun 2023, dengan rasio perempuan mencapai 41,61 dan laki-laki sebesar 39,74. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor demografis, termasuk perbedaan angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan perempuan memiliki proporsi penduduk usia non-produktif yang lebih besar. Lalu, dari segi stabilitas gender, rasio ketergantungan laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang cukup stabil namun dengan sedikit peningkatan setiap tahunnya. Rasio ketergantungan laki-laki mengalami kenaikan yang lebih lambat dan teratur dibandingkan dengan perempuan. Pada perempuan, terdapat kenaikan yang sedikit lebih signifikan terutama pada tahun 2022 dan 2023. Stabilitas yang relatif konsisten pada kedua gender ini menunjukkan bahwa struktur usia penduduk di Papua Tengah mengalami perubahan secara bertahap, tanpa fluktuasi yang ekstrem. Namun, dengan beban ketergantungan perempuan yang secara konsisten lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan di Papua Tengah mungkin memiliki beban ketergantungan yang lebih besar, baik dalam hal jumlah penduduk usia non-produktif atau peran dalam menopang penduduk usia produktif. Dapat disimpulkan bahwa, dari tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan beban ketergantungan secara bertahap, dengan perempuan yang memiliki rasio ketergantungan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenaikan yang relatif stabil menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur demografi berlangsung secara perlahan namun konsisten. Hal ini mungkin menjadi perhatian bagi kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial, mengingat tingginya beban ketergantungan pada penduduk perempuan yang dapat mempengaruhi ekonomi dan struktur sosial di Papua Tengah.

Berdasarkan Gambar 6.12 rasio ketergantungan di Provinsi Papua Pegunungan dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat pola yang menunjukkan peningkatan bertahap dalam rasio ketergantungan setiap tahunnya baik untuk laki-laki, perempuan, maupun total keseluruhan. Berikut adalah analisis deskriptif berdasarkan tahun yang tersedia. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Papua Pegunungan menunjukkan angka yang cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Papua. Rasio ketergantungan untuk laki-laki berada di angka 29,17, sementara untuk perempuan sedikit lebih rendah di angka 28,14, menghasilkan rasio ketergantungan total sebesar 28,69. Angka-angka ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan di Papua Pegunungan pada tahun 2020 relatif rendah, di mana jumlah penduduk usia produktif mampu menopang penduduk usia non-produktif dengan baik.



Sumber: SP2020 September dan Proyeksi Penduduk

Gambar 6.12 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Pegunungan, 2020–202

Perbedaan kecil antara laki-laki dan perempuan mengindikasikan distribusi usia yang cukup seimbang dalam struktur populasi. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan dalam rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan untuk laki-laki naik menjadi 30,90 dan untuk perempuan meningkat menjadi 30,32. Total rasio ketergantungan di tahun ini juga naik ke angka 30,63. Kenaikan ini menunjukkan adanya sedikit penambahan beban ketergantungan di Papua Pegunungan, meskipun kenaikannya masih tergolong moderat. . Peningkatan ini dapat mengindikasikan bertambahnya jumlah penduduk usia non-produktif dibandingkan dengan usia produktif, namun beban ketergantungan secara keseluruhan tetap terkendali. Lalu, pada tahun 2022, rasio ketergantungan kembali mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan laki-laki naik ke angka 32,01, sementara perempuan mencapai 31,69. Total rasio ketergantungan di tahun ini meningkat menjadi 31,86.

Peningkatan ini menunjukkan adanya pertambahan jumlah penduduk usia non-produktif yang perlu didukung oleh penduduk usia produktif. Walaupun peningkatannya tidak terlalu tajam, adanya kenaikan yang konsisten dalam dua tahun berturut-turut menunjukkan adanya perubahan demografis yang mengarah pada peningkatan beban ketergantungan di wilayah ini. Kemudian, di tahun 2023, tren peningkatan rasio ketergantungan berlanjut dengan rasio ketergantungan laki-laki mencapai 33,24 dan perempuan sedikit lebih rendah di 33,19, menghasilkan rasio ketergantungan total sebesar 33,21.



Peningkatan ini menunjukkan penduduk usia non-produktif terus bertambah, menambah beban penduduk usia produktif di Papua Pegunungan. Kenaikan yang hampir sama pada laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa peningkatan beban ketergantungan terjadi secara merata pada kedua gender, mencerminkan perubahan demografis yang konsisten di wilayah ini. Dapat disimpulkan dari tahun 2020 hingga 2023, Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren peningkatan yang bertahap dalam rasio ketergantungan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan beban ketergantungan di wilayah tersebut, dengan penduduk usia produktif yang harus menopang semakin banyak penduduk usia non-produktif. Walaupun peningkatan ini terbilang lambat, tren yang konsisten ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur demografi yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial untuk mendukung penduduk usia produktif di Papua Pegunungan.

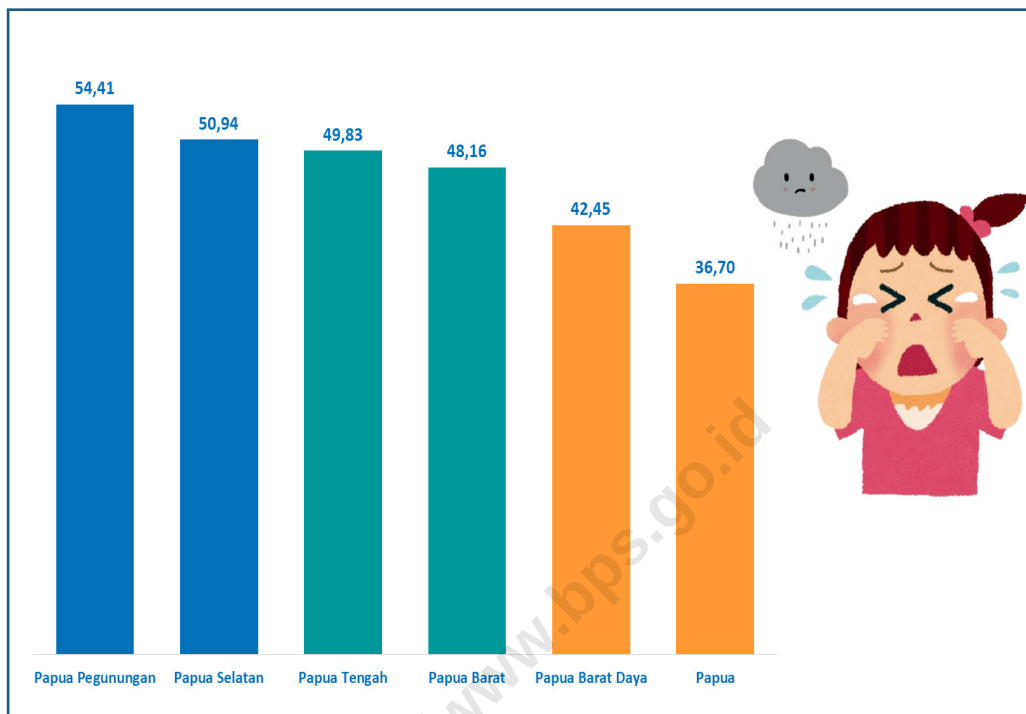
Selain itu, rasio ketergantungan di Provinsi Papua Pegunungan dari tahun 2020 hingga 2023 dapat dianalisis berdasarkan tren yang terlihat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta stabilitas gender. Tren rasio ketergantungan di Papua Pegunungan menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan total berada di angka 28,69, kemudian meningkat menjadi 30,63 pada tahun 2021, 31,86 pada tahun 2022, dan mencapai 33,21 pada tahun 2023. Tren peningkatan yang bertahap menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk usia non-produktif atau penurunan proporsi penduduk usia produktif di wilayah ini, yang berdampak pada bertambahnya beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Jika dilihat dari perbedaan antara rasio ketergantungan laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang menarik. Sepanjang periode empat tahun tersebut, rasio ketergantungan perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun perbedaan antar gender ini relatif kecil. Misalnya, pada tahun 2020, rasio ketergantungan laki-laki adalah 29,17, sedangkan perempuan adalah 28,14. Pada tahun 2023, perbedaan ini masih terlihat dengan rasio ketergantungan laki-laki sebesar 33,24 dan perempuan 33,19. Meskipun perbedaan antar gender ini konsisten setiap tahun, jarak antara rasio laki-laki dan perempuan sangat tipis, menunjukkan distribusi beban ketergantungan yang hampir merata di antara kedua gender. Lalu, jika dilihat dari stabilitas gender, baik laki-laki maupun perempuan mengalami tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perubahan demografi yang mempengaruhi beban ketergantungan terjadi secara merata pada kedua gender, tanpa adanya fluktuasi besar atau perbedaan mencolok antar gender. Stabilitas ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang berimbang dalam populasi usia non-produktif pada laki-laki dan perempuan, sehingga peningkatan beban ketergantungan tidak hanya terpusat pada salah satu kelompok gender. Kenaikan yang stabil ini juga menunjukkan pola pertumbuhan demografi yang berkelanjutan, di mana rasio ketergantungan tidak mengalami lonjakan atau penurunan drastis yang dapat mengindikasikan perubahan signifikan dalam struktur usia. Dapat disimpulkan bahwa, dari tahun 2020 hingga 2023, Papua Pegunungan mengalami peningkatan bertahap dalam rasio ketergantungan baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan perbedaan yang sangat kecil antara kedua gender. Tren yang stabil ini menunjukkan beban ketergantungan di provinsi ini meningkat secara bertahap dan merata pada laki-laki dan perempuan. Perlu diperhatikan dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi. Peningkatan beban ketergantungan yang stabil mengindikasikan perlunya dukungan berkelanjutan bagi penduduk usia produktif untuk menghadapi tantangan demografis yang terus berkembang di Papua Pegunungan.



6.3 Angka Kematian Balita (AKBa)

Berdasarkan Gambar 6.13 angka kematian balita di wilayah Papua dan Papua Barat hasil dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Papua Pegunungan memiliki angka kematian balita tertinggi dibandingkan dengan semua provinsi lain di wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu sebesar 54,41, menunjukkan adanya tantangan besar dalam sektor kesehatan anak di wilayah ini. Kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses ke layanan kesehatan, terutama bagi balita yang rentan terhadap penyakit dan membutuhkan perawatan khusus, sehingga tingginya angka kematian ini mengindikasikan bahwa intervensi kesehatan yang lebih intensif dan terarah diperlukan untuk menekan angka kematian balita di Papua Pegunungan. Selanjutnya, Papua Selatan menempati posisi kedua dengan angka kematian balita sebesar 50,94 walaupun sedikit lebih rendah dari Papua Pegunungan, angka ini tetap tergolong tinggi dan menunjukkan masalah serupa terkait akses dan kualitas layanan kesehatan. Papua Selatan mungkin juga mengalami tantangan dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan distribusi layanan kesehatan yang merata, sehingga program kesehatan khusus untuk balita, seperti imunisasi, gizi seimbang, dan pengobatan penyakit menular, sangat penting untuk mengurangi angka kematian di wilayah ini. Sementara itu, Papua Tengah mencatat angka kematian balita sebesar 49,83, sedikit lebih rendah dari Papua Selatan tetapi menunjukkan kondisi hampir serupa, di mana kesehatan anak di wilayah ini juga masih memerlukan perhatian khusus. Papua Tengah mungkin memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Papua Pegunungan, namun angka kematian balita yang masih tinggi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perawatan kesehatan balita perlu diperkuat, di mana masalah gizi buruk dan penyakit menular mungkin menjadi penyebab utama tingginya angka kematian di wilayah ini. Dengan angka kematian balita sebesar 48,16, Papua Barat memiliki angka yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah; meskipun angka ini sedikit lebih baik, tetap menunjukkan adanya tantangan dalam kesehatan anak yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Papua Barat mungkin memiliki lebih banyak akses ke fasilitas kesehatan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua, tetapi masih perlu untuk memperbaiki distribusi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas perawatan balita, terutama di daerah yang belum terjangkau secara optimal.

Papua Barat Daya memiliki angka kematian balita sebesar 42,45, yang merupakan angka kedua terendah di wilayah ini, meskipun masih di atas 40, angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dan kesejahteraan balita di Papua Barat Daya dibandingkan dengan provinsi sebelumnya. Papua Barat Daya kemungkinan memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dasar dan intervensi kesehatan balita, tetapi masih membutuhkan peningkatan layanan untuk mencapai angka kematian balita yang lebih rendah dan memastikan kesejahteraan anak yang lebih baik. Di sisi lain, Provinsi Papua memiliki angka kematian balita terendah di antara semua provinsi di wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu 36,70, mencerminkan kondisi yang lebih baik untuk kesehatan anak dan menunjukkan bahwa provinsi ini mungkin memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, program imunisasi yang lebih luas, dan dukungan gizi yang memadai untuk balita. Capaian ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam mengembangkan strategi kesehatan balita yang efektif dan berkelanjutan, dan Papua menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka kematian balita, namun tetap diperlukan pemantauan dan peningkatan untuk mempertahankan dan terus menurunkan angka kematian balita.



Sumber: Hasil LF SP2020

Gambar 6.13 Angka Kematian Balita Daerah Otonomi Baru

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa grafik ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam angka kematian balita di antara provinsi-provinsi di Papua dan Papua Barat. Wilayah-wilayah yang memiliki angka kematian balita tinggi, seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan, memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi balita. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, akses ke gizi yang baik, serta program imunisasi dan pencegahan penyakit menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki. Papua sebagai provinsi dengan angka kematian balita terendah menunjukkan bahwa program kesehatan dan intervensi yang tepat sasaran dapat menekan angka kematian secara signifikan. Pengalaman dari provinsi ini bisa dijadikan referensi bagi wilayah lain dalam merancang kebijakan dan program yang mampu mengurangi angka kematian balita. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kematian balita di wilayah Papua dan Papua Barat.



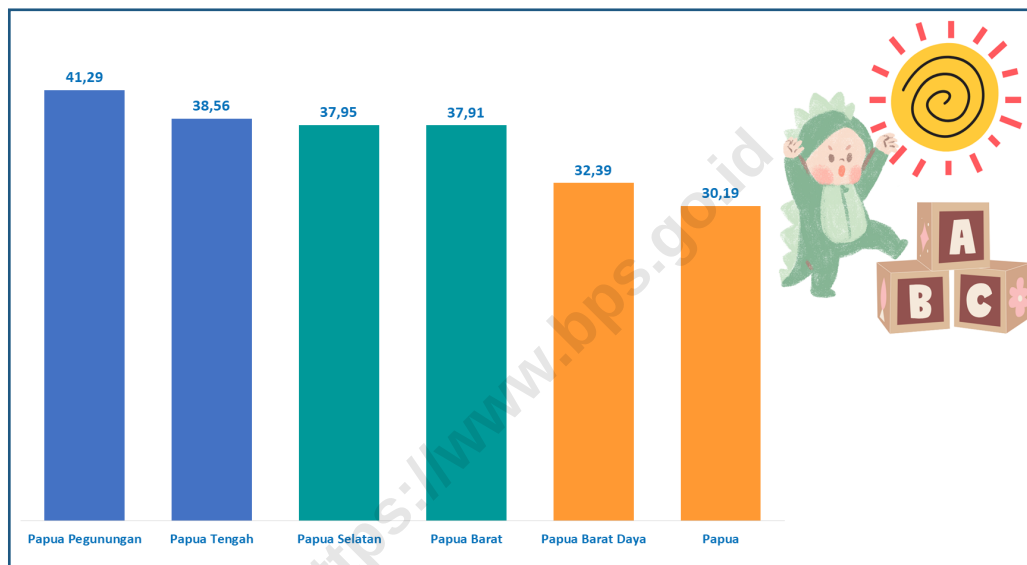
6.4 Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan Gambar 6.14 mengenai angka kematian bayi di wilayah Papua dan Papua Barat yang dihasilkan dari Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Papua Pegunungan memiliki angka kematian bayi tertinggi, yaitu 41,29 per 1.000 kelahiran hidup; tingginya angka ini menunjukkan tantangan kesehatan yang serius, terutama dalam hal akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan dasar. Kondisi geografis yang bergunung-gunung dan terpencil kemungkinan besar menjadi kendala utama yang membatasi akses penduduk terhadap layanan kesehatan yang memadai; minimnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta keterbatasan dalam program imunisasi dan layanan gizi mungkin berkontribusi terhadap tingginya angka ini. Oleh karena itu, diperlukan program yang terfokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan dan dukungan transportasi medis, seperti layanan kesehatan keliling, untuk menekan angka kematian bayi di wilayah ini. Sementara itu, Papua Tengah mencatat angka kematian bayi sebesar 38,56 per 1.000 kelahiran hidup, yang merupakan angka tertinggi kedua; wilayah ini juga kemungkinan menghadapi kendala akses kesehatan yang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau serta distribusi layanan kesehatan yang tidak merata. Papua Tengah mungkin memiliki keterbatasan dalam hal tenaga medis dan fasilitas yang memadai, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga untuk menurunkan angka ini, diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, Papua Selatan memiliki angka kematian bayi sebesar 37,95 per 1.000 kelahiran hidup, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Papua Tengah; meskipun angkanya lebih rendah, kondisi ini tetap mengindikasikan tantangan kesehatan yang signifikan bagi bayi di wilayah ini. Wilayah yang luas dan penduduk yang tersebar mungkin membuat akses layanan kesehatan sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, sehingga program peningkatan akses layanan kesehatan yang mencakup penyediaan fasilitas tambahan di daerah-daerah terpencil serta peningkatan kualitas gizi dan imunisasi dapat membantu menurunkan angka kematian bayi di Papua Selatan. Selain itu, Papua Barat mencatat angka kematian bayi sebesar 37,91 per 1.000 kelahiran hidup, yang hampir sama dengan Papua Selatan; provinsi ini mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dibandingkan provinsi-provinsi sebelumnya, namun tantangan tetap ada dalam hal mencapai wilayah-wilayah terpencil.

Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata dan kurangnya tenaga medis yang memadai di beberapa area bisa menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka kematian bayi di Papua Barat, sehingga program kesehatan khusus untuk bayi, seperti peningkatan cakupan imunisasi dan edukasi gizi bagi ibu hamil, akan membantu dalam mengurangi angka ini. Di sisi lain, Papua Barat Daya memiliki angka kematian bayi sebesar 32,39 per 1.000 kelahiran hidup, yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat; hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor kesehatan bayi di wilayah ini, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Papua Barat Daya kemungkinan memiliki lebih banyak akses terhadap layanan kesehatan dasar dan program imunisasi yang lebih baik; namun, penyediaan layanan tambahan di daerah-daerah yang sulit dijangkau serta peningkatan gizi dan sanitasi tetap diperlukan untuk menurunkan angka kematian bayi lebih jauh.



Terakhir, Provinsi Papua mencatat angka kematian bayi terendah, yaitu 30,19 per 1.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan bahwa provinsi Papua memiliki kondisi kesehatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat; akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, cakupan imunisasi yang tinggi, serta dukungan program kesehatan ibu dan anak mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka ini, dan keberhasilan Papua dalam menekan angka kematian bayi dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam menerapkan program kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.



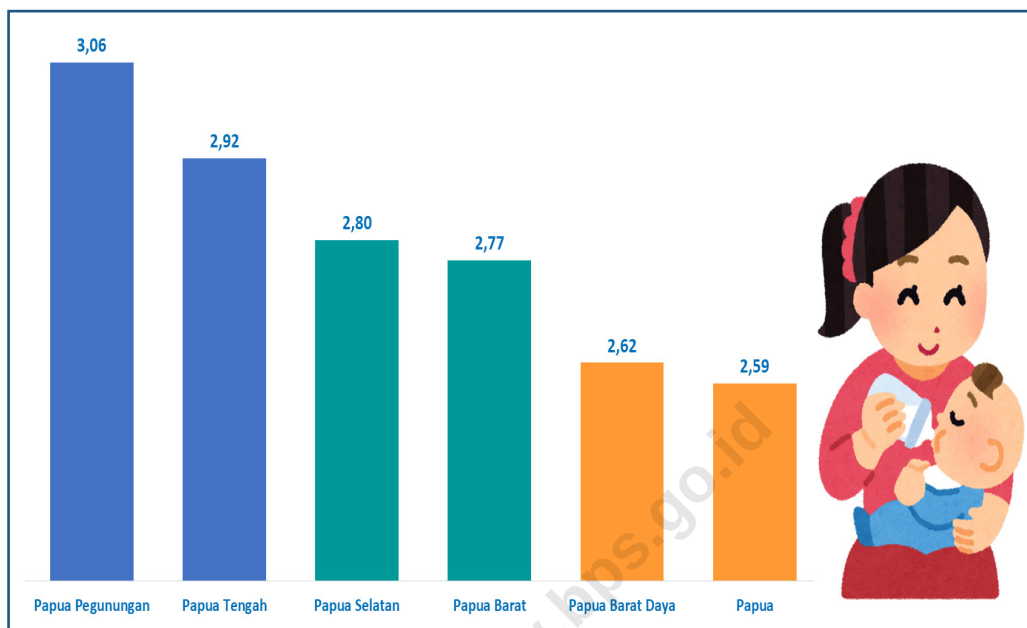
Gambar 6.14 Angka Kematian Bayi (IMR) Daerah Otonomi Baru

Berdasarkan analisis deskriptif tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam angka kematian bayi antarprovinsi, dengan Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi (41,29 per 1.000 kelahiran hidup) dan Provinsi Papua angka terendah (30,19 per 1.000 kelahiran hidup). Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta akses yang tidak merata terhadap program imunisasi dan layanan gizi tampaknya menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi di wilayah-wilayah dengan angka tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sebaliknya, Provinsi Papua dengan angka kematian bayi terendah mencerminkan kondisi kesehatan yang lebih baik, kemungkinan didukung oleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan cakupan imunisasi yang luas. Untuk menurunkan angka kematian bayi di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, diperlukan program kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga medis yang merata, layanan kesehatan keliling untuk daerah terpencil, serta kampanye penyuluhan tentang kesehatan ibu dan bayi. Keberhasilan Provinsi Papua dalam menekan angka kematian bayi dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya menurunkan angka kematian bayi secara signifikan di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.



6.5 Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan Gambar 6.15 mengenai angka kelahiran total (Total Fertility Rate) di wilayah Papua dan Papua Barat dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), terdapat variasi tingkat kelahiran antarprovinsi, di mana Papua Pegunungan mencatat angka kelahiran total tertinggi, yaitu 3,06, yang menunjukkan bahwa rata-rata wanita di wilayah Papua Pegunungan melahirkan lebih dari tiga anak selama masa suburnya. Tingginya angka kelahiran ini bisa jadi dipengaruhi oleh faktor budaya, keterbatasan akses terhadap informasi keluarga berencana, serta rendahnya penggunaan kontrasepsi di wilayah tersebut; tingkat kelahiran yang tinggi ini dapat memberikan tantangan dalam hal penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di wilayah ini, sehingga intervensi yang berfokus pada edukasi keluarga berencana serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi mungkin diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mengatur jumlah kelahiran. Selanjutnya, Papua Tengah memiliki angka kelahiran total sebesar 2,92, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Papua Pegunungan; walaupun sedikit lebih rendah, angka ini tetap menunjukkan kecenderungan untuk memiliki banyak anak, dan seperti halnya Papua Pegunungan, keterbatasan akses terhadap layanan keluarga berencana serta faktor sosial dan budaya mungkin menjadi penyebab tingginya angka kelahiran di wilayah ini, sehingga peningkatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di Papua Tengah dapat membantu masyarakat dalam merencanakan keluarga secara lebih baik. Papua Selatan mencatat angka kelahiran total sebesar 2,80; meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Papua Pegunungan dan Papua Tengah, angka ini masih menunjukkan bahwa rata-rata wanita di wilayah ini memiliki hampir tiga anak, dan tingginya angka kelahiran ini dapat mempengaruhi kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih banyak di masa depan, sehingga program yang mendorong keluarga berencana serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka kelahiran di wilayah ini. Sementara itu, Papua Barat memiliki angka kelahiran total sebesar 2,77, yang sedikit lebih rendah dari Papua Selatan; angka ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Papua Barat mulai mendekati angka kelahiran yang lebih moderat, namun tetap relatif tinggi, sehingga meskipun Papua Barat mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dibandingkan beberapa wilayah lainnya, edukasi yang lebih luas tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat membantu dalam mengelola angka kelahiran ini. Selain itu, Papua Barat Daya mencatat angka kelahiran total sebesar 2,62; angka ini menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dalam angka kelahiran dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, yang bisa jadi mencerminkan keberhasilan dalam penyebaran informasi mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah ini, namun peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil tetap diperlukan untuk mempertahankan atau menurunkan angka ini lebih lanjut. Terakhir, Provinsi Papua memiliki angka kelahiran total terendah, yaitu 2,59, yang menunjukkan bahwa rata-rata wanita di Papua memiliki sekitar dua hingga tiga anak sepanjang masa suburnya; tingkat kelahiran yang lebih rendah ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan kesadaran kesehatan reproduksi di provinsi ini, sehingga keberhasilan Papua dalam menurunkan angka kelahiran ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam mengembangkan program keluarga berencana yang efektif dan komprehensif, meskipun demikian, upaya untuk mempertahankan angka ini dan terus menurunkannya jika memungkinkan tetap perlu dilakukan.



Gambar 6.15 Angka Kelahiran Total (TFR) Daerah Otonomi Baru Hasil Long Form SP2020

Berdasarkan Gambar 6.15 mengenai angka kelahiran total di wilayah Papua dan Papua Barat, terdapat variasi signifikan antarprovinsi, dengan Papua Pegunungan mencatat angka kelahiran tertinggi, yaitu 3,06, dan Provinsi Papua mencatat angka terendah sebesar 2,59. Tingginya angka kelahiran di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian kelahiran yang mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan keluarga berencana dan faktor budaya. Sebaliknya, angka kelahiran yang lebih rendah di Papua Barat Daya dan Provinsi Papua mencerminkan keberhasilan dalam penyebaran informasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Untuk menurunkan dan mengelola angka kelahiran secara merata, diperlukan upaya edukasi, peningkatan akses kesehatan reproduksi, serta program keluarga berencana yang lebih intensif, terutama di wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi, sehingga kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat dikelola lebih optimal.

6.6 Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup

Berdasarkan Gambar 6.16 jumlah migran masuk seumur hidup di wilayah Papua dan Papua Barat, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah migran yang masuk ke setiap provinsi, di mana Provinsi Papua mencatat jumlah migran masuk tertinggi, yaitu sebanyak 223.403 orang. Tingginya angka migran ini menunjukkan bahwa provinsi Papua mungkin memiliki daya tarik ekonomi, sosial, atau infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Papua dan Papua Barat.



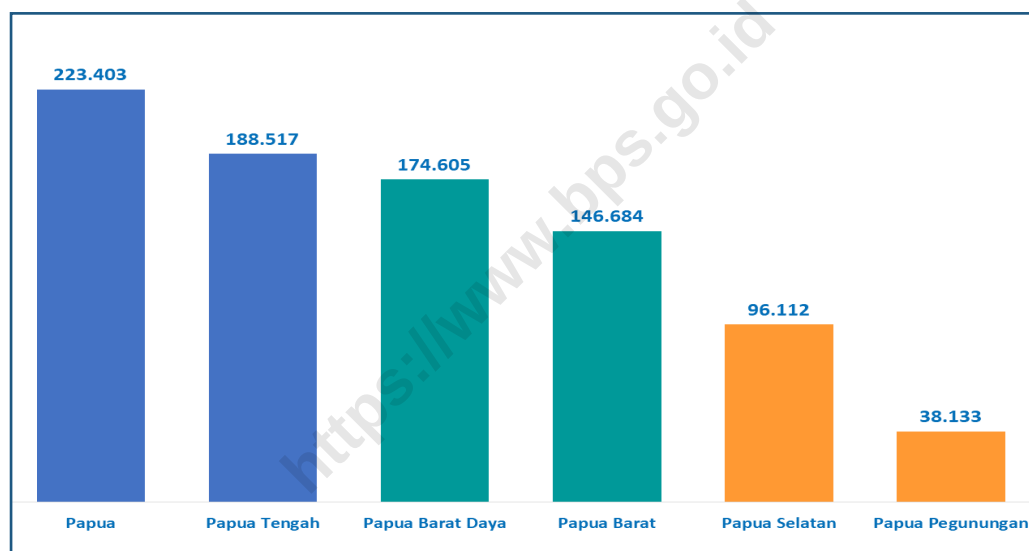
Pusat-pusat perkotaan, seperti Jayapura yang merupakan ibu kota Papua, serta fasilitas publik yang lebih lengkap mungkin menjadi faktor penarik migran, dan provinsi ini juga menjadi pintu masuk utama bagi migran dari luar wilayah Papua, sehingga wajar jika jumlah migran yang masuk lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Selanjutnya, Papua Tengah memiliki jumlah migran masuk sebanyak 188.517 orang, yang merupakan jumlah tertinggi kedua setelah Papua; angka ini menunjukkan bahwa Papua Tengah juga memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi migran, di mana faktor-faktor yang mungkin menarik migran ke Papua Tengah antara lain peluang kerja di sektor pertambangan dan sumber daya alam, serta adanya pusat administrasi dan layanan publik yang cukup berkembang. Meski demikian, jumlah migran yang masuk masih lebih rendah dibandingkan dengan Papua, mungkin karena infrastruktur dan layanan publik yang belum sekompleks yang ada di Papua. Papua Barat Daya mencatat jumlah migran masuk sebanyak 174.605 orang, menunjukkan bahwa wilayah ini juga menarik perhatian bagi migran, mungkin karena potensi ekonomi di sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan; selain itu, Papua Barat Daya memiliki akses yang lebih dekat ke pulau-pulau tetangga di wilayah timur Indonesia, yang mungkin memudahkan mobilitas penduduk dari daerah-daerah sekitar, dan infrastruktur serta akses yang lebih baik dibandingkan wilayah yang lebih terpencil seperti Papua Pegunungan juga bisa menjadi faktor yang mendukung masuknya migran ke wilayah ini. Papua Barat memiliki jumlah migran masuk sebanyak 146.684 orang; angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, yang mungkin menunjukkan bahwa daya tarik ekonominya sedikit lebih terbatas atau tingkat perkembangan infrastrukturnya lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah tersebut. Namun, Papua Barat tetap menjadi salah satu tujuan migran, mungkin karena potensi sektor perkebunan, pertanian, serta adanya kota Sorong yang merupakan salah satu kota besar di Papua Barat dan berfungsi sebagai pintu masuk bagi wilayah Papua Barat.

Papua Selatan mencatat jumlah migran masuk 96.112 orang, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Papua dan Papua Barat; angka ini mungkin disebabkan oleh infrastruktur yang masih terbatas, kesempatan kerja yang tidak sebanyak wilayah lain, serta akses yang lebih sulit. Papua Selatan kurang memiliki pusat-pusat ekonomi atau kota besar yang bisa menarik migran dalam jumlah besar, sehingga migran yang datang cenderung lebih sedikit. Sementara itu, Papua Pegunungan memiliki jumlah migran masuk paling sedikit, yaitu hanya 38.133 orang, dan rendahnya jumlah migran masuk ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau, terbatasnya infrastruktur, minimnya kesempatan ekonomi yang dapat menarik migran; wilayah ini memiliki medan yang bergunung dan relatif terpencil, sehingga sedikit penduduk dari luar yang bermigrasi ke Papua Pegunungan, dan faktor sosial-budaya lokal yang kuat bisa menjadi alasan yang membuat wilayah ini kurang menarik.

Berdasarkan gambar 6.16, dapat disimpulkan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat perbedaan signifikan dalam jumlah migran yang masuk ke setiap provinsi. Provinsi Papua mencatat angka tertinggi, yaitu 223.403 orang, yang menunjukkan daya tarik ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang lebih baik, terutama dengan keberadaan kota Jayapura sebagai pusat perkotaan dan pintu masuk utama migran dari luar wilayah. Papua Tengah berada di urutan kedua dengan 188.517 migran, didorong oleh potensi di sektor pertambangan dan sumber daya alam, meskipun infrastruktur dan layanan publiknya belum sekompleks di Papua.



Papua Barat Daya menarik 174.605 migran, yang mungkin disebabkan oleh potensi sektor perikanan, kehutanan, dan kedekatan akses ke pulau-pulau tetangga, serta infrastruktur yang relatif lebih baik. Papua Barat, dengan 146.684 migran, tetap menjadi tujuan migrasi meskipun memiliki perkembangan infrastruktur yang terbatas, terutama berkat kota Sorong sebagai pintu masuk ke wilayah ini. Papua Selatan dan Papua Pegunungan mencatat jumlah migran masuk yang jauh lebih rendah, masing-masing 96.112 dan 38.133 orang, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, peluang kerja yang minim, dan akses geografis yang sulit, terutama di Papua Pegunungan yang bergunung-gunung dan terpencil. Kesimpulannya, daya tarik migrasi di wilayah Papua dan Papua Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur, aksesibilitas, dan potensi ekonomi lokal, dengan wilayah yang lebih berkembang dan mudah diakses cenderung memiliki lebih banyak migran.



Gambar 6.16 Jumlah Migran Masuk Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023

6.7 Jumlah Migran Keluar Seumur Hidup

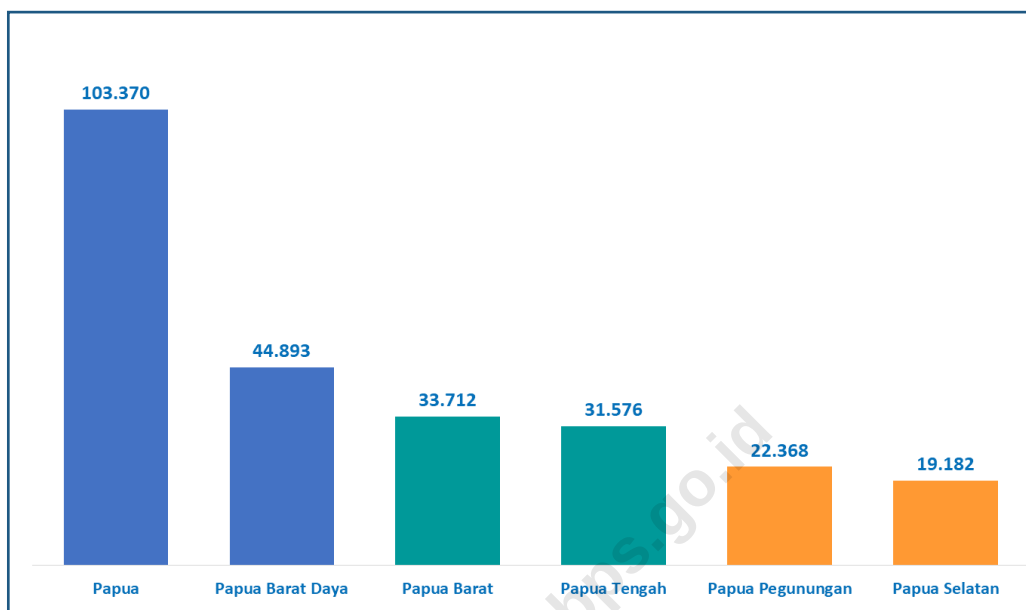
Berdasarkan Gambar 6.17 mengenai jumlah migran keluar seumur hidup di wilayah Papua dan Papua Barat, terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah migran yang meninggalkan masing-masing provinsi, di mana Provinsi Papua mencatat jumlah migran keluar tertinggi, yaitu sebanyak 103.370 orang; tingginya angka migran keluar ini menunjukkan bahwa meskipun Papua memiliki daya tarik yang cukup besar bagi migran masuk, banyak juga penduduk yang memilih untuk meninggalkan provinsi ini, kemungkinan karena pencarian kesempatan kerja, pendidikan, atau akses fasilitas kesehatan yang lebih baik di luar Papua, terutama mengingat Papua adalah provinsi dengan populasi terbesar di wilayah ini. Selanjutnya, Papua Barat Daya memiliki jumlah migran keluar sebanyak 44.893 orang, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Papua; tingginya angka ini mungkin disebabkan oleh migrasi keluar untuk mencari peluang ekonomi atau akses layanan publik yang lebih baik di luar provinsi, di samping faktor kedekatan geografisnya dengan wilayah Indonesia bagian timur lainnya, yang bisa menjadi tujuan migrasi.



Papua Barat mencatat jumlah migran keluar sebesar 33.712 orang, menunjukkan bahwa meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan Papua dan Papua Barat Daya, migrasi keluar tetap signifikan, yang mungkin didorong oleh pengaruh kota Sorong sebagai pusat kota di Papua Barat, di mana penduduk dari daerah pedesaan mungkin bermigrasi ke luar provinsi untuk mencari peluang di kota besar atau wilayah yang lebih berkembang. Papua Tengah memiliki jumlah migran keluar sebanyak 31.576 orang, di mana meskipun angka migran masuk cukup tinggi, angka migran keluar yang signifikan menunjukkan bahwa penduduk tetap terdorong untuk bermigrasi keluar, terutama karena keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peluang ekonomi yang lebih baik di luar Papua; harapan penduduk untuk meningkatkan taraf hidup juga menjadi faktor pendorong migrasi ini. Sementara itu, Papua Pegunungan memiliki jumlah migran keluar sebanyak 22.368 orang, yang rendahnya angka ini mungkin disebabkan oleh keterikatan sosial budaya yang kuat, di mana masyarakat memiliki hubungan erat dengan tanah leluhur dan komunitas mereka; selain itu, medan yang bergunung-gunung mungkin membatasi mobilitas penduduk. Papua Selatan mencatat jumlah migran keluar paling sedikit, yaitu 19.182 orang, dan rendahnya angka ini kemungkinan disebabkan oleh keterikatan sosial budaya yang kuat serta terbatasnya akses transportasi yang mempersulit mobilitas keluar provinsi, di samping peluang kerja lokal yang mungkin cukup memadai, sehingga lebih sedikit penduduk yang terdorong untuk bermigrasi ke luar.

Berdasarkan grafik jumlah migran keluar seumur hidup, dapat disimpulkan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat terlihat adanya variasi signifikan dalam jumlah migran yang meninggalkan setiap provinsi. Provinsi Papua mencatat jumlah migran keluar tertinggi dengan 103.370 orang, yang menunjukkan bahwa meskipun provinsi ini memiliki daya tarik migran masuk, banyak penduduk juga memilih keluar, kemungkinan untuk mencari peluang ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang lebih baik di luar Papua. Papua Barat Daya berada di urutan kedua dengan 44.893 migran keluar, didorong oleh alasan serupa, serta kedekatan geografisnya dengan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Papua Barat mencatat 33.712 migran keluar, yang meskipun lebih rendah, tetap signifikan, terutama dengan pengaruh kota Sorong sebagai pusat migrasi. Papua Tengah dengan 31.576 migran keluar juga menunjukkan adanya dorongan penduduk untuk keluar demi meningkatkan taraf hidup melalui akses pendidikan dan ekonomi yang lebih baik di luar Papua.

Di sisi lain, Papua Pegunungan dan Papua Selatan mencatat migran keluar yang lebih rendah, masing-masing 22.368 dan 19.182 orang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterikatan sosial budaya yang kuat serta medan geografis yang sulit diakses, membatasi mobilitas keluar. Kesimpulannya, faktor ekonomi, pendidikan, akses layanan publik, dan keterikatan sosial budaya berperan penting dalam pola migrasi keluar di wilayah Papua dan Papua Barat, dengan provinsi yang lebih terhubung dan berkembang cenderung memiliki migrasi keluar yang lebih tinggi.



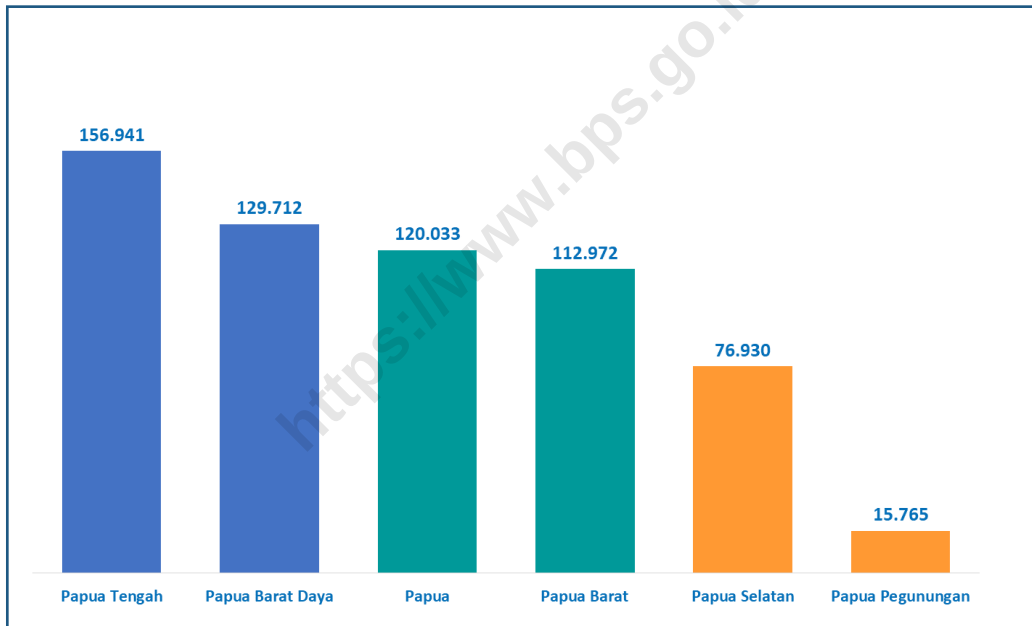
Gambar 6.17 Jumlah Migran Keluar Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023

6.8 Jumlah Migran Neto Seumur Hidup

Berdasarkan grafik jumlah migran neto seumur hidup di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah migran neto yang dimiliki oleh setiap provinsi, di mana Papua Tengah mencatat jumlah migran neto tertinggi, yaitu 156.941 orang. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Tengah memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi migran masuk, dengan jumlah migran yang masuk jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah migran yang keluar; faktor-faktor yang mungkin menarik migran ke Papua Tengah antara lain peluang kerja di sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya, serta infrastruktur yang cukup berkembang untuk menunjang kehidupan migran, sehingga provinsi ini terus berkembang sebagai tujuan migrasi. Selanjutnya, Papua Barat Daya memiliki jumlah migran neto sebesar 129.712 orang, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Papua Tengah; tingginya jumlah migran neto ini menunjukkan bahwa Papua Barat Daya juga menjadi tujuan migrasi yang cukup menarik, kemungkinan karena akses yang lebih dekat ke wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur serta potensi ekonominya di sektor perikanan, kehutanan, dan perdagangan, sehingga migran yang masuk mungkin melihat provinsi ini sebagai tempat dengan akses pasar dan infrastruktur yang mendukung. Provinsi Papua mencatat jumlah migran neto sebesar 120.033 orang, dan sebagai provinsi dengan populasi besar, tingginya migran neto ini menunjukkan bahwa meskipun banyak penduduk yang meninggalkan Papua, jumlah migran yang masuk masih jauh lebih besar, dengan pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura yang menawarkan peluang kerja, fasilitas publik lengkap, serta berbagai kesempatan pendidikan dan kesehatan lebih baik dibandingkan wilayah terpencil. Sementara itu, Papua Barat memiliki jumlah migran neto sebesar 112.972 orang; meskipun lebih rendah dibandingkan Papua Tengah dan Papua Barat Daya, angka ini tetap



menunjukkan Papua Barat sebagai tujuan migrasi penting di wilayah ini, terutama dengan kehadiran kota Sorong sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama yang menarik migran ke sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi. Papua Selatan mencatat jumlah migran neto sebesar 76.930 orang, yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya; hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja dan infrastruktur yang belum sebaik provinsi-provinsi dengan jumlah migran neto lebih tinggi, meskipun provinsi ini masih memiliki potensi migrasi yang cukup, terutama di sektor-sektor lokal seperti pertanian dan perkebunan. Terakhir, Papua Pegunungan memiliki jumlah migran neto terendah, yaitu hanya 15.765 orang; rendahnya angka ini kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit diakses, medan bergunung-gunung, serta keterbatasan infrastruktur dan peluang ekonomi yang membuat Papua Pegunungan kurang menarik bagi migran dari luar, selain adanya keterikatan budaya yang kuat dengan tanah kelahiran, sehingga mobilitas keluar dan masuk di wilayah ini relatif rendah.



Gambar 6.18 Jumlah Migran Net Seumur Hidup DOB Papua, 2020–2023

Berdasarkan Gambar 6.18 jumlah migran neto seumur hidup, dapat disimpulkan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat terlihat perbedaan signifikan antarprovinsi dalam hal daya tarik migrasi. Papua Tengah mencatat migran neto tertinggi dengan 156.941 orang, menunjukkan daya tarik kuat bagi migran masuk, terutama karena peluang kerja di sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan serta infrastruktur yang mendukung. Papua Barat Daya berada di posisi kedua dengan 129.712 migran neto, kemungkinan dipengaruhi oleh akses yang lebih dekat ke wilayah timur Indonesia dan potensi ekonomi di sektor perikanan dan kehutanan. Provinsi Papua juga memiliki migran neto yang tinggi sebesar 120.033 orang, didukung oleh pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura yang menawarkan peluang kerja dan fasilitas publik yang lebih lengkap.



Papua Barat, meskipun sedikit lebih rendah dengan 112.972 migran neto, tetap menjadi tujuan migrasi penting dengan adanya kota Sorong sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama. Papua Selatan mencatat 76.930 migran neto, yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya, mungkin disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dan peluang kerja. Terakhir, Papua Pegunungan memiliki migran neto terendah, yaitu hanya 15.765 orang, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit diakses, keterbatasan infrastruktur, serta keterikatan budaya yang kuat, sehingga mobilitas keluar dan masuk di wilayah ini relatif rendah. Kesimpulannya, daya tarik migrasi di wilayah Papua dan Papua Barat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, aksesibilitas, dan kondisi geografis.

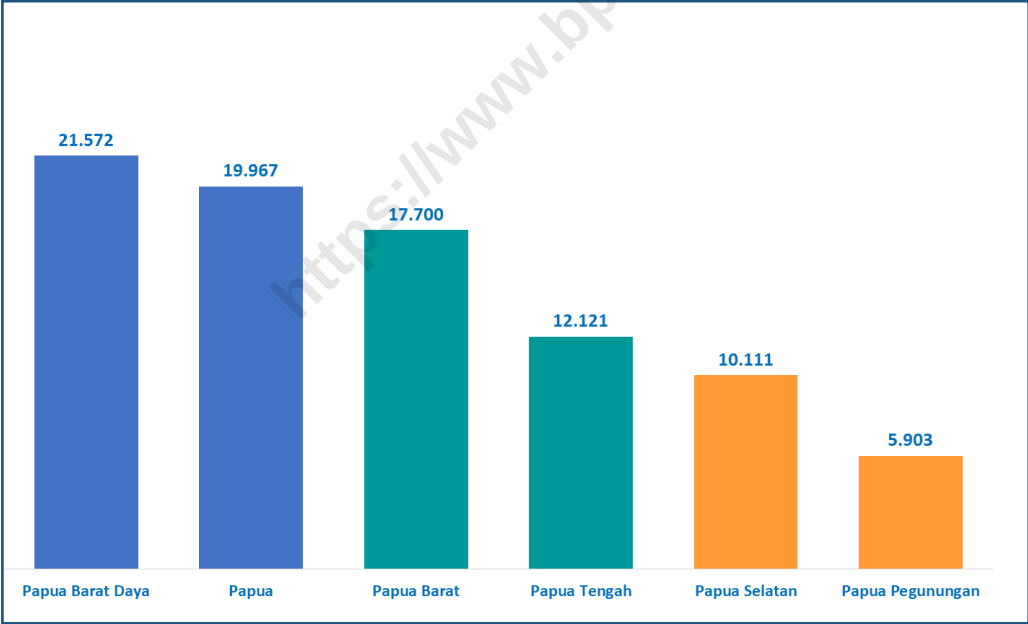
6.9 Jumlah Migran Masuk Risen

Berdasarkan Gambar 6.19 jumlah migran masuk risen di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat bahwa terdapat variasi signifikan dalam jumlah migran yang masuk ke setiap provinsi, di mana Papua Barat Daya mencatat jumlah migran masuk tertinggi, yaitu 21.572 orang; angka ini menunjukkan bahwa provinsi ini merupakan tujuan utama bagi migran baru, mungkin karena potensi ekonominya di sektor perikanan, kehutanan, dan perkebunan, serta akses geografis yang lebih mudah ke wilayah Indonesia bagian timur lainnya, yang memudahkan mobilitas penduduk dari luar provinsi. Selanjutnya, Provinsi Papua memiliki jumlah migran masuk sebesar 19.967 orang, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Papua Barat Daya; sebagai provinsi dengan jumlah populasi terbesar, Papua memiliki daya tarik kuat bagi penduduk luar provinsi, dengan Kota Jayapura sebagai pusat utama yang menawarkan peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lain di Papua dan Papua Barat. Papua Barat mencatat jumlah migran masuk sebesar 17.700 orang, yang meskipun lebih rendah dibandingkan Papua Barat Daya dan Papua, tetap menunjukkan bahwa Papua Barat merupakan salah satu tujuan migrasi yang signifikan, terutama karena Kota Sorong yang berperan sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama yang menarik migran di sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi. Sementara itu, Papua Tengah mencatat jumlah migran masuk sebesar 12.121 orang; meskipun lebih rendah dari provinsi-provinsi sebelumnya, Papua Tengah tetap memiliki daya tarik tersendiri, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, dengan infrastruktur yang berkembang di wilayah ini mendukung kedatangan migran baru. Papua Selatan memiliki jumlah migran masuk sebesar 10.111 orang, yang menunjukkan daya tarik migrasi yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya, mungkin disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan peluang kerja yang tidak sebanyak di provinsi-provinsi dengan jumlah migran masuk lebih tinggi; meskipun demikian, potensi sektor pertanian dan perkebunan di Papua Selatan tetap menjadi daya tarik bagi sebagian migran. Terakhir, Papua Pegunungan memiliki jumlah migran masuk terendah, yaitu hanya 5.903 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit diakses dan keterbatasan infrastruktur, membuat wilayah ini kurang menarik bagi penduduk dari luar provinsi, serta medan bergunung-gunung dan keterikatan budaya lokal yang kuat yang membatasi mobilitas penduduk baik masuk maupun keluar dibandingkan dengan wilayah lain di Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan grafik jumlah migran masuk risen, dapat disimpulkan di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat adanya variasi signifikan dalam daya tarik migrasi ke setiap provinsi.



Papua Barat Daya mencatat jumlah migran masuk tertinggi dengan 21.572 orang, yang menunjukkan daya tariknya sebagai tujuan utama migran baru, kemungkinan besar karena potensi ekonominya di sektor perikanan, kehutanan, dan perkebunan serta akses geografis yang lebih mudah ke wilayah timur Indonesia. Provinsi Papua berada di posisi kedua dengan 19.967 migran masuk, didukung oleh keberadaan Kota Jayapura sebagai pusat ekonomi dan layanan publik yang menarik. Papua Barat dengan 17.700 migran masuk juga menunjukkan signifikansi sebagai tujuan migrasi, terutama karena Kota Sorong sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan. Papua Tengah, meskipun memiliki 12.121 migran masuk yang lebih rendah, tetap menarik bagi migran, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Papua Selatan, dengan 10.111 migran masuk, menunjukkan daya tarik yang relatif rendah, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, meskipun sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi potensi. Terakhir, Papua Pegunungan mencatat migran masuk terendah, yaitu 5.903 orang, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit dan keterikatan budaya lokal yang kuat, membatasi mobilitas baik masuk maupun keluar. Kesimpulannya, faktor ekonomi, infrastruktur, dan akses geografis berperan besar dalam menentukan daya tarik migrasi di wilayah Papua dan Papua Barat, dengan Papua Barat Daya dan Papua menjadi tujuan utama migrasi baru di wilayah ini.



Gambar 6.19 Jumlah Migran Masuk Risen DOB Papua, 2020–2023



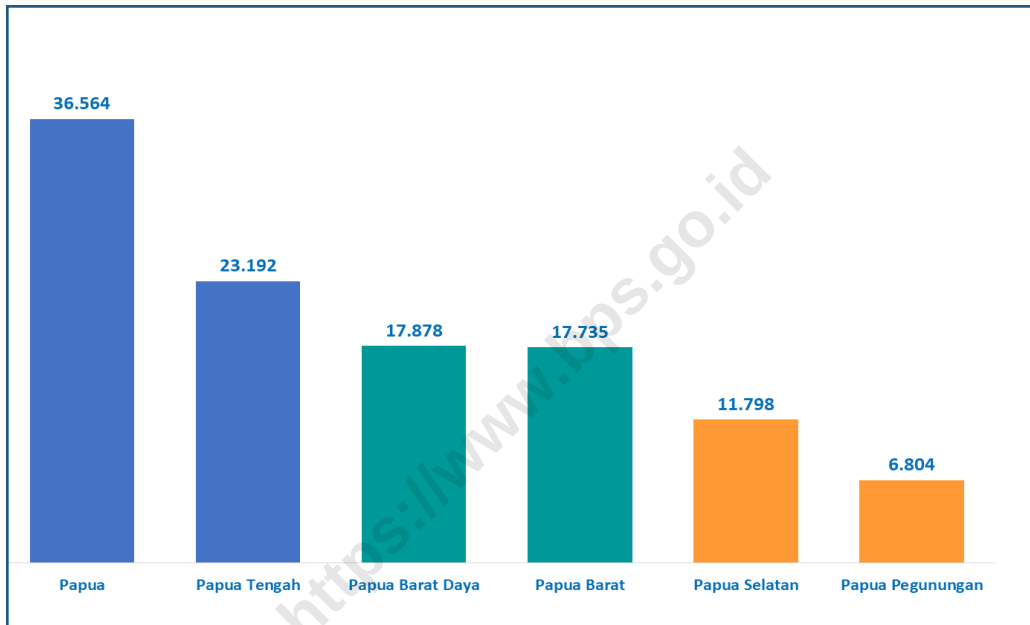
6.10 Jumlah Migran Keluar Risen

Berdasarkan Gambar 6.20 jumlah migran keluar risen di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk yang meninggalkan setiap provinsi, di mana Provinsi Papua mencatat jumlah migran keluar tertinggi, yaitu 36.564 orang; angka ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Papua dan Papua Barat, yang mungkin disebabkan oleh penduduk yang mencari peluang ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang lebih baik di luar provinsi, terutama mengingat Papua memiliki populasi besar dengan kebutuhan layanan publik yang tinggi. Selanjutnya, Papua Tengah memiliki jumlah migran keluar sebesar 23.192 orang, tertinggi kedua setelah Papua; tingginya angka ini menunjukkan bahwa Papua Tengah juga mengalami tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi, kemungkinan karena sebagian penduduk mencari peluang kerja atau fasilitas publik yang lebih baik di luar provinsi, meskipun Papua Tengah memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan dan perkebunan, namun fasilitas pendidikan atau kesehatan mungkin belum memadai. Papua Barat Daya mencatat jumlah migran keluar sebesar 17.878 orang, menunjukkan bahwa meskipun provinsi ini memiliki potensi ekonomi baik di sektor perikanan dan kehutanan, sebagian penduduk tetap memilih bermigrasi keluar, mungkin untuk mencari peluang lebih baik di wilayah yang lebih berkembang. Papua Barat dengan 17.735 migran keluar hampir setara dengan Papua Barat Daya; meskipun memiliki kota besar seperti Sorong sebagai pusat ekonomi dan pelabuhan utama, sebagian penduduk tetap meninggalkan provinsi ini untuk mencari pekerjaan atau layanan publik yang lebih baik di luar Papua Barat. Sementara itu, Papua Selatan mencatat jumlah migran keluar yang lebih rendah, yaitu 11.798 orang, yang kemungkinan disebabkan oleh keterikatan sosial dan budaya yang kuat serta terbatasnya akses transportasi yang mempersulit mobilitas keluar, sehingga penduduk Papua Selatan mungkin merasa cukup dengan peluang lokal di sektor pertanian dan perkebunan. Terakhir, Papua Pegunungan memiliki jumlah migran keluar terendah, yaitu 6.804 orang, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit diakses dan medan bergunung-gunung yang membatasi mobilitas, serta keterikatan budaya yang kuat dengan tanah kelahiran, yang membatasi tingkat migrasi keluar dari wilayah ini.

Berdasarkan Gambar 6.20 jumlah migran keluar risen, dapat disimpulkan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat terlihat perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk yang meninggalkan setiap provinsi. Provinsi Papua mencatat jumlah migran keluar tertinggi dengan 36.564 orang, menunjukkan tingkat migrasi keluar yang cukup tinggi, kemungkinan karena penduduknya mencari peluang ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang lebih baik di luar provinsi, mengingat Papua memiliki populasi besar dengan kebutuhan layanan publik yang tinggi. Papua Tengah berada di posisi kedua dengan 23.192 migran keluar, menunjukkan migrasi keluar yang cukup tinggi yang mungkin didorong oleh kebutuhan akan fasilitas pendidikan atau kesehatan yang lebih memadai di luar provinsi, meskipun Papua Tengah memiliki potensi ekonomi di sektor pertambangan dan perkebunan. Papua Barat Daya dan Papua Barat mencatat angka migrasi keluar yang hampir setara, masing-masing sebesar 17.878 dan 17.735 orang; meskipun memiliki potensi ekonomi dan kota besar seperti Sorong, sebagian penduduk tetap bermigrasi, kemungkinan mencari peluang yang lebih baik di wilayah yang lebih berkembang.



Di sisi lain, Papua Selatan memiliki migrasi keluar lebih rendah, yaitu 11.798 orang, yang bisa jadi disebabkan oleh keterikatan sosial dan budaya serta keterbatasan akses transportasi yang membatasi mobilitas keluar. Papua Pegunungan mencatat migrasi keluar terendah dengan 6.804 orang, kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit diakses dan keterikatan budaya yang kuat dengan tanah kelahiran. Kesimpulannya, faktor pencarian peluang ekonomi, fasilitas publik, kondisi geografis, dan keterikatan sosial budaya memengaruhi perbedaan tingkat migrasi keluar di wilayah Papua dan Papua Barat.



Gambar 6.20 Jumlah Migran Keluar Risen DOB Papua, 2020–2023

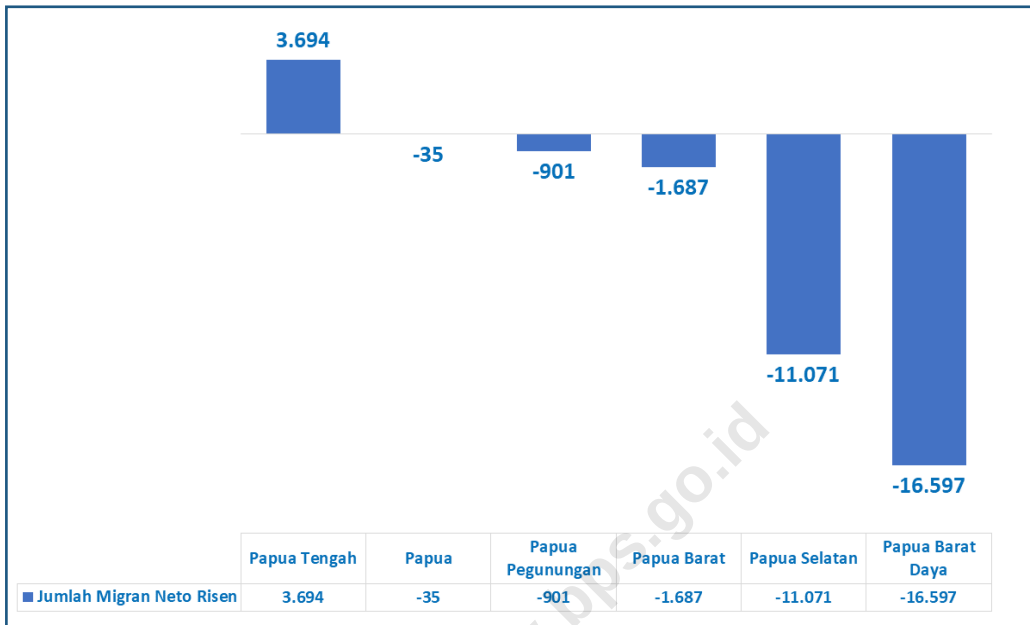
6.11 Jumlah Migran Neto Risen

Berdasarkan Gambar 6.21 jumlah migran neto risen di wilayah Papua dan Papua Barat, terlihat perbedaan signifikan dalam migrasi neto atau selisih antara migran masuk dan keluar di setiap provinsi, di mana Papua Tengah mencatat angka migran neto positif sebesar 3.694 orang, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki lebih banyak migran yang masuk dibandingkan yang keluar; angka ini menunjukkan daya tarik Papua Tengah bagi migran, kemungkinan karena peluang kerja di sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan, serta infrastruktur yang lebih berkembang dibandingkan beberapa provinsi lain di wilayah Papua. Dengan angka migrasi neto positif ini, Papua Tengah tampaknya menjadi provinsi dengan daya tarik kuat bagi penduduk dari luar wilayah. Sementara itu, Provinsi Papua mencatat angka migran neto yang hampir netral, yaitu -35 orang, yang menunjukkan keseimbangan antara jumlah migran masuk dan keluar; hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura yang menarik penduduk luar, sementara sebagian besar penduduk asli mencari peluang di luar provinsi, mencerminkan daya tarik yang sama besar untuk migran masuk dan keluar.



Di sisi lain, Papua Pegunungan memiliki migran neto negatif sebesar -901 orang, menunjukkan bahwa jumlah migran keluar lebih besar dibandingkan migran yang masuk, kemungkinan disebabkan oleh kondisi geografis yang bergunung-gunung, keterbatasan infrastruktur, dan layanan publik yang kurang menarik bagi penduduk luar; keterikatan budaya yang kuat juga mungkin membuat penduduk lokal cenderung tidak bermigrasi, meskipun angka migrasi keluar tetap lebih tinggi dari migrasi masuk. Selanjutnya, Papua Barat mencatat migran neto negatif sebesar -1.687 orang, yang menunjukkan kecenderungan migrasi keluar lebih besar dibandingkan dengan migrasi masuk, meskipun memiliki kota besar seperti Sorong sebagai pusat ekonomi, karena sebagian penduduk mungkin mencari peluang ekonomi atau pendidikan yang lebih baik di luar Papua Barat. Papua Selatan mencatat migran neto negatif yang cukup besar, yaitu -11.071 orang, yang menunjukkan tingkat migrasi keluar yang sangat tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesempatan kerja yang menarik, dan aksesibilitas yang relatif rendah, sehingga membuat penduduk Papua Selatan lebih memilih pindah ke wilayah dengan peluang lebih baik dari segi ekonomi maupun layanan publik. Terakhir, Papua Barat Daya memiliki migran neto negatif terbesar, yaitu -16.597 orang, yang menunjukkan perbedaan signifikan antara migran masuk dan keluar, meskipun memiliki potensi ekonomi di sektor perikanan dan kehutanan; angka ini kemungkinan disebabkan oleh keinginan penduduk untuk mencari peluang yang lebih baik di luar provinsi, serta keterbatasan infrastruktur dan akses layanan publik di Papua Barat Daya.

Berdasarkan grafik jumlah migran neto risen, dapat disimpulkan bahwa di wilayah Papua dan Papua Barat terlihat perbedaan signifikan dalam migrasi neto di setiap provinsi. Papua Tengah mencatat migran neto positif sebesar 3.694 orang, menunjukkan daya tarik tinggi bagi migran, kemungkinan karena peluang kerja di sektor pertambangan dan perkebunan serta infrastruktur yang berkembang. Provinsi Papua memiliki migran neto hampir netral (-35), mencerminkan keseimbangan antara migran masuk dan keluar, kemungkinan didorong oleh pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura yang menarik penduduk luar, sementara sebagian penduduk asli mencari peluang di luar provinsi. Di sisi lain, Papua Pegunungan mencatat migran neto negatif sebesar -901, yang mungkin disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit diakses, keterbatasan infrastruktur, dan keterikatan budaya yang mengurangi daya tarik bagi migran. Papua Barat mencatat migran neto negatif sebesar -1.687 orang, meskipun memiliki kota besar seperti Sorong, menunjukkan bahwa sebagian penduduk tetap memilih meninggalkan provinsi ini demi peluang ekonomi atau pendidikan yang lebih baik. Papua Selatan mencatat migran neto negatif yang cukup besar (-11.071), yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan peluang kerja, sehingga membuat penduduk lebih memilih pindah ke wilayah dengan peluang ekonomi lebih baik. Terakhir, Papua Barat Daya mencatat migran neto negatif terbesar (-16.597), menunjukkan perbedaan signifikan antara migran masuk dan keluar, meskipun ada potensi di sektor perikanan dan kehutanan; hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan layanan publik yang mendorong penduduk untuk mencari peluang di luar provinsi.



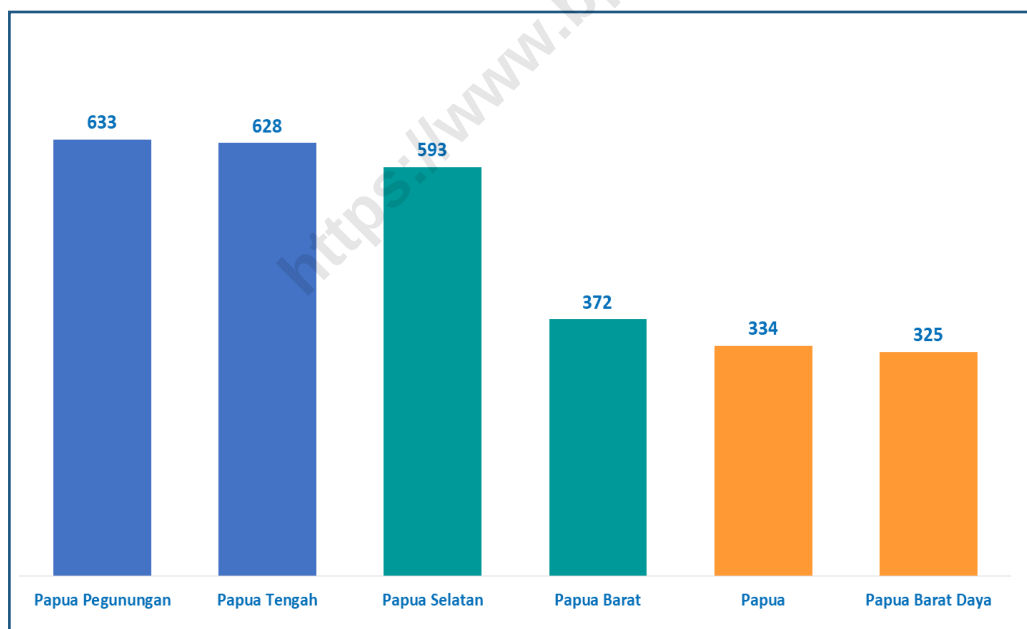
Gambar 6.21 Jumlah Migran Neto Risen DOB Papua, 2020–2023

6.12 Maternal Mortality Ratio (MMR)

Gambar 6.22 menunjukkan Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Ratio*/MMR) di berbagai wilayah Papua yang merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan berdasarkan grafik tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah kematian ibu di setiap provinsi. Papua Pegunungan memiliki MMR tertinggi, yaitu sebesar 633 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan angka yang tinggi ini menunjukkan tantangan besar dalam sektor kesehatan ibu di wilayah ini, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta minimnya tenaga medis terlatih, sehingga faktor-faktor ini mengakibatkan rendahnya tingkat layanan kesehatan ibu, terutama di daerah-daerah terpencil di wilayah pegunungan. Papua Tengah menempati posisi kedua dengan MMR sebesar 628 kematian per 100.000 kelahiran hidup; walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan Papua Pegunungan, angka ini tetap tergolong sangat tinggi dan mencerminkan tantangan yang serupa, seperti terbatasnya akses terhadap perawatan medis, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, di mana infrastruktur kesehatan yang kurang memadai serta minimnya fasilitas kesehatan mungkin turut berkontribusi pada tingginya MMR di wilayah ini. Papua Selatan mencatat MMR sebesar 593 kematian per 100.000 kelahiran hidup; angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Papua Pegunungan dan Papua Tengah, namun tetap menunjukkan adanya tantangan besar dalam menurunkan angka kematian ibu, di mana masalah yang mungkin dihadapi termasuk sulitnya akses ke layanan kesehatan maternal dan kurangnya program kesehatan yang terfokus pada kebutuhan ibu hamil, yang bisa membantu menurunkan risiko komplikasi saat melahirkan.



Papua Barat memiliki MMR sebesar 372 kematian per 100.000 kelahiran hidup, yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga provinsi sebelumnya, namun masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional dan global; tingginya MMR di Papua Barat mungkin disebabkan oleh masih adanya wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan kurangnya infrastruktur kesehatan, meskipun akses yang lebih baik ke kota-kota besar di provinsi ini mungkin telah membantu menurunkan angka MMR. Provinsi Papua mencatat MMR sebesar 334 kematian per 100.000 kelahiran hidup, yang lebih rendah dari Papua Barat, dan angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki akses layanan kesehatan ibu yang lebih baik, terutama di pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura, yang mungkin memiliki fasilitas kesehatan dan program maternal yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya; meskipun demikian, angka ini tetap tinggi dan membutuhkan perhatian untuk peningkatan layanan kesehatan ibu. Papua Barat Daya memiliki MMR terendah di antara provinsi-provinsi lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu 325 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan angka yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa Papua Barat Daya mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan maternal dan infrastruktur kesehatan yang lebih memadai; walaupun demikian, angka ini tetap menunjukkan perlunya peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil, terutama di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau.



Gambar 6.22 Angka Kematian Ibu (MMR) DOB (Daerah Otonomi Baru)



Dapat diambil kesimpulan bahwa dari grafik di atas mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam Angka Kematian Ibu (MMR) di wilayah Papua dan Papua Barat, dengan Papua Pegunungan mencatat MMR tertinggi sebesar 633 kematian per 100.000 kelahiran hidup, yang mencerminkan tantangan besar dalam sektor kesehatan ibu akibat keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, medan geografis yang sulit dijangkau, dan minimnya tenaga medis terlatih. Provinsi Papua Tengah juga menunjukkan angka MMR yang tinggi di posisi kedua dengan 628 kematian per 100.000 kelahiran hidup, mencerminkan tantangan serupa dalam akses dan infrastruktur kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Papua Selatan mencatat MMR sebesar 593, sedikit lebih rendah namun tetap tinggi, yang menandakan adanya kendala dalam akses ke layanan kesehatan maternal dan terbatasnya program kesehatan khusus ibu hamil. Di sisi lain, Papua Barat memiliki MMR sebesar 372, yang relatif lebih rendah namun tetap di atas standar nasional dan global, menunjukkan bahwa wilayah terpencil dan infrastruktur yang belum memadai masih menjadi tantangan. Provinsi Papua dengan MMR sebesar 334 menunjukkan akses kesehatan yang lebih baik, terutama di pusat-pusat perkotaan seperti Jayapura, namun masih membutuhkan peningkatan layanan kesehatan ibu. Terakhir, Papua Barat Daya dengan MMR terendah sebesar 325 mencerminkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan maternal dan infrastruktur yang relatif memadai, namun tetap memerlukan upaya perbaikan khususnya di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau. Secara keseluruhan, data ini menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan ibu di wilayah Papua untuk menurunkan angka kematian ibu secara keseluruhan.

6.13 Umur Harapan Hidup

Secara umum, umur harapan hidup di Papua Barat mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan gambar 6.23 dengan total UHH meningkat dari 67,64 pada tahun 2020 menjadi 70,11 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup di provinsi tersebut selama periode tersebut.

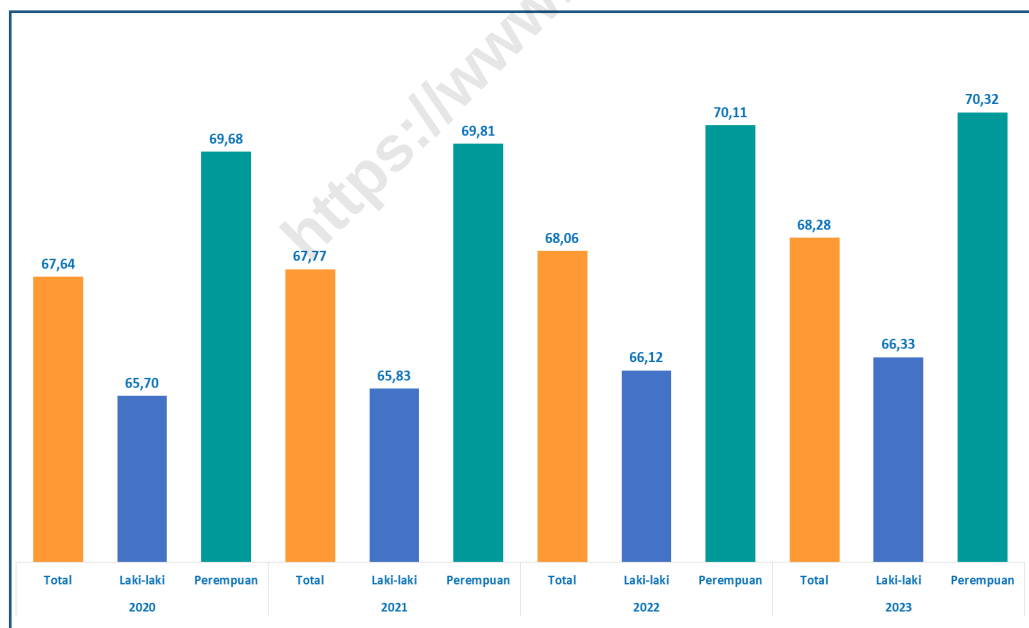
Perbedaan UHH berdasarkan jenis kelamin terlihat cukup mencolok. Secara konsisten, perempuan memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai 69,68 sementara laki-laki hanya 65,70. Tren ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan UHH perempuan mencapai 69,81 pada 2021 dan 70,32 pada 2023, sedangkan UHH laki-laki menunjukkan kenaikan lebih lambat, dari 67,77 di 2021 menjadi 66,33 di 2023. Kesenjangan ini menyoroti tren bahwa perempuan di Papua Barat secara umum memiliki UHH yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Melihat perkembangan per tahun, dari 2020 ke 2021 terjadi peningkatan signifikan dalam angka harapan hidup total, yaitu dari 67,64 menjadi 69,68. Peningkatan ini terlihat pada kedua jenis kelamin. Namun, dari 2021 ke 2022, angka harapan hidup mengalami sedikit penurunan, terutama pada laki-laki yang turun dari 67,77 menjadi 66,12, sedangkan perempuan turun dari 69,81 menjadi 68,06. Pada 2023, angka harapan hidup kembali mengalami peningkatan, dengan total UHH naik menjadi 70,11, terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada perempuan yang mencapai 70,32, sementara laki-laki mengalami sedikit peningkatan menjadi 66,33.



Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan memiliki UHH lebih tinggi daripada laki-laki dapat dihubungkan dengan faktor-faktor kesehatan atau sosial yang mempengaruhi perbedaan ini, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan gaya hidup yang mungkin lebih mendukung kesehatan perempuan dibandingkan laki-laki. Meskipun secara umum terjadi peningkatan UHH dari 2020 hingga 2023, penurunan yang terjadi pada 2022 mungkin mengindikasikan adanya faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi UHH, khususnya di kalangan laki-laki. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Papua Barat telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari UHH yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kalangan perempuan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada kesehatan laki-laki, mengingat UHH mereka yang relatif lebih rendah dan cenderung berfluktuasi. Program kesehatan yang lebih proaktif bagi laki-laki, seperti peningkatan kesadaran kesehatan, akses ke layanan medis, dan edukasi tentang pencegahan penyakit kronis, perlu dipertimbangkan. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif akan membantu mendukung peningkatan angka harapan hidup secara menyeluruh di Papua Barat. Data ini secara keseluruhan mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup di Papua Barat, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kesenjangan UHH antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 6.23 UHH Provinsi Papua Barat, 2020–2023



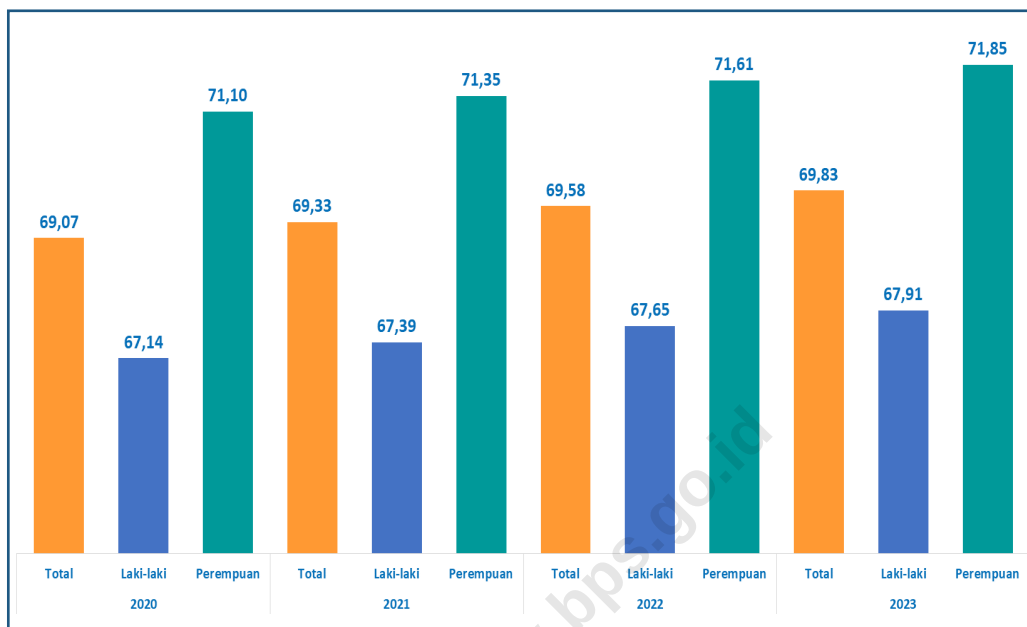
Berdasarkan Gambar 6.24 umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Papua Barat Daya dari tahun 2020 hingga 2023, tren umum menunjukkan adanya peningkatan angka harapan hidup secara konsisten. UHH total meningkat dari 69,07 pada tahun 2020 menjadi 71,61 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya selama empat tahun terakhir. Tren kenaikan ini mengindikasikan upaya perbaikan dalam aspek kesehatan serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdampak positif pada harapan hidup.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur harapan hidup perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki sepanjang periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, UHH perempuan berada di angka 71,10 sementara laki-laki 67,14, yang kemudian terus menunjukkan kesenjangan antara kedua kelompok ini setiap tahunnya. Perempuan mencatatkan angka yang lebih tinggi setiap tahun, dengan peningkatan dari 71,10 di tahun 2020 hingga mencapai 71,85 di tahun 2023. Sebaliknya, meskipun angka UHH laki-laki juga mengalami peningkatan, kenaikannya lebih lambat, dari 67,14 pada tahun 2020 menjadi 67,91 pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua Barat Daya cenderung memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, yang bisa disebabkan oleh faktor kesehatan atau perbedaan gaya hidup.

Perkembangan tiap tahun menunjukkan beberapa fluktuasi pada angka harapan hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2020 ke 2021, terdapat peningkatan total UHH dari 69,07 menjadi 69,33, dengan kenaikan di kedua jenis kelamin. Dari tahun 2021 ke 2022, terjadi kenaikan lebih signifikan, di mana UHH total mencapai 71,35, terutama didorong oleh kenaikan angka harapan hidup perempuan, sementara laki-laki mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2023, UHH total kembali naik menjadi 71,61, dengan perempuan mencapai 71,85 dan laki-laki 67,91. Fluktuasi kecil ini menunjukkan adanya pengaruh faktor eksternal atau kebijakan yang mungkin memengaruhi umur harapan hidup di setiap tahunnya.

Secara keseluruhan, analisis data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mencolok dalam umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di Papua Barat Daya. Perempuan memiliki UHH yang lebih tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor biologis, gaya hidup, atau akses kesehatan yang berbeda antara kedua jenis kelamin. Meski demikian, peningkatan total UHH setiap tahunnya menjadi indikasi positif bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya terus meningkat. Penurunan kecil pada angka UHH di beberapa tahun menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut untuk mempertahankan tren positif ini, terutama pada kelompok laki-laki yang memiliki UHH lebih rendah.

Implikasi kebijakan dari data ini menyoroti pentingnya perhatian khusus pada kesehatan laki-laki di Papua Barat Daya. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan program-program kesehatan yang lebih proaktif dan spesifik untuk laki-laki, seperti peningkatan kesadaran tentang kesehatan, akses layanan medis, serta edukasi tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit kronis. Selain itu, program kesehatan yang berfokus pada kesehatan preventif dan promotif perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup secara keseluruhan di wilayah ini. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, diharapkan angka harapan hidup di Papua Barat Daya dapat terus meningkat dan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 6.24 UHH Provinsi Papua Barat Daya, 2020–2023

Berdasarkan Gambar 6.25 umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Papua dari tahun 2020 hingga 2023, tren umum menunjukkan peningkatan yang konsisten pada angka harapan hidup total. UHH meningkat dari 69,65 pada tahun 2020 menjadi 72,04 pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup dan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat di Provinsi Papua. Kenaikan UHH ini mencerminkan upaya yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, dengan capaian yang terus naik setiap tahunnya.

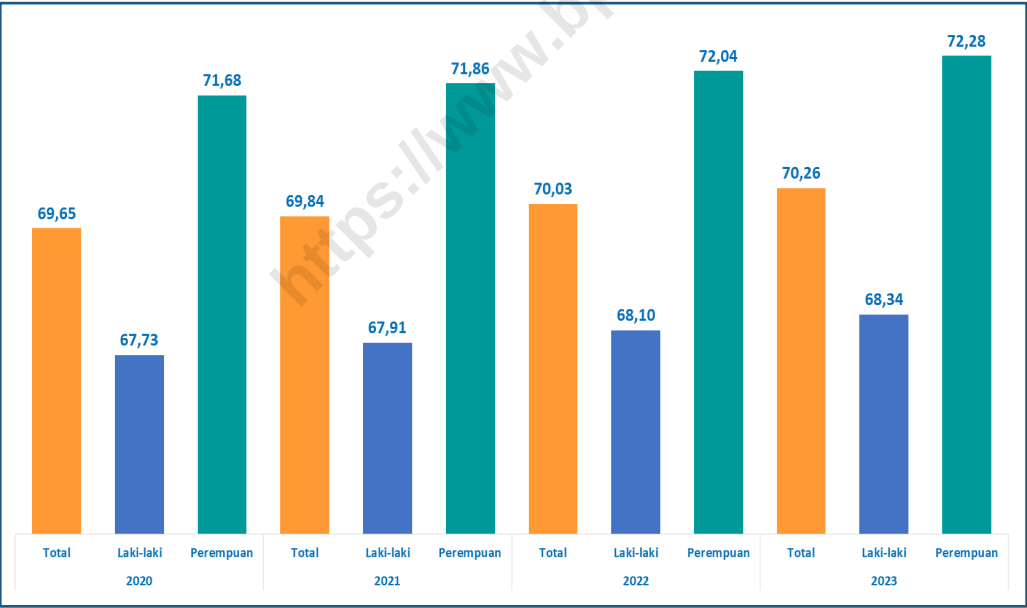
Perbedaan berdasarkan jenis kelamin terlihat cukup signifikan dalam data ini, di mana perempuan secara konsisten memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan tercatat di angka 71,68 sedangkan laki-laki hanya 67,73. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana UHH perempuan mencapai 72,28 dan laki-laki meningkat namun lebih lambat, hanya mencapai 68,34. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua cenderung memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan perbedaan biologis.

Perkembangan tiap tahun menunjukkan pola peningkatan dan fluktuasi kecil pada angka harapan hidup di Papua. Dari 2020 ke 2021, UHH total meningkat dari 69,65 menjadi 69,84. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan signifikan dalam umur harapan hidup total, yang mencapai 71,86, terutama karena peningkatan pada perempuan yang mencapai 71,68 sementara laki-laki juga mengalami sedikit peningkatan ke angka 67,73. Pada 2023, UHH total Papua kembali meningkat ke angka tertinggi di 72,04, dengan perempuan mencapai 72,28 dan laki-laki meningkat ke 68,34. Peningkatan yang terjadi setiap tahun mengindikasikan adanya dampak positif dari intervensi kesehatan dan program kesejahteraan yang berjalan di Papua.



Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perbedaan yang konsisten dalam umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua. Perempuan cenderung memiliki UHH yang lebih tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang berbeda antara jenis kelamin. Peningkatan angka harapan hidup secara total setiap tahun menjadi indikator yang positif terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Papua, meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan UHH laki-laki yang tertinggal dibandingkan perempuan. Data ini menyoroti pentingnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harapan hidup di setiap kelompok.

Dari segi kebijakan, data ini menunjukkan kebutuhan untuk lebih fokus pada program kesehatan yang menargetkan laki-laki, mengingat UHH mereka yang lebih rendah dan peningkatan yang cenderung lebih lambat dibandingkan perempuan. Pemerintah daerah dapat memperkuat program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, dengan fokus pada edukasi kesehatan, akses layanan medis yang lebih mudah, dan penyuluhan tentang gaya hidup sehat. Selain itu, kebijakan yang mendorong pemerataan akses kesehatan antara laki-laki dan perempuan dapat membantu meningkatkan UHH laki-laki di Papua. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan Provinsi Papua dapat mencapai peningkatan angka harapan hidup yang lebih merata di masa depan.



Gambar 6.25 UHH Provinsi Papua, 2020–2023

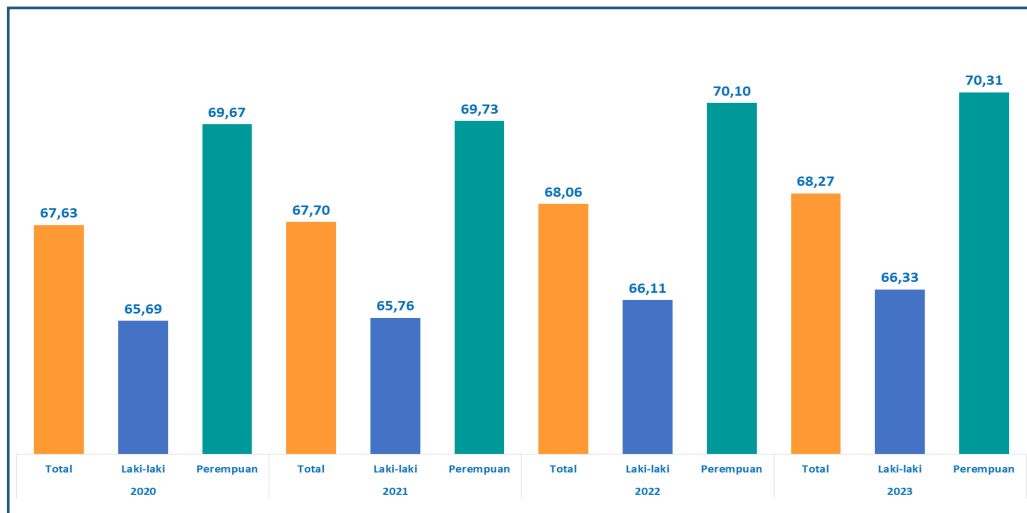
Berdasarkan Gambar 6.26 umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2023, tren umum menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam umur harapan hidup total. Angka ini meningkat dari 67,63 pada tahun 2020 menjadi 70,10 pada tahun 2023, yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat di Papua Selatan. Tren ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan kesehatan dan sosial di provinsi ini.



Perbedaan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki umur harapan hidup yang konsisten lebih tinggi daripada laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan berada pada angka 69,67, sementara laki-laki hanya mencapai 65,69. Perbedaan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana UHH perempuan mencapai 70,31 dan laki-laki di angka 66,33. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua Selatan memiliki keunggulan dalam harapan hidup dibandingkan laki-laki, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, akses kesehatan, serta perbedaan biologis antara jenis kelamin.

Perkembangan tiap tahun menunjukkan adanya variasi dalam peningkatan UHH di Papua Selatan. Dari tahun 2020 ke 2021, total UHH mengalami sedikit kenaikan dari 67,63 menjadi 69,73, dengan perempuan mencapai 68,06 pada 2022 dan laki-laki hanya sedikit meningkat menjadi 66,11. Pada tahun 2023, UHH total kembali meningkat menjadi 70,10, dengan UHH perempuan mencapai puncaknya di 70,31, sedangkan laki-laki hanya mencapai 66,33. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa peningkatan UHH terjadi secara bertahap, meskipun ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan Perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua Selatan, di mana perempuan memiliki UHH yang lebih tinggi. Meski demikian, tren peningkatan UHH dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, perbedaan yang signifikan antara UHH laki-laki dan perempuan mungkin mengindikasikan adanya faktor kesehatan atau sosial tertentu yang mempengaruhi kualitas hidup laki-laki di Papua Selatan. Implikasi kebijakan dari data ini adalah pentingnya fokus pada program kesehatan yang lebih proaktif untuk laki-laki, mengingat UHH mereka yang relatif lebih rendah dibandingkan perempuan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat program kesehatan khusus bagi laki-laki, yang meliputi edukasi tentang kesehatan, gaya hidup sehat, dan pencegahan penyakit kronis. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan preventif dan promotif yang menyeluruh di Papua Selatan diharapkan mendukung peningkatan UHH yang lebih merata di masa depan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara keseluruhan.



Gambar 6.26 UHH Provinsi Papua Selatan, 2020–2023



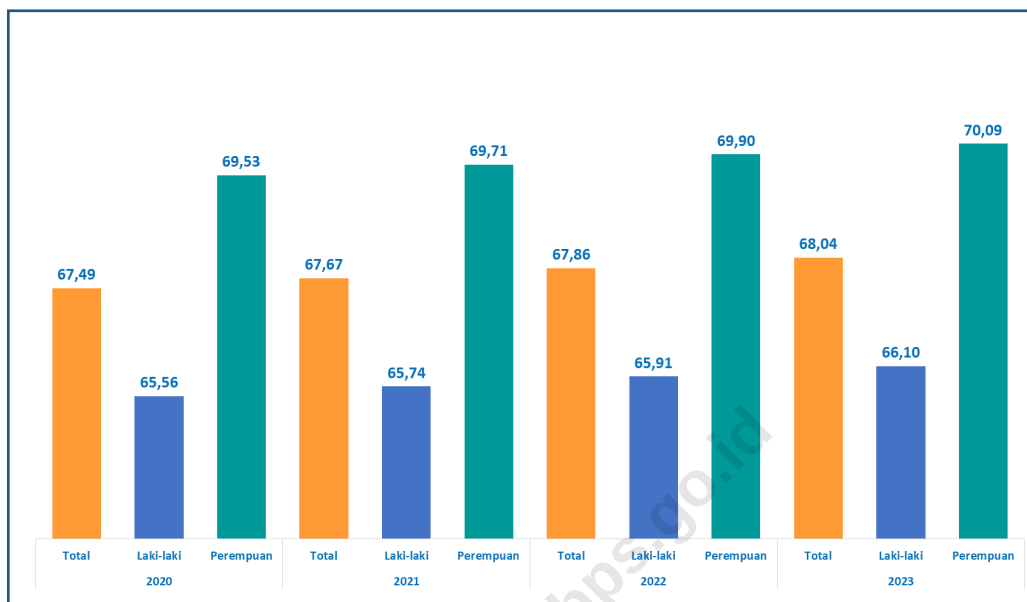
Berdasarkan Gambar 6.27 umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya tren umum peningkatan UHH yang stabil. UHH total di Papua Tengah naik dari 67,49 pada tahun 2020 menjadi 69,90 pada tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Papua Tengah, meskipun terdapat perbedaan tingkat peningkatan antara laki-laki dan perempuan.

Dari segi perbedaan berdasarkan jenis kelamin, perempuan secara konsisten memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki setiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan berada di angka 69,53, sedangkan laki-laki hanya 65,56. Perbedaan ini berlanjut hingga 2023, di mana UHH perempuan mencapai 70,09 sementara laki-laki berada pada angka 66,10. Perbedaan UHH ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua Tengah cenderung memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki, yang bisa dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin.

Perkembangan tiap tahun menunjukkan adanya peningkatan dan sedikit fluktuasi pada angka harapan hidup. Dari tahun 2020 ke 2021, UHH total mengalami kenaikan dari 67,49 menjadi 67,67. Pada tahun 2022, total UHH meningkat lagi menjadi 69,71. Di tahun 2023, UHH total mencapai angka tertinggi sebesar 69,90. Peningkatan tahunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam kondisi kesehatan masyarakat di Papua Tengah, meskipun laju peningkatan UHH laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan.

Secara keseluruhan, analisis data ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam UHH antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan yang secara konsisten memiliki UHH lebih tinggi. Meskipun UHH total mengalami peningkatan setiap tahunnya, UHH laki-laki masih tertinggal jika dibandingkan dengan perempuan, yang mungkin menandakan adanya perbedaan akses atau penerapan gaya hidup sehat yang kurang merata antara kedua kelompok ini. Tren peningkatan UHH ini, tetap menjadi indikasi positif terhadap perbaikan kesehatan masyarakat secara keseluruhan di Papua Tengah.

Dari sisi kebijakan, data ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program-program kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan harapan hidup laki-laki di Papua Tengah. Program-program kesehatan preventif, peningkatan akses ke layanan medis, dan edukasi mengenai gaya hidup sehat bagi laki-laki dapat menjadi strategi yang efektif. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan yang merata antara laki-laki dan perempuan di Papua Tengah diharapkan dapat mendukung peningkatan UHH yang lebih seimbang di masa depan. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, diharapkan Provinsi Papua Tengah dapat mencapai peningkatan angka harapan hidup yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 6.27 UHH Provinsi Papua Tengah, 2020–2023

Berdasarkan Gambar 6.28 umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Papua Pegunungan dari tahun 2020 hingga 2023, tren umum menunjukkan adanya peningkatan angka harapan hidup total secara bertahap. UHH total naik dari 66,81 pada tahun 2020 menjadi 69,14 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, menunjukkan hasil positif dari upaya kesehatan dan kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

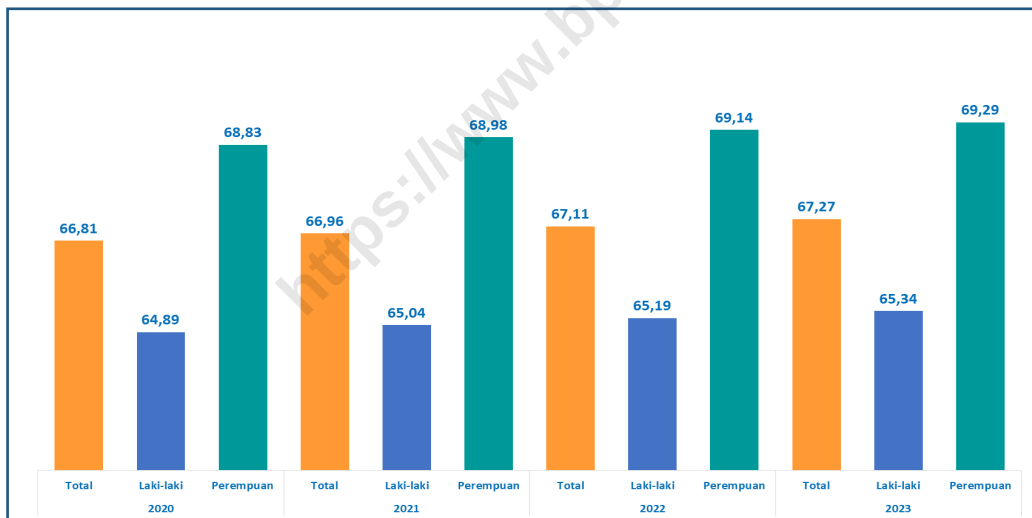
Dari segi perbedaan berdasarkan jenis kelamin, perempuan secara konsisten memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai 68,83 sedangkan laki-laki berada pada angka 64,89. Tren ini terus berlanjut hingga 2023, di mana UHH perempuan mencapai 69,29 sementara laki-laki hanya mencapai 65,34. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan di Papua Pegunungan cenderung memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan laki-laki, yang dapat disebabkan oleh faktor gaya hidup, akses kesehatan, dan perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin.

Perkembangan per tahun menunjukkan adanya peningkatan yang stabil, meskipun laju peningkatannya berbeda-beda setiap tahun. Dari tahun 2020 ke 2021, total UHH meningkat dari 66,81 menjadi 66,96. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan yang lebih signifikan, di mana UHH mencapai 68,98, terutama didorong oleh kenaikan pada perempuan yang mencapai 67,11. Pada 2023, total UHH kembali meningkat ke angka 69,14, dengan UHH perempuan yang mencapai 69,29 sementara laki-laki hanya sedikit meningkat ke 65,34. Fluktuasi ini menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten, meskipun pertumbuhan harapan hidup laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan.



Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di Papua Pegunungan. Perempuan secara konsisten memiliki UHH lebih tinggi, dan peningkatan tahunan lebih signifikan dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin mencerminkan adanya faktor sosial dan kesehatan yang lebih mendukung perempuan atau adanya kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi di kalangan laki-laki. Tren peningkatan UHH ini menjadi indikator yang baik bahwa ada peningkatan dalam kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan, meskipun kesenjangan gender tetap menjadi perhatian.

Implikasi kebijakan dari data ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih fokus pada kesehatan laki-laki di Papua Pegunungan. Program-program yang berfokus pada peningkatan kesadaran kesehatan laki-laki, akses ke layanan medis, dan edukasi mengenai gaya hidup sehat dapat menjadi prioritas untuk memperkecil kesenjangan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, meningkatkan akses layanan kesehatan preventif dan promotif yang merata di seluruh wilayah Papua Pegunungan diharapkan dapat mendorong peningkatan UHH secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan harapan hidup di Papua Pegunungan dapat terus meningkat dan mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 6.28 UHH Provinsi Papua Pegunungan, 2020–2023

7

Penutup





Selama periode 1961-2020, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 97,02 juta jiwa pada 1961 menjadi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020, dan menempati peringkat keempat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Namun, laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami penurunan antar waktu, berdasarkan hasil SP2020 laju pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi 1,25 persen pada periode 2010-2020, dan diperkirakan akan terus melambat. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, serta migrasi. Kontribusi dari ketiga variabel ini menentukan pertumbuhan penduduk pada saat ini, termasuk karakteristik dan distribusinya akan menentukan tren di masa depan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Indonesia masih menikmati bonus demografi yang dicerminkan dengan angka rasio ketergantungan di tahun 2020 sebesar 44,33 dengan lebih banyak orang yang berada di usia produktif dibandingkan non-produktif. Namun, penurunan penduduk usia non produktif Indonesia lebih terjadi di usia muda, sementara proporsi penduduk usia lanjut terus meningkat selama 50 tahun terakhir yang turut mencerminkan adanya penuaan populasi Indonesia (*aging population*). Fenomena ini mencerminkan peningkatan harapan hidup dan perubahan struktur usia. Terdapat dua faktor utama yang mendorong penuaan populasi adalah meningkatnya harapan hidup akibat perkembangan sosial ekonomi yang pesat secara global serta menurunnya angka kelahiran (WHO, 2015).

Tingkat fertilitas Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Sensus Penduduk 1971 menunjukkan TFR mencapai 5,61, yang berarti rata-rata seorang perempuan melahirkan 5 – 6 anak sepanjang masa reproduksinya, sementara hasil Long Form SP2020 menunjukkan penurunan TFR menjadi 2,18, yang berarti rata-rata perempuan melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya. Demikian juga dengan Angka Kelahiran Kasar (CBR), hasil Long Form SP2020 mencatat terdapat 17,07 kelahiran hidup di antara 1.000 penduduk Indonesia. Kelahiran tertinggi terjadi pada perempuan umur 25-29 tahun dengan nilai ASFR 130,62 kelahiran per 1000 perempuan.

Tingkat mortalitas Indonesia juga terus mengalami penurunan, angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 16,85 pada tahun 2020. Penurunan ini mencapai 35 persen dalam satu dekade dan bahkan 90 persen selama lima puluh tahun (1971 – 2020). Selain penurunan angka kematian bayi, tantangan juga terdapat pada penurunan kematian anak di bawah lima tahun, untuk memastikan kelangsungan hidup anak tersebut. Angka kematian balita di Indonesia berdasarkan hasil Long Form SP2020 adalah sebesar 19,83 per 1000 kelahiran hidup, yang mana 2,98 per 1000 kelahiran hidup diantaranya adalah kematian anak. Seiring dengan penurunan angka kematian penduduk usia dini di Indonesia, Umur Harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia juga turut mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup perempuan Indonesia hasil Long Form SP2020 menunjukkan usia yang lebih tinggi dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup laki-laki. Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin berturut-turut berdasarkan hasil Long Form SP2020 adalah 71.25 tahun untuk laki-laki dan 75.60 tahun untuk perempuan.

Angka kematian ibu Indonesia masih cukup tinggi yaitu 189 per 100.000 kelahiran hidup, namun terdapat tren penurunan yang signifikan selama satu dekade sehingga memberikan optimisme untuk mencapai target RPJMN pada tahun 2024 yaitu sebesar 183. Disparitas



tinggi antar pulau dan provinsi menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru di Papua dan Papua Barat diharapkan dapat mempercepat pembangunan kesehatan di wilayah tersebut, sehingga dapat menekan angka kematian ibu yang masih sangat tinggi khususnya di Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki angka kematian ibu tertinggi, yaitu 633 per 100.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Provinsi Papua Tengah dengan 628 per 100.000.

Secara umum, pembangunan bidang kependudukan di Indonesia terus mengalami kemajuan yang dicerminkan dengan semakin baiknya tingkat fertilitas maupun mortalitas. Namun, disparitas antar wilayah perlu menjadi perhatian selanjutnya. Percepatan penurunan angka kematian di wilayah timur Indonesia, selain akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan, namun tentunya akan berdampak terhadap percepatan penurunan angka kematian nasional. Penyediaan infrastruktur baik kesehatan, ekonomi, dan transportasi menjadi penting, untuk meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang semakin tinggi, tentunya akan memberikan dampak terhadap kemajuan suatu wilayah. Berdasarkan hasil long form SP2020, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan tingkat migrasi semumur hidup (*life time migration*) tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pemerataan pembangunan diberbagai bidang perlu terus digalakkan untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas tahun 2045



Daftar Pustaka

- Adioetomo, S.M. & Indrayanti, Ratna. 2018. 'Memasuki Dunia Kerja dan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia' dalam Adioetomo, S.M. & Pardede, E.L. (ed.). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini. Depok: Rajawali Pers.
- ARTHUR, M. M. L. (2021) *Industrialization: Demographic Transition Theory*. Salem Press Encyclopedia, [s. l.],
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas, BPS, UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bongaarts. 1978. A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility. *Population and Development Review* 4(1): 105-132.
- Brass, William (1975), "Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data, Laboratories for Population on Statistics, An Occasional Publications", Chapel Hill: The Department of Biostatistics Scholl of Public Health The University of North Carolina
- Burhanuddin, dkk. 2020. Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Bima. *Jurnal PenKoMi : Kajian pendidikan & Ekonomi*. Vol. 3, No. 2 (2020)
- Bidarti, Agustina. 2020. "Teori Kependudukan". Bogor: Lindan Bestari.
- Freedman, Ronald. 1961/1962. *The Sociology of Human Fertility: a trend report and bibliography, "Current Sociology"*, 10-11 (2); 35-115, New York.
- Freedman J.L. (1975). *Crowding and behavior*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Gu, Danan, Andrew, Kirill & Dupr, Matthew E. (2021). *Major Trends in Population Growth Around the World*. Chinese Center for Disease Control and Prevention : Vol.3 No.28
- Gunawan, E., Jamal, A., & Abbas, I. (2020). Apakah Faktor Demografi Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia? *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 100-114. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16161>
- Jayakusuma, I Made Wisnu., & Sudibia, I Ketut. (2022). Pengaruh Status Migrasi, Pekerjaan, Pendidikan, dan Latar Belakang Ekonomi Terhadap UKP dan Fertilitas Wanita Usia Subur. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(5), 510 - 523. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Kemen PPPA. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KIRK, Dudley. (1996) *Demographic Transition Theory*. *Population Studies*, [s. l.], v. 50, n. 3, p. 361-387, 1996. Disponivel em: <https://e-resources.perpusnas.go.id:3730/linkprocessor/plink?id=a2f2c568-19c4-347f-b03f-751a0dbfa991>. Acesso em: 9 jul. 2024.
- Listyaningsih, Umi., Satiti, Sonyaruri. (2021). Dinamika Fertilitas dan Prevalensi Kotrasepsi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 153-168. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>



- Adioetomo, S.M. & Indrayanti, Ratna. 2018. 'Memasuki Dunia Kerja dan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia' dalam Adioetomo, S.M. & Pardede, E.L. (ed.). *Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers.
- ARTHUR, M. M. L. (2021) *Industrialization: Demographic Transition Theory*. Salem Press Encyclopedia, [s. l.],
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Fertilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas, BPS, UNFPA. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bongaarts. 1978. A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility. *Population and Development Review* 4(1): 105-132.
- Burhanuddin, dkk. 2020. Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Bima. *Jurnal PenKoMi : Kajian pendidikan & Ekonomi*. Vol. 3, No. 2 (2020)
- Bidarti, Agustina . 2020. "Teori Kependudukan" . Bogor: Lidan Bestari.
- Freedman, Ronald. 1961/1962. *The Sociology of Human Fertility: a trend report and bibliography, "Current Sociology"*, 10-11 (2); 35-115, New York.
- Freedman J.L. (1975). *Crowding and behavior*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Gu, Danan, Andrew, Kirill & Dupr, Matthew E . (2021). *Major Trends in Population Growth Around the World* . Chinese Center for Disease Control and Prevention : Vol.3 No.28
- Gunawan, E., Jamal, A., & Abbas, I. (2020). Apakah Faktor Demografi Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia? *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(1), 100-114. <https://doi.org/10.24815/jped.v6i1.16161>
- Jayakusuma, I Made Wisnu., & Sudibia, I Ketut. (2022). Pengaruh Status Migrasi, Pekerjaan, Pendidikan, dan Latar Belakang Ekonomi Terhadap UKP dan Fertilitas Wanita Usia Subur. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(5), 510 - 523. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta
- KIRK, Dudley. (1996) *Demographic Transition Theory*. *Population Studies*, [s. l.], v. 50, n. 3, p. 361-387, 1996. Disponivel em: <https://e-resources.perpusnas.go.id:3730/linkprocessor/plink?id=a2f2c568-19c4-347f-b03f-751a0dbfa991>. Acesso em: 9 jul. 2024.
- Listyaningsih, Umi., Satiti, Sonyaruri. (2021). Dinamika Fertilitas dan Prevalensi Kotrasepsi di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 153-168. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.595>
- Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rahadian, Angga Sisca & Handayani, Titik. 2020. "Kependudukan dan Pembangunan, Persembahan untuk 80 Tahun Dr. Yulfita Raharjo". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Samosir, Omas Bulan & Prihastuti, Dewi. (2016). "Keragaman Demografi dan Kesenjangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia" dalam Kuncoro, Ari & Harmadi, Sonny H.B (ed.). *Mozaik Demografi*. 67-98. Jakarta: Penerbit Salemba Empat



Samsaputra, Satrio. (2022). Causes of Early Marriage and Level Fertility in Kabupaten Pinrang. *Indonesi Journal Islamic Community Development*. 1(1): 1 – 6.
UNICEF. 2024. Levels & Trends in Child Mortality. New York: UN.

Tri Rini Puji Lestari. 2020. Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu dan Anak. *Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020* hal. 75 – 89

Tin Afifah', Sarimawar Djaja dan Joko Irianto. 2008. Tren dan Disparitas Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKA), Angka Kematian Balita (AKBA) menurut Sosial Ekonomi di Indonesia, Susenas 1998, 2001 dan 2003. *Bul. Penel. Kesehatan*, Vol. 36, No. 3, 2008:115 -126.

Saputra, Wiko. (2013). "Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia". *Prakarsa Policy Papers/ Public Policy/2013/01*.

United Nations. (2015). Sustainable Development Goals. New York: UN

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Marriage Data 2019 (POP/DB/Marr/Rev2019)*.

Wahyuningrum, Febrianti & Soesilowati, ETTY . 2021. "The Effect of Economic Growth, Population and Unemployment on HDI" . *Indonesian Journal of Development Economics*: Vol.4 Juni 2021.

Yeung, Wei-Jun Jean . (2022). *Demographic and Family Transition in Southeast Asia*. Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-85679-3>

Lampiran





Lampiran 1 Penduduk Indonesia (juta jiwa), 1961–2020

Sensus/Survei (1)	Jumlah (2)
SP1961	97,02
SP1971	119,21
SP1980	147,49
SP1990	179,38
SUPAS1995	194,75
SP2000	206,26
SUPAS2005	213,38
SP2010	237,63
SUPAS2015	255,18
SP2020	270,20

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 2 Jumlah Penduduk Negara ASEAN (juta jiwa), 1961–2020

Tahun	Indonesia	Filipina	Vietnam	Thailand	Myanmar	Malaysia	Kamboja	Laos	Singapura	Brunei Darus-salam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1961	97,02	28,79	33,41	27,65	53,02	8,16	5,57	2,17	1,67	0,09
1971	119,21	38,52	42,45	36,94	22,21	10,42	6,62	2,73	2,13	0,14
1980	147,49	48,04	52,49	45,65	27,81	12,98	5,20	3,29	2,44	0,19
1990	179,38	62,85	65,50	54,74	33,23	17,83	7,37	4,31	3,04	0,26
1995	194,75	70,55	72,05	59,10	39,82	20,33	10,02	4,93	3,53	0,29
2000	206,26	79,63	77,15	63,01	42,61	22,97	12,46	5,43	4,04	0,33
2005	213,38	88,02	81,09	66,02	45,29	25,84	13,44	5,87	4,27	0,36
2010	237,63	96,34	87,46	68,58	47,44	28,66	14,50	6,33	5,08	0,39
2015	255,18	105,31	92,82	70,54	49,02	31,23	15,62	6,80	5,53	0,42
2020	270,20	112,08	98,08	71,64	51,09	33,89	16,73	7,35	5,62	0,45



Lampiran 3 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk, 1961–2020

Periode	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)
1961-1971	2,10
1971-1980	2,31
1980-1990	1,98
1990-2000	1,44
2000-2010	1,49
2010-2020	1,25

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2020, dan 2010–2020

Provinsi	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,93	2,72	1,46	2,36 1	1,56
Sumatera Utara	2,60	2,06	1,32	1,10	1,28
Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63	1,34	1,29
Riau	3,11	4,30	4,35	3,58	1,40
Jambi	4,07	3,40	1,84	2,56	1,34
Sumatera Selatan	3,32	3,15	2,39	1,85	1,25
Bengkulu	4,39	4,38	2,97	1,67	1,55
Lampung	5,77	2,67	1,17	1,24	1,65
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0,97	3,14	1,70
Kepulauan Riau	-	-	-	4,95	2,02
DKI Jakarta	3,93	2,42	0,17	1,41	0,92
Jawa Barat	2,66	2,57	2,03	1,90	1,11
Jawa Tengah	1,64	1,18	0,94	0,37	1,17
DI Yogyakarta	1,10	0,57	0,72	1,04	0,58
Jawa Timur	1,49	1,08	0,70	0,76	0,79
Banten	-	-	3,21	2,78	1,10
Bali	1,69	1,18	1,31	2,15	1,01
Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82	1,17	1,63
Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64	2,07	1,25
Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29	0,91	2,04
Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99	1,79	1,84
Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45	1,99	1,13
Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81	3,81	2,13
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	2,31	1,60	1,33	1,28	1,40
Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57	1,95	1,22
Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49	1,17	1,18
Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15	2,08	1,58
Gorontalo	-	-	1,59	2,26	1,16
Sulawesi Barat	-	-	-	2,68	1,98
Maluku	2,88	2,79	0,08	2,80	1,83
Maluku Utara	-	-	0,48	2,47	2,07
Papua Barat	-	-	-	3,71	3,94
Papua	2,67	3,46	3,22	5,39	4,13
INDONESIA	2,31	1,98	1,44	1,49	1,25



Lampiran 5 Angka Kelahiran Kasar (CBR) Hasil LF SP2020

Provinsi	CBR
(1)	(2)
Aceh	19,64
Sumatera Utara	19,69
Sumatera Barat	19,07
Riau	18,71
Jambi	18,40
Sumatera Selatan	17,41
Bengkulu	16,56
Lampung	17,76
Kepulauan Bangka Belitung	18,23
Kepulauan Riau	18,97
DKI Jakarta	13,94
Jawa Barat	16,81
Jawa Tengah	15,70
DI Yogyakarta	13,69
Jawa Timur	14,62
Banten	16,51
Bali	15,42
Nusa Tenggara Barat	19,38
Nusa Tenggara Timur	22,02
Kalimantan Barat	18,96
Kalimantan Tengah	19,16
Kalimantan Selatan	17,98
Kalimantan Timur	17,70
Kalimantan Utara	19,40
Sulawesi Utara	15,56
Sulawesi Tengah	18,49
Sulawesi Selatan	17,94
Sulawesi Tenggara	21,03
Gorontalo	18,99
Sulawesi Barat	21,07
Maluku	20,97
Maluku Utara	20,59
Papua Barat	22,84
Papua	22,03
Indonesia	17,07



Lampiran 6 Tren Angka Kelahiran Total (TFR) dari SP1971-LF SP2020

Provinsi	Angka Kelahiran Total (TFR)					LF SP2020
	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,27	5,24	4,37	2,81	2,79	2,42
Sumatera Utara	7,20	5,94	4,29	3,10	3,01	2,48
Sumatera Barat	6,18	5,76	3,89	3,06	2,91	2,46
Riau	5,94	5,44	4,09	2,77	2,82	2,28
Jambi	6,39	5,57	3,76	2,67	2,51	2,28
Sumatera Selatan	6,33	5,59	4,22	2,88	2,56	2,23
Bengkulu	6,72	6,20	3,97	2,68	2,51	2,30
Lampung	6,36	5,75	4,05	2,65	2,45	2,28
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	2,60	2,54	2,24
Kepulauan Riau	-	-	-	-	2,38	2,21
Dki Jakarta	5,18	3,99	2,33	1,63	1,82	1,75
Jawa Barat	6,34	5,07	3,47	2,51	2,43	2,11
Jawa Tengah	5,33	4,37	3,05	2,06	2,20	2,09
Di Yogyakarta	4,76	3,42	2,08	1,44	1,94	1,89
Jawa Timur	4,72	3,56	2,46	1,71	2,00	1,98
Banten	-	-	-	2,72	2,35	2,01
Bali	5,96	3,97	2,28	1,89	2,13	2,04
Nusa Tenggara Barat	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59	2,43
Nusa Tenggara Timur	5,96	5,54	4,61	3,37	3,82	2,79
Kalimantan Barat	6,27	5,52	4,44	2,99	2,64	2,33
Kalimantan Tengah	6,83	5,87	4,03	2,74	2,56	2,31
Kalimantan Selatan	5,43	4,60	3,24	2,33	2,35	2,31
Kalimantan Timur	5,41	4,99	3,28	2,50	2,61	2,18
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	2,35
Sulawesi Utara	6,79	4,91	2,69	2,13	2,43	2,10
Sulawesi Tengah	6,53	5,90	3,85	2,75	2,94	2,32
Sulawesi Selatan	5,71	4,88	3,54	2,56	2,55	2,22
Sulawesi Tenggara	6,45	5,82	4,91	3,31	3,20	2,57
Gorontalo	-	-	-	2,70	2,76	2,30
Sulawesi Barat	-	-	-	-	3,33	2,58
Maluku	6,89	6,16	4,59	3,39	3,56	2,52
Maluku Utara	-	-	-	3,18	3,35	2,47
Papua Barat	-	-	-	-	3,18	2,66
Papua	7,20	5,35	4,70	3,28	2,87	2,76
Indonesia	5,61	4,68	3,33	2,34	2,41	2,18



Lampiran 7 Penduduk Indonesia Menurut Provinsi (ribu jiwa), 1971–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2020, dan 2010–2020

Provinsi	1971	1980	1990	1995	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.008,6	2.611,3	3.416,2	3.847,6	3.930,9	4.494,4	5.274,9
Sumatera Utara	6.621,8	8.360,9	10.256,0	11.114,7	11.649,7	12.982,2	14.799,4
Sumatera Barat	2.793,2	3.406,8	4.000,2	4.323,2	4.248,9	4.846,9	5.534,5
Riau	1.641,5	2.168,5	3.304,0	3.900,5	4.957,6	5.538,4	6.394,1
Jambi	1.006,1	1.446,0	2.020,6	2.370,0	2.413,8	3.092,3	3.548,2
Sumatera Selatan	3.440,6	4.629,8	6.313,1	7.207,5	6.899,7	7.450,4	8.467,4
Bengkulu	519,3	768,1	1.179,1	1.409,1	1.567,4	1.715,5	2.010,7
Lampung	2.777,0	4.624,8	6.017,6	6.657,8	6.741,4	7.608,4	9.007,8
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	900,2	1.223,3	1.455,7
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	1.679,2	2.064,6
DKI Jakarta	4.579,3	6.503,4	8.259,3	9.112,7	8.389,4	9.607,8	10.562,1
Jawa Barat	21.623,5	27.453,5	35.384,4	39.206,8	35.729,5	43.053,7	48.274,2
Jawa Tengah	21.877,1	25.372,9	28.520,6	29.653,3	31.228,9	32.382,7	36.516,0
DI Yogyakarta	2.489,4	2.750,8	2.913,1	2.916,8	3.122,3	3.457,5	3.668,7
Jawa Timur	25.517,0	29.188,9	32.504,0	33.844,0	34.783,6	37.476,8	40.665,7
Banten	-	-	-	-	8.098,8	10.632,2	11.904,6
Bali	2.120,3	2.469,9	2.777,8	2.895,6	3.151,2	3.890,8	4.317,4
Nusa Tenggara Barat	2.203,5	2.724,7	3.369,6	3.645,7	4.009,3	4.500,2	5.320,1
Nusa Tenggara Timur	2.295,3	2.737,2	3.268,6	3.577,5	3.952,3	4.683,8	5.325,6
Kalimantan Barat	2.019,9	2.486,1	3.229,2	3.635,7	4.034,2	4.396,0	5.414,4
Kalimantan Tengah	701,9	954,4	1.396,5	1.627,5	1.857,0	2.212,1	2.670,0
Kalimantan Selatan	1.699,1	2.064,6	2.597,6	2.893,5	2.985,2	3.626,6	4.073,6
Kalimantan Timur	733,8	1.218,0	1.876,7	2.314,2	2.455,1	3.553,1	3.766,0
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	701,8
Sulawesi Utara	1.718,5	2.115,4	2.478,1	2.649,1	2.012,1	2.270,6	2.621,9
Sulawesi Tengah	913,7	1.289,6	1.711,3	1.938,1	2.218,4	2.635,0	2.985,7
Sulawesi Selatan	5.180,6	6.062,2	6.981,6	7.558,4	8.059,6	8.034,8	9.073,5
Sulawesi Tenggara	714,1	942,3	1.349,6	1.586,9	1.821,3	2.232,6	2.624,9
Gorontalo	-	-	-	-	835,0	1.040,2	1.171,7
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	1.158,7	1.419,2
Maluku	1.089,6	1.411,0	1.857,8	2.086,5	1.205,5	1.533,5	1.848,9
Maluku Utara	-	-	-	-	785,1	1.038,1	1.282,9
Papua Barat	-	-	-	-	-	760,4	1.134,1
Papua	923,4	1.173,9	1.648,7	1.942,6	2.220,9	2.833,4	4.303,7
INDONESIA	119.208,2	147.490,3	179.378,9	194.754,8	206.264,6	237.641,3	270.203,9



Lampiran 8 Penduduk Indonesia Menurut Pulau, 2020

Pulau	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)
Sumatera	58,60	21,68
Jawa	151,60	56,10
Kalimantan	16,60	6,15
Bali dan Nusa Tenggara	15,00	5,54
Sulawesi	19,90	7,36
Maluku dan Papua	8,60	3,17

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 9 Tren Angka Kelahiran Menurut Umur Tertentu (ASFR) dari SP 1971-LF SP2020

Provinsi	Sensus Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1971	158	324	316	241	130	62	22
	1980	105	281	265	204	120	55	17
	1990	74	224	233	177	105	45	14
	2000	45	141	147	115	69	32	14
	2010	29	125	157	130	81	28	8
	2020	16	97	151	119	76	23	3
Sumatera Utara	1971	129	333	351	304	197	94	31
	1980	87	285	310	253	159	73	20
	1990	47	212	241	190	112	44	12
	2000	33	147	177	140	78	32	12
	2010	30	138	176	142	82	27	7
	2020	21	107	159	120	67	17	3
Sumatera Barat	1971	129	313	317	255	152	59	11
	1980	102	289	299	244	151	58	8
	1990	49	191	215	174	107	35	7
	2000	32	130	166	143	89	39	12
	2010	28	123	166	140	88	31	6
	2020	14	86	163	129	75	22	2
Riau	1971	149	299	298	228	140	55	19
	1980	108	281	279	222	133	51	13
	1990	71	214	219	170	95	39	11
	2000	42	128	152	119	69	31	13
	2010	44	136	156	123	72	26	7
	2020	26	101	139	107	59	21	3
Jambi	1971	217	319	301	229	130	58	24
	1980	143	287	269	218	126	54	17
	1990	97	208	185	141	81	32	10
	2000	62	133	132	103	60	29	13
	2010	57	126	131	101	59	21	7
	2020	50	101	130	99	52	18	3
Sumatera Selatan	1971	152	326	320	248	150	56	13
	1980	111	283	291	225	135	58	14
	1990	85	224	219	166	98	41	12
	2000	52	136	142	112	70	40	25
	2010	51	126	137	107	61	22	7
	2020	36	102	137	96	56	17	2



Lanjutan Lampiran 9

Provinsi	Sensus Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)						
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bengkulu	1971	155	346	330	274	139	70	29
	1980	117	323	308	238	158	76	19
	1990	91	222	204	146	87	35	10
	2000	57	142	137	103	59	27	11
	2010	51	128	136	103	58	20	6
	2020	38	107	144	97	57	16	2
Lampung	1971	216	326	310	224	129	53	13
	1980	151	301	278	218	126	58	18
	1990	88	217	197	155	96	45	14
	2000	54	131	129	102	63	34	17
	2010	43	124	128	104	62	23	7
	2020	35	108	136	99	60	16	3
Bangka Belitung	2000	32	130	166	143	89	39	12
	2010	28	123	166	140	88	31	6
	2020	14	86	163	129	75	22	2
Kepulauan Riau	2010	20	91	144	123	69	23	7
	2020	13	76	152	118	63	18	2
DKI Jakarta	1971	140	266	268	198	110	41	12
	1980	94	208	213	157	87	31	8
	1990	36	121	138	100	49	16	5
	2000	20	73	98	78	39	14	5
	2010	17	73	107	93	52	17	5
	2020	8	60	118	94	54	15	1
Jawa Barat	1971	208	305	280	211	199	50	14
	1980	157	264	237	185	109	49	13
	1990	92	181	170	132	77	33	9
	2000	57	119	123	99	61	30	13
	2010	44	115	128	105	65	24	7
	2020	24	94	125	98	59	18	2
Jawa Tengah	1971	144	284	265	199	115	47	12
	1980	110	245	222	162	89	37	9
	1990	73	176	153	111	65	25	6
	2000	38	101	109	84	49	22	9
	2010	39	111	122	95	51	17	4
	2020	23	99	131	98	52	15	2



Lanjutan Lampiran 9

Provinsi	Sensus Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)						
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DI Yogyakarta	1971	68	253	252	199	117	48	14
	1980	51	183	189	141	80	31	8
	1990	29	123	127	82	40	12	3
	2000	14	62	88	71	35	13	4
	2010	20	90	117	95	50	14	2
	2020	12	71	124	100	55	15	1
Jawa Timur	1971	149	246	225	169	96	45	14
	1980	114	207	172	115	65	29	9
	1990	69	148	122	84	45	18	6
	2000	37	89	90	66	36	17	8
	2010	41	108	107	82	43	14	4
	2020	31	102	113	88	46	13	2
Banten	2000	48	119	129	111	72	42	24
	2010	34	104	124	105	66	26	10
	2020	18	82	122	98	58	20	3
Bali	1971	134	298	300	229	137	67	26
	1980	95	240	200	128	79	38	14
	1990	46	151	127	75	35	16	6
	2000	38	109	112	70	31	12	6
	2010	39	117	127	86	42	12	4
	2020	20	97	141	91	46	13	1
Nusa Tenggara Barat	1971	155	311	321	278	159	75	32
	1980	109	303	315	268	180	89	34
	1990	81	245	240	199	137	68	25
	2000	58	142	139	112	72	41	19
	2010	45	124	131	110	69	29	10
	2020	47	107	134	105	66	23	4
Nusa Tenggara Timur	1971	72	241	292	267	189	94	37
	1980	45	214	281	259	182	95	32
	1990	43	194	241	210	143	69	22
	2000	34	136	171	152	104	52	24
	2010	45	161	189	173	122	55	18
	2020	28	109	148	143	89	33	6
Kalimantan Barat	1971	141	297	308	245	146	82	34
	1980	111	275	275	223	131	68	21
	1990	96	229	222	172	107	47	15
	2000	59	143	146	115	71	36	15
	2010	58	130	135	105	65	27	9
	2020	43	106	133	102	60	20	4



Lanjutan Lampiran 9

Provinsi	Sensus Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kalimantan Tengah	1971	179	322	327	258	173	81	25
	1980	129	305	288	240	139	53	20
	1990	97	216	191	152	93	45	12
	2000	75	144	129	98	60	31	13
	2010	69	127	123	99	62	25	9
	2020	63	115	113	87	55	24	5
Kalimantan Selatan	1971	179	264	259	202	109	57	15
	1980	127	249	229	169	91	44	10
	1990	76	176	163	126	69	28	9
	2000	56	118	116	90	53	25	10
	2010	55	122	119	93	55	19	5
	2020	45	108	129	100	58	20	2
Kalimantan Timur	1971	151	292	260	199	114	54	11
	1980	116	264	250	199	106	46	16
	1990	71	180	170	124	70	30	10
	2000	51	127	131	101	57	25	10
	2010	51	127	138	110	65	23	8
	2020	22	92	135	104	61	19	3
Kalimantan Utara	2020	34	94	134	113	68	24	4
Sulawesi Utara	1971	103	312	350	298	199	77	19
	1980	85	256	245	197	126	60	12
	1990	55	163	142	96	52	22	7
	2000	51	116	111	79	43	18	7
	2010	53	124	124	97	60	23	5
	2020	43	97	116	88	53	19	3
Sulawesi Tengah	1971	147	309	316	261	168	75	30
	1980	114	278	293	250	162	62	21
	1990	85	215	199	140	85	37	10
	2000	63	140	137	110	63	29	13
	2010	66	146	145	118	76	29	9
	2020	39	109	128	101	61	23	4
Sulawesi Selatan	1971	133	277	281	226	130	67	27
	1980	90	228	244	203	124	63	23
	1990	54	168	187	148	91	43	16
	2000	41	114	130	109	68	35	16
	2010	43	117	132	112	71	27	9
	2020	29	94	127	103	65	22	3



Lanjutan Lampiran 9

Provinsi	Sensus Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Umur Ibu (ASFR)						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulawesi Tenggara	1971	137	312	314	255	172	83	16
	1980	111	306	292	228	142	68	17
	1990	81	260	255	199	120	50	15
	2000	69	167	167	129	78	37	16
	2010	61	150	160	136	88	34	10
	2020	35	111	143	120	76	26	4
Gorontalo	2000	67	149	132	100	59	25	9
	2010	62	147	136	106	68	27	7
	2020	46	111	130	92	54	25	3
Sulawesi Barat	2010	67	156	161	138	91	39	13
	2020	44	120	140	111	72	24	5
	2020	31	102	113	88	46	13	2
Maluku	1971	97	267	325	311	225	109	43
	1980	87	268	307	262	189	91	27
	1990	67	215	233	196	127	57	24
	2000	43	144	168	147	98	52	27
	2010	45	150	180	159	109	50	20
	2020	25	95	134	123	84	34	9
Maluku Utara	2000	77	155	143	123	70	44	22
	2010	59	147	163	141	96	44	19
	2020	42	104	134	101	73	33	6
Papua Barat	2010	53	137	151	135	89	47	24
	2000	38	109	131	126	82	38	10
Papua	1971	172	367	349	286	173	71	21
	1980	111	243	237	205	134	93	47
	1990	104	224	219	172	116	73	32
	2000	74	168	152	121	76	43	23
	2010	56	131	130	106	74	49	29
	2020	59	135	134	100	67	41	17
Indonesia	1971	155	286	273	211	124	55	17
	1980	116	248	232	177	104	46	13
	1990	71	179	171	129	75	31	9
	2000	44	114	122	95	56	26	12
	2010	41	117	130	105	61	22	6
	2020	27	98	131	101	58	18	3



Lampiran 10 Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Laki-Laki)

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH)					
	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	LFSP2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	44,6	53,5	60,8	65	68,2	70,72
Sumatera Utara	48,4	54,4	60,3	64	68,8	71,01
Sumatera Barat	43,1	48,4	57,5	62,1	67,7	71,33
Riau	44	50,5	59,4	63,1	69,7	71,43
Jambi	42,8	48,5	57,6	62,1	67,8	71,22
Sumatera Selatan	42,6	51,9	58,1	62,1	68,9	71,26
Bengkulu	40,9	50,2	58,5	62,1	68,3	70,63
Lampung	44,1	52,4	58,5	63,1	69,7	71,43
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	62,1	68,7	71,26
Kepulauan Riau	-	-	-	-	70,8	71,82
DKI Jakarta	47,1	55,8	64,3	69,2	72,8	72,51
Jawa Barat	40,8	46,2	54,2	61,1	68,9	71,78
Jawa Tengah	44,4	52,5	59,4	64	70,4	72,51
DI Yogyakarta	51,8	59,9	64,7	69,2	72,1	73,22
Jawa Timur	48,6	52,7	59,7	63,1	69,3	71,79
Banten	-	-	-	59,1	69,4	71,73
Bali	46,8	53,7	62,5	66	70,7	71,83
Nusa Tenggara Barat	33,7	37,7	44,6	54,3	63,1	69,24
Nusa Tenggara Timur	42,9	47,2	56,9	61,1	65,3	68,95
Kalimantan Barat	44,4	48,8	56	61,1	68,3	71,14
Kalimantan Tengah	47	52,2	61	63,1	69,5	71,07
Kalimantan Selatan	41,1	48,1	54,1	58,1	66,4	71,19
Kalimantan Timur	51,5	52,2	60,8	65	70,3	71,9
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	71,28
Sulawesi Utara	49,7	53,5	59,8	68,1	69,1	71,19
Sulawesi Tengah	43,4	46,9	53,8	59,1	63,9	68,39
Sulawesi Selatan	41,7	50,3	58,3	61,1	67,3	71,02
Sulawesi Tenggara	40,8	49,3	56,8	62,1	65	69,62
Gorontalo	-	-	-	61,1	61,2	67,91
Sulawesi Barat	-	-	-	-	63,2	67,99
Maluku	44,5	48,1	57	60,1	63,7	67,82
Maluku Utara	-	-	-	57,2	64,9	68,14
Papua Barat	-	-	-	-	68,1	65,92
Papua	54,9*)	51,4	56,2	61,1	71,1	65,65
Indonesia	44,2	50,6	58,1	63,5	68,7	71,25



Lampiran 11 Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Perempuan)

Provinsi (1)	Umur Harapan Hidup (UHH)					
	SP1971 (3)	SP1980 (4)	SP1990 (5)	SP2000 (6)	SP2010 (7)	LFSP2020 (8)
Aceh	47,6	56,8	64,5	69	72,2	74,75
Sumatera Utara	51,3	57,8	63,9	67,9	72,8	75,09
Sumatera Barat	46	51,4	60,9	65,9	71,7	75,78
Riau	47	53,5	63	66,9	73,6	76
Jambi	45,7	51,4	61	65,9	71,8	75,55
Sumatera Selatan	45,5	55,1	61,6	65,9	72,8	75,63
Bengkulu	43,7	53,2	62	65,9	72,2	74,65
Lampung	47,1	55,6	62	66,9	73,6	76
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	65,9	72,6	75,63
Kepulauan Riau	-	-	-	-	74,6	76,8
DKI Jakarta	50	59,2	68,2	73,1	76,5	78,02
Jawa Barat	43,6	49,1	57,4	64,8	72,8	76,72
Jawa Tengah	47,4	55,7	63	67,9	74,3	76,99
DI Yogyakarta	55	63,6	68,5	73,1	75,9	76,83
Jawa Timur	51,5	56	63,3	66,9	73,2	76,75
Banten	-	-	-	62,8	73,3	76,63
Bali	49,7	57	66,2	70	74,5	76,83
Nusa Tenggara Barat	36,3	40,4	47,3	57,6	67	73,2
Nusa Tenggara Timur	45,8	50,1	60,3	64,8	69,3	72,9
Kalimantan Barat	47,3	51,8	59,4	64,8	72,2	75,38
Kalimantan Tengah	49,8	55,4	64,7	66,9	73,4	75,23
Kalimantan Selatan	44	51	57,3	61,8	70,4	75,48
Kalimantan Timur	54,7	55,4	64,5	69	74,2	76,05
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	75,67
Sulawesi Utara	52,7	56,8	63,4	72	73	75,48
Sulawesi Tengah	46,4	49,7	57	62,8	67,8	72,33
Sulawesi Selatan	44,6	53,3	61,8	64,8	71,3	75,12
Sulawesi Tenggara	43,6	52,3	60,2	65,9	68,9	73,6
Gorontalo	-	-	-	64,8	65	71,85
Sulawesi Barat	-	-	-	-	67	71,93
Maluku	47,5	51	60,4	63,8	67,6	71,77
Maluku Utara	-	-	-	60,7	68,9	72,08
Papua Barat	-	-	-	-	72,1	69,9
Papua	58,3*)	54,5	59,6	64,8	74,9	69,62
Indonesia	47,2	53,7	61,5	67,3	72,6	75,6



Lampiran 12 Tren Umur Harapan Hidup Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin dari SP1971-LF SP2020 (Total)

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH)					
	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	LFSP2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	46,2	55,2	62,7	67	70,2	72,69
Sumatera Utara	49,9	56,1	62,1	66	70,9	73
Sumatera Barat	44,6	49,9	59,2	64	69,7	73,5
Riau	45,6	52	61,2	65	71,7	73,66
Jambi	44,3	50	59,2	64	69,9	73,33
Sumatera Selatan	44,1	53,6	59,8	64	70,9	73,39
Bengkulu	42,3	51,8	60,2	64	70,3	72,59
Lampung	45,6	54	60,2	65	71,7	73,66
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	64	70,7	73,39
Kepulauan Riau	-	-	-	-	72,7	74,25
DKI Jakarta	48,6	57,6	66,3	71,2	74,7	75,2
Jawa Barat	42,3	47,7	55,8	63	70,9	74,19
Jawa Tengah	45,9	54,1	61,2	66	72,4	74,39
DI Yogyakarta	53,5	61,8	66,6	71,2	74,1	74,95
Jawa Timur	50,1	54,4	61,5	65	71,3	74,21
Banten	-	-	-	61	71,4	74,12
Bali	48,3	55,4	64,3	68,1	72,7	74,27
Nusa Tenggara Barat	35	39,1	45,9	56	65,1	71,17
Nusa Tenggara Timur	44,4	48,7	58,6	63	67,4	70,88
Kalimantan Barat	45,9	50,4	57,7	63	70,3	73,21
Kalimantan Tengah	48,4	53,9	62,8	65	71,5	73,1
Kalimantan Selatan	42,6	49,6	55,7	60	68,4	73,28
Kalimantan Timur	53,2	53,8	62,7	67	72,3	73,7
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	73,42
Sulawesi Utara	51,3	55,2	61,6	70,1	71,1	73,28
Sulawesi Tengah	45	48,3	55,4	61	65,9	70,31
Sulawesi Selatan	43,2	51,9	60	63	69,3	73,02
Sulawesi Tenggara	42,3	50,8	58,5	64	67	71,56
Gorontalo	-	-	-	63	63,2	69,83
Sulawesi Barat	-	-	-	-	65,1	69,91
Maluku	46	49,6	58,7	62	65,7	69,75
Maluku Utara	-	-	-	59	67	70,06
Papua Barat	-	-	-	-	70,2	67,86
Papua	56,7*)	53	57,9	63	73	67,59
Indonesia	45,7	52,2	59,8	65,4	70,7	73,37

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id